

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC/SP**

Glendon Alexandre da Silva

Vale de Lágrimas

**Um estudo a respeito da noção de doença sob o ponto de vista
de religiões brasileiras no início do século XXI**

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

SÃO PAULO – 2009

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC/SP**

Glaiton Alexandre da Silva

Vale de Lágrimas

**Um estudo a respeito da noção de doença sob o ponto de vista
de religiões brasileiras no início do século XXI**

MESTRADO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO

Dissertação apresentada como exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Ciências da Religião à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da Prof^a Dr^a Maria José Fontelas Rosado Nunes.

SÃO PAULO – 2009

SILVA, Glayton Alexandre da

Vale de Lágrimas: um estudo a respeito da noção de doença sob o ponto de vista de religiões brasileiras no início do século XXI. 198 páginas.

Dissertação de Mestrado – Ciências da Religião, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Sociologia da Religião

1. Sociologia da Religião 2. Doença 3. Saúde 4. Representações Sociais

TERMO DE APROVAÇÃO

GLAYTON ALEXANDRE DA SILVA

Vale de Lágrimas:

**Um estudo a respeito da noção de doença sob o ponto de vista de
religiões brasileiras no início do século XXI**

Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre no Curso de mestrado em Ciências da Religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela seguinte banca examinadora:

São Paulo – Mar/2009

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação por processos fotocopíadores ou eletrônicos.

Assinatura:_____ Local e Data:_____

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha mãe, Maria da Conceição Silva, que em sua simplicidade me deu o apoio necessário para essa empreitada intelectual.

AGRADECIMENTOS

Aos meus irmãos, Wilson e Adriano, pelas palavras de incentivo e demonstrações de júbilo que, mesmo quando eu julgava não ser merecedor, animaram-me a continuar firme em meus propósitos.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – por ter viabilizado a realização do curso e dessa pesquisa.

À Prof^a Dr^a Maria José Fontelas Rosado Nunes (ou simplesmente Zeca) pela forma competente como desenvolveu as atividades de orientação e pelas palavras de apoio e incentivo que culminaram no êxito desta dissertação.

À secretária Andréia do programa de Ciências da Religião pela postura sempre solícita e paciente na resolução das mais diversas situações.

Ao meu amigo de infância, José Carlos Alexandre, ouvinte de minhas queixas e sempre solidário nos momentos em que minhas inquietações afloravam.

Às minhas amigas Ângela, Elen, Gina, Maria de Lourdes, Karen, Tânia e Valéria, as quais encontrei empreendendo a mesma jornada e que iluminaram meu caminho com conversas descontraídas, muitos risos, conselhos e cumplicidade.

Aos meus colegas e professores de curso que contribuíram para elucidar muitas dúvidas e que, principalmente, ajudaram a suscitar muitas outras perguntas.

EPÍGRAFE

E você ainda vive!
Em meus olhos está o teu paraíso!
Tu não estás sozinha.
Tuas lágrimas de desespero eu banirei.
Eu estou ao teu lado,
para guiar teu passos vacilantes.
Sorria e tenha esperança!
Pois, o próprio Amor sou eu! (Eu sou o AMOR!)
Embora teu caminho seja sombrio e tenebroso,
Anima-te!
Eu sou o divino!
Eu sou o perdão!
Eu sou Deus.
Erga teus olhos e contempla-me.
Eu venho a ti do firmamento acima,
transformando a Terra em um paraíso.
Eu sou o Amor!
E um anjo revoou próximo de mim,
e beijou-me com o frio beijo da morte.
Este corpo sem valor é o meu corpo!
Leve-o para onde desejares,
pois morta já estou.*

* Trecho da aria *La Mamma Morta* (*The Dead Mother*) da ópera *Andrea Chénier* de Umberto Giordano (1896). Esse trecho é uma tradução livre da canção original em italiano executada pela soprano que interpreta a personagem Madalena di Coigny. A canção foi imortalizada na voz da soprano Maria Callas. Adicionalmente, essa canção fez parte da trilha sonora do filme *Filadélfia* (1993), no qual o ator Tom Hanks interpreta um advogado homossexual vitimado pela AIDS e que luta contra as injustiças do preconceito.

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar a concepção de doença em religiões brasileiras. Sob a perspectiva da teoria das Representações Sociais, busca-se a identificação das interpretações da causalidade dos processos mórbidos sob o ponto de vista de católicos, evangélicos, espíritas e praticantes dos cultos afro-brasileiros (umbanda e candomblé). Com esse intuito, é proposta uma discussão para a definição dos termos doença e religião, além de uma análise da relação dessa última com a medicina.

Os modelos etiológicos e as concepções populares sobre a doença revelam a importância de se conhecer as representações de saúde/doença enquanto balizadoras de comportamentos sociais de proteção, exclusão e assistência aos indivíduos enfermos. A história das representações de saúde/doença foram sempre pautadas pela inter-relação dos seres humanos e seus corpos com diversos elementos naturais, sociais e sobrenaturais. Em decorrência da função terapêutica desempenhada pelas religiões ao longo dos séculos, crenças religiosas permeiam essas representações e levaram, inevitavelmente, a uma moralização das enfermidades. Essa constatação acaba mostrando que quando se trata de representações sociais da doença observa-se mais permanências do que mudanças no decorrer dos anos.

A moralização das doenças aliada à elevação da saúde ao estatuto de "ideal social" pela medicina moderna e pelas religiões no geral influem na maneira como os agentes sociais afetados pela doença, e os grupos religiosos aos quais pertencem, lidam com o sofrimento. As questões sobre a razão das doenças desloca-se do *como?* para o *por que?* e a doença, antes concebida como uma mera alteração fisiológica, tem seus domínios estendidos para além do corpo.

Palavras chaves: Representação Social, Doença, Saúde, Religiões Brasileiras.

ABSTRACT

This study intends to analyze the interpretation of sickness among Brazilian religions. Based upon the theory of Social Representations it will be identified the interpretations of sickness causality according to catholics, protestants, spiritists and Afro-Brazilian religion followers (umbanda and candomblé). In order to accomplish such purpose it is first suggested a discussion to better define controversial terms such as sickness and religion, as well as the relationship between the latter and medical practice.

Etiologic models and popular conceptions of sickness reveal the importance of comprehending health/sickness representations as they work as a measure to social behaviors such as protection, exclusion and aiding of sick people. The history of health/sickness representations was always ruled by the inter-relationship of human beings and their bodies with several natural, social and supernatural elements. Due to the therapeutic role played by religions during centuries, religion believes pervade these representations and they inevitably led to the moralization of diseases. This evidence shows that when it comes to social representation of sickness the more things change the more they remain the same.

Disease moralization process and the promotion of health to the status of "social ideal" by modern medicine and by religions as a whole have influenced the way social agents affected by disease, as well as the religious group they belong to, used to face suffering. Inquiries concerning the reason of the diseases have moved from *how?* to *why?* and the disease first conceived as a mere physiologic change in the human body has its domains extended far beyond it.

Key Words: Social Representations, Sickness, Health, Brazilian Religions.

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO-----	01
I.	ETIOLOGIA DAS DOENÇAS-----	14
	Introdução-----	14
I.1.	O que é doença afinal?-----	18
I.2.	Modelos etiológicos da doença-----	23
I.2.1.	Modelo ontológico e modelo relacional-----	24
I.2.2.	Modelo exógeno e modelo endógeno-----	29
I.2.2.1.	As relações entre os modelos ontológico/funcional e exógeno/endógeno-----	31
I.2.3.	Modelo aditivo e modelo subtrativo-----	32
I.2.4.	Modelo maléfico e modelo benéfico-----	33
I.3.	A concepção popular da doença-----	36
I.4	A Teoria das Representações Sociais-----	42
I.4.1	Uma teoria em construção: críticas e reflexões metodológicas-----	46
II	RELIGIÕES BRASILEIRAS-----	50
	Introdução-----	50
II.1	As religiões do Brasil: além dos números-----	53
II.2	Catolicismo no Brasil-----	56
II.2.1	Catolicismo: unidade religiosa e pluralismo cultural-----	58
II.2.2	O declínio-----	63
II.3	Protestantismo no Brasil-----	68
II.3.1	Pentecostalismo: a Era do Espírito-----	70
II.3.2	Neopentecostalismo: prosperidade, cura e exorcismo-----	74
II.4	Espiritismo no Brasil-----	77
II.4.1	Chico Xavier: espiritismo à brasileira-----	82
II.5	As religiões afro-brasileiras-----	86
II.5.1	Candomblé: o legado dos Orixás-----	88
II.5.2	Umbanda: uma religião brasileira-----	91
III	SAÚDE/DOENÇA E SUAS INTERPRETAÇÕES RELIGIOSAS-----	94
	Introdução-----	94

III.1	Doenças e Religião-----	99
III.1.1	Definindo Religião-----	100
III.1.2	A função terapêutica das religiões-----	103
III.1.2.1	Saúde e Salvação: uma divisão secular-----	103
III.1.2.2	Religião e Medicina: a saúde como ideal social-----	107
III.2	As interpretações religiosas das doenças-----	110
III.2.1	Catolicismo: as doenças sob a ótica bíblica-----	110
III.2.1.1	As doenças no Antigo Testamento-----	114
III.2.1.2	As doenças no Novo Testamento-----	121
III.2.1.3	Saúde e fé cristã: o advento da RCC-----	127
III.2.1.4	Catolicismo popular: na saúde e na doença, rogai ao santo!-----	129
III.2.2	Protestantismo: uma dicotomia desnecessária-----	133
III.2.2.1	Doença e cura divina-----	134
III.2.3	Espiritismo e sua lógica-----	137
III.2.3.1	Hospital celestial: a doença como terapia-----	139
III.2.4	O Candomblé e sua cosmovisão-----	144
III.2.4.1	A balança dos Orixás-----	146
III.2.5	Umbanda: a doença é desordem-----	149
III.3	O consenso religioso-----	153
III.3.1	A causalidade-----	154
III.3.1.1	Causas Instrumentais-----	159
III.3.1.2	Causas Eficientes-----	160
III.3.1.3	Causas Conjecturais-----	163
III.3.2	A essência das interpretações religiosas das doenças-----	167
	CONSIDERAÇÕES FINAIS-----	174
	BIBLIOGRAFIA -----	177

ÍNDICE DE TABELAS E FIGURAS

Tabela 01	População residente segundo a religião – Brasil -----	54
Tabela 02	Evolução População Evangélica – Brasil-----	72
Tabela 03	Evangélicos de Missão (Brasil, 2000)-----	72
Tabela 04	Evangélicos de Origem Pentecostal (Brasil, 2000)-----	73
Tabela 05	Pesquisa de Opinião Pública Instituto GALLUP: Crenças (Brasil, 1988)-----	80
Tabela 06	Cor declarada dos seguidores por grupo religioso (Brasil, 2000)-----	81
Tabela 07	Média de anos de estudos por grupo religioso (Brasil, 2000)-----	82
Tabela 08	Causalidade das doenças por religião-----	158
Figura 01	Esquema de interpretação religiosa das doenças-----	170

INTRODUÇÃO

Quando iniciei essa pesquisa eu somente havia tido contato com a metodologia clássica das investigações científicas. Os postulados da ciência clássica – neutralidade, objetividade, universalidade e racionalidade – eram a meu ver inquestionáveis e essenciais para a validade de todo e qualquer conhecimento. No curso da realização dessa pesquisa, entretanto, acabei tendo contato com as teorias e metodologias feministas que mudaram sobremaneira o modo como eu enxergava a ciência. O presente trabalho não tratará de questões de gênero, é verdade, mas julgo ser necessário apresentar as idéias feministas que trazem uma nova perspectiva a respeito da construção do conhecimento e que por sua importância acadêmica merecem ser propagadas a despeito das críticas contrárias a esse movimento. Embora os assuntos sobre gênero não sejam abordados no decorrer desse trabalho, na medida do possível, farei uso de linguagem inclusiva para evitar que as mulheres ou o "aspecto feminino" passem despercebidos sob a pretensa universalidade dos substantivos masculinos. Adicionalmente, essas considerações de cunho feminista, refletir-se-ão na forma como as citações serão feitas, pois sempre que julgar pertinente incluirei o nome e o sobrenome do/a autor/a referido/a para deixar claro se determinado conhecimento é de autoria de um homem ou de uma mulher.

Um dos grandes entraves ao desenvolvimento de estudos feministas reside ainda nas associações negativas e pejorativas associadas ao termo. Por isso é comum ouvir: "Eu não sou feminista, mas...". Esta frase revela uma preocupação em se distanciar de uma possível militância que poderia comprometer a validade do conhecimento elaborado e expressa, ao mesmo tempo, a preocupação instaurada diante da constatação de um problema, seja em decorrência da percepção de alguma desigualdade social ou da própria experiência pessoal. Outro entrave é a afirmação descabida de que hoje em dia não faz mais sentido falar de "feminismo"¹. Para aqueles/as que realmente acreditam

¹ De fato, a primeira coisa que precisa ser dita sobre o feminismo é que ele não existe, ou seja, não existe um discurso único sobre o tema. O que existe, na verdade, são feminismos (no plural). O que entendemos como "feminismo" é, de fato, um agrupamento de idéias, múltiplas e diversificadas que não pode ser visto como um discurso único de mulheres. Embora haja dificuldades na definição do termo "feminismo", é possível captar características comuns dos diferentes movimentos feministas. A primeira característica comum a todas as fases de desenvolvimento das idéias feministas é o interesse pela posição inferiorizada ocupada pelas mulheres nas mais diversas sociedades, bem como a discriminação que as afeta. Em decorrência dessa primeira característica, o segundo ponto em comum ao longo da história das idéias feministas é o engajamento pela mudança da ordem social, política e cultural com o intuito de dirimir as

nisso, ressalto que embora a luta feminista tenha logrado algumas conquistas, a realidade nos mostra que se está longe de uma zona de conforto. Algumas pessoas julgam que as mudanças sociais, decorrentes das idéias feministas, reduziram as formas de discriminação contra as mulheres, já outras pessoas acreditam que na verdade essas mudanças só tornaram a discriminação menos evidente. E de fato, a história nos mostra que diferentes contextos sócio-culturais são capazes de mascarar sob o ilusório direito de igualdade de todo ser humano diversos tipos de discriminação. Se assim não o fosse, questões relacionadas à violência contra as mulheres por seus cônjuges, limitações e restrições impostas às mulheres no âmbito religioso, união homossexual dentre outros exemplos já teriam sido há muito tempo superadas.

Pondo estes obstáculos à parte, o "feminismo" tornou-se o palco de importantes discussões políticas e ideológicas que, embora sob diferentes formas, aponta sempre para a tese de que as relações entre os sexos se caracteriza pela desigualdade e opressão. De uma forma geral, todas as formas de feminismo buscam identificar as causas dessa desigualdade e corrigi-la, pois são geralmente consensuais no fato de que a maioria das culturas atuais e passadas foram estruturadas de um modo que coloca as mulheres em desvantagens em relação aos homens. Adicionalmente, foram reconhecidas posteriormente outras hierarquias na ordem social além do gênero, tais como: a raça, a classe social, a orientação sexual, a idade, o credo etc. Portanto, as pesquisas feministas podem tomar diferentes direções, de acordo com o recorte adotado, no intuito de demonstrar que a sociedade privilegia determinados grupos em detrimento de outros. Para validar tais assunções, inevitavelmente, o "feminismo" teve de buscar recursos na ciência, reduto inquestionável do saber objetivo, universal e imparcial.

As críticas feministas à ciência clássica tiveram início em meados dos anos 70 do século XX. A principal crítica repousava no enviesamento androcêntrico existente em todo o processo de desenvolvimento e construção do saber nas investigações científicas. O saber, pretensamente universal, identificava o homem ou o aspecto masculino como a norma e sua contraparte, a mulher e o feminino, quando contemplada, aparece como o desvio da norma, validando as idéias do senso comum de

formas de discriminação contra a mulher. Estas premissas básicas de todos os movimentos feministas impede (ou pelo menos deveria) que o encaremos como um movimento exclusivo de mulheres, embora seja de fato em prol delas, pois esse movimento pode ser inserido em uma perspectiva maior que visa a dignificação da pessoa, envolvendo todos os membros da sociedade. Por isso compartilho da opinião de Stanley citada por Paula Silva *et al.* (2005, p. 362) de que o "feminismo" não é apenas uma perspectiva, um modo de ver; nem tampouco uma epistemologia, uma forma de conhecer; é sobretudo uma ontologia, uma maneira de viver.

inferioridade e justa subordinação do sexo feminino ao masculino. Em decorrência dessa constatação, de acordo com Laura Fonseca *et al.* (2001), sob o ponto de vista epistemológico, as teorias feministas acabaram se distanciando claramente da ciência clássica nos seguintes aspectos:

- a) Não se postula a noção de objetividade absoluta;
- b) Não se camufla a forma como o/a investigador(a) está implicado/a na sua investigação;
- c) Não se pressupõe que o objeto de análise é "passivo", quando este, pelo contrário, está em constante modificação;
- d) Não se oculta como são importantes, para o contexto da análise, as relações de poder que se estabelecem entre agente de investigação e as pessoas ou grupos investigados.

O legado do positivismo nas pesquisas científicas se faz sentir nas metodologias e práticas de pesquisa ao encorajar a neutralidade e a isenção dos/as investigadores/as no que tange ao processo de coleta, análise e interpretação dos dados. Assim, a imagem ideal do/da cientista é aquela de um indivíduo alheio ao seu objeto e alheio sobretudo à repercussão de sua subjetividade no modo de analisar e interpretar esse mesmo objeto, ou seja, o/a investigador/a é despido/a utopicamente de todas as suas crenças, valores e ideologias a ponto de ignorar todos os fatores sociais, culturais, políticos e históricos que justificam as posturas daqueles indivíduos com os quais interage na sua empreitada intelectual. Essa tendência de excluir o social e o conjuntural das formulações do conhecimento obviamente fez com que o "feminismo" levantasse uma série de críticas ao positivismo e as abordagens estruturalistas e essencialistas no que diz respeito as formas de construir, analisar e interpretar o discurso científico vigente. O "feminismo", enquanto sistema teórico-metodológico, se opõe a um sistema científico orientado pela individualidade, pelo androcentrismo e pela alienação das estruturas sociais de poder. Em outras palavras, as metodologias em ciência social acabaram inseridas em debates epistemológicos sobre "como conhecemos, o que conhecemos e o que reivindicamos como conhecimento verdadeiro ou não" (BRINSKELL, Heather *apud* FONSECA, Laura *et al.*, 2001, sem paginação definida).

A crítica feminista trouxe assim à tona a questão epistemológica (qual a natureza do conhecimento e qual a relação entre investigador/a e o que se há para conhecer?) e a questão metodológica (como é que o/a investigador/a pretende obter o conhecimento desejado?) nas ciências sociais. As noções conceituais dominantes (objetividade, racionalidade, universalidade e neutralidade) e a metodologia científica vigente mostraram-se débeis na tentativa de identificar e eliminar crenças misóginas e androcêntricas das ciências sociais. De acordo com Paula Silva *et al.* (2005), emergiram no seio do "feminismo" três tendências epistemológicas, com o intuito de fomentar novas formas de desenvolvimento do conhecimento: o empirismo feminista (*feminist empiricism*); as teorias do ponto de vista feminista (*feminist stand-point*) e o feminismo pós-moderno (*feminist postmodernism*).

A primeira tendência epistemológica, o empirismo feminista, recorre aos métodos tradicionais de pesquisa (principalmente o quantitativo) tentando corrigir preconceitos de gênero na investigação, além de ter suas bases apoiadas na racionalidade e na objetividade da ciência. Embora visasse a identificação e eliminação do caráter androcêntrico das pesquisas, esta perspectiva é alvo de críticas ao não questionar as bases da pesquisa científica e aceitar seus métodos como "naturais".

Já a segunda corrente epistemológica, as teorias do ponto de vista feminista, pode ser considerada uma revolução ao incluir as experiências das mulheres na elaboração do conhecimento. Acreditava-se que ao se destacar as experiências individuais das mulheres seria possível contribuir para a construção de um conhecimento menos enviesado. Porém, mais uma vez, essa tendência foi alvo de severas críticas. Isso porque se destacou a tendência, dentro desta perspectiva, de universalização de conceitos, tais como: "mulheres", "opressor", "ponto de vista feminino" dentre outros. Se o ponto de partida e o foco da investigação feminista são as experiências das mulheres, é importante reconhecer que as mulheres são diferentes e não podem ser categorizadas sem levar em conta uma pluralidade de fatores que determinam as suas relações sociais, tais como: raça, classe social, idade etc.

Assim emergiu o feminismo pós-moderno, a terceira tendência epistemológica citada anteriormente, que sugere "a existência de variados pontos de vista feministas contraditórios e conflituosos, considerando impossível a noção unitária de verdade" (SILVA, Paula *et al.*, 2005, p. 363). Entre os/as pesquisadores/as feministas pós-modernos/as reconhece-se, então, a inexistência de um modo correto de interpretação. Existe, para eles/elas, a capacidade do/a investigador/a explorar e escolher diferentes

tipos de interpretação. O pós-modernismo caracteriza-se pelo constante questionamento da razão, possibilitando novas interpretações e alterando noções tidas como universais. Essa conjunção entre as idéias pós-modernas e o feminismo permitiu uma reflexão e revisão da teoria feminista, mostrando que o "feminismo" ainda guarda muitos indícios essencialistas e, por sua vez, o "feminismo" ajuda a revelar que há mais sinais de androcentrismo e ingenuidade política nas idéias pós-modernas do que se imagina. Essa relação e crítica mútua, permitiu a teoria feminista pós-moderna um distanciamento dos conceitos unitários de mulher e de identidade de gênero e a adoção de noções plurais e complexas de identidade social.

Inserir-se nesta terceira proposta epistemológica feminista o conceito de "reflexividade enquanto prática auxiliadora da desconstrução do paradigma moderno nas ciências sociais" (NEVES, Sofia; 2005; p. 409). A reflexividade é uma característica distintiva dos/as pós-modernistas que advogam contra a noção de que os elementos pessoais não interferem nem determinam os achados ditos "científicos", em outras palavras, salientam a natureza socialmente construída daquilo que conhecemos e tomamos como verdade e que todo e qualquer conhecimento depende do ponto de vista do sujeito que o cria. A adoção de métodos reflexivos nas ciências sociais, segundo Sofia Neves, exige: a adoção de planos de pesquisa flexíveis, a promoção da componente educacional dos discursos científicos, a desmistificação da pertença do conhecimento aos especialistas, o envolvimento de todos/as na interpretação dos resultados e na criação de recomendações e promoção de mudanças e, por fim, a explicitação das experiências e perspectivas pessoais nos trabalhos acadêmicos. Esses procedimentos revelariam que as disciplinas científicas não são "produtos naturais", mas sim resultado de um conjunto de práticas sociais, histórica e culturalmente contextualizadas, próprias de uma determinada sociedade. Isso realça o fato de que "não haver relação entre investigador/a e investigado(s)/a(s) é uma impossibilidade física e social, pois existe sempre uma interdependência entre as pessoas que participam no processo de investigação" (GERGEN *apud* NEVES, Sofia: 2005; p. 410). A reflexividade deve respaldar-se nas implicações desse cruzamento a fim de favorecer um melhor entendimento das dinâmicas sociais.

De uma forma geral, a maior contribuição epistemológica do "feminismo" para as ciências sociais é nos conceder a oportunidade de sermos mais conscientemente reflexivos. Pensar sobre nosso próprio pensamento, indagar nossos pré-entendimentos e os seus efeitos na investigação científica. A constatação de que o pensamento científico

tem por alicerce elementos androcêntricos, classicistas, etnocêntricos e heterossexistas motiva uma profunda reforma da maneira como as pesquisas científicas são conduzidas. A metodologia feminista constitui assim uma ferramenta essencial para se realizar esse processo de desconstrução. Mais do que contribuir para o processo de construção de conhecimento, a metodologia feminista logrou (pelo menos de forma parcial e momentânea) o feito épico de por à baixo conceitos e métodos científicos outrora vistos como universais e imparciais. Ressalto o caráter parcial e momentâneo dessas conquistas para que não sejamos iludidos com a idéia de que nada mais há para se fazer e de que "tudo pode ser tomado como certo". Ao contrário, o estado atual dos estudos feministas na academia nos mostra que a manutenção do *status quo* (androcêntrico) ainda é uma ameaça patente. Seja qual for a perspectiva feminista adotada, ainda há muito que se fazer para que a investigação científica tenha uma abordagem mais inclusiva e se torne propulsora da plena equidade entre os sexos na esfera pública e privada.

A investigação científica feminista ilustra a "clara consciência dos/as investigadores/as [a respeito] do seu papel e envolvimento pessoal na investigação" (REINHARTZ *apud* NEVES, Sofia: 2005, p.410), pois o conhecimento é sempre moldado por quadro de referências sócio-políticas. A reflexividade constitui, então, um exercício a ser praticado com o intuito de identificar o impacto desses quadros de referência na produção dos discursos científicos e populares. Essa prática não permite apenas elucidar as relações de poder presentes na investigação científica, mas ajudam a esclarecer os propósitos e intenções de determinados discursos e também a responsabilidade do/a investigador/a pelo conhecimento produzido. É por isso que Donna Haraway, citada por Sofia Neves (2005), afirma que o conhecimento produzido pelos/as feministas é apenas uma verdade particular e limitada que deve responder a três questões: a da responsabilidade, a do posicionamento e a da parcialidade. Para isso os trabalhos acadêmicos devem explicitar quem patrocina a investigação, quem se beneficiará dos resultados obtidos e quem é o/a investigador/a (sua carreira, crenças e posicionamento político). O que produzir, como produzir e com que finalidade são assim apenas algumas das interrogações que a metodologia feminista pode nos ajudar a responder, tendo em mente que esta metodologia está comprometida com valores e ideologias intervencionistas a serviço de mudanças sociais. Em síntese, podemos afirmar que:

as metodologias feministas são reflexivas na medida em que implicam o reconhecimento da influência dos fatores sociais, históricos, culturais e políticos na construção do conhecimento (negando assim a possibilidade da neutralidade e da objetividade) e o reconhecimento do envolvimento dos/as investigadores/as na produção da ciência e dos seus discursos (NEVES, Sofia: 2005, p. 411).

Creio que a perspectiva feminista traz para as ciências sociais e para os estudos das religiões, em especial, análises mais responsáveis e menos dispare de realidade. Essa perspectiva liberta pesquisadores/as da objetividade fictícia, revelando as implicações dos aspectos culturais, sociais, políticos e históricos no processo de investigação. Além disso, ressalta a importância da responsabilidade do/a pesquisador/a por aquilo que é produzido e a necessidade de que a investigação científica esteja a serviço de problemas de um determinado contexto (parcialidade) para que seu potencial transformador da vida social seja mais efetivo.

Uma vez feita essas considerações teórico-metodológicas que refletem minha opinião pessoal a respeito da natureza e do processo de construção do conhecimento científico, creio que é necessário elucidar aspectos importantes da pesquisa que será apresentada e, para tanto, tentarei esclarecer primeiramente os motivos que me levaram a escrever esse trabalho. Eu nasci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais e aos quatro anos de idade mudei-me para São Paulo com meus pais. Morando em um bairro da periferia desta cidade tive ao longo dos anos contato direto e indireto com diversas formas de expressões religiosas. Diretamente estive em contato com o catolicismo, o espiritismo e a umbanda e, indiretamente tive contato com o protestantismo e o pentecostalismo ao ouvir relatos das experiências de amigos, vizinhos e desconhecidos da TV. Do contato com essas religiões e do interesse pessoal pela Sociologia surgiram algumas indagações quanto ao comportamento de indivíduos religiosos, notadamente perante as doenças.

Guardo recordações de romarias à cidade de Aparecida do Norte, palco por excelência das demonstrações de devoção popular, que despertaram em mim espanto e incompreensão. Nas ocasiões em que participei dessas romarias não era raro observar romeiros pagando suas promessas à santa padroeira do Brasil através de duras penas. Relembro que, por exemplo, sob o sol escaldante de certa tarde, transeuntes das mais diversas localidades brasileiras podiam observar uma senhora de cerca de 30 anos percorrendo de joelhos os 389 metros de comprimento da Passarela da Fé, a qual é uma ponte de concreto que liga a Basílica Velha à Nova, a fim de pagar sua promessa à

santa. Os motivos que levaram essa senhora a se impor tamanho tormento me são desconhecidos ainda hoje, porém, uma breve apreciação da sala de ex-votos da basílica de Nossa Senhora Aparecida revela que a grande maioria das promessas está vinculada à saúde e a doença.

Nos últimos anos, as igrejas neopentecostais tem feito uso intenso da televisão. Apoiados em discursos que realçam a autoridade da igreja, a importância da prosperidade e o caráter apocalíptico das mazelas da vida; imagens de templos lotados e tumultuados são veiculadas diariamente. Os testemunhos ganham destaque e, em alguns casos, são feitas reconstituições cinematográficas de experiências pessoais marcadas por desavença familiar, crise financeira e problemas de saúde. Dentre esses três tipos de problemas (familiares, financeiros e de saúde), os relatos sobre doença e cura divina ocupam grande espaço da programação dos canais de televisão neopentecostais, bem como as campanhas e shows para arrecadação de recursos financeiros para os mais diversos eventos dessas igrejas. Pessoalmente, creio que alguns episódios a que assisti poderiam ser classificados como tragicômicos. Destaco, em particular, um episódio em que a bispa Sônia Hernandez da igreja Renascer em Cristo bradava aos indivíduos que foram à sua igreja com problemas de saúde e que supostamente foram abençoados com a cura durante a realização do culto, que estava sendo televisionado, para que se dirigissem ao altar para dar seu testemunho. Atendendo a solicitação da bispa formou-se uma fila próxima ao altar, tamanho era o número de indivíduos "abençoados". Quando chegou sua vez, uma senhora obesa de cerca de 40 anos fez então seu relato que reproduzo de forma livre: "Eu vim à igreja sentindo fortes dores nas pernas, mal podia caminhar...mas, agora, agora já estou bem melhor!" A declaração dessa senhora não atendia, obviamente, as expectativas a respeito de cura divina da bispa Sônia, pois o discurso da fiel revelava apenas a diminuição de uma dor e não a cura definitiva da doença que a castigava, seja qual fosse. Não satisfeita com o que ouvira a bispa replicou: "Você está bem melhor ou curada? Pula aí que eu quero ver!". A senhora, então, saltitou modestamente umas três vezes seguidas com grande dificuldade e com um sorriso estampado no rosto constrangido acenava com a cabeça em concordância com a bispa que bradava: "Ela está curada! Vejam só!" e, ao mesmo tempo, direcionava a senhora de volta a seu assento e já se preparava para ouvir o próximo relato.

Em uma conversa informal com uma vizinha, ela confessou-me cabisbaixa que não mais freqüentaria a igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Segundo ela, a solução de seus problemas financeiros e amorosos indiretamente exigiam uma

contribuição em dinheiro à igreja nos dias em que costumava freqüentar os cultos. Na impossibilidade de fazer tais doações, dada as suas restrições financeiras, e a fim de se livrar da pressão do grupo ao qual pertencia, a jovem dizia que era melhor não mais comparecer aos cultos. Não é objetivo desta dissertação discutir o papel do dinheiro nas cerimônias neopentecostais, mas esse discurso nos permite fazer algumas suposições. De certa forma, o dinheiro é uma representação da fé desse grupo religioso e, portanto, figura em um cenário de troca. Doar, ofertar ou sacrificar seus bens materiais à Deus é uma prova de fé. Para aqueles que dão provas de sua fé, Deus supostamente os recompensaria com a prosperidade e com o resgate de uma existência decaída².

Esses exemplos dentre muitos outros que não cabem nesta dissertação, derivados de minha experiência pessoal, aguçaram minha curiosidade acadêmica porque são marcados por idéias de auto-flagelo e sacrifício de bens materiais. Essas idéias são, na minha opinião, contraditórias à contemporaneidade essencialmente capitalista e racional. Indaguei-me por diversas vezes o que poderia justificar a permanência desses atos no ambiente religioso. Os exemplos aqui citados respondem, de certa forma, à essa indagação. Nesses exemplos, fica clara a busca de soluções para problemas individuais corriqueiros e que podem afetar qualquer indivíduo em qualquer contexto histórico-cultural: os problemas de relacionamento (amoroso, profissional e familiar) ou convívio social, os problemas financeiros e os problemas de saúde. Deduzi, então, que muitos dos comportamentos que chamaram minha atenção estavam vinculados não só com a necessidade de definição de uma identidade grupal dos indivíduos religiosos, mas também com as crenças a respeito da superação desses problemas. Uma vez feita essa dedução, por uma escolha pessoal e guiado meramente pela preferência pelo assunto, decidi focar minha pesquisa nas questões relacionadas à saúde e esse fator por si só realça o caráter parcial e circunscrito desta dissertação que, apoiada especialmente nos pressupostos feministas, não almeja a universalidade. Esbarrei, então, na questão da metodologia a ser empregada para abordar esse assunto.

Galliano (1986) afirma que método científico é um instrumento usado pela ciência na sondagem da realidade, ou seja, é um instrumento formado por um conjunto de procedimentos, mediante os quais os problemas científicos são formulados e as hipóteses científicas são examinadas. Godoy (1995), por sua vez, afirma que nas

² Como não pretendo me estender nesse assunto recomendo aos interessados a leitura da dissertação de mestrado de Drance E. Silva (2000) a respeito da representação social do dinheiro entre os neopentecostais.

ciências sociais existem basicamente dois métodos de pesquisa, o método quantitativo e o qualitativo. O método quantitativo caracteriza-se pela formulação de hipóteses, pelo/a pesquisador/a, que serão verificadas por meio de testes estatísticos a fim de descobrir e classificar a relação entre duas ou mais variáveis (causalidade entre fenômenos). No método qualitativo, por sua vez, não há a preocupação com enumeração ou medição dos eventos estudados, nem com o emprego de instrumental estatístico para proceder à análise dos dados, pois não há necessariamente a busca de evidências numéricas que comprovem a hipótese. Dada as particularidades dessa pesquisa, apropriei-me das idéias relacionadas aos estudos comparativos causais, nos quais o/a pesquisador/a parte de efeitos observáveis e procura descobrir os antecedentes de tais efeitos. Assim, por exemplo, o auto-flagelo e o sacrifício de bens materiais figuram como as variáveis observáveis e a concepção religiosa das doenças é assumida como uma das fontes de tais comportamentos. É claro que estudos dessa natureza não são calcados em relações causais propriamente ditas, pois os comportamentos humanos estão sujeitos a uma série de variáveis que não podem ser manipuladas e submetidas a um controle rígido. A complexidade inerente aos fenômenos sociais, entretanto, não impede que estudos comparativos causais sejam empregados para identificar possíveis causas e possíveis estudos experimentais.

Embora o método qualitativo seja privilegiado nesta dissertação, não foram descartados dados quantitativos que auxiliassem na elucidação dos aspectos das religiões analisadas e nas conclusões a respeito das interpretações das doenças por essas religiões. É importante ressaltar desde já que este estudo não envolverá trabalho de campo. Limitar-se-á à revisão literária de livros e/ou artigos produzidos pelas religiões alvo deste estudo, textos científicos, artigos e demais meios de difusão escrita do conhecimento sobre essas religiões. Em suma, prevalecem os procedimentos teóricos e descritivos para conclusão deste trabalho e os resultados esperados são: a) oferecer meios para a compreensão de comportamentos humanos, motivados por questões religiosas, observáveis em nossa sociedade no que tange a busca de cura para males físicos; b) contribuir com material científico que motive discussões interdisciplinares, com as demais áreas do conhecimento das ciências sociais, tais como: psicologia; história; sociologia; economia dentre outras, sobre as implicações da noção de enfermidade propagada por religiões brasileiras.

O presente trabalho tem assim por intuito, de uma forma mais geral, apresentar e analisar as interpretações a respeito das doenças em religiões praticadas no território

brasileiro. A escolha dessas religiões foi pautada pelos dados censitários do ano de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela evidente função terapêutica ainda desempenhada por essas religiões. Foram selecionadas cinco religiões que aparecem de forma individualizada na rubrica das tabelas sintéticas sobre a distribuição por religião da população residente brasileira. No ano de 2000, os dados censitários mostravam que cerca de 74% da população brasileira se declarava Católica, 16% afirmavam ser Evangélicos, 1,3% diziam-se Espíritas e 0,3% estavam distribuídos entre a Umbanda e o Candomblé (religiões afro-brasileiras). Esse grupo, composto por cinco religiões, representavam em 2000 aproximadamente 91% da população brasileira. Portanto, o objeto desse estudo será averiguar quais as diferentes interpretações a respeito das enfermidades, sob o ponto de vista de cristãos (católicos e evangélicos), de espíritas e de praticantes das religiões afro-brasileiras (candomblé e umbanda). Os objetivos específicos fixados para esse estudo são:

- Proceder à revisão de literatura religiosa sobre enfermidade/cura e temas relacionados;
- Caracterizar e apresentar os diferentes pontos de vista a respeito das enfermidades de acordo com as diferentes doutrinas religiosas;
- Discorrer sobre conceitos chaves presentes nos discursos religiosos que estejam intimamente ligados a noção de doença/cura;
- Estudar a existência de traços comuns entre as religiões alvo do estudo no que tange a compreensão dos processos mórbidos.

Assim como a ciência evoluiu, em cada época da história o pensamento religioso também sofreu influências condicionadas por certa mentalidade. Cada período histórico fez emergir conceitos e crenças relacionadas à realidade vivenciada pela humanidade e a enfermidade sempre fez e fará parte dessa realidade. Embora a consciência de finitude e da fragilidade da vida humana façam parte do senso comum, deve-se reconhecer que ela se apresenta de modo mais direto àqueles que se sentem ameaçados em sua vida, seja por uma doença ou por qualquer outro perigo. A busca por um sentido dos mais diversos eventos da vida humana, é característica marcante das religiões. Assim, configuram-se como problemas de pesquisa desta empreitada intelectual: Quais são as interpretações, sob a ótica dos pensamentos cristãos (católico e evangélico), espíritas e

das religiões afro-brasileiras (Candomblé e Umbanda), a respeito da enfermidade e da superação das moléstias corporais? Qual ou quais aspectos são compartilhados entre os discursos das principais práticas religiosas brasileiras no início do século XXI no que tange as doenças? É possível que as interpretações religiosas sobre as doenças estejam relacionadas aos comportamentos de auto-flagelo e sacrifício de bens materiais?

É notório que a medicina moderna logrou elevado nível de sofisticação tecnológica, porém nossa sociedade é profundamente marcada pela busca de soluções mágicas para as doenças. A esperança de superação das moléstias do corpo e da alma leva multidões às portas dos terreiros de umbanda e dos centros espíritas kardecistas. O "dom da cura" é uma marca registrada nas seitas protestantes pentecostais e a esperança do milagre é traço característico do catolicismo popular, por exemplo. Mas afinal o que é doença? Qual o significado de adoecer para o ser humano? É necessário que o sentido de enfermidade seja compreendido, pois ela desempenha um papel sócio-cultural de grande relevância para o entendimento de uma sociedade e, sobretudo, de um indivíduo, uma vez que fomenta em maior ou menor medida esse ou aquele comportamento humano. Não obstante, ainda não foi encontrado um conceito de saúde/doença que não cause discordâncias no ambiente acadêmico.

É notório que os discursos religiosos vislumbram legitimamente as doenças como distúrbios comportamentais e orgânicos, tal como o saber médico dominante a concebe. Entretanto, ao incorporar tal definição o discurso religioso tem a capacidade de reinterpretá-la e operacionalizá-la de maneira própria. Nos primórdios do pensamento religioso, as enfermidades eram compreendidas como sendo o resultado da ação de seres sobrenaturais, ou seja, como castigo dos deuses e a manifestação da sua ira pela violação de mandamentos ou como punição do pecado. Outras explicações foram sendo dadas para as causas das doenças, até o atual estado de estruturação científica do conhecimento médico, mas em maior ou menor grau persiste em nossa sociedade remanescentes desta vinculação primordial entre doença e culpa. É por isso que se assumirá como hipótese deste trabalho que um possível traço em comum entre as religiões estudadas no que concerne a interpretação dos estados mórbidos é a permanência de idéias que incutem no próprio indivíduo a responsabilidade pelo mal que o acomete. Em outras palavras, dentre as múltiplas interpretações existentes, privilegia-se a noção de que a enfermidade é uma sanção para atos e condutas reprováveis, do ponto de vista religioso e social, praticadas por um indivíduo ou grupo de indivíduos. Portanto, para as religiões, a noção de enfermidade vai além da esfera

físico-biológica e atinge um plano moral que impele o indivíduo enfermo a buscar reequilíbrio orgânico, espiritual e social (não exatamente nessa ordem).

A dissertação foi dividida, no total, em três capítulos. No primeiro capítulo serão abordados: o conceito de doença, os modelos etiológicos e a concepção popular de doença, bem como a teoria das representações sociais. O segundo capítulo tratará de elucidar quais são as religiões alvo do estudo e para tanto serão utilizadas as informações estatísticas divulgada pelo IBGE acompanhadas de apreciações qualitativas desses números. O propósito do segundo capítulo é fornecer um quadro amplo do cenário religioso brasileiro e apresentar, brevemente, informações referentes às religiões analisadas: sua história, sua estrutura hierárquica, sua cosmovisão, suas principais práticas dentre outros detalhes que ajudem o/a leitor/a a compreender como o universo religioso brasileiro está configurado. Já no terceiro capítulo adotar-se-á uma definição de religião e, através de uma perspectiva histórica das funções terapêuticas religiosas, analisar-se-á a relação entre medicina e religião. Adicionalmente, no terceiro capítulo será apresentada uma síntese da análise de documentos produzidos pelas religiões alvo e de textos científicos produzidos a respeito dessas religiões com o propósito de identificar as diferentes interpretações das doenças. Encerrando esse último capítulo, será discutido "o consenso" religioso a respeito dos processos mórbidos.

CAPÍTULO I

ETIOLOGIA DAS DOENÇAS

INTRODUÇÃO

A conceituação de saúde/doença ainda é um assunto muito controverso. Na década de 50, a reflexão sobre o conceito de saúde foi motivada pela definição proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que de certa forma despertava a atenção para o espectro social da saúde. Segundo Parsons, citado por Luciana Dias (1995, p.12), "a saúde não pode ficar confinada ao nível exclusivamente físico ou orgânico, pois deve ser concebida de um modo capaz de abranger tanto o orgânico como o social". As condições sociais são, dessa forma, apontadas como importantes fatores na determinação da saúde de uma população e, as reformas sociais e políticas passam a ser alternativas para a melhoria da saúde do povo. No final da década de 60 é lançada na França a primeira edição do livro *O Normal e o Patológico*, originalmente a tese de doutoramento de Georges Canguilhem. Para esse autor, ainda sendo citado por Luciana Dias (1995, p.13), "o ser humano só concorda que está com saúde, quando se sente mais do que normal, isto é, não apenas adaptado ao meio e às suas exigências, mas também normativo, capaz de seguir normas de vida"; em outras palavras, Canguilhem destacava a dimensão política, social e econômica da saúde. Seguindo a mesma linha de pensamento e no mesmo período de publicação do livro de Canguilhem, autores brasileiros também escreviam a respeito da possibilidade da medicina oferecer soluções econômicas e sociais para as doenças e não apenas proteger e promover a saúde.

Essa tendência de destacar o caráter social dos processos de debilidade física serve apenas como exemplo de um processo maior que busca uma definição cada vez mais abrangente para o termo saúde, ou seja, busca-se ressaltar a importância de compreensão da saúde enquanto processo dinâmico determinado por uma interação de múltiplos fatores, inseridos em relações que perpassam a esfera da individualidade, a social, a religiosa, a ambiental dentre outras. Ciente da importância dessas considerações, o primeiro tópico do capítulo I irá tratar justamente da questão da definição dos termos saúde/doença, normal/anormal a fim de mostrar que "cada qual opera com o conhecimento e o entendimento que possui em qualquer período histórico, por mais estreito que esse entendimento possa ser" (RYAN, Penélope; 1999; p.167) e

que tais definições estão impregnadas por julgamentos de valor que não deveriam ser assumidos como a expressão máxima do saber.

E notório que para a maioria dos indivíduos, a concepção de doença não é relevante. Para esses indivíduos, o que é importante é a compreensão da origem das doenças, sua etiologia. Os estudos realizados por François Laplantine mostram que as sociedades, independente do contexto histórico-cultural, tendem a criar modelos de interpretação das enfermidades. Esses modelos além de fornecer explicações quanto às causas das doenças, norteiam as práticas terapêuticas e as ações dos indivíduos ante as doenças e os doentes. Dada a complexidade dos fenômenos sociais, é possível supor de imediato que não existe uma hierarquização entre diferentes modelos interpretativos e que tampouco a predominância de um modelo qualquer, em determinada época histórica, implique no completo abandono dos demais. Na realidade, não há a adoção de um modelo etiológico único e as diferentes proposições se mesclam e se complementam.

Em seu livro *Antropologia da Doença* (1991), François Laplantine, destaca os seguintes pares de modelos etiológicos: ontológico/funcional; exógeno/endógeno; aditivo/subtrativo e, finalmente, maléfico/benéfico. Esses modelos são apresentados aos pares porque para cada tipo de idéia a respeito da causa das doenças há outra que se lhe opõe de forma direta. Assim, por exemplo, um indivíduo poderá vivenciar uma doença como algo maléfico ou destrutivo se a interrupção de suas funções sociais, provocada pela doença, comprometer laços afetivos com outros indivíduos e/ou trazer perdas irreparáveis para uma carreira profissional. Outro indivíduo poderia vivenciar a mesma doença como libertadora, algo benéfico, se ao contrário a doença configurar uma possibilidade de fuga de um papel social repressor de sua individualidade. O segundo tópico do capítulo I apresentará todos esses modelos de forma mais detalhada com o propósito de mostrar que as doenças podem ser interpretadas de maneiras específicas por diferentes sociedades e que essas interpretações servem de suporte à expressão de crenças e valores morais mais amplos.

As interpretações populares das doenças refletem as regras e o saber de uma sociedade e a interpretação que grupos coletivos fazem de ambos revelam, muitas vezes, noções de saúde e doença independentes dos saberes dominantes. O terceiro tópico do capítulo I tratará, então, das concepções populares da doença a fim de demonstrar que a distância entre o pensamento popular e o erudito é menor do que geralmente supomos. É óbvio que o discurso popular não é uma cópia, mais ou menos exata, do discurso

médico, ou seja, não é pautado pela enumeração de sintomas e de fenômenos orgânicos. Isso porque as disfunções orgânicas e os sintomas das doenças ganham sentido à medida em que provocam alterações na vida da pessoa doente e de sua identidade social.

No final da década de 60, Claudine Herzlich³ abordou essa questão da análise das representações sociais da saúde e da doença da classe média e alta da sociedade francesa. O objetivo do estudo de Herzlich era constatar:

através de quais noções e quais valores os membros [de uma sociedade] dão forma e sentido às suas experiências orgânicas individuais e compreender como, nessas bases, se elabora uma realidade social compartilhada coletivamente (ADAM & HERZLICH, 2001, p. 77).

O estudo surpreendentemente mostrou que a linguagem utilizada para exprimir-se a respeito da saúde/doença, suas causas e manifestações, não era uma linguagem do corpo, mas uma linguagem que abordava as relações do indivíduo com a sociedade. A teoria causal elaborada pelos indivíduos enxergava a doença como proveniente de uma relação conflituosa com o social que implicava, invariavelmente, em uma interrupção do desempenho de funções sociais. Em outras palavras, a saúde não aparece como uma situação puramente orgânica ou a simples ausência de doença, mas sim como algo natural, que indiretamente denota equilíbrio com o ambiente social e religioso. Essa noção de equilíbrio aparece também nas análises de Canguilhem, para quem a saúde é um conceito normativo que ultrapassa o simples estado orgânico.

O trabalho de Maria Cecília S. Minayo foi buscar essas mesmas informações junto a população pobre de uma favela do Rio de Janeiro quase 20 anos depois da publicação da edição francesa do livro de Herzlich. Embora o ambiente e a época desses dois trabalhos seja bastante distinto, as análises de Minayo reforçam que o sentido da experiência do doente e seu comportamento continuam sendo pautadas pelas noções de equilíbrio e inter-relacionamento, as quais exprimem as relações da pessoa com seu meio social. Ambos os trabalhos, o de Minayo e o de Herzlich, inserem-se em uma perspectiva que aceita a existência de um pensamento "profano" sobre saúde e doença, ou seja, independente do saber profissional (dos médicos), expresso por membros de diferentes grupos sociais. Em geral esses estudos mostram, de acordo com Rory Willians citado por Adam & Herzlich (2001, p. 80), que ao descrever e explicar suas

³ Ver Herzlich, C. *Santé et maladie, analyse d'une représentation sociale*. Paris: Mouton, 1969.

moléstias os indivíduos apóiam-se em visões de mundo subjacentes, quanto ao caráter produtor ou destruidor da saúde de seu ambiente social. As interpretações das doenças ganham, nesses discursos, um caráter pluridimensional: natural, sobrenatural, sócio-econômico e psicológico que contraria o modelo biomédico vigente, que tende a colocar em evidência as causas naturais das doenças.

Em síntese, para interpretar os fenômenos orgânicos, as pessoas recorrem a conceitos, símbolos e estruturas de referências interiorizadas conforme os grupos sociais e culturais a que pertençam. Essa afirmação está alicerçada na teoria das Representações Sociais elaborada por Serger Moscovici (1961) e Denise Jodelet (1989), que será discutida no quarto e último tópico do capítulo I. Os trabalhos de Moscovici e Jodelet nos ajudam a compreender, por exemplo, como em certos casos os conjuntos de sentidos sobre as doenças, formados pelo imaginário coletivo, podem adquirir força e impor-se às pessoas afetadas. Para ilustrar a situação, basta lembrar que ainda hoje os grupos de conscientização e defesa de gays e lésbicas lutam para desmitificar a noção de que o vírus da AIDS guarda relação apenas com esse contingente populacional.

A teoria das Representações Sociais investiga como se formam e como funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade. Segundo essa teoria, o coletivo interfere na elaboração psicológica (representação de um dado objeto, tema) e, por sua vez, essa mesma representação irá influenciar as relações sociais. Em outras palavras, as representações sociais orientam condutas e práticas sociais, além de guardar relação com a linguagem, a ideologia e o imaginário social.

Sob a baliza dessa teoria, a afirmação de Canguilhem de que é a apreciação dos doentes e das idéias dominantes no meio social que determinam o conceito de doença faz todo o sentido. Porém, é importante mencionar que "não se deve enxergar nas representações da doença (...) a simples assunção, por parte dos indivíduos, de um discurso coletivo; eles não são somente suportes de representações perfeitamente coerentes e constituídas fora deles" (ADAM & HERZLICH, 2001, p.82). Esses autores, sabiamente, alertam para o fato de que as elaborações a respeito das doenças não apóiam-se exclusivamente em recursos coletivos, mas também estão sujeitas a reinterpretções orientadas pelas experiências individuais e pelo contexto sociocultural onde se efetua esse processo interpretativo. Os estudos de Jodelet provaram que o trabalho interpretativo depende do sistema de relações que ele ajuda a produzir ao mesmo tempo em que se torna sua expressão. Assim, por exemplo, a coexistência de

indivíduos saudáveis com enfermos processa-se mediante a delimitação de fronteiras materiais e simbólicas que deixem essa diferenciação mais evidente. As práticas utilizadas para manter essa diferenciação serão alavancadas pelas crenças que se tem a respeito da doença e, ao longo do anos, as crenças justificam as práticas e as práticas, por sua vez, fomentam as crenças em um círculo vicioso.

I.1. O QUE É DOENÇA, AFINAL?

Georges Canguilhem (2000, p. 93) afirma que “mais do que a opinião dos médicos, é a apreciação dos pacientes e das idéias dominantes no meio social que determina o que se chama doença”. Essa afirmação ressalta o fato de que o termo doença possui muitas definições, porém, independentemente de todos os significados dados ao termo, é notório que todos essas definições são marcadas por um julgamento de valor. Assim sendo, saúde e doença são mais que fatos objetivos, pois são comandadas por julgamentos de valor e não existe valor sem referência, implícita ou explícita, ao social. Estar doente, nesta perspectiva, é um conceito geral de não-valor que compreende todos os valores negativos possíveis, enquanto, que a saúde é o protótipo de todo valor. Em linhas gerais, reproduzindo as palavras de François Laplantine:

Estar doente, estar bem de saúde são noções que transbordam de significações (econômicas, políticas, morais, religiosas, existenciais), mas toda sociedade opta por uma certa idéia da normalidade que é necessariamente acompanhada por uma capacidade normativa e, para alguns, a normalização dos comportamentos (LAPLANTINE, François: 1991, p. 102).

Não obstante, a ciência médica não consiste em especular sobre o conceito das doenças; pois a tarefa que lhe cabe é determinar quais são os fenômenos vitais durante os quais os seres humanos se dizem doentes, suas causas e sua evolução. Apesar do aparente desaparecimento do julgamento de valor nos conceitos empíricos, não se deve esquecer que a atividade médica tem como objeto o doente e seus julgamentos de valor. A dificuldade na determinação médica do normal e da saúde reside no fato dos médicos não se preocuparem com o sentido de conceitos que pareçam excessivamente vulgares ou excessivamente metafísicos, tais como “saúde” e “doença”.

O que interessa aos médicos é diagnosticar e curar. Teoricamente, curar é fazer voltar à norma uma função ou um organismo que dela se tinham afastado. O médico geralmente tira a norma de seus conhecimentos, de sua experiência profissional e da representação comum da norma num meio social em dado momento. É norma, no sentido mais usual da palavra, aquilo que é como deve ser ou o que se encontra na maior parte dos casos de uma determinada espécie ou que constitui a média ou o módulo de uma característica mensurável. Esse conceito, entretanto, é equivocado, pois designa ao mesmo tempo “um fato e um valor atribuído a esse fato por aquele que fala, em virtude de um julgamento de apreciação que ele adota” (CANGUILHEM, Georges: 2000, p.95). Em medicina, esse equívoco permitiu que o estado normal designasse tanto o estado habitual de um órgão quanto seu estado ideal. O estado normal do corpo é o que o médico procura restabelecer, mas será que se deve considerá-lo como normal porque é visado como fim da atividade médica ou é visado porque é considerado como normal pelo maior interessado, o doente? Canguilhem responde a essa pergunta da seguinte maneira:

É a vida em si mesma, e não a apreciação médica, que faz do normal biológico um conceito de valor e não um conceito de realidade estatística. Para o médico, a vida não é um objeto, é uma atividade polarizada, cujo esforço espontâneo de defesa e de luta contra tudo que é valor negativo é prolongado pela medicina, que lhe traz o esclarecimento da ciência humana, relativo, mas indispensável (CANGUILHEM, Georges: 2000, p.100).

Desta forma, o fato de um ser humano reagir a uma doença traduz um fato fundamental: a vida não é indiferente às condições nas quais ela é possível, a vida é polaridade e por isso é também posição inconsciente de valor, ou seja, a vida é uma atividade normativa. Por atividade normativa entende-se qualquer julgamento, que aprecie ou qualifique um fato em relação a uma norma, cuja forma está subordinada àquele que institui as normas.

Com bases nas considerações feitas até aqui, seria então correto assumir que o conceito de anormal equivale ao estado enfermo? Recorremos outra vez as considerações que Canguilhem faz a respeito de dois termos: a anomalia e o anormal; para obtermos uma resposta a essa pergunta.

Anomalia vem do grego *anomalía* que significa desigualdade, aspereza; *omalos* designa, em grego, o que é uniforme, regular, liso; de modo que anomalia é, etimologicamente, *an-omalos*, o que é desigual, rugoso, irregular. Ora, freqüentemente houve enganos a respeito da etimologia desse termo,

derivando-o não de *omalos*, mas de *nomos* que significa lei, segundo a composição *a-nomos*. (...) Assim, com todo o rigor semântico, anomalia designa um fato, é um termo descritivo, ao passo que anormal implica em referência a um valor, é um termo apreciativo, normativo. Mas a troca de processos gramaticais acarretou uma colusão dos sentidos respectivos de anomalia e anormal (CANGUILHEM, Georges: 2000, p.101).

Fisiologicamente, a anomalia é consequência de uma variação individual que impede dois seres de poderem se substituir um ao outro de modo completo. No entanto, diversidade não é doença.

O anormal não é patológico, a despeito da confusão gramatical apontada pelo autor. Poderíamos inclusive encontrar argumentos para definir o patológico como normal, visto que uma saúde continuamente perfeita é um fato anormal, pois a doença faz parte da experiência dos seres vivos. Nesse sentido abusivo, é evidente que o patológico não é anormal, porém, a doença continua a ser um estado contra o qual se deve lutar para continuar a viver, isto é, ela deve ser prevista como um estado anormal em relação à persistência da vida.

Patológico implica em *pathos*, ou seja, sentimento direto e concreto de sofrimento e de impotência. Assim sendo, o patológico é realmente o anormal. Porém, o uso recente e incorreto faz do anormal o adjetivo de anomalia e, por conseguinte, tende-se a confundir a anomalia com doença. Assim quando se fala em anomalias, não se pensa na simples variedade como um desvio estatístico, mas sim nas deformidades nocivas e incompatíveis com a vida. Somente quando a anomalia é interpretada quanto a seus efeitos em relação à atividade do indivíduo e, portanto, de sua auto-imagem de valor e de seu destino, é que a anomalia pode ser convertida em enfermidade.

As pessoas nascem ou se tornam enfermas. É próprio da doença vir a interromper o curso de algo. Pode haver para o enfermo uma atividade possível e um papel social condigno, no entanto, a limitação forçada de um ser humano a uma condição única e invariável contraria a referência ao ideal humano normal que é a adaptação possível e voluntária a todas as condições imagináveis. É o abuso potencial da saúde que concede valor a noção de saúde. Saúde aqui concebida no sentido normativo que define o tipo ideal de estrutura e de comportamentos orgânicos, haja vista que a saúde adjetivada (por exemplo, boa saúde) é um pleonasmo que define um conceito descritivo de certa disposição e reação de um organismo em relação às possíveis doenças. A distinção entre os dois conceitos, normativo absoluto (saúde) e

descritivo qualificado (boa saúde), faz-se necessária porque um equivale à presença de um fato e o outro de um valor, respectivamente.

De acordo com Canguilhem (2000) ao se distinguir a anomalia do estado patológico, a variedade biológica do valor negativo, podemos atribuir, em suma, ao próprio indivíduo a responsabilidade de distinguir o ponto em que começa a doença. Essa afirmação é importante porque padrões biológicos médios estatísticos (por exemplo, número médio de batimentos cardíacos) não permitem que se afirme que um determinado indivíduo é normal ou não. Assim sendo, não podemos nos limitar “a estabelecer a comparação com uma norma resultante da média, e sim, na medida do possível, com as condições do próprio indivíduo” (SINGERIST *apud* CANGUILHEM, Georges: 2000, p. 145).

Uma vez que o normal não possui a rigidez de um determinativo para todos os indivíduos da mesma espécie e sim uma flexibilidade de uma norma que se transforma em relação com condições individuais, pode-se afirmar que o limite entre normal e patológico torna-se bastante impreciso. Essa fronteira entre o normal e o patológico será imprecisa se compararmos diversos indivíduos simultaneamente, mas é, ao contrário, perfeitamente precisa para um único e mesmo indivíduo considerado sucessivamente. Assim sendo, aquilo que é normal em determinadas condições pode se tornar patológico em outra situação se permanecer inalterado. Cabe ao próprio indivíduo avaliar essas transformações, pois é ele que sofre as consequências da incapacidade de realizar as tarefas que a nova situação lhe impõe.

Uma norma de vida é superior a outra quando inclui o que a primeira permitia e o que não permitia. Em situações diferentes há normas diferentes, mas ao mesmo tempo equivalentes. Assim sendo, todas as normas são normais. Isso não quer dizer, porém, que o estado patológico ou anormal seja consequência da ausência de qualquer norma. A doença é ainda uma norma da vida, embora seja uma norma inferior, pois “não tolera nenhum desvio das condições em que é válida, por ser incapaz de se transformar em outra norma” (CANGUILHEM, Georges: 2000, p. 146). Isso quer dizer que o indivíduo enfermo está normalizado em condições bem definidas em decorrência de não poder exercer pleno exercício de sua capacidade normativa, ou seja, instituir normas diferentes em situações diferentes. Em suma:

Os sintomas patológicos são a expressão do fato das relações do organismo e meio, que correspondem à norma, terem sido transformadas pela transformação do organismo, e pelo fato de muitas coisas, que eram normais

para o organismo normal, não o serem mais, para o organismo modificado (CANGUILHEM, Georges: 2000, p. 148).

Sendo a doença a ameaça à existência de vida, a definição de doença exige como ponto de partida o indivíduo. A doença surge quando o organismo é modificado de tal forma que chega a causar reações funcionais negativas na interação com o meio que lhe é próprio. A fim de se adaptar as novas normas de vida o doente, geralmente, passa a reduzir o seu nível de atividade para prevenir maiores reações negativas. Portanto, o doente é doente por só poder admitir uma norma, não pela ausência de normas, mas pela incapacidade de ser normativo. A doença passa a ser, então, não uma variação da dimensão da saúde, mas sim uma nova dimensão da vida.

Assumindo-se que a doença é uma espécie de norma biológica, conseqüentemente, o estado patológico não pode ser chamado de anormal no sentido absoluto, mas anormal apenas na relação com determinada situação. Da mesma forma, ser sadio e ser normal não são conceitos mútua e exclusivamente equivalentes, já que o patológico é de alguma forma normal conforme exposto em parágrafos anteriores. Ser sadio significa, assim, ser normal e normativo (capaz de instituir normas) em uma determinada situação e em outras situações eventuais. Assim sendo, “o que caracteriza a saúde é a possibilidade de ultrapassar a norma que define o normal momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de instituir normas em situações novas” (CANGUILHEM, Georges: 2000, p. 158). A saúde é, desta maneira, uma margem de tolerância às mudanças do meio. Essas considerações quanto à influência e interações com o meio podem remeter às idéias deterministas, porém, de fato, se distanciam dessa concepção ao privilegiar a capacidade normativa do ser humano. Adicionalmente, “mudança do meio” pode soar de certa maneira uma incoerência, ou seja, é admissível do ponto de vista social (por exemplo, instituições, modas e costumes são de fato efêmeros), porém, é um absurdo em se tratando de meio cósmico, no qual sistemas de leis e princípios físicos, mecânicos, químicos, biológicos lhe concedem determinada constância, invariabilidade. É claro que esse meio definido pela ciência é regido por leis e princípios, mas temos que lembrar que essas leis são meras abstrações teóricas. O ser humano não vive de abstrações teóricas, mas entre seres e acontecimentos que diversificam essas leis e que o impelem a situações de risco potencial à sua saúde. Assim sendo, o ser humano reconhece as categorias saúde e doença no plano da experiência e não no plano da ciência. A ciência é capaz de explicar essa experiência, mas não a anula.

A saúde é assim um conjunto de segurança e seguros para enfrentar as mudanças do meio. Estar em boa saúde é poder ficar doente e se recuperar e, a característica da doença é a redução dessa margem de tolerância às mudanças do meio. Essa redução implica no fato de viver em meios diferentes e não em alguns lugares do meio antigo. Isso se traduz na preocupação popular quanto às doenças que podem advir após se contrair uma primeira doença, ou seja, observa-se uma preocupação com a precipitação de doenças mais do que com uma complicação da primeira, pois cada doença reduz o poder do indivíduo de enfrentar outras.

Em linha com as idéias discutidas até aqui, pode-se afirmar que um indivíduo sente-se em boa saúde quando, além de estar adaptado ao meio e às suas exigências, é capaz de seguir novas normas de vidas. Por um lado, essa afirmação, no âmbito médico, permite encarar as doenças como crimes, uma vez que os interessados são, de certa forma, responsáveis pela enfermidade que lhes acomete. Por outro lado, é notório que a possibilidade de abusar da saúde faz parte da saúde. Em outras palavras, a saúde concede garantias que tornam normal o ato de abusar, haja vista que a vida humana não se limita à vida vegetativa. O ser humano, mesmo sob o aspecto físico, não se limita a seu organismo. O corpo é apenas um meio de todos os meios de ações possíveis e, portanto, para se julgar o normal e o patológico, devemos olhar para além do corpo.

1.2. MODELOS ETIOLÓGICOS DA DOENÇA

Até muito recentemente (início do século XIX), a prática médica esteve estritamente ligada à cultura e à época na qual se inscrevia, jamais chegando a se livrar da superstição religiosa (particularmente antes de Hipócrates) e da especulação filosófica. Houve, porém, uma ruptura ao longo da qual a medicina emancipar-se-ia como uma ciência objetiva com relação ao social. Tendo isso em mente, os próximos tópicos tratarão, dentro de uma ótica etiológica, da evolução do pensamento médico e dos modelos etiológicos que marcaram todo esse processo.

François Laplantine (1991, p. 37) afirma que “toda sociedade, toda época é obcecada pelo que considera causa por excelência da doença”. Os grupos humanos tendem a criar modelos para explicar o surgimento da doença. Esses modelos são construções teóricas de caráter operatório, ou seja, representam um conjunto de hipóteses de pesquisa que não podem substituir a realidade empírica, uma vez que têm por objetivo precisamente pensar esta última e pôr em evidência o que ela não diz. Os

modelos etiológicos são fortemente influenciados pelos padrões culturais vigentes, assim sendo, em toda cultura, em determinado momento, privilegia-se um certo número de representações (dominantes) em detrimento de outras representações, que nem por isso estão ausentes, mas apenas marginalizadas em relação às representações dominantes. Nada impede, entretanto, que os modelos possam coexistir dentro de uma mesma sociedade em um dado período e, em alguns casos, uma determinada representação pode inclusive ser eliminada definitivamente (ou momentaneamente) do campo social.

Laplantine identifica os seguintes modelos etiológicos: modelo ontológico e relacional, modelo exógeno e endógeno, modelo aditivo e subtrativo e, por fim, modelo maléfico e benéfico. Esses modelos serão apresentados brevemente a seguir. Vale ressaltar que, segundo definição do referido autor:

Um modelo etiológico é uma matriz que consiste em uma certa combinação de relações de sentido e que comanda, com mais frequência à revelia dos autores sociais, soluções originais, distintas e irredutíveis, para responder ao problema da doença (LAPLANTINE, François: 1991, p. 39).

Assim sendo, os diferentes modelos de representações da doença devem ser constantemente comparados uns com relação aos outros e não serem avaliados a partir de um dentre os demais, pois não existe supremacia hierárquica de um modelo com relação a outro.

1.2.1. MODELO ONTOLÓGICO E MODELO RELACIONAL

Modelo Ontológico

O modelo ontológico baseia-se no princípio de que existe um “ser da doença”, cujo arcabouço teórico é encontrado nos primórdios da medicina hipocrática em sua tentativa de ruptura com o pensamento especulativo e sua atenção aos sintomas corporais do doente. Essa idéia é reforçada pela visão dualista cartesiana que separa corpo e alma, pelo desenvolvimento da anatomia e pelas descobertas microbiológicas de Pasteur. Adicionalmente, essa idéia de um “ser da doença” encontra uma formulação sistemática com base nas seguintes abordagens:

a) Medicina das Espécies (Essencialismo)

Durante o século XVII e XVIII, em decorrência do desenvolvimento dos Estados Nacionais, surgiu a necessidade de conhecer a população de um território, contá-la era então imperativo. Esta contagem era uma condição para a verificação da grandeza nacional, que dependia da quantidade de riqueza circulante e do tamanho dos exércitos. Contar o povo significava, também, contar os mortos e saber a razão dessas mortes. Desta forma, surgiram os primeiros impulsos classificatórios das doenças. A primeira inspiração para essa classificação foi a botânica. Esse modelo fundamentou-se na localização das propriedades essenciais das doenças que podiam ser catalogadas ou divididas em famílias, gêneros, espécies e subespécies à maneira das classificações botânicas.

b) Medicina das Lesões (Anatomismo)

As preocupações dessa abordagem não estão mais centradas nas entidades, formas ou variedades mórbidas, mas sim nos danos orgânicos. Os fundamentos dessa abordagem foram propiciados por Giovanni Battista Morgani na obra *Adversia Anatomica* (1719). Os trabalhos de Morgani relacionaram em bases experimentais os sintomas clínicos com as lesões orgânicas, mostrando que cada alteração funcional, que se traduz nos sintomas da doença, possui uma correspondente alteração orgânica. Todo o pensamento médico do século XIX será animado por essa procura da localização da doença, a qual se torna possível graças aos avanços decorrente da observação de cadáveres, norteadas pela idéia de que não existe um único sintoma clínico que não seja acompanhado de uma lesão, a qual poderia ser identificada através da dissecação dos corpos.

c) Medicina das Especificidades

Essa abordagem surge em decorrência das duas abordagens apresentadas acima e seu fundamento é que o “ser da doença”, provocando lesões e traduzindo-se em sintomas, tem sempre uma causa precisa. Essa abordagem encontra seu apoio nas grandes descobertas da bacteriologia, no aperfeiçoamento do microscópio em combinação com o desenvolvimento de técnicas laboratoriais que possibilitaram a

comprovação fotográfica da teoria microbiana. Segundo Sevalho (1993) a causa microscópica da doença representa, também, uma conformação à visão de mundo estabelecida pela física Newtoniana na qual tudo se originava de partículas cada vez menores, tais como moléculas e átomos. Essa representação apreende a doença segundo as categorias de entrada (restituir o que foi perdido) e saída (extrair o que entrou), ou seja, combater o que se considera uma entidade inimiga e estranha ao organismo.

Embora essas abordagens apresentem diferenças notáveis quanto à ênfase a um determinado aspecto particular da doença, a interpretação ontológica oferece duas vantagens incontestáveis no que tange a compreensão e aceitação da doença pelo enfermo. Primeiro, as doenças são isoláveis, assim sendo, é possível determinar o local exato (órgão do corpo humano) em que o mal se concentra e a cirurgia, desta forma, pode reparar esse mal. A medicina se torna objetiva e prática na medida que identifica o adversário, enfrenta-o e pode fazê-lo se retirar. Segundo, as representações localizadoras acalmam, pois é tranquilizante para um indivíduo enfermo saber que o que não funciona é um de seus órgãos e não o próprio indivíduo como um todo. Quando o doente imagina que a doença não guarda relação com sua pessoa, ocorre uma transferência da culpa pelo estado de debilidade, mesmo que inconscientemente, e isso lhe serve de consolo.

Modelo Relacional (ou Funcional)

O modelo relacional ou funcional se opõe ao modelo ontológico na medida em que abandona a noção de um “ser da doença” (alguma coisa em algum lugar do corpo). O patológico nesse modelo é considerado desarmonia, desequilíbrio, desarranjo (por excesso ou falta), ou seja, a doença não é vista como uma entidade inimiga estranha ao doente (germe, vírus, possessão demoníaca, etc.). A noção de desarmonia ou desequilíbrio só faz sentido quando definimos a contraparte da relação, desta forma, em decorrência de diferentes interpretações, esse modelo apresenta três variantes:

a) O indivíduo e si mesmo

A noção de doença como ruptura do equilíbrio entre o indivíduo e si mesmo encontra suas bases na “medicina humoral”. A “medicina humoral”, de Hipócrates,

compreende os sintomas da doença menos como um efeito de um agente estranho e externo ao doente do que como variações de um dos quatro “humores” humanos, a saber: o sangue, a fleuma, a bÍlis amarela e a bÍlis negra. Sob essa Ótica, a saúde era vista como a justa proporção desses componentes no corpo e, a doença como o desequilÍbrio em decorrência do excesso ou da falta de um deles.

Embora no sÉculo XVI a tendÉncia da medicina ocidental É decididamente anatÔmica, somente no fim do sÉculo XVIII a medicina oficial passa a optar por uma interpretaçÓo mais fisiolÓgica no que tange as doenÇas. A partir desse perÍodo, considera-se menos um agente patogênico para a causa das doenÇas e mais o esforço do organismo para reagir a esse agente. A atençÓo É desviada dos Órgãos para as funçÓes desse mesmo Órgão, orientando assim a medicina oficial na direçÓo da idÉia de que “a doenÇa É a prÓpria funçÓo fisiolÓgica, mas a funçÓo desviada” (LAPLANTINE, François: 1991, p.56). Dito de outra maneira, a doenÇa resulta de uma disfunçÓo, por exagero ou atenuaçÓo, do funcionamento normal do organismo e, desta forma, doenÇa e saúde deixam de ser duas qualidades diferentes em constante oposiçÓo e passam a ser compreendidas como “simples modificaçÓes fisiolÓgicas” (BERNARD *apud* LAPLANTINE, François: 1991, p.57), ou seja, sÓo no dito popular faces da mesma moeda.

b) O indivÍduo e o cosmos

A doenÇa, nessa vertente, É considerada como efeito de uma desarmonia entre o microcosmo e a natureza do macrocosmo e o reequilÍbrio cÓsmico requer a intervençÓo direta dos elementos naturais ou É obtido por meio deles. As idÉias dessa vertente encontram seu fundamento nas obras de Paracelso (1493-1541) que buscou explicar e dividir as doenÇas com base nas seguintes causas: *ens astrorum* (influÊncia cÓsmica que varia de acordo com clima e localidade geogrÁfica); *ens veneni* (substÂncia tÓxica proveniente dos alimentos a qual É assumida como a causa das doenÇas contagiosas); *ens naturale et spirituale* (deficiÊncia constitucional fÍsica ou mental) e; *ens deale* (uma afliçÓo enviada pela providÊncia divina). Paracelso acreditava que na natureza havia substÂncias com dois tipos de influÊncia para a saúde humana: uma benÉfica (*essentia*) e outra prejudicial (*venena*) e que tais substÂncias podiam ser separadas por meio da alquimia e aplicadas no tratamento das doenÇas.

Entretanto, o advento do método experimental em fisiologia e as descobertas pasteurianas impuseram em nossa sociedade a visão ontológica. Assim, as interpretações calcadas nos pressupostos de Paracelso acabaram sendo totalmente abandonadas pela prática médica.

c) O indivíduo e seu meio social

Ao passar de uma interpretação ontológica para uma interpretação relacional da doença, compreendemos que o estado enfermo vai além do corpo que sofre e abrange a pessoa do doente. Segundo a época e a sociedade em questão, essa interpretação apresenta duas diferentes formulações. A primeira formulação é a religiosa, na qual:

A doença é, ao mesmo tempo, uma advertência que faz supor uma infração (voluntária ou involuntária) cometida, um apelo à ordem que exige uma reparação, uma injunção para que se restaurem as relações da comunidade com ela mesma, já que foi posta em perigo pela doença de um só de seus elementos (LAPLANTINE, François: 1991, p.63).

Esse tipo de interpretação era mais comum em comunidades primitivas, nas quais o sacrifício era a oferta da sociedade para reencontrar e fortalecer seu eixo de equilíbrio. Vale ressaltar que a cura do indivíduo não era o principal intento das práticas religiosas envolvendo sacrifícios, mas sim a restauração do equilíbrio das relações entre as pessoas e as divindades cultuadas.

A segunda formulação, dentro desse sistema de interpretação, é a mágica (ou feitiçaria). Essa formulação envolve a noção de sortilégios que podem ser lançados e devolvidos ao expedidor. Desta forma, a doença remete ao doente, mas se situa no exterior dele.

Percebe-se nessas formulações um processo de reificação do social, assim, quando a família, a sociedade, os ancestrais ou os sortilégios são incorporados à noção de doença, esta “não mais aparece como pertencente à ordem da alteração, mas da alteridade⁴; não mais como pertencendo à ordem da variação quantitativa, mas da invasão, da agressão (ou da escolha), ou seja, da diferença qualitativa” (LAPLANTINE,

⁴ Alteridade (ou outriedade) é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo o homem social interage e interdepende de outros indivíduos. Assim, como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a existência do “eu-individual” só é permitida mediante um contato com o outro (que em uma visão expandida se torna o Outro - a própria sociedade diferente do indivíduo).

François: 1991, p. 65). Essa observação nos leva a mudar nossa leitura do pensamento etiológico, não devemos mais considerá-lo sob a luz do relacional em oposição ao ontológico, mas sob a luz do exógeno em oposição ao endógeno.

I.2.2. MODELO EXÓGENO E MODELO ENDÓGENO

Modelo Exógeno

As representações no modelo exógeno assumem a intervenção exterior (micróbios, vírus, modo de vida etc.) como principal causa das doenças. Assim sendo, a doença é um elemento estranho ao doente que, proveniente do exterior, vem lhe assolar. Nesse modelo, a doença pode ter sua origem em: a) um agente externo antropomorfizado de má vontade (feiticeiro, espírito, diabo, deus etc.) ou; b) um agente externo nocivo natural proveniente do meio físico, químico e bioquímico.

O pensamento médico ocidental moderno e contemporâneo, tanto erudito quanto popular, apresenta duas direções de interpretação de causalidade das doenças segundo o modelo exógeno: uma química e outra social. O advento da microbiologia permitiu que surgisse uma interpretação da doença focada no impacto de agente invisíveis externos ao organismo sadio. Micróbios e vírus tornam a doença precisa e isolável. Observa-se nessas interpretações que a noção de uma causalidade externa é reforçada por uma representação ontológica, pois essa idéia, como dito anteriormente, tranqüiliza e satisfaz a idéia de que “eu não me encontro na origem de minha doença (...), quem está doente é um de meus órgãos, acidentalmente afetado por minúsculos seres vindos do meu exterior” (CANGUILHEM, Georges: 1991, p. 70). A interpretação de cunho social, por sua vez, atribui a origem de um número muito grande de doenças tanto ao meio social quanto aos hábitos humanos (ou modo de vida). Assim, a doença pode estar vinculada à educação, às más condições de moradia, ao desemprego, à duração da jornada de trabalho, aos hábitos alimentares, à fadiga, à poluição, ao ruído etc. Este tipo de interpretação privilegia a alimentação natural, a vida no campo, o contato com a natureza em contraposição à tudo aquilo que guarda relação com a vida moderna (particularmente, a vida urbana), a qual é tida como patogênica por excelência.

Em suma, nota-se que as representações provenientes desse modelo permitem que o indivíduo enfermo seja encarado como vítima, bom, inocente e não responsável pelo que lhe aconteceu e que a doença pertence ao absolutamente mau que tomou conta

dele e veio habitá-lo contra sua vontade. Independentemente do agente externo a ser considerado (físico, biológico, químico ou social), o indivíduo mantém uma relação de exterioridade com a doença que, seguindo-se a localização do intruso, permite separar o agressor do agredido, o culpado da vítima, o outro absoluto de si mesmo.

Modelo Endógeno

No modelo endógeno a doença é deslocada para o indivíduo, ela é parte do próprio interior do sujeito e não algo proveniente do meio externo. A fragilidade, o caráter, o temperamento, a hereditariedade genética dentre outros estão compreendidos nesse tipo de representação. Doenças de nutrição, desarranjos do metabolismo, desequilíbrios hormonais, problemas de crescimento são exemplo de doenças que não possuem um agente patogênico externo claramente definido e, desta forma, supõe-se a concepção de uma etiologia endógena, centrípeta.

O modelo endógeno tem suas raízes fincadas na medicina humoral de Hipócrates, que acreditava que a doença não podia ser compreendida independentemente do meio geográfico e climático, mas derivava principalmente de um desequilíbrio interno; em Platão, cujo conceito de equilíbrio está vinculado à união harmoniosa de corpo e alma, e finalmente; em Aristóteles que considerava a patologia como parte da natureza do indivíduo que a produz. Essas idéias de uma etiologia endógena são reforçadas no século XIX com o surgimento do vitalismo⁵ médico que, contrapondo-se a física médica, considera que “as causas da doença não são localizáveis e isoláveis, mas provêm de um desequilíbrio geral que deve ser posto em relação com o campo particular de cada indivíduo” (LAPLANTINE, François: 1991, p.81).

As abordagens psicológicas, psicanalíticas e psicossomáticas da doença ressaltam a importância do indivíduo, não como participante da doença, mas como responsável pela gênese de seu estado. Laplantine afirma que uma das grandes originalidades da psicanálise foi o interesse pelos conflitos intrapsíquicos relacionados com os fatores externos que podem provocar distúrbios mentais em um indivíduo, ou seja, o interesse pelas próprias instâncias psíquicas do indivíduo e não com as relações

⁵ O dicionário Merriam-Webster define vitalismo como: a) uma doutrina de que as funções de um organismo vivo são devidas a um princípio vital distinto das forças físico-químicas; b) uma doutrina de que o processo da vida não é explicável somente pelas leis da física e da química, pois a vida é de alguma forma autodeterminante. Há, com base nessa doutrina, uma insistência na complexidade e na originalidade do ser humano.

desse com o meio. Essas abordagens trazem à tona o conceito de psicogênese das doenças. Aos poucos, se populariza a tese de que toda doença, inclusive as orgânicas, procede de um desequilíbrio da sexualidade. Georg Groddeck, citado por Laplantine, radicaliza ao afirmar que nenhum sintoma, mesmo corporal, é alheio ao desejo do indivíduo. De acordo com Groddeck:

O [ser humano] fabrica suas doenças, ele é a causa delas e não é preciso que busquemos outras. A doença, e em particular a doença física, é sempre a expressão psicológica ou, melhor ainda, a simbolização do que desejamos secretamente (GRODDECK *apud* LAPLANTINE, François: 1991, p.82).

Embora muitos sejam os trabalhos relacionados ao caráter endógeno de algumas doenças, as representações focadas na exteriorização patogênica permanecem incontestavelmente privilegiadas por nossa cultura. A idéia de que o doente está presente em sua doença, ou melhor, de que ele é sua doença e essa é uma emanção do próprio doente, contrapõe-se de maneira drástica ao modelo exógeno. Por isso não é de se surpreender que na incapacidade de um médico encontrar uma causalidade externa diretamente relacionada com o estado patológico de seu paciente, esse assuma prontamente que não existem conhecimentos cientificamente avançados para diagnosticar tal enfermidade ou, ao considerá-la uma patologia endógena, limite-se ao aspecto da hereditariedade da doença.

Em síntese, o modelo endógeno possui duas variantes significativas: uma genética e uma psicológica. A variante genética baseia suas explicações sobre a doença no destino e na fatalidade (estou doente, mas nada tenho a ver com isso), ou seja, atribui-se a etiologia aos antepassados do doente (hereditariedade). A variante psicológica, por sua vez, se orienta a partir da liberdade e da culpabilidade (estou doente porque eu o quis ou desejei involuntariamente).

I.2.2.1. As relações entre os modelos ontológico/funcional e exógeno/endógeno

Os dois modelos podem se relacionar de diversas maneiras, dito de outra forma, há varias combinações possíveis entre os modelos apresentados até aqui. Não é plausível; entretanto, supor que um dos modelos seja histórica ou logicamente superior aos demais. Desta forma, por exemplo, a variante ontológica do modelo exógeno pode

ser considerada um modelo, ou seja, cada diferente combinação constitui um novo modelo.

É importante ressaltar que a passagem da explicação ontológica à explicação relacional da doença é um processo que se efetua gradativamente quando se admite uma interpretação exógena, por outro lado, quando se admite a interpretação endógena, essa passagem ocorre por ruptura ou descontinuidade. Isso ocorre porque as imputações causais são sempre acompanhadas de valores morais e, assim, forçam as representações da doença a se deslocar entre os extremos de dois pólos. Se o indivíduo não é considerado responsável por sua doença, “a etiologia incriminada pode ser tanto endógena quanto exógena, uma vez que as noções de fatalidade religiosa, do acaso infeccioso e da necessidade genética são todas suscetíveis de explicar esse caso” (LAPLANTINE, François: 1991, p.89). Por outro lado, se o indivíduo é considerado responsável por sua doença, as explicações são encontradas na variante psicológica da etiologia endógena (notoriamente na psicanálise). Outra possibilidade que se apresenta é a interpretação de que a doença, tendo sua origem no exterior, foi provocada, não obstante, pelo indivíduo que teria podido evitá-la. Assim, mesmo dentro de uma interpretação mais exógena, não mais se isenta o indivíduo da responsabilidade por seu estado e, em certo sentido, o mesmo passa a ser culpado por sua doença.

1.2.3. MODELO ADITIVO E MODELO SUBTRATIVO

Modelo Aditivo

No modelo aditivo impera a compreensão positiva da doença que é presença e não ausência de algo, como um objeto que não estava lá e que começou a se instalar e a invadir o corpo; em suma, alguma coisa a mais. Essa noção é confirmada pelas expressões usuais: “*estou com gripe*”, “*estou com cólica*”, “*estou com dor de cabeça*” dentre outras, as quais atestam uma adição simbólica, mas bem real de um acréscimo indesejável. Nesse modelo a etiologia é geralmente associada ao excesso (de tensão, de alimentação, de bebida etc.).

Modelo Subtrativo

Ao contrário do modelo precedente, no modelo subtrativo a doença não é qualquer coisa a mais que precisa ser extraída. Prevalece nesse modelo a compreensão negativa da doença que não é mais presença positiva a ser eliminada, mas a ausência (algo subtraído do doente) que requer uma terapia aditiva.

Laplandine acredita que as nuances desse modelo são mais visíveis na cultura mulçumana ortodoxa, para a qual a doença é antes de ordem da negação que da afirmação, de ausência mais que presença e, cuja cura advém de processos de purificação externa (abluições), de junção e adição (plantas medicinais). Encontramos na cultura ocidental cristã, por oposição, maiores nuances do modelo aditivo. Nas representações ocidentais é comum a interpretação da doença como uma positividade indesejável que requer, geralmente, intervenção cirúrgica de extração. Essas diferenças de pensamento, em vias práticas, influenciam a noção do papel e do comportamento médico esperado pelo doente, ou seja, um/a bom/boa médico/a pode ser aquele/a que extrai (sangue, urina, órgão etc.) ou aquele/a que acrescenta (medicamentos, injeções etc.).

1.2.4. MODELO MALÉFICO E MODELO BENÉFICO

Modelo maléfico

A constituição do saber médico ocidental se inscreve na perseguição de uma lógica que é a do mal absoluto, ressalta Laplandine. Nessa ótica, o patológico é sempre negativo, ou seja, a doença é nociva, indesejável e deve ser evitada por uma rede muito densa de tabus e profilaxia. “A doença não é apenas um desvio biológico, mas é também um desvio social, e o doente é vivido pelos outros e vê ele mesmo como um ser socialmente desvalorizado” (LAPLANDINE, François: 1991, p. 103). As palavras de Laplandine indicam que as doenças segundo esse modelo de interpretação possuem apenas um caráter negativo, humilhante e excludente.

Essas são as principais características do modelo maléfico, cuja representação da doença como avaliação totalmente privadora, nos força a viver a doença como um não, o azar, o absurdo que nada revela e que nada pode justificar. Esse processo, de certa forma, é acompanhado por um enaltecimento da ciência médica, ou seja, a cultura

médica torna-se cada vez mais uma parte importante da nossa cultura e propaga quase que de maneira inconsciente o “sentido médico”. Tal como Laplantine o concebe, o “sentido médico” consiste em viver utopicamente para evitar completamente a doença, retardar a hora da morte, conservar a qualquer preço o mais precioso de todos os bens: a saúde.

Modelo benéfico

Embora nossa cultura seja comandada pela prioridade da doença como situação negativa, existem raras compreensões comandadas pela noção de experiência positiva que se contrapõe ao modelo exposto anteriormente.

Essa noção positiva da doença surge quando os sintomas vivenciados pelo indivíduo não são mais considerados como aberrações a serem contidas, mas como uma mensagem a ser ouvida e desvendada. Nesse contexto:

A doença é uma reação que tem, se não um valor, pelo menos um sentido, já que é tida como uma tentativa de restauração do equilíbrio perturbado, e mesmo, em certos casos, como um episódio que exalta e enriquece (LAPLANTINE, François: 1991, p. 116).

Sob a ótica do modelo benéfico as doenças podem ser entendidas como:

a) Gratificação – nessa concepção a doença permite, ao mesmo tempo, escapar das opressões da vida em sociedade e atrair as atenções para si, visto que a situação do doente provoca dependências sociais e afetivas cobiçadas. Estar doente, segundo esse ponto de vista, não apresenta só inconvenientes em razão da solicitude das pessoas que cercam o indivíduo enfermo e da qual o mesmo se beneficia;

b) Proeza – é muitas vezes a partir de uma experiência patológica que o indivíduo dá provas de uma vontade excepcional, ampliando ao máximo suas potencialidades e desenvolvendo-as de forma contrária a invalidez aparente. A doença é a oportunidade para superação de si mesmo, é iniciação e afloramento de produções artísticas;

c) Alerta – as manifestações patológicas, as quais traduzem as reações do indivíduo às influências do meio externo e/ou interno, não são consideradas nessa variante como uma resposta gratuita e inadequada do organismo. Essas manifestações fornecem, sobretudo, uma informação importante ao médico, que com frequência poderá utilizá-las para diagnosticar e iniciar um tratamento de cura;

d) Salvação – nessa concepção a doença é considerada como a experiência mais significativa que possa ser vivida, pois exalta, libera e enriquece. A afirmação anterior de que a doença possua uma função insubstituível e que tem valor em si mesma remete-nos a uma interpretação profundamente marcada pelo pensamento religioso. O sintoma, na lógica das representações mal-doença, deixa de ser interpretado como uma punição e passa a ser interpretado como “eleição, o que nos permite avaliar o poder de reversibilidade e de ambivalência que se atribui ao sagrado: este, com efeito, agride e salva (...)” (LAPLANTINE, François: 1991, p. 119). Assim sendo, o sofrimento que fere a carne (mas salva a alma) ganha um sentido: a doença é prova de santidade, é graça;

e) Liberdade – a saúde, considerada como a ausência total da doença, em nossa sociedade, exprime-se como um direito e, sobretudo, como um dever (de travar um combate inexorável contra a anormalidade, o envelhecimento e a própria morte). É contra esse “dever” que, ultimamente, um certo número de indivíduos protesta e reivindica o direito à doença, de forma contrária ao ideal social e médico. Comportamentos e discursos “antimedicina” podem soar patéticos, mas devemos ter em mente que os mesmos geralmente surgem quando:

Os indivíduos vivem, por ocasião de um episódio patológico, um questionamento de sua existência, ou quando uma sociedade, em um dado momento de sua história, atravessa uma crise profunda de seus valores fundamentais (LAPLANTINE, François: 1991, p. 122).

f) Volúpia – baseado na psicanálise, a doença longe de ser um não-senso, possui um enorme significado pessoal para o doente e, desta forma, esse encontra prazer nos sintomas e apresenta uma reação negativa diante dos tratamentos. O doente sela uma aliança com sua doença e essa passa a ser seu ponto de equilíbrio. A prática terapêutica

nesses casos não deve visar a cura, mas sim a emergência de uma nova organização psicológica.

Encerramos assim a exposição dos modelos etiológicos que de certa forma traduzem a evolução e os diferentes pontos de vista sobre as doenças, mas cabe aqui uma pergunta: quão próximo estão essas abstrações científicas da realidade? A fim de tentarmos responder a essa pergunta, trataremos no próximo tópico da concepção popular das doenças.

1.3. A CONCEPÇÃO POPULAR DA DOENÇA

É importante analisarmos os pontos de vista populares no que tange à etiologia das doenças porque através da compreensão do modo de pensar dessa camada social pode-se empreender uma análise mais crítica a respeito de suas atitudes e práticas. Sabemos que as explicações etiológicas e a prática médica são marcadas pelo momento histórico, pelas condições sociais e pela experiência de vida dos indivíduos; porém, não podemos esquecer que as explicações etiológicas analisadas até aqui são meras abstrações teóricas. De certa maneira, tende-se a subestimar o ponto de vista popular por acreditar que o mesmo envolva apenas questões metafísicas ou sobrenaturais. Cabe então a pergunta: será que o ponto de vista popular das doenças é tão limitado quanto imaginamos?

Em estudos realizados pela pesquisadora Maria Cecília Minayo (1988) junto às classes populares, verificou-se que a concepção de saúde-doença segundo moradores de favelas do Rio de Janeiro integra sofrimento, angústias, medos, questões filosóficas e metafísicas, bem como aspectos da medicina “oficial” e de outros sistemas alternativos. Por meio de uma análise dos discursos populares, Minayo identificou os seguintes “domínios de causação” das doenças: natural; sócio-econômico, psicossocial e sobrenatural.

a) A causalidade natural

Trata-se da vinculação das doenças aos fenômenos da natureza. Assim, por exemplo, mudanças de tempo, ciclo lunares, frio, calor, alimentos inadequados, chuvas, ventos são apontados nos discursos populares como causadores de diversos males. Deve

ser ressaltado, entretanto, que a relação positiva com a natureza é apontada por essas mesmas pessoas como benéfica, assim sendo, é o desrespeito através da intervenção desordenada do homem na natureza (a poluição, por exemplo) que provoca os males. Adicionalmente, algumas doenças são assumidas como normais em determinada fase do ciclo da vida, assim sendo, há doenças típicas de crianças, de adultos e de idosos.

A naturalização da saúde e da doença, é importante mencionar, não é uma idéia recente. Há cerca de 5.000 mil anos os egípcios que habitavam o Nilo desenvolveram uma naturalização desses conceitos. Aliado às suas crenças sobrenaturais, mágicas e religiosas, esse povo admitia a existência de um princípio, o *whdw*, que se aderiu ao organismo humano, mediante contato com a matéria fecal, provocando mau cheiro, supurações e abscessos no corpo. Acreditava-se, também, que a absorção de *whdw* pelo organismo era mais intensa na velhice. Essa perspectiva natural quanto às doenças foi transmitida aos gregos, que consolidaram a passagem das interpretações sobrenaturais para as naturais, por intermédio da medicina humoral desenvolvida por Hipócrates e seus seguidores. Gregos, hindus e chineses em diferentes contextos e abordagens acreditavam em certos sistemas de correspondência entre os elementos do corpo e os elementos da natureza. O equilíbrio entre ambos seria a condição para a saúde e esse equilíbrio deveria ser perseguido através dos cuidados com: o corpo, os hábitos alimentares, os exercícios físicos e de uma convivência harmoniosa com a natureza. Assim sendo, é possível constatar que a noção do impuro que ameaça invadir e corromper os corpos, através dos alimentos e dos ares, reveste as representações de saúde e doença há milênios, provando que há mais permanências culturais no que tange as representações de saúde-doença do que habitualmente supomos.

b) A causalidade sócio-econômica

São aquelas doenças ligadas às condições materiais de existência, tais como: o tipo de trabalho, a moradia, o saneamento básico, as carências alimentares (fome), o sistema básico de saúde dentre outras questões sociais. As pessoas entrevistadas por Minayo apontam as condições precárias de moradia, a baixa renda familiar, a falta de alimentação e as condições insalubres de trabalho como principais causas de diversas enfermidades. É importante ressaltar também que é comum essas pessoas atribuírem à intervenção médica dos serviços de saúde a causa de algumas enfermidades, mortes e lesões irreparáveis. Essa crítica ao erro médico leva, geralmente, à descrença e

desconfiança quanto aos métodos adotados pela medicina “oficial”. Minayo (1988) afirma que essa descrença é fruto de uma “experiência prática em que [as classes populares] se sentem anôminas, impotentes e discriminadas”. Não obstante, essa camada da sociedade faz uso intenso dos serviços de saúde públicos em decorrência da aceitação do sistema biomédico, o qual é o padrão dominante na sociedade moderna e, também, por reconhecimento da eficácia da medicina “oficial” em muitos casos.

É impossível não notar a similaridade dessas idéias populares com o que comumente chamamos de medicina social. O surgimento dessa denominação remota ao início do século XIX quando um estudo sistemático da relação entre sociedade, doença e medicina começou de fato. O médico alemão Rudolf Virchow (1821-1902) é considerado por muitos como o fundador da medicina social, embora ele não tenha sido o primeiro a abordar a relação entre saúde e sociedade. Em 1848, Virchow identificou através de suas pesquisas que fatores sociais, tais como a pobreza, a baixa escolaridade e a falta de democracia, eram elementos chaves para o desenvolvimento de epidemias. Essa constatação motivou a divisão das epidemias em dois grupos distintos. O primeiro grupo, denominado natural, engloba as epidemias decorrentes do clima e das estações do ano, segundo Virchow. O segundo grupo foi denominado de “epidemias artificiais”, que podem ser entendidas como:

Atributos da sociedade, produtos de uma cultura falsa ou de uma cultura que não é disponível a todas as classes. Esses são indicadores de defeitos produzidos pela organização política e social e, portanto, afetam principalmente aquelas classes que não usufruem as vantagens da cultura (ROSEN *apud* ANDERSON; Matthew; SMITH, Lanny e SIDEL, Victor: 2005, sem pag. definida).

O termo medicina social assumiu diferentes conotações ao longo do tempo, porém, certos princípios básicos se mantiveram, a saber: primeiro, a aceitação de que as condições sócio-econômicas influenciam profundamente a saúde, as doenças e a prática médica; segundo, a afirmação de que a saúde da população é uma questão de mérito social; e terceiro, a obrigatoriedade da promoção dos cuidados com a saúde através de meios individuais e coletivos.

Não obstante, tradicionalmente, a medicina “oficial” reluta em aceitar o fato de que os fatores sociais desempenham um papel fundamental no binômio saúde-doença. No final do século XIX, os avanços da patologia e da microbiologia fizeram com que os fatores sociais ocupassem papel secundário nas interpretações etiológicas das doenças.

Porém, “os seres humanos são, nas palavras de Aristóteles, ‘animais sociais’ nos quais o biológico e o social estão inexoravelmente ligados” (ANDERSON, Matthew; SMITH, Lanny e SIDEL, Victor: 2005, sem paginação definida).

As estatísticas de saúde européias contribuíram de forma ímpar para a medicina social ao demonstrar que havia diferenças enormes nas taxas de mortalidade em diferentes segmentos de classe. Saúde e doença eram termos sinônimos de riqueza e pobreza, respectivamente. Infelizmente, muito dessas constatações ainda permanece como uma dura verdade em nossa sociedade.

c) A causalidade psicossocial

Esse domínio abrange as doenças, supostamente, provocadas por sentimentos e emoções, tais como: a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza e os sustos. Os sentimentos e emoções utilizados no discurso popular estão, geralmente, vinculados ao relacionamento interpessoal com a família, com o sexo oposto, com a comunidade e com o ambiente de trabalho. Curiosamente, levar sustos durante a gravidez é apontado nas falas populares como responsável por má-formação congênita e por doenças mentais dos recém-nascidos. A imaginação popular não pará por aí. Os discursos também revelam a crença na predisposição para a doença de acordo com os traços da personalidade de uma pessoa. Será que realmente existem personalidades inclinadas à saúde e outras à doença ou a crença popular é totalmente infundada? A resposta a essa pergunta é controversa, uma vez que existem muitos fatores que podem influenciar os traços de personalidade de uma pessoa. Porém algumas considerações sobre o tema merecem ser expostas.

Por traço da personalidade entendemos um padrão de pensamento e comportamento, uma forte predisposição para pensar e agir de uma determinada maneira. Os traços de personalidade refletem visões filosóficas de um determinado indivíduo sobre si mesmo e do mundo, em outras palavras, refletem uma crença geral a respeito de como o mundo funciona e de quem é responsável pelos problemas da vida, um conjunto de valores relacionados ao que é importante e aos compromissos assumidos com base em uma escolha pessoal.

As pesquisas relacionadas aos traços de personalidade evoluíram a partir dos estudos do sentimento de impotência. Estudos mostraram que há fases na vida de um ser humano em que esse apresenta um “complexo de desistência” (ENGEL *apud* SMITH,

Jonathan: 1993, p. 96). As características desse complexo são: desamparo e desesperança; baixa auto-estima; abandono de relacionamentos e funções sociais; confusão e perda da noção de tempo e, finalmente, recordações de outros períodos passados do mesmo complexo. Este processo é descrito como sendo um período de “impotência do senso psicológico, um sentimento que por curtos ou longos períodos de tempo impede um indivíduo de lidar com as mudanças do ambiente” (ENGEL *apud* SMITH, Jonathan: 1993, p. 96). Diversos estudos sugeriram que existe uma relação entre o “complexo de desistência” e as doenças; porém, as situações que podem provocar o aparecimento de tal complexo no ser humano variam de indivíduo para indivíduo. Em decorrência dessa inconstância, surgiram algumas avaliações cognitivas a fim de complementar essa teoria.

A primeira variante do “complexo de desistência” leva em consideração o que se denominou “estilo explicativo” (ABRANSOM, GARBER & SELIGMAN *apud* SMITH, Jonathan: 1993, p.96); ou seja, é um traço da personalidade que reflete a percepção subjetiva de impotência e de desenvoltura do indivíduo. Quando a personalidade de um indivíduo é norteadada pelo estilo explicativo pessimista, o risco de perda de auto-estima e aparecimento de outros problemas (inclusive de saúde) em face de uma situação difícil ou fracasso é muito elevado.

A segunda variante dessa teoria leva em consideração o *constructo* denominado “*locus* de controle” (ROOTER *apud* SMITH, Jonathan: 1993, p.97), o qual representa um traço da personalidade que afeta a percepção de controle das situações. Um indivíduo pode possuir um *locus* de controle interno (as situações da vida são encaradas como reflexo do comportamento do próprio indivíduo) ou externo (as situações que se apresentam são atribuídas a agentes externos, tais como: o acaso, o destino, Deus, a sorte etc.). No que tange a comportamentos relacionados às doenças e à saúde, pode ser proposta três escalas de percepção do *locus* de controle: a) a crença de que a saúde e a doença são resultados do comportamento do próprio indivíduo; b) a crença de que se pode confiar o cuidado com a saúde e o tratamento das doenças aos profissionais especializados e; c) a crença de que saúde e doença são coisas do acaso. Esse tipo de escala permite analisar a percepção que determinado indivíduo possa ter sobre a responsabilidade e tratamento de sua doença, pois diferentes tipos de percepção resultarão em diferentes respostas às terapias possíveis.

Assim, embora acredite que não seja um completo absurdo afirmar, com base no que fora exposto, que existem traços da personalidade que podem ser associados à

algumas doenças, creio que deve ser ressaltado que o estabelecimento de uma relação direta entre essas duas variáveis requer muita cautela, visto que há muitos fatores a serem levados em consideração (esperança, otimismo, pessimismo, introversão, extroversão, hostilidade etc.) e alguns ainda requerem maiores estudos.

d) A causalidade sobrenatural

Esse domínio de causação abrange o universo dos espíritos e seres transcendentais. Vontade divina, espíritos, “mau-olhado”, “olho-grande”, por exemplo, são vinculados à diversos estados patológicos. Esse tipo de explicação geralmente aparece vinculado às explicações de cunho psicossocial, por isso, as pessoas buscam recursos da medicina “oficial” e, ao mesmo tempo, buscam respaldo religioso através de orações, banhos de descarga, promessas e penitências. Particularmente, sob a ótica popular, quando as doenças não são explicadas de modo satisfatório pelo diagnóstico médico, seu entendimento é dado como punição divina, “encosto” ou “coisa que mandaram” (transtorno espiritual provocado por “olho-grande” ou “mau-olhado” que se reflete no corpo do indivíduo afetado). Isso mostra que certos aspectos de caráter religioso, maldições e castigos divinos ainda revestem as representações de saúde e doença, onde o medo e a culpabilidade aparecem sempre atrelados à essa última.

Averiguamos, em linhas gerais, que o sistema etiológico popular possui um caráter holístico⁶, pois engloba o natural, o emocional, o social e o sobrenatural, atribuindo assim uma concepção pluralística à doença ao integrar diferentes explicações. A esse respeito, Minayo escreveu que:

Esses quatro níveis de explicação [natural, sócio-econômico, psicossocial e sobrenatural] apresentam-se com dimensões distintas, vinculadas, intercambiantes e não contraditórias. Eles se unificam na visão da doença como a ação patogênica de elementos de ruptura das relações do indivíduo com a natureza e com seu grupo social. Se em última instância Deus é considerado por esse grupo quem dirige a vida e é nele que encontram a fonte da harmonia, a existência terrena é o palco da dor e da cura: nesse sentido a doença cumpre um papel questionador, integrador e de re-equilíbrio: seu

⁶ Conforme definição do dicionário on-line de neurociências, holístico é derivado de *holismo*, cuja raiz grega “*holos*”, significa todo, total, universal. O *holismo* é uma atitude de compreensão das coisas que considera sempre o conjunto e a integração das partes com o todo. Quando se fala em visão holística, estaria se referindo a uma visão global e integrada, o conjunto visto de maneira harmônica, a totalidade dos elementos presentes.

conceito é holístico (MINAYO, Maria Cecília: 1988, sem paginação definida).

O embate existente entre o conhecimento erudito e o popular no que tange a etiologia das doenças, talvez, deva-se em grande parte ao caráter impessoal, massivo e com ênfase no biológico do atendimento médico. A prática médica moderna é marcada pela alta tecnologia, medicações e intervenções cirúrgicas alheias a experiência e ao controle dos indivíduos a ela sujeitos, ou seja, os doentes. Não obstante o veredicto médico é aceito; porém, é relativizado e a crença em sua eficácia inclui outros critérios extra-científicos, afirma Minayo.

É notório que o campo religioso faz parte da cultura popular e; portanto, não nos surpreende o fato da religião estar presente nas explicações sobre saúde/doença. É importante ressaltar que a explicação religiosa das doenças ultrapassa os limites de classe. As noções religiosas sobre as doenças possuem raízes históricas profundas e seu estudo é capaz de revelar aspectos sociológicos, antropológicos e psicológicos interessantíssimos. A história revela, por exemplo, que as explicações das doenças unem causas socioeconômicas com apelações religiosas sem contradições há muito tempo. No terceiro capítulo serão abordadas as interpretações religiosas das doenças a fim de demonstrar que o discurso religioso tem a capacidade de reinterpretar e operacionalizar o conceito de doença de maneira própria na tentativa de conferir sentido às experiências de debilidade física ou mental. Mas antes, na busca de um embasamento teórico, será apresentada no próximo tópico a teoria das Representações Sociais que, críticas à parte, elucida e justifica o propósito deste trabalho de pesquisa.

I.4 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

A teoria das representações sociais permeia diversas discussões do campo das ciências sociais, pois constitui uma forma privilegiada de pensar a relação entre objetividade e subjetividade na evolução das sociedades. Embora as representações sociais façam parte de nosso cotidiano, seu conceito não é de fácil apreensão, justamente porque essa teoria se encontra em uma encruzilhada interdisciplinar, compartilhando idéias com a Psicologia, Sociologia, História e Filosofia. A utilização dessa teoria visa

ultrapassar o nível da constatação sobre o que se passa "na cabeça" dos indivíduos, para procurar compreender "como" e "por que" essas percepções, atribuições, atitudes e expectativas são construídas e mantidas, recorrendo aos sistemas de significação socialmente enraizados e partilhados que as orientam e justificam. (MAZZOTTI, Alda; 1994; p. 60)

O estudo das representações sociais talvez permita que se atinja tal propósito, na medida em que investiga como se formam e como funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade. Por suas relações com a linguagem, a ideologia e o imaginário social e, principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das práticas sociais, as representações sociais constituem elementos essenciais à análise das interpretações religiosas concernente às doenças ou, em outras palavras, à análise do papel do simbólico na orientação das condutas humanas.

As representações sociais podem ser entendidas como “modalidades de conhecimento prático, orientadas para a comunicação e para a compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos” (JODELET, Denise *apud* SPINK, Mary Jane: 1993, 300). A premissa básica da teoria das representações sociais é a de que não existe separação entre o universo externo (social/religioso) e o universo interno (psique) do sujeito: em sua atividade representativa, ele não reproduz passivamente um objeto dado, mas, de certa forma, o reconstrói. As representações sociais, assim como as opiniões e as atitudes, orientam o comportamento do sujeito, na medida em que reconstituem os elementos do ambiente no qual o comportamento terá lugar. Vale ressaltar, entretanto, que as representações sociais não são apenas “opiniões sobre”, mas teorias coletivas sobre o real, sistemas com lógica e linguagem particulares, com uma estrutura única de valores e conceitos, e que “determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores ou das idéias compartilhadas pelos grupos e regem, subsequente, as condutas desejáveis ou admitidas” (MOSCOVICI, Serge *apud* MAZZOTTI, Alda: 1994, p.62). São, em suma, formas de conhecimento. Embora essa forma de conhecimento se manifeste por meio de elementos cognitivos (conceitos, idéias, imagens), não se limitam a esses componentes cognitivos, visto que são socialmente elaboradas e compartilhadas. Essas formas de conhecimento possibilitam a comunicação e a interação entre os indivíduos para a construção de uma realidade comum. Em síntese, as representações sociais podem ser vistas como um saber do senso comum cuja função “é estabelecer uma ordem que permita aos indivíduos orientarem-se em seu mundo material e social e dominá-lo, assim como possibilitar a comunicação

entre os indivíduos” (JODELET, Denise *apud* DIAS, Luciana: 1995, p. 64). Embora associadas ao senso comum, as representações sociais não são meras recombinações de conteúdos leigos sob pressão das forças do grupo. Elas são também fomentadas pela ciência, cujas idéias circulam publicamente através da mídia.

Segundo Mazzotti (1994), a noção de representação social, tal como é aqui entendida, foi introduzida por Serge Moscovici em 1961, em um estudo sobre a representação social da psicanálise. Coube à principal colaboradora de Moscovici, Denise Jodelet, a tarefa de sistematização desse campo de estudo, bem como o aprofundamento teórico dessa matéria. Jodelet procurou esclarecer melhor o conceito e os processos formadores das representações sociais através da publicação dos resultados de seu trabalho de pesquisa em 1989.

Tendo em mente que a função das representações sociais é contribuir “exclusivamente para os processos de formação de condutas e de orientação das comunicações sociais” (MOSCOVICI, Serge *apud* MAZZOTTI, Alda: 1994, p.64), Moscovici afirmou que existem dois processos que dão origem às representações: a objetivação e a ancoragem. De uma forma simples, a objetivação é a passagem de conceitos ou idéias para esquemas ou imagens concretas; e a ancoragem, é a constituição de uma rede de significações em torno do objeto, relacionando-o à valores e práticas sociais preexistentes. Jodelet, de acordo com a síntese feita por Mazzotti (1994), retoma ambos conceitos propostos por Moscovici. Quanto ao processo de objetivação, Jodelet afirma que este processo envolve três etapas: primeiramente, a construção seletiva, a qual é o período em que, através de critérios normativos e culturais, o sujeito se apropria das informações e saberes sobre um dado objeto. Só se retém o que está de acordo com o sistema de valores do grupo e, neste processo de apropriação, enquanto alguns elementos são mantidos outros são ignorados ou rapidamente esquecidos. Em segundo lugar, a formação de um núcleo figurativo, isto é, a formação de uma idéia que reproduz de maneira figurativa uma estrutura conceitual; e, finalmente, a naturalização, ou seja, a transformação destas imagens em elementos da realidade por meio do comportamento. Quanto ao conceito de ancoragem, Jodelet procura mostrar que a intervenção do social se traduz na significação e na utilidade que são conferidas à representação. Ao analisar a ancoragem como atribuição de sentido, a autora afirma que uma pessoa ancora o desconhecido em representações já existentes de acordo com a hierarquia de valores de uma sociedade ou do grupo do qual ela faz parte.

Isso, então, contribui para criar em torno do objeto uma rede de significações própria e única.

A análise destes processos permite compreender como o funcionamento do sistema cognitivo interfere no social e como o social interfere na elaboração cognitiva. A atividade representativa constitui, portanto, um processo psíquico. Nesse processo, o objeto da representação entra em uma série de relacionamentos e de articulações, com outros objetos existentes e conhecidos, a tal ponto que o primeiro objeto “deixa de existir como tal para se converter em um equivalente dos objetos aos quais foi vinculado” (MAZZOTTI, Alda: 1994, p. 63). Por exemplo, ao se aproximar a doença da noção de mal, deforma-se a idéia da primeira, bem como se transforma a concepção do segundo. Os vínculos que se estabelecem em torno do objeto traduzem necessariamente uma escolha, a qual é orientada por experiências e valores do sujeito, desta forma, é “razoável concluir que uma pessoa se informa e se representa alguma coisa unicamente depois de ter adotado uma posição, e em função da posição tomada” (MOSCOVICI, Serge *apud* MAZZOTTI, Alda: 1994, p.64).

Além de apresentar os processos que levam à origem das representações, Mazzotti relata, ainda se referindo a Moscovici, as situações sociais que constituem terreno fértil para o surgimento das representações sociais. Segundo a autora, essas situações sociais apresentam três características básicas:

- a) dispersão das informações, o que faz com que os dados de que o sujeito dispõe sobre um novo objeto social sejam, ao mesmo tempo, excessivos e insuficientes, contribuindo para a incerteza quanto ao âmbito das questões envolvidas;
- b) pressão para a inferência, gerando desvios nas operações intelectuais, na medida em que o sujeito precisa, a qualquer momento, no curso das conversações cotidianas, estar pronto para dar sua opinião, tornando estáveis impressões com alto grau de incerteza e;
- c) focalização sobre um determinado aspecto ou ponto de vista, o que influencia o estilo de reflexão do sujeito. (MAZZOTTI, Alda: 1994, p.64).

Tais condições levam o sujeito, independentemente de seu nível cultural, a se utilizar de lugares comuns e de fórmulas consagradas na avaliação de objetos e eventos sociais, sem a preocupação de integrá-los em um todo coerente; a fazer deduções de causalidade com base em similaridades espaciais ou temporais, valores, intenções, etc. Em resumo, o indivíduo é estimulado a formar uma conclusão que, antecedendo o devido raciocínio, sirva apenas para demonstrar o que já estava previamente estabelecido. Essas situações podem levar o indivíduo a apresentar o que Moscovici

denominou de “polifasia cognitiva”, ou seja, a coexistência, no mesmo indivíduo, de modos de pensamento diversos, correspondentes a diferentes estágios de desenvolvimento cognitivos. Cada um desses modos de pensamento responde a uma necessidade específica condicionada pelo tipo de situação e de interação social. Isso explicaria, por exemplo, porque um mesmo indivíduo ao se defrontar com a doença recorra tanto à medicina oficial quanto às práticas religiosas no intuito de identificar as causas do mal que o abate.

Agora, voltando as questões propostas por esse trabalho, julgo que os estudos das representações sociais sobre saúde/doença “estão inseridos numa visão centrada no significado atribuído à saúde/doença pelos autores, isto é, no conteúdo das teorias apresentadas em função de suas lógicas próprias e de sua coerência” (DIAS, Luciana: 1995, p. 65), visto que as doenças remetem a uma interrogação que extrapola o corpo individual e o diagnóstico médico. A busca pelo significado das doenças, de acordo com Luciana Dias (1995, p.65) citando Mary Jane Spink, “remete necessariamente a uma interpretação coletiva complexa e em constante movimento. Remete, em suma, ao discurso da sociedade sobre as enfermidades e os enfermos”.

As representações sociais, enquanto produtos de uma sociedade, podem ser apreendidas através da evidenciação de seu conteúdo e de seus elementos constitutivos: informações, crenças, imagens e valores expressos pelos sujeitos, os quais podem ser obtidos por meio de questionários, entrevistas, observações, análise de documentos, etc. Já enquanto processo social, o estudo das representações sociais deve ter como foco a relação entre a estrutura da representação (organização e hierarquização dos elementos que configuram seu conteúdo) e as condições sociais de sua produção, bem como as práticas sociais que induz e justifica. Para tanto é requerido a análise de aspectos culturais, ideológicos e inter-racionais, do grupo estudado, que possam explicar a emergência de um dado núcleo figurativo, inscrevendo-o em uma rede de significações.

I.4.1 Uma teoria em construção: críticas e reflexões metodológicas

Um estudo que se propõe a analisar as mais diferentes concepções sobre saúde/doença de diversos grupos religiosos brasileiros pode parecer, à primeira vista, uma aspiração infundada, pretensiosa. Porém, se considerarmos que esses grupos não estão totalmente isolados, ou seja, estão em constante troca e compartilham uma linguagem, uma forma de entender o mundo, que orienta suas ações, a tarefa perde sua

aura hercúlea. Enquanto grupos culturais distintos, as diversas religiões aqui abordadas não deixam de prestar serviços a uma coletividade que compartilha das idéias que elas divulgam mesmo para aqueles que alegam pertença a um único e exclusivo grupo. Assim, a teoria das Representações Sociais constitui forte embasamento teórico para esse estudo no intuito de identificar as representações da doença privilegiadas pelo discurso dos grupos religiosos analisados e, adicionalmente, permitir a compreensão de algumas ações de indivíduos religiosos confrontados pelos fenômenos mórbidos.

Não ignoro, todavia, as críticas feitas à esta teoria. Embora muitas dessas críticas tenham implicações metodológicas, é inegável que o principal foco das críticas sejam os aspectos teóricos, principalmente, no que se refere a questão de falta de clareza de conceitos. Este é o caso, por exemplo, conforme nos relata Alda Mazzotti, das críticas feitas por Rom Harré⁷. Segundo Harré o termo social possui uma tríplice ambigüidade, ou seja, "é usado para indicar que a representação é de um objeto social, ou que ela própria, enquanto entidade, é algo social ou, ainda, que a representação é social por ser partilhada por um grupo" (MAZZOTTI, Alda: 1994, p. 69). Para Harré, o último conceito somente seria aplicável a grupos sociais reais que se intercomunicam, possuem papéis específicos e relações de compromisso. Entretanto, Rom Harré acredita que a maioria das pesquisas trabalha com o que ele denominou de "grupos taxionômicos, criados pelo pesquisador e constituídos por um agregado de pessoas ligadas pela simples semelhança de suas crenças" (HARRÉ, Rom *apud* MAZZOTTI, Alda: 1994, p. 69). Respondendo a essa crítica Moscovici, em trabalhos posteriores, afirmou que não se pode negar que esse grupos taxionômicos existam, nem tampouco se pode negar que exista um certo grau de associação entre seus membros. Cada indivíduo se apropria, atualiza e expressa os valores culturais dos grupos em que está inserido, sendo, portanto, válido captar tais interpretações nas falas e condutas individuais.

Assim, pode-se afirmar que a escolha de um grupo ou de outro dependerá do tipo de questão em que está interessado/a o/a pesquisador/a. Por exemplo, quanto aos estudos preocupados com o imaginário social, ou seja, que partem da premissa de que exista "um quadro cultural que matricia a produção imaginativa [de um determinado] grupo" (TEVES *apud* MAZZOTTI, Alda: 1994, p. 69) através da veiculação de significados, valores e aspirações sem que haja interação entre os membros, parece ser legítimo a investigação a respeito do processo de apropriação dessa matriz

⁷ Ver HARRÉ, R. Some reflections on the concept of social representation. *Social Research*, n.51, p.927-938, 1984.

representacional por indivíduos que partilham uma condição comum (social, política, religiosa, econômica etc.).

Segundo Mazzotti, Potter e Litton⁸, apresentaram uma crítica mais difícil de ser contestada. O trabalho desses autores chamou a atenção para o fato de que, uma vez que os agentes sociais podem pertencer a diversos e distintos grupos sociais, nada garante que um indivíduo se identifique com aquele grupo especificado pelo/a pesquisador/a. O questionamento feito por esses autores destaca a necessidade do estabelecimento de critérios analíticos na escolha dos grupos em estudo e a necessidade de obtenção de informações detalhadas sobre os sujeitos envolvidos, utilizando-as na análise dos dados. No estudo de religiões brasileiras, por exemplo, essa crítica ganha significativa importância, porque muitas vezes a religião declarada não é capaz de evidenciar todas as crenças e práticas de um indivíduo acostumado com o sincretismo religioso. Ainda se referindo a questão da constituição dos grupos, os autores citados por Mazzotti no início desse parágrafo, acreditam que o tamanho dos grupos e o nível de consenso necessário para a constatação da existência de uma representação social são pontos que não foram suficientemente elucidados. A pesquisa empírica de Moscovici fez uso de um grande número de sujeitos (2.265); porém, trabalhos posteriores e de outros autores baseados em sua teoria utilizaram números muito mais modestos (menos de uma dezena). Como não é propósito desse trabalho discutir mais a fundo as implicações metodológicas dessa última crítica, encerro a questão com o argumento de Denise Jodelet, referida por Mazzotti, que salienta que

as conotações sociais do pensamento não se devem tanto a sua distribuição entre muitos indivíduos e sim ao fato de que o pensamento de cada um deles é, de várias maneiras, marcado pelo fato de que outros também pensam da mesma forma (MAZZOTTI, Alda: 1994, p.70).

Tais discussões mostram que a teoria das Representações Sociais não está de todo consolidada e essas questões a serem respondidas expõem o fato de que tal teoria ainda encontra-se em processo de construção. A definição de procedimentos metodológicos, por exemplo, ainda carece de um arcabouço e elementos que norteiem os estudos nesse campo. A grande variedade de abordagens nos estudos de representações sociais é devedora da multidisciplinaridade típica dessa teoria, ou seja, os estudos podem ser conduzidos em diferentes áreas científicas e sob diferentes

⁸ Ver POTTER, J., LITTON, I. Some problems underlying the theory of social representations. *British Journal of Social Psychology*, n.24, p.81-90, 1985.

tradições de pesquisa, mas também deve-se em parte a inexistência de um arcabouço metodológico predefinido. A despeito da variedade, os trabalhos não devem perder o foco e deixar de responder às questões que esta linha de investigação se propõe a responder: como o social interfere na elaboração psicológica (representação) e como esta representação interfere no social.

CAPÍTULO II

RELIGIÕES BRASILEIRAS

INTRODUÇÃO

A população brasileira é majoritariamente cristã (89% da população de acordo com o censo de 2000), sendo sua maior parte católica. Todavia, essa aparente unidade religiosa é marcada por forte sincretismo religioso⁹, o que torna o Brasil um país religiosamente diverso, com certa dose de tolerância e muita mobilidade entre as religiões.

O catolicismo apostólico romano foi introduzido no Brasil pelos missionários que acompanhavam os colonizadores portugueses. Coube a esses missionários a educação e evangelização (de indígenas) nos colégios das mais diversas ordens religiosas. Os séculos XVI e XVII foram marcados pelos conflitos entre congregações religiosas e colonos em decorrência da escravização de indígenas e o Estado funcionou como intermediador desses conflitos. Até meados do século XVIII, o Estado ainda mantinha o controle da atividade eclesiástica no Brasil e somente com a declaração da república, em 1890, é que o catolicismo deixou de ser a religião oficial do país. Não obstante, a igreja católica continua a exercer grande influência nos aspectos sociais, políticos e culturais dos brasileiros. O Brasil é considerado o maior país católico no

⁹ Quando o assunto é a religiosidade brasileira, além da evidente diversidade e da relativa oposição, pode-se perceber pontes, relações e transferência de sentidos entre as religiões. Para alguns autores, esse processo é visto de forma otimista por promover a confraternização de valores e sentimentos, enquanto para outros é um processo que meramente privilegia aspectos de uma religião em detrimento da essência "pura" de outra, ou seja, esses autores o interpretam mais como um processo que envolve a assimilação hierárquica e neutralizadora da diferença do que como uma confraternização propriamente dita, pois sincretismo e tolerância não são sinônimos.

A relação sincrética brasileira mais evidente aparece no catolicismo e nas religiões afro-brasileiras, em decorrência de um processo histórico que motivou a assimilação de valores e símbolos do primeiro por essas últimas. Porém, esse processo não se limita à essas religiões. As crenças indígenas e as idéias do espiritismo também permeiam o imaginário majoritariamente cristão dos brasileiros.

Adicionalmente, alguns autores julgam que a contraface desse fenômeno de hibridação de crenças e rejeição da necessidade de uma exclusividade religiosa é o crescimento de grupos religiosos que defendem a ortodoxia. Esses grupos religiosos, no geral, desencadeiam uma batalha (confrontação e acusações explícitas) contra outras religiões e, especialmente, contra a bricolagem religiosa, a qual passa a ser interpretada como um descomprometimento com a fé. Essa afirmação é ilustrada pela intolerância neopentecostal em relação às religiões afro-brasileiras. O comportamento neopentecostal, por sua vez, é justificado pela situação de exclusão das camadas mais pobres da sociedade brasileira, ou seja, o pluralismo religioso e a exclusão socioeconômica (baseada na classe social e/ou na raça) motivam mais a competição pelo reconhecimento social do que a união dos grupos religiosos minoritários.

Essa nota sintetiza algumas idéias do artigo de Roberta Campos (2008) a respeito das interpretações do sincretismo e anti-sincretismo na/da cultura brasileira, o qual fora publicado na revista BIB no. 65 da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS).

mundo, pois aproximadamente 74% (ou quase 126 milhões) dos habitantes se declaram católicos.

Essas enormes cifras escondem, porém, o fato de que o catolicismo brasileiro não é um bloco rígido e unitário como parece. A fraqueza doutrinária aliada a pouco controle permitiu aos católicos brasileiros a assimilação e aceitação das mais diversas crenças, bem como lhes diminuiu o interesse pelas formas tradicionais de religiosidade. A conjunção desses fatores culminou em dados estatísticos surpreendentes: 40% dos indivíduos que responderam ser católicos no último censo demográfico (2000) do IBGE alegam ser "não-praticantes". Assim, de uma forma geral, o catolicismo brasileiro se distancia em muito das determinações da Santa Sé em Roma. Por isso é possível identificar, atualmente, quatro versões de catolicismo no Brasil: o tradicionalista, mais conservador e defensor da ortodoxia; os remanescentes da Teologia da Libertação, com forte engajamento político e social; o popular, marcado por forte devoção aos santos e; finalmente, as comunidades carismáticas, movimentos religiosos recentes caracterizados pela exaltação do Espírito Santo. Os dois últimos possuem funções terapêuticas gritantes e são, comumente, palco para a realização de milagres. Na batalha contra as doenças, fortemente influenciado pela Bíblia e sua noção de troca, o catolicismo popular sela uma aliança com os santos, seres divinos com atribuições relacionadas às necessidades e aos problemas corriqueiros humanos, além de abarcar as mais diversas crenças e superstições. As comunidades carismáticas, por sua vez, embora possuam a tendência de uma moral mais conservadora, assemelham-se em certos aspectos às igrejas pentecostais, como no uso dos dons do Espírito Santo para superação das moléstias corporais.

A queda no contingente de católicos contribuiu, não proporcionalmente, para o aumento do número de evangélicos, bem como daqueles que declaram não ter religião, os quais representam cerca de 8% da população brasileira de acordo com o censo de 2000. Nas últimas décadas a religião protestante tem crescido bastante em número de adeptos, alcançando parcela bastante significativa da população (cerca de 15% de acordo com o último censo). Assim como o catolicismo, os evangélicos também não constituem um grupo homogêneo de indivíduos que professam o mesmo credo. A maioria dos autores que tratam dessa religião procuram classificá-la, para fins didáticos, em três grandes grupos: os protestantes históricos, os protestantes pentecostais e os neopentecostais. As funções terapêuticas são mais acentuadas nos dois últimos, onde os dons do Espírito Santo são manifestados e o eterno combate entre o "bem" e o "mal" se

processa na vida e nos corpos dos seres humanos. O uso intensivo dos meios midiáticos: TV, rádio, jornais e revistas, ajudam a atrair grandes multidões aos templos e eventos desses grupos religiosos. Apoiados na teologia da prosperidade, essas pessoas buscam a solução de seus problemas financeiros, amorosos, familiares e, sobretudo, de saúde.

Embora o contingente dos adeptos das religiões afro-brasileiras (umbanda e candomblé) e do espiritismo seja minúsculo em comparação com o grupo das religiões cristãs, não se deve subestimar a influência que o sistema de crenças desses grupos exerce sobre os brasileiros declarados cristãos.

A mão-de-obra escrava, oriunda da África, trouxe suas próprias práticas religiosas, que sobreviveram à opressão dos colonizadores mediante um processo de camuflagem das suas deidades. As divindades de origem africana foram associadas aos santos católicos e, a despeito de toda opressão e opinião pública contrária, algumas tradições foram conservadas e assimiladas pela população brasileira. Baseados na crença de que cada indivíduo é "governado" por uma entidade divina – o orixá – as idéias de equilíbrio e a necessidade de se respeitar as características da personalidade e as preferências dos orixás permeiam as interpretações sobre as doenças desses grupos religiosos e as práticas terapêuticas se tornaram uma parte relevante dos cultos, em consonância com o cunho assistencial da maioria dos terreiros e "centros espíritas" existentes atualmente.

O espiritismo, por sua vez, começou a ser divulgado na segunda metade do século XIX e, hoje, o Brasil concentra o maior número de espíritas do mundo. Embora não fosse o propósito de Allan Kardec, o aspecto religioso de suas idéias foi o que acabou se tornando hegemônico no Brasil. O Brasil contou com uma figura importantíssima para a assimilação e disseminação das idéias espíritas: o médium Chico Xavier, cuja obra literária e personalidade carismática (com pitadas de santidade) promoveu a difusão e aceitação de muitos conceitos espíritas pelo povo brasileiro, notadamente, pelas classes populares que encontravam nos seus livros uma linguagem que não primava pelo rebuscamento excessivo das palavras, diferentemente da forma como, em geral, os livros sagrados religiosos são apresentados. A postura e a adoção da moral cristã por Chico Xavier, além da debilidade doutrinária do catolicismo, fez com que grande parcela dos indivíduos declarados católicos reproduzissem em seus discursos idéias de cunho espírita. A natureza tipicamente assistencialista dos "centros espíritas" acabou incorporando funções terapêuticas de vital importância para a manutenção e crescimento desse segmento religioso.

No capítulo que se segue serão apresentadas descrições mais detalhadas das "principais" correntes religiosas brasileiras citadas nos parágrafos pretéritos, ordenadas pela porcentagem de integrantes de acordo com o recenseamento demográfico do IBGE em 2000. Além da relevância em termos de representatividade populacional, é importante destacar que essas religiões, em certa medida, fomentam os comportamentos religiosos que me motivaram a fazer indagações e a realizar essa pesquisa. A função terapêutica dessas religiões é bastante evidente, embora o grau de sua importância e a abordagem dos problemas de saúde varie muito dentro dos diversos grupos existentes nas rubricas mais gerais utilizadas pelo IBGE. Ressalto, nesse momento, que esse capítulo é apenas uma passagem rápida sobre essas religiões, não há aqui a pretensão de um aprofundamento das nuances e detalhes específicos (principalmente rituais) dessas religiões. Esse capítulo, todavia, é de vital importância para a aplicação da teoria das representações sociais, visto que as representações devem sempre ser referidas às condições de sua produção. Confesso que me julgo inapto para sintetizar toda a complexidade do quadro religioso brasileiro, tanto pela restrição de tempo e espaço quanto pela limitação de meus conhecimentos. Não obstante, julgo que as poucas informações que consegui reunir e apresentarei a seguir serão valiosas para a compreensão das religiões no Brasil no início do século XXI.

II.1 AS RELIGIÕES DO BRASIL: ALÉM DOS NÚMEROS

O Brasil já foi um país essencialmente católico. Dados censitários de 1940 demonstram que 95,2% da população brasileira já foi declarada católica um dia. Não alheio às transformações culturais, ao processo de secularização e ao direito de liberdade religiosa, o Brasil assiste desde então o declínio do número de católicos e, não menos importante, a um aumento do número de evangélicos. A comprovação empírica de tal afirmação é obtida através dos dados censitários de 2000 publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os quais demonstram uma redução constante da proporção de católicos na população brasileira.

Uma análise quantitativa dos dados apresentados na Tabela 1 mostra que a população brasileira continua sendo predominantemente cristã. No censo de 1940 os cristãos totalizavam 98% e, no censo de 2000 somavam 89% da população residente, cerca de 152 milhões de pessoas de um total de 170 milhões. Portanto, falar em pluralismo religioso no Brasil pode soar deveras incoerente. Todavia, para compreender

o quadro religioso brasileiro, há que se fazer certas considerações de caráter qualitativo nos números apresentados pelo censo, caso contrário, as análises meramente quantitativas levarão a conclusões dispares da realidade brasileira.

Tabela 1 – População residente segundo a religião – Brasil***

Religião	1940**	1980*	1991*	2000*
Católica	95,2	89,2	83,3	73,7
Evangélica	2,6	6,6	9,0	15,4
Espírita	1,1	0,7	1,1	1,4
Afro-brasileiras	-	0,6	0,4	0,3
Outras religiões	0,8	1,3	1,4	1,8
Sem Religião	0,3	1,6	4,8	7,4
Total	100%	100%	100%	100%

Fontes:

(*) PRANDI, Reginaldo – Segredos Guardados: Orixás na alma brasileira

(**) CAMARGO, Cândido P.F. – Católicos, Protestantes, Espíritas

(***) Não inclui religião não declarada e não determinada.

Primeiramente, deve-se levar em conta que cada uma das religiões destacadas pelos censos nacionais se distingue por um patrimônio cultural, unidade doutrinária, formas de organização institucional e eclesiástica próprias. Entretanto, com o decorrer dos anos surgem ocasionalmente instituições religiosas, calcadas no mesmo referencial histórico-cultural das formas ditas ortodoxas, que se diferenciam das formas vigentes mediante a agregação de conteúdos sincréticos que atendam as situações sociais emergentes. Ao captar esses dados e agrupá-los para fins de interpretação, tende-se a agrupar sob uma mesma rubrica as religiões ortodoxas e todas as demais formas derivadas da primeira. Assim, na rubrica Evangélicos, por exemplo, tem-se uma ampla gama de igrejas e congregações protestantes que se diferem muito uma das outras. Soma-se na mesma linha os números de fiéis de igrejas de cunho histórico (advindas da Reforma Protestante do século XVI) com os números de fiéis das igrejas neopentecostais tão presentes nas áreas populacionais de mais baixa renda. Quanto ao catolicismo, deve-se levar em consideração que há muitas maneiras de interpretá-lo, pois comumente se escutam vários títulos para definir o grau de participação e pertença de seus membros, tais como: católico praticante, católico carismático, católico popular

dentre outros. Vale ressaltar que em oposição ao termo católico praticante existe o termo católico não-praticante, o qual é utilizado para designar os indivíduos que, apesar de freqüentar cerimônias religiosas de casamentos, funerais e batizados e declarando-se católicos, não tomam parte regularmente de ritos (por exemplo, a missa aos domingos). Esses católicos muitas vezes desconhecem partes importantes da própria religião e quase sempre discordam dos ensinamentos morais da Igreja quando estes não estão adaptados às tendências do mundo contemporâneo como o relativismo cultural e a liberalidade sexual. Em síntese, embora exista uma grande diferença entre se declarar católico e manter uma prática católica, os censos nacionais não fazem tal distinção ao indagar “Qual é a sua religião?” durante a coleta dos dados censitários.

Em segundo, não se pode ignorar que preconceitos de classe e raça, cujas raízes históricas são bastante profundas, exerçam influência na resposta concedida ao agente censitário. O catolicismo já foi a única religião tolerada no país e a fonte básica de legitimação social, portanto, não seria de se espantar que indivíduos pertencentes e praticantes de outros credos se auto-afirmem católicos, mesmo que o catolicismo tenha perdido sua condição de religião oficial após o advento da República e a liberdade de escolha religiosa faça parte da vida do brasileiro. Essas considerações têm impacto sobre os números apresentados na rubrica das religiões afro-brasileiras (candomblé e umbanda), as quais ainda sofrem agressões e estão sujeitas a fortes preconceitos. A subestimativa das religiões afro-brasileiras, muitas vezes, deve-se também ao fenômeno da dupla pertença e ao sincretismo religioso. Muitos praticantes dessas religiões se declaram católicos porque freqüentam também ritos católicos, visto que desde o início as religiões afro-brasileiras se fizeram sincréticas, mediante o paralelismo entre divindades africanas e católicas, a adoção do calendário de festas católicas e a valorização da freqüência aos ritos e sacramentos da igreja católica. Seguindo a mesma linha de pensamento, a umbanda, a qual é uma síntese do candomblé com o espiritismo kardecista, assiste muitos dos seus integrantes se declararem espíritas, por exemplo. Em linhas gerais, pode-se afirmar que muitos praticantes das religiões afro-brasileiras estão escondidos nas rubricas “católicos” e “espíritas” do censo.

E finalmente, em terceiro lugar, há que se considerar a parcela da população que alega não possuir religião. Essa parcela da população tem crescido ao longo dos anos, passando de apenas 0,3% em 1940 para 7,4% em 2000. A categoria “sem religião” é bastante ambígua, pois essa categoria engloba ateus, agnósticos e indivíduos que não possuem nenhum vínculo com as instituições religiosas tradicionais. O fato de um

indivíduo não possuir vínculo com instituições religiosas não significa que o mesmo não tenha religiosidade ou crença religiosa. De acordo com Carranza¹⁰, esse tipo de comportamento é denominado “*desinstitucionalização*”¹¹ e resulta do individualismo exacerbado promovido pela sociedade de consumo contemporânea. Dessa forma, o aumento dos “sem religião” pode ser compreendido tanto como um indicador de desinteresse pelo vínculo com instituições religiosas como evidência de certo grau de ateísmo da população brasileira.

II.2 CATOLICISMO NO BRASIL

No dia 26 de abril de 1500¹², no litoral sul da Bahia, foi rezada uma missa de Páscoa, a primeira de tantas que desde então foram celebradas naquele que veio a tornar-se o maior país católico do mundo.

O cristianismo chega no Brasil já no descobrimento e lança profundas raízes na sociedade a partir do período da colonização, devido a um acordo de Direito de Padroado firmado entre o Papa e a Coroa Portuguesa. Neste tipo de acordo, todas as terras que os portugueses conquistassem deveriam ser catequizadas, mas tanto as Igrejas quanto os religiosos se submeteriam à Coroa Portuguesa em termos de autoridade, administração e gerência financeira. Ordens e congregações religiosas assumiram serviços nas paróquias e dioceses, institutos educacionais, hospitais e a evangelização indígena.

Os séculos XVI e XVII foram marcados pelos conflitos entre congregações religiosas e colonos em decorrência da escravização de indígenas. Vale lembrar que durante todo esse período o Estado era responsável pelo controle de todas as funções da Igreja e participava de todas as tomadas de decisões, inclusive na intermediação dos conflitos entre colonos e missionários. As conquistas de maior autonomia da igreja iniciam-se no século XVIII, quando as Constituições Primeiras do Arcebispado da

¹⁰ CARRANZA, Brenda. Radiografia dos dados religiosos. Artigo veiculado via internet: data e paginação não definida.

¹¹ O processo de desinstitucionalização religiosa envolve idéias de desfiliação e trânsito, onde as pertencas culturais e religiosas tornam-se opcionais e revisáveis, o que se traduz na proliferação de igrejas, movimentos e grupos informais, que não mais se prendem aos protocolos de autorização ou sanção eclesiástica, bem como na difusão/disseminação do religioso para além das fronteiras reguladas pelas instituições religiosas.

¹² A grande maioria dos dados históricos a respeito do catolicismo foi obtida no site Wikipedia: a enciclopédia livre. Os acessos foram realizados em diversas datas ao longo do ano de 2008 e os dados podem ser acessados e verificados em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Católica_no_Brasil, bem como nos diversos links relacionados ao tema e disponíveis na mesma página.

Bahia, uniformizam o culto, a educação, a formação do clero e a atividade missionária. Mesmo com o agravamento dos conflitos entre colonos e padres, até meados do século XVIII, o Estado ainda manteve o controle, por meio do padroado, da atividade eclesiástica no Brasil. Nas décadas de 1860 e 1870, em decorrência de determinações mais rígidas da Santa Sé em Roma quanto às questões doutrinárias e cerimoniais, os conflitos entre a Igreja e o Estado se agravaram. Porém, somente com a declaração da República, em 1890, é que o catolicismo deixou de ser a religião oficial do país. Uma vez decretada a separação entre Igreja e Estado, a República acabou com o padroado e reconheceu o caráter leigo do Estado e passou a garantir a liberdade religiosa.

Nos primórdios da República Brasileira, as associações e paróquias passaram a editar jornais e revistas para combater a circulação de idéias anarquistas, comunistas ou protestantes. A década de 30 do século XX é marcada pela forte participação da Igreja em assuntos políticos. A Igreja busca a valorização da identidade cultural brasileira expandindo-se para as camadas populares. Nessa época, a Igreja fazia uso da Liga Eleitoral Católica (LEC) para recomendar e apoiar candidatos políticos que se comprometessem em defender os interesses do catolicismo e no final dessa mesma década apóia a ditadura do Estado Novo para conter os avanços dos partidos de esquerda.

Em 1952 é criada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que coordena a ação da Igreja no país. Idealizada por Dom Helder Camara, a CNBB é a primeira agremiação episcopal do mundo com a finalidade de coordenar a ação da Igreja como um todo no território nacional. No final dos anos 50, as preocupações da Igreja voltam-se para as questões sociais geradas pelo modelo de capitalismo no país, como a fome e o desemprego. Com o Regime Militar de 1964 crescem os conflitos entre Igreja e Estado. A partir de 1968, com o Ato Institucional nº 5 (AI-5), os vínculos de apóio mútuo entre Igreja e Estado são aparentemente rompidos diante da violenta repressão - prisões, torturas e assassinatos de estudantes, operários e padres e perseguições aos bispos.

Ainda nessa mesma época, a Igreja atuava em setores populares por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), as quais eram formadas por religiosos e leigos. Inspiradas na Teologia da Libertação e idealizadas, em seu início, pelo Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro Dom Eugênio, elas vinculavam valores cristãos com a luta por justiça social. Os abusos contra a ordem jurídica e os direitos humanos levaram a

Igreja a se engajar fortemente na luta pela redemocratização, ao lado de instituições da sociedade civil.

Ao longo dos anos 80 e 90, com a redemocratização da sociedade brasileira e com alguns de seus ensinamentos fortemente criticados pela Santa Sé, a Teologia da Libertação perde parte de sua influência. Nesse período cresce o vigor da Renovação Carismática Católica (RCC), surgida nos EUA. Em oposição à politização da Teologia da Libertação, o movimento busca uma renovação das práticas tradicionais do catolicismo, enfatizando uma experiência mais pessoal com Deus. Práticas antigas foram retomadas, como a reza do terço e a devoção Mariana, e as cerimônias passaram a ser carregadas de música e emoção. O Movimento de Renovação Carismática valoriza a ação do Espírito Santo, aproximando-se da visão das igrejas neopentecostais evangélicas. Esse movimento religioso atraiu, principalmente, a juventude para os cultos e grupos de oração. Uma das figuras mais proeminente da RCC, por exemplo, é o Padre Marcelo Rossi, religioso paulistano que se tornou um fenômeno de mídia com suas missas-show.

Atualmente, uma das maiores comunidades carismáticas brasileiras é a Canção Nova, a qual é presidida pelo padre Jonas Abib. A Canção Nova trabalha no ramo de evangelização por meio de eventos, peregrinações e da mídia católica (rádio, TV e internet), além de comercializar uma linha de produtos diversificada: livros, CDs, roupas, dentre outras bugigangas.

Os críticos mais ferrenhos da RCC alegam que ela faz uma leitura literal e fundamentalista da Bíblia, além de promover histeria coletiva; não obstante, isso não tem sido empecilho para o crescimento do movimento que é impulsionado pelo uso intenso dos recursos midiáticos.

II.2.1 Catolicismo: unidade religiosa e pluralismo cultural

É surpreendente como a história de uma religião se confunde com a história de um povo. Desde a mítica primeira missa celebrada por Frei Henrique de Coimbra, o catolicismo passou a modelar, à sua maneira, a cultura e a civilização daquela que outrora se chamara Ilha de Vera Cruz e, logo depois, Terra de Santa Cruz.

Historicamente, não é raro que se considere que o catolicismo se impôs à cultura local tal qual uma camisa de força no afã de que as diversas tradições aqui existentes se processassem dentro da lógica cristã. Assim sendo, missionários jesuítas e

colonizadores portugueses, de um lado, nativos indígenas e escravos africanos, de outro lado, são vistos como blocos distintos, totalmente opostos e separados, que se chocam como que em uma disputa. Essas análises históricas ignoram a dialética existente no conflito e a possibilidade de que a evangelização tenha sido reelaborada pelas culturas nativas e africanas a partir de suas próprias representações, impondo dessa forma adaptações nos projetos missionários. Se tal fato não houvesse ocorrido, afirma Sousa Junior, o catolicismo:

(...) não conseguiria sobreviver, manter-se ou mesmo conviver com estas tradições. Embora seja inegável o poder coercitivo desempenhado por esta religião atrelada ao Estado na colônia brasileira, é digno de nota o fato de que esta Igreja permitiu durante todo o tempo invenções, adaptações e recriações no seu próprio interior. Talvez porque soubesse desde o seu primeiro momento na Colônia que desta abertura dependeria sua própria vida. (SOUZA JUNIOR *apud* BRITO, Ênio: 2004, p. 42).

*Alea iacta est!*¹³ Essa postura de tolerância acabou por sedimentar as bases do sincretismo tão presente no catolicismo brasileiro e por definir traços típicos da identidade nacional: a religiosidade popular. A religiosidade popular católica tem assim suas origens fincadas em uma cultura luso-brasileira, desenvolvida no Brasil desde o seu descobrimento. Mas o que explica a existência dessa religiosidade popular desde o período colonial? E ainda, como se explica essa postura de tolerância do catolicismo oficial com as mais variadas formas de religiosidade popular? Segundo Câmara Neto,

as causas são várias e diversas, e têm como pano de fundo a implantação da fé católica em Portugal e as condições de seu domínio americano. Inúmeros grupos étnicos implantaram no território português, aberto ao mar e vizinho à África, um vasto caleidoscópio cultural, onde uma religiosidade de caráter híbrido plasmou-se ao longo dos séculos, tendo como principais vertentes o catolicismo, o islamismo e as práticas fetichistas africanas, todas permeadas de rituais, feitiçarias e superstições. Somando-se a isto a predominância do caráter rural, têm-se o quadro de uma religiosidade *sui generis*, muito mais afeita ao misticismo e à continuidade das crenças pagãs do que próxima a uma religiosidade consentânea aos padrões desejados pela ortodoxia católica.¹⁴

¹³ *Alea iacta est* (ou *alea jacta est*) é a expressão em latim para “a sorte está lançada”. Na verdade a expressão é citada pelo historiador e biógrafo romano Suetônio como *iacta alea est* em seus relatos sobre o imperador romano Júlio César. Segundo seus relatos a frase foi proferida por Júlio César em 10 de Janeiro do ano 49 a.C. enquanto ele liderava seu exército na travessia do riacho Rubicão, localizado no norte da península Itálica. Nesse dia, ele invadiu Roma à frente de seu exército, em um ato de afronta ao Senado romano, e começou uma longa guerra civil contra Pompeu (106 a.C. – 48 a.C.), então líder do Senado. A frase é utilizada hoje em dia para indicar que um evento passou do ponto em que se pode recuar ou desistir e que algo inevitável irá ocorrer. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Alea-iacta-est>.

¹⁴ CÂMARA NETO, Isnard de Abulquerque. Artigo eletrônico da revista de antropologia “Os Urbanistas” disponível em: <http://www.aguaforte.com/antropologia/ISNARD.html>

A manutenção e consolidação da fé romano-cristã sempre foram os principais objetivos da Igreja e para tanto não faltaram manobras de desmoralização das antigas tradições religiosas. Tentou-se estabelecer a hegemonia do catolicismo por meio da imposição das celebrações e da catequese, no entanto, não se logrou dirimir a influência dos antigos cultos. “Estes continuaram a se manifestar, de forma sincrética ou mesmo camuflada, através de formas populares de fé católica, como as festas de santos e romarias” (AZZI, Riolando: 1987, p.79). O Brasil recebeu como herança essa forte comoção para a mística, e “os aspectos devocionais dão mais lugar à fantasia e aos arranjos e conveniências do espírito do que ao cumprimento dos ditames da ortodoxia”¹⁵. Essa forma do catolicismo foi denominada, por diversos estudiosos, como catolicismo tradicional, o qual é o resultado de uma equação complexa que envolve a ingênua e leiga pureza cristã, mesclada com as superstições vulgares de um paganismo europeu e com os resíduos das tradições judaicas de que não se libertaram os novos cristãos, somando-se mais tarde as crenças dos escravos africanos e de indígenas, os quais tiveram que, igualmente, se sujeitar ao culto dos senhores brancos.

O catolicismo tradicional está tão vinculado à cultura do povo brasileiro que, em certos momentos, a diferença entre o cultural e o religioso não é bastante nítida. A religião católica era parte integrante e fundamental da sociedade e toda a cultura era permeada por expressões cristãs. Assim, é válido afirmar que o Brasil é um país de tradição cultural católica. As manifestações do catolicismo tradicional (procissões, novenas, romarias, etc.) vão nortear o imaginário do povo brasileiro em suas relações com o sobrenatural, formando-se em nosso país um catolicismo extra-oficial (leigo), de caráter pragmático, popular e tributário de superstições tomadas de outras religiões ou sistemas de crença. A este opor-se-á o catolicismo renovado: romano, clerical, tridentino, individual e sacramental. Em outras palavras, o catolicismo oficial, voltado para a salvação da alma, fará frente a um “catolicismo de santos”, em que a figura de Cristo perde importância e a resolução dos problemas cotidianos tem primazia sobre a salvação da alma. Os santos, cada um com sua “especialidade”, tornam-se objetos de devoção pessoal do pequeno núcleo familiar (oratório), dos pequenos povoados (capela) ou das grandes massas (santuário). Os santos são os companheiros dessa jornada chamada vida e com eles o fiel mantém um relacionamento íntimo e pessoal: conversa,

¹⁵ CÂMARA NETO, Isnard de Abulquerque. Artigo eletrônico da revista de antropologia “Os Urbanistas” disponível em: <http://www.aguaforte.com/antropologia/ISNARD.html>

pede, agradece e, inclusive, zanga-se. O auxílio dos santos é “recompensado” pelos fiéis com festas, romarias, pagamentos de promessas e procissões, e quando o auxílio pretendido não é recebido, os santos são “punidos”, seja com blasfêmias, seja com “castigos” impetrados nas imagens. Em síntese, segundo Oliveira, o culto devocional é:

caracterizado por uma maneira específica de se relacionar com o santo que se resume na prática de alianças ou contratos, na forma de dom e contra-dom, em que o fiel se compromete a retribuir simbolicamente uma vantagem material ou simbólica conseguida ou pretendida (OLIVEIRA *apud* SILVA, André: 2003 , p. 32).

Isso mostra que a eficácia da divindade é constantemente testada por meio de promessas para a obtenção de pedidos ou através da invocação perene de proteção. A esta relação bastante humanizada com o sobrenatural, reúne-se uma vasta gama de gestualização corporal, tais como: as persignações excessivas (vulgarmente conhecidas como “sinal da cruz”), as genuflexões, a repetição de preces e as penitências envolvendo, geralmente, dolorosos e incômodos sacrifícios físicos.

As festas religiosas, as procissões e os santuários são geralmente o palco dessas demonstrações de fé. Nas festas religiosas, a distinção entre sagrado e profano é imprecisa, pois essas podem ser também consideradas simplesmente reuniões sociais com músicas, cantos, danças, fogos de artifícios, banquetes etc. Além de servir como meio de exibição da gratidão de um indivíduo ou de uma comunidade para com um determinado santo, essas festas religiosas são artifícios para a convivência e confraternização entre um indivíduo e seus semelhantes. Os festejos são geralmente marcados pela pompa das vestimentas, pelo colorido exuberante, pela fartura de alimentos e pelo estrondo das músicas e cantos. Dentre as principais festas estão: o ciclo natalino, a Páscoa, o ciclo Junino, a Semana Santa, Santo Reis, Divino Espírito Santo dentre outras.

As romarias (ou peregrinações) a determinados santuários têm por finalidade exprimir a fé, manifestada seja pela realização de um pedido de graça ou pelo cumprimento de uma promessa, ou simplesmente homenagear a um santo. Diversos são os santuários brasileiros alvos de romarias, com destaque para o santuário da Nossa Senhora da Conceição Aparecida (SP) o qual acolhe romeiros dos pontos mais distantes do Brasil desde que a Virgem Aparecida foi proclamada padroeira do Brasil pelas entidades eclesiásticas. Além do santuário de Aparecida, que inclusive recebeu a visita do Papa Bento XVI em 2007, deve se citar os santuários de Bom Jesus de Iguape (SP),

Bom Jesus da Lapa (BA), Nosso Senhor do Bonfim (BA), Nossa Senhora da Piedade (MG), São Francisco das Chagas (CE) dentre outros. São depositados nesses santuários objetos denominados de ex-votos, os quais representam a obtenção de uma graça e/ou a quitação de uma promessa. Os ex-votos mais comuns são as esculturas de parafina e madeira de partes do corpo humano (em casos envolvendo promessas ligadas à saúde), fotos, gravuras, vestimentas e apetrechos em geral (são depositados, por exemplo, desde vestidos matrimoniais de mulheres que alcançaram o tão almejado matrimônio até capacetes de motoqueiros que sobreviveram à acidentes de trânsito) dentre inúmeros outros objetos.

Neste contexto de festas e romarias surge como força motriz o “milagre”, o qual pode ser entendido como: a realização de um pedido, antes ou após o cumprimento de uma promessa, o bem estar da comunidade devota ou até, como o mero êxito das festas. De acordo com Zaluar (1983), o milagre para os devotos de um santo pode também ser tudo aquilo cujo resultado não seria considerado óbvio ou certo em termos de expectativas, mesmo quando nenhuma graça fora solicitada. Assim como no caso dos Azande, estudados por Evans-Pritchard (1978), em que a “bruxaria” serve para explicar o “acaso” em uma situação cujo desfecho é ruim, o milagre, como modelo inverso, serve para explicar o bom desfecho de acontecimentos que rompem com a continuidade da vida cotidiana. Assim, um telhado que desaba sobre uma família e que não provoca mortes ou ferimentos graves é logo interpretado como um milagre, ocorrido pela intervenção do santo de devoção.

Uma vez feita essa breve apresentação das origens e características do catolicismo popular, vale ainda lembrar, que o termo religiosidade popular é bastante controverso e sua definição ainda é cercada de muitas críticas. A principal crítica dirigida ao termo refere-se a indefinição e falta de rigor do conceito de povo. Há autores que definem a religiosidade popular mediante a comparação entre o ambiente rural e urbano, o primitivo em oposição ao moderno, a resistência do proletariado ao capitalismo, religião prescrita e a religião praticada dentre outros. A tendência, porém, é atribuir as manifestações religiosas populares à camada da população com menor poder aquisitivo e menor grau de instrução acadêmica. Assim, a definição de religiosidade popular estaria pautada em critérios sócio-econômicos, na divisão da sociedade entre classe dominante e classe dominada, cultura de elite e de cultura do povo. Porém, diversos estudos das festas típicas do catolicismo popular revelaram a participação efetiva de fazendeiros, comerciantes e outros membros das elites locais como

contribuintes das “festas do povo”. A classe dominante, de acordo com esses estudos, participa ativamente das festas, embora sua participação nos rituais se dê de maneira condizente com sua posição social. Conclui-se, então, que classes sociais distintas podem compartilhar as mesmas práticas e crenças religiosas e, portanto, a definição de religiosidade popular, única e exclusivamente, por essa via de raciocínio seria equivocada.

É com base nessa conclusão de que a religiosidade popular não é patrimônio de classes oprimidas e marginalizadas, ou seja, que independe de classe social, que surge uma outra tendência de pensamento. Essa outra tendência acredita que a definição da religiosidade popular esbarra inevitavelmente no grau de relação de “ortodoxia” que o devoto mantém com a religião oficial. Assim, o catolicismo popular é definido contrapondo-se religião popular e religião oficial. Nesta vertente de pensamento assume-se que:

a religiosidade popular, portanto, não é corpo eclesial nem corpo doutrinário, configurando-se em uma religiosidade dotada de razoável independência da hierarquia eclesiástica -incluindo-se aí toda a documentação oficial da Igreja e todos os teólogos elaboradores da doutrina-, independência essa do caráter sistemático do catolicismo oficial, materializada em uma explosão quase íntima do “sagrado”, humanizando-o, sentindo-o próximo, testando-o e sentindo sua força por métodos criados, não pelo clero, mas pelos próprios devotos, métodos esses que são transmitidos, em sua grande totalidade, oralmente. Em suma, o vivido em oposição ao doutrinal.¹⁶

A definição proposta por Câmara Neto é muito pertinente, porém, como bem observa Sérgio Ferreti (2001), citando Driessen (1982, p.82), “no contexto do catolicismo, o que existe é mais uma tensão nas relações entre igreja universal e catolicismo local e não exatamente uma distinção entre religião oficial e popular”.

II.2.2 O declínio

Lia-se no quinto artigo da Constituição Brasileira de 1824: “a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular, em casas para isso destinadas, sem

¹⁶ CÂMARA NETO, Isnard de Abulquerque. Artigo eletrônico da revista de antropologia “Os Urbanistas” disponível em: <http://www.aguaforte.com/antropologia/ISNARD.html>.

forma alguma exterior de templo”¹⁷. Com isso o imperador D. Pedro I adotou o catolicismo como religião oficial do país. Os dados do último recenseamento demográfico realizado pelo IBGE mostram que aquela que já foi a religião oficial do Brasil continua sendo, em números absolutos, a religião da maioria dos brasileiros. Em 1991, de acordo com o IBGE, 122 milhões de pessoas se declaravam católicas. Uma década depois, os católicos ainda representavam quase três quartos da população brasileira (125 milhões de pessoas). Esses dados mostram que o número de adeptos do catolicismo continua crescendo, porém, a taxas inferiores à do crescimento populacional. Isso inevitavelmente levou à redução da proporção de católicos na população brasileira. Em 1940 a população brasileira era de 41 milhões de pessoas e 95%, desse total, eram católicos, já em 2000, o Brasil contava uma população de 170 milhões de indivíduos, sendo que apenas 73% desses assumiam a confissão católica. O incremento populacional nesse período foi equivalente a 129 milhões de pessoas, porém, apenas cerca de 67% desses indivíduos (86 milhões de pessoas) aderiram ao catolicismo. Os demais (43 milhões de pessoas) foram engrossar principalmente o saldo das rubricas dos evangélicos e dos “sem religião”.

Os censos, realizados a intervalos regulares de dez anos, revelam o declínio paulatino da proporção de católicos na população brasileira. Segundo Pierucci (2004), à medida que uma sociedade se moderniza, o declínio das religiões tradicionais majoritárias é inevitável e, por conseguinte, a sociologia da religião no Brasil tornou-se uma “sociologia do catolicismo em declínio”. Se por um lado a redução demográfica do catolicismo não causa mais surpresa (ou pelos menos não deveria), por outro lado causa espanto o fato dessa queda no número de adeptos ter se acelerado nas últimas décadas do século XX. Entre 1940 e 1970 a redução no percentual de católicos foi de apenas 4,1%, passando de 95,2% da população residente para 91,1%. Em 1980 esse número caiu para 89,2% e na década seguinte a queda disparou e atingiu o patamar de 83,3%. E finalmente, em 2000, despencou para 73,7% (uma queda de quase 10% em apenas uma década). No último decênio do século XX, *pari passu*, há um crescimento extraordinário do número de evangélicos e do grupo dos “sem religião”. Uma análise mais detalhada, feita no tópico a seguir, irá abordar os prováveis fatores responsáveis por esse aumento na categoria dos evangélicos.

¹⁷ Conforme texto extraído da Constituição Política do Império do Brasil de 1824. Disponível em: [http://pt.wikisource.org/wiki/Constituição_Política_do_Império_do_Brasil](http://pt.wikisource.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Pol%C3%ADtica_do_Imp%C3%A9rio_do_Brasil)

Além da crescente “destraditionalização”¹⁸, em termos religiosos, da sociedade brasileira, é impossível não notar o crescimento da categoria dos “sem religião”. O crescimento desse grupo pode ser atribuído a dois fatores bem distintos. O primeiro fator que poderia explicar esse aumento é o fenômeno de “desinstitucionalização” e, o segundo fator, é o aumento do grau de ateísmo da população brasileira, o qual estaria sendo promovido pelo processo de secularização da sociedade. Os dados apresentados na tabela 5, mais à frente, nos fazem crer que o primeiro deve prevalecer sobre o segundo, visto que 89,7% dos indivíduos sem religião, entrevistados pelo Instituto Gallup em 1988, afirmam acreditar em Deus. Mais de 50% dos entrevistados que declararam não possuir religião, nessa mesma pesquisa, acreditavam na existência de um paraíso no céu, bem como na vida após a morte. Deixando de lado o fato da categoria dos “sem religião” ser bastante questionável, em decorrência das limitações que um censo nacional encerra, este grupo apresenta um crescimento invejável se comparado com as demais categorias utilizadas nos recenseamentos demográficos do IBGE. Passando de insignificantes 0,2%, em 1940, para 7,3% em 2000. E tal como ocorreu com a rubrica dos evangélicos, seu crescimento acelerado processa-se justamente no período em que se acentua a queda do catolicismo.

Se o declínio do catolicismo é inexorável, visto que processo de secularização impõe a todas as religiões a ótica de mercado, cabe a pergunta: será que o Brasil deixará de ser um país majoritariamente católico nas próximas décadas? Em termos econômicos, a religião nos dias atuais é um assunto de “escolha” ou “preferência” do indivíduo ou de um núcleo familiar *ipso facto* carece de obrigatoriedade, em outras palavras, um indivíduo pode decidir que religião quer “comprar”. Se as instituições religiosas convivem com a dinâmica de preferência do consumidor, *a priori*, é de se supor que deveriam levar em conta os desejos dos seus potenciais consumidores ao ofertarem seus bens religiosos. Não obstante, o catolicismo vivenciou uma era de monopólio e talvez não tenha vislumbrado com clareza esse ambiente plural e competitivo contemporâneo. O tradicionalismo religioso, expresso em diversos dogmas católicos, conspira contra as mudanças sugeridas pela preferência dos consumidores secularizados; embora, deva-se ressaltar que isso não significa que os conteúdos

¹⁸ O processo de destraditionalização é uma fase em que os costumes e valores de uma tradição são submetidos a uma reflexão crítica radical. Estes valores são postos à prova e, de acordo com sua validade social e cultural, são aprovados ou não pelos sujeitos. Esse fenômeno traz consigo as seguintes consequências: a necessidade de (re) construção da identidade pessoal; relações e comunidades que se gestam muito mais pela afinidade do que pela proximidade física ou determinação canônica; busca de novos caminhos para a experiência religiosa.

religiosos não estejam suscetíveis a ligeiras mudanças. O que não se pode predizer é a direção dessas mudanças nem o tempo decorrido até que sejam de fato incorporadas. As pressões externas podem, de igual maneira, gerar ou um afrouxamento ou um recrudescimento das heranças confessionais. Seja qual for a direção dessas mudanças, estima-se que o catolicismo no Brasil ainda contabilizará perdas no número de adeptos tendo em vista que os vínculos institucionais estabelecidos com seus fiéis são muitos tênues.

A fraqueza desse vínculo deve-se ao fato do catolicismo ser uma religião que não é seguida à risca pela maioria dos seus adeptos. Quando o vínculo institucional é fraco e quando o processo de iniciação (no caso do catolicismo, o batismo) demanda pouco esforço, nada impede que o indivíduo venha a aderir a outro credo, pois economicamente há pouco ou nenhum custo envolvido na troca. A “compra” de um bem religioso pressupõe a subordinação do indivíduo a todo um arcabouço dogmático e ideológico, o qual é promovido e propagado pela instituição religiosa que o tenha ofertado. Tal subordinação é observada no catolicismo em diferentes graus de intensidade e, para a maioria dos adeptos, os sinais de subordinação são baixíssimos. Em uma pesquisa de opinião do Datafolha, publicada no jornal Folha de São Paulo de 06/05/07, 61% dos entrevistados concordaram com a afirmação “os católicos não praticam sua religião” e, talvez mais surpreendente, seja o fato de 58% dos católicos entrevistados também concordarem com tal afirmação. Adicionalmente, essa pesquisa, constatou que somente 9% dos católicos entrevistados mudaram algum hábito ou deixaram de fazer algo por causa de sua religião, enquanto, por exemplo, 54% dos evangélicos pentecostais responderam “sim” à mesma indagação. Esses dados mostram porque é tão comum haver divergências de opiniões, polêmicas e discussões provocadas pelos discursos eclesiais católicos tanto no ambiente interno como externo da religião e, sobretudo, mostram como é fácil para um católico oscilar entre as categorias “católico praticante”, “católico não praticante” e “sem religião” (subentenda-se indivíduos que embora apresentem crença religiosa recusam-se a assumir publicamente vínculos com quaisquer instituições religiosas).

Em seu artigo “É fácil ser católico” (Folha de São Paulo – 06/05/07), Pierucci afirma que o fato do catolicismo demandar pouco ou nenhum esforço de seus fiéis responde por parte de sua força. Há que se anuir com tal afirmação, com base no que já foi exposto, pois bem se sabe que as bênçãos e perdões para os católicos são inesgotáveis e independem dos níveis de contribuição ou méritos individuais. Tal

comodidade é prerrogativa somente dos católicos, os quais por meio do sacramento da confissão recebem perdão por aqueles pecados cometidos após o batismo. Após a confissão, além da contrição, cabe ao fiel o cumprimento de uma penitência que envolve certas preces ou outros atos determinados pelo sacerdote com a intenção de fazer expiação de todos os males cometidos. Uma diferença que merece menção entre os católicos e os evangélicos é a forma como se processa a confissão. Enquanto para os evangélicos a confissão é pública, no catolicismo a confissão é privada e velada. Isso é importante porque através dos “testemunhos” (confissões públicas) a comunidade evangélica ajuda a controlar o comportamento desviante dos seus membros, pois tem ciência dele. O mesmo já não ocorre no catolicismo, onde praticamente inexistem mecanismos de sanção negativa que, por ventura, poderiam impedir ou coibir a reincidência de comportamentos desviantes. Essa característica complacente do catolicismo serve de atrativo e talvez explique porque é pouco provável que se assista a mudanças drásticas no quadro religioso atual. As perdas de contingente católico, sabendo-se que o fraco vínculo institucional os torna mais suscetíveis aos efeitos da propaganda das demais religiões existentes, estarão assim condicionadas principalmente à disposição de seus adeptos em trocar essa cômoda situação por maior rigor e submissão a pressupostos religiosos.

Flávio Pierucci (2004), com base em suas análises do censo 2000, aponta que em alguns estados brasileiros (Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Espírito Santo) a proporção de católicos encontra-se entre 50% a 60% da população desses estados. Sem fazer quaisquer considerações, o referido autor então conclui que isso indica que os dias do catolicismo como religião majoritária, em um “bom número” dos Estados brasileiros, estão realmente se esgotando. Não acredito porém que a situação particular de nenhuma unidade federativa brasileira, cujas características socioeconômicas são bastante distintas de uma para outra, permita esse tipo de generalização. Além do mais, referir-se a quatro Estados, de um total de vinte e sete unidades federativas, por meio da expressão “bom número” configura-se um exagero. Seria demasiado reducionismo julgar que uma estatística regional seja capaz de predizer tendências aplicáveis ao âmbito nacional em um país tão enorme e com tantos contrastes como o Brasil. Acredito, porém, que talvez os estados mencionados mereçam, dependendo do interesse de outros/as pesquisadores/as, um estudo que revele os fatores que conduziram a perdas mais acentuadas no número de católicos nesse período em comparação com os demais Estados.

II.3 PROTESTANTISMO NO BRASIL

Assim como o catolicismo, a presença do protestantismo no Brasil¹⁹ data do período de sua colonização. Entretanto, há que se mencionar que sua presença nesse período foi temporária e não há indícios de que houvesse nenhum intento real de implantação da Reforma no Brasil. Essa fase do protestantismo coincide com a implantação da colônia francesa no Rio de Janeiro (1555) e com as invasões holandesas na Bahia (1624) e em Pernambuco (1630). Ambos, franceses e holandeses foram expulsos da colônia em 1567 e 1654, respectivamente, porém, deixaram significativa herança religiosa reformada no Brasil. Antônio Mendonça (2004) refere-se a essa fase como “protestantismo de invasão”.

Depois das expulsões não há mais registros de atividades protestantes no Brasil. Somente em 1808, com a elevação do Brasil à categoria de Reino e com a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, surgiu uma brecha oficial que permitia a presença de outra religião que não fosse a católica em solo brasileiro. Em 1824, comunidades de luteranos e reformados se organizam em Nova Friburgo, Rio de Janeiro e em várias outras províncias do Império. Essa fase do "protestantismo de imigração" (CAMARGO, Cândido: 1973) é caracterizada pela formação de pequenas comunidades étnicas de protestantes que aos poucos foram abrindo espaço para a cultura brasileira, como por exemplo, a celebração dos cultos em português.

O "protestantismo de missão ou conversão" (CAMARGO, Cândido: 1973) originou-se de missões norte-americanas do século XIX. Porém, os distribuidores de Bíblias podem ser considerados os verdadeiros pioneiros do protestantismo de missão. As restrições impostas às demais expressões religiosas pela religião oficial, tais como a proibição da prática de proselitismo e limitações quanto à construção de templos, foram contornadas com a divulgação do Evangelho. A distribuição de bíblias independente da pregação formal foi o maior trunfo da propaganda protestante, visto que a simples leitura da Bíblia é um pressuposto para a conversão à fé protestante. Cunhou-se, dessa forma, o termo Evangélico em referência aos indivíduos que liam a Bíblia.

A primeira missão metodista no Brasil iniciou-se em 1836 e foi encerrada cinco anos depois, sendo reaberta somente em 1876, com a chegada do missionário John

¹⁹ A grande maioria dos dados históricos a respeito do protestantismo foi obtida no site Wikipedia: a enciclopédia livre. Os acessos foram realizados em diversas datas ao longo do ano de 2008 e os dados podem ser acessados e verificados em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo>, bem como nos diversos links relacionados ao tema e disponíveis na mesma página.

James Ransom, que organizou a primeira igreja metodista no Rio de Janeiro em 1878. O primeiro missionário presbiteriano, Ashbel G. Simonton, chegou ao Rio de Janeiro em 1859 e a primeira igreja presbiteriana foi organizada em 1862 na mesma cidade. Os batistas organizaram sua primeira igreja em Salvador em 1882, por intermédio dos missionários William B. Bagby e Anne L. Bagby. Os episcopais estabeleceram-se definitivamente no Brasil em 1889, ano da proclamação da República, e iniciaram seus cultos no Rio Grande do Sul no ano seguinte. Desta forma, “todas as tradições históricas da Reforma estavam presentes e organizadas no Brasil até o fim do Império” (Mendonça, 2004, p. 55).

Com o advento da ditadura militar na década de 60, algumas igrejas protestantes se fecharam em si mesmas e passaram a reforçar suas identidades em prejuízo a maior participação em ações sociais e políticas. É inegável, porém, a contribuição dada pelas igrejas tradicionais à sociedade brasileira no que se refere aos costumes e à cultura intelectual, por meio de suas instituições educacionais. O desinteresse pelas questões sócio-políticas e a defesa acirrada de sua identidade provocaram uma retração das igrejas tradicionais e isso acabou abrindo espaço para a multiplicação das igrejas de caráter pentecostal.

Sob o ponto de vista das idéias mais próximas da Reforma Religiosa ocorrida no século XVI, o protestantismo brasileiro poderia ser dividido em três grandes grupos: os protestantes tradicionais (episcopais anglicanos, luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas dentre outros), os pentecostais (Congregação Cristã no Brasil²⁰, Assembléia de Deus, Brasil para Cristo, Evangelho Quadrangular e outras) e os neopentecostais (Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Renascer em Cristo etc.). Esses três grupos são tão distintos entre si que alguns estudiosos julgam inadequado utilizar o termo “protestantismo brasileiro” para denominar os cristãos não-católicos no Brasil. Segundo Antônio Mendonça (2004, p.76) é necessário “trabalhar com o conceito de campo cristão não-católico e, dentro dele, estabelecer as distinções necessárias e evitar as generalizações inadequadas que vêm sendo feitas”. Mesmo ciente da diversidade de expressões religiosas que o termo “protestante” encerra, por enquanto

²⁰ A igreja Congregação Cristã do Brasil é em geral incluída entre o grupo de pentecostais clássicos, visto que apresenta características que dificultam sua classificação. Tem origens pentecostais, entretanto, possui significativo distanciamento das práticas de glossolalia e mantém firmemente uma teologia com traços calvinistas (portanto, está mais próxima do grupo dos protestantes tradicionais). A ordem e a disciplina são mantidas por uma liderança admirável visto que a tradição é mantida exclusivamente pela comunicação oral. É uma igreja pré-milenista que possui uma visão negativa quanto à participação política de seus fiéis.

serão mantidas as classificações usuais, pois não é propósito desse trabalho elaborar novas categorias classificatórias das religiões em estudo. Não obstante, adianto que no capítulo III, essas classificações serão reformuladas de acordo com a obra de Jonatas S. Meneses, a qual me parece mais satisfatória para o alcance dos objetivos aqui propostos.

II.3.1 Pentecostalismo: a Era do Espírito

Pentecostalismo é como se chama a doutrina de determinados grupos religiosos cristãos, originados no seio do protestantismo, que se baseia na crença do poder do Espírito Santo. Tradicionalmente reconhece-se o início do movimento pentecostal no ano de 1906, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na Rua Azuza, onde houve um grande reavivamento espiritual caracterizado principalmente pelo “batismo com o Espírito Santo”, evidenciado pelos dons do Espírito (glossolalia, curas milagrosas, profecias, interpretação de línguas e discernimento de espíritos, dentre outros). O fervor missionário (proselitismo), a alegria, o entusiasmo, os sinais externos de santidade (roupas e costumes recatados) e as manifestações dos dons do Espírito Santo são as principais características dos integrantes desse movimento que acredita que o Espírito Santo continua a se manifestar nos dias de hoje, tal como ocorreu na festa de Pentecostes, a qual é uma festa do antigo calendário bíblico israelita e cujo significado é “cinquenta dias depois” (da Páscoa), na narrativa do Novo Testamento (Atos 2, 1-13). Nessa passagem, o Espírito Santo manifestou-se aos apóstolos por meio de línguas de fogo e fez com que eles pudessem falar em outros idiomas (glossolalia) para serem entendidos pela multidão heterogênea que os ouvia.

Liderados por William Seymour (1870-1922), o avivamento da Rua Azuza, antes realizado informalmente por alguns poucos fiéis em um velho galpão, ganhou destaque na mídia e atraiu mais pessoas e rapidamente grupos semelhantes foram se organizando pelo território americano. Surgiram assim grupos independentes com novas denominações e algumas denominações protestantes já estabelecidas adotaram doutrinas e práticas pentecostais, por exemplo, a Igreja de Deus em Cristo. Posteriormente, houve inclusive alguns grupos ligados ao movimento pentecostal que começaram a crer no unicismo em vez da trindade (Pai, Filho e Espírito Santo). Com o crescimento da rivalidade entre os que criam no unicismo e os que criam na trindade, ocorreu um cisma e novas denominações nasceram, por exemplo, a Igreja Pentecostal Unida (unicista) e as Assembléias de Deus (trinitária).

No Brasil, o Pentecostalismo chegou em 1910-1911, com a vinda dos missionários americanos: Louis Francescon, que dedicou seu trabalho entre as colônias italianas no Sul e Sudeste do Brasil, originando a Congregação Cristã no Brasil; Daniel Berg e Gunnar Vingren, que iniciaram suas missões na Amazônia e Nordeste, dando origem às Assembléias de Deus. A expansão pentecostal brasileira é geralmente classificada em três grandes ondas. A primeira, chamada pentecostalismo clássico, abrangeu o período de 1910 a 1950 e iniciou-se com a implantação de igrejas protestantes no país. A Congregação Cristã no Brasil e da Assembléia de Deus foram as primeiras a serem fundadas e, com o passar do tempo, difundiram-se pelo território nacional. Desde o início, ambas as igrejas caracterizam-se pelo anticatolicismo, pela ênfase na crença no batismo no Espírito Santo e por um ascetismo que rejeita os valores do mundo e defende a plenitude da vida moral.

A segunda onda começou a surgir na década de 1950, quando chegaram a São Paulo dois missionários norte-americanos da *International Church of The Foursquare Gospel*. Na capital paulista, eles criaram a Cruzada Nacional de Evangelização e, centrados na cura divina, iniciaram a evangelização das massas, principalmente pelo rádio. Em seguida, fundaram a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mais tarde surgiram a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, O Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Casa da Bênção, Igreja Unida, Igreja de Nova Vida e diversas outras igrejas pentecostais menores.

A terceira onda data de meados dos anos 70, coincidindo com o período da ditadura militar e da modernização das comunicações brasileiras, e é conhecida usualmente como neopentecostal. A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Renascer em Cristo são os principais expoentes desta fase.

A tabela 2, a seguir, mostra a evolução do contingente evangélico no Brasil a partir da década de 40. Observa-se, nessa tabela, que a proporção de evangélicos na população brasileira tem aumentado constantemente. No início da década de 40 totalizavam apenas 2,6% da população residente, trinta anos depois somavam 5,8% da população e, na passagem do século XX para o século XXI, saltam para 15,4% do total da população brasileira. A última década do século XX é o período que registra o maior aumento no número de evangélicos: em números absolutos passam de 12,6 milhões de pessoas para 26,2 milhões, ou seja, o contingente de evangélicos mais que duplica nesse período.

Tabela 2 – Evolução População Evangélica – Brasil

Ano	1940	1950	1960	1970	1980	1991	2000
População (em milhões)*	41,2	51,9	70,1	93,1	119,0	146,8	169,8
% evangélicos**	2,6	3,4	4,3	5,8	6,6	8,6	15,4
No. Evangélicos (em milhões)	1,1	1,8	3,0	5,4	7,9	12,6	26,2
Variação (em milhões)	-	0,7	1,2	2,4	2,5	4,7	13,6

(*) Fonte: IBGE, <http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/demograficas.html>

(**) Fonte: PIERUCCI, Antônio Flávio. Bye bye, Brasil – o declínio das religiões tradicionais no Censo 2000, com exceção dos percentuais de 2000 e 1991 que foram obtidos diretamente das tabelas do IBGE.

Uma análise detalhada dos 26,2 milhões de evangélicos no Brasil em 2000 demonstra que: 17,6 milhões são evangélicos de origem pentecostal, 6,9 milhões são evangélicos oriundos de igrejas classificadas na categoria do “protestantismo tradicional” (ou de missão) e o restante, 1,6 milhões, representam evangélicos sem afiliação institucional ou vinculados às pequenas denominações protestantes. A Tabela 3 e a Tabela 4, a seguir, demonstram a composição dos evangélicos de missão e dos evangélicos de origem pentecostal em 2000 por denominação religiosa, respectivamente.

Tabela 3 – Evangélicos de Missão (Brasil, 2000)

Denominações	No. Adeptos	% no grupo	% total evangélicos
Batista	3.162.691	45,6	12,1
Adventista	1.209.842	17,4	4,6
Luterana	1.062.145	15,3	4,1
Presbiteriana	981.064	14,1	3,7
Metodista	340.963	4,9	1,3
Congregacional	148.836	2,1	0,6
Outras	34.224	0,5	0,1
Total	6.939.765	100,0	26,5

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

Tabela 4 – Evangélicos de Origem Pentecostal (Brasil, 2000)

Denominações	No. Adeptos	% no grupo	% total evangélicos
Assembléia de Deus	8.418.140	47,8	32,1
Congregação Cristã no Brasil	2.489.113	14,1	9,5
Universal do Reino de Deus	2.101.887	11,9	8,0
Quadrangular	1.318.805	7,5	5,0
Deus é Amor	774.830	4,4	3,0
Maranata	277.342	1,6	1,1
Brasil para Cristo	175.618	1,0	0,7
Casa da Benção	128.676	0,7	0,5
Nova Vida	92.315	0,5	0,4
Outras	1.840.581	10,4	7,0
Total	17.617.307	100,0	67,3

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

Somados, evangélicos de missão e evangélicos de origem pentecostal representam, em 2000, 93,8% do total de evangélicos do país, sendo que mais de um terço (32,1% para ser exato) desse total é representado pelos fiéis da igreja Assembléia de Deus, 12,1% são afiliados à igreja Batista, 9,5% à igreja Congregação Cristã no Brasil e 8% estão vinculados à IURD. Esse grupo, de apenas quatro das inúmeras instituições religiosas protestantes brasileiras, respondem por 61,7% do total de evangélicos brasileiros. De acordo com o censo de 1991, a Igreja Assembléia de Deus tinha 2,4 milhões de fiéis, o que correspondia a 29,8% dos pentecostais e 18,3% do total de evangélicos, em 2000, conforme mostra a Tabela 4, o número de fiéis dessa instituição triplicou: são agora 8,4 milhões de fiéis perfazendo 47,8% do total de evangélicos de origem pentecostal e 32,1% do total de evangélicos no Brasil. Tamanha façanha, em termos de crescimento percentual, só é superada pela IURD, a qual logrou um aumento de 682% na última década do século XX. O censo de 1991 indicava que a IURD possuía cerca de 269 mil seguidores, já em 2000, esse grupo atingiu a marca de 2,1 milhões de pessoas.

Uma das principais características do pentecostalismo é a sua fragilidade institucional, ou seja, os vínculos que mantêm fiéis e pastores ligados à determinada igreja podem ser facilmente rompidos por dissidências teológicas ou administrativas. Essa fragilidade gera inúmeras cisões que, por sua vez, levam ao surgimento de uma grande gama de denominações, igrejas e seitas. O total de Outras igrejas de origem pentecostal mostra que 10,4% (quase dois milhões de pessoas) dos pentecostais estão distribuídos em uma série de “micro-igrejas”. Alguns números apresentados na Tabela

4, entretanto, demonstram um movimento contrário a essa característica inata de pulverização, ou seja, a tendência à concentração. Nota-se que 54,6% dos pentecostais brasileiros são representados apenas por quatro instituições religiosas, a saber: Assembléia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, IURD e Igreja do Evangelho Quadrangular.

Com o advento do pentecostalismo, várias denominações protestantes tradicionais experimentaram movimentos internos, com manifestações pentecostais. Assim, após as devidas cisões, foram denominados “Renovados”, como a Igreja Presbiteriana Renovada (originária da Igreja Presbiteriana), Convenção Batista Nacional (originária da Convenção Batista Brasileira), Igreja do Avivamento Bíblico (originária da Igreja Metodista), Igreja Cristã Maranata (originária também da Igreja Presbiteriana) e a Igreja Adventista da Promessa (originária da Igreja Adventista do Sétimo Dia). Nos anos mais recentes a doutrina de renovação do pentecostalismo ultrapassou até mesmo as fronteiras do protestantismo, surgindo movimentos de renovação pentecostal até mesmo na igreja católica, como a Renovação Carismática Católica (RCC). O padre católico Marcelo Rossi ao realizar mega-eventos (incluindo o lançamento de filmes e a realização de missas-show), ao fazer benção das carteiras profissionais de desempregados e orações, via rádio e TV, não fica afastado do mundo da diversão e do espetáculo promovido pelas práticas neopentecostais.

II.3.2 Neopentecostalismo: prosperidade, cura e exorcismo

A terceira fase do protestantismo brasileiro é conhecida como neopentecostalismo. A IURD (fundada e liderada pelo bispo Edir Macedo no Rio de Janeiro em 1977) foi a primeira instituição religiosa da fase neopentecostal criada no Brasil. Adicionalmente, a Igreja Internacional da Graça de Deus (liderada e fundada pelo missionário R. R. Soares em 1978 também no Rio de Janeiro), a Renascer em Cristo (criada pelo apóstolo Estevam Hernandes e sua esposa, a bispa Sônia, em 1986 no estado de São Paulo) e a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (Brasília, 1992) figuram como os precursores e os principais expoentes dessa fase.

Diferentemente dos pentecostais, os cultos neopentecostais não enfatizam a experiência individual e coletiva da posse do Espírito Santo. Esses cultos inovam ao introduzirem práticas sincréticas do catolicismo popular, das religiões afro-brasileiras, do espiritismo, bem como, algumas crenças e superstições populares sem qualquer

vínculo religioso (por exemplo, o mau olhado). A prática religiosa neopentecostal baseia-se: a) na adoção de uma teologia da prosperidade, cujo pressuposto filosófico é a confissão positiva, ou seja, “a convicção de que a palavra dita com fé, repetida continuamente, sem dúvida alguma, a despeito de quaisquer evidências contrárias, gera milagres” (SILVA, 2000, p. 54); b) em curas milagrosas, as quais são corroboradas mediante testemunho público dos fiéis, e; c) na prática do exorcismo, cujo alvo são espíritos e demônios geralmente associados às divindades das religiões afro-brasileiras. Com base nesses três pilares, as igrejas neopentecostais usam toda sua criatividade ritual para promover múltiplas atividades e bênçãos, tais como: reunião de louvor e adoração, sessão do descarrego e de quebra de feitiçaria, corrente da família, marcha para Jesus, campanha da multiplicação etc. com o intuito de manter o fiel ligado à igreja, atrair novos adeptos e arrecadar recursos financeiros.

Atualmente no Brasil, diversos programas religiosos são transmitidos diariamente em canais abertos e de TVs por assinatura e, rádio. Tanto os setores da igreja católica quanto das protestantes se articulam na aquisição de poderosas redes de comunicação com diversas finalidades, as quais vão desde a comercialização da fé até a difusão do Evangelho. As igrejas neopentecostais, notoriamente, são as que mais intensamente utilizam a mídia eletrônica e os meios de comunicação massiva: o rádio, a TV e a mídia impressa, e por isso, alguns autores as denominam “igrejas eletrônicas”. Paradoxalmente, embora as igrejas neopentecostais façam uso mais intenso dos meios de comunicação massiva, “a mentalidade, a ética e a ação continuam marcadas pelo individualismo que visa a solução religiosa de problemas pessoais de ordem existencial ou material” (MENDONÇA, Antônio: 2004, p.75).

Berger (1985, p. 149) afirmava que em situações de pluralismo religioso “as instituições religiosas tornam-se agências de mercado e as tradições religiosas bens de consumo”, portanto, não é de se espantar que a lógica de mercado que norteia a difusão da propaganda religiosa permita a utilização de apelos nem sempre éticos quanto à veracidade dos milagres anunciados. Os testemunhos públicos (ou sua dramatização na TV ou rádio), daqueles ditos vitoriosos, encorajam outros a tomarem o mesmo caminho em busca de resultados semelhantes. A despeito da questionável veracidade desses testemunhos, de uma forma geral, a mídia tem sobretudo colaborado para que as peculiaridades “dos grupos religiosos se moldem confortavelmente à vida social do

Brasil, mudando a forma de convivência e de percepção da realidade religiosa”²¹. Dessa forma, logra-se, por exemplo, substituir a imagem estereotipada do indivíduo evangélico (ou simplesmente “crente”, no linguajar popular) por imagens com contornos mais próximos da realidade contemporânea. O “crente”, cujo estereótipo é o homem de paletó ou a mulher de saia comprida e cabelos longos que deliberadamente negaram os prazeres mundanos e temporais, agora é o artista, o cantor, o empresário, a dona-de-casa, o político ou qualquer profissional com o qual o expectador se identifique e, portanto, não estão mais sujeitos às avaliações pejorativas e preconceituosas. Essa intensa utilização da mídia aliada a outros fatores que escapam ao escopo desse trabalho refletiu-se no censo: o número de evangélicos de origem pentecostal passou de 8,1 milhões de pessoas, em 1991, para 17,6 milhões em 2000. Ainda no que se refere aos números do censo, vale mencionar, que a IURD é a maior igreja neopentecostal do Brasil, representando cerca de 12% do grupo de igrejas de origem pentecostal e 8% do total de evangélicos do país. Esse crescimento é parcialmente explicado pela utilização de técnicas administrativas de gestão empresarial, principalmente, o marketing religioso.

Outro ponto de relevância quanto à caracterização das igrejas neopentecostais é o seu ataque aos símbolos de herança religiosa africana presentes no Brasil. As igrejas neopentecostais, em geral, têm a crença de que é preciso eliminar a presença do diabo no mundo e que as demais religiões estão pouco engajadas nessa missão ou servem de palco para a ação do demônio, o qual se disfarça nas divindades cultuadas nessas religiões. As religiões afro-brasileiras (candomblé e umbanda), bem como o espiritismo kardecista, são os principais alvos da ira neopentecostal que se expressa por meio de: ataques feitos no âmbito dos cultos neopentecostais e em seus meios de divulgação, agressões físicas contra os membros dessas religiões, interrupção das cerimônias religiosas afro-brasileiras realizadas em espaço público (incluindo a depredação de qualquer construção que guarde relação simbólica com essas religiões) dentre outros. Esse ataque frontal às religiões afro-brasileiras acabou gerando, paradoxalmente, a incorporação da liturgia afro-brasileira nas práticas neopentecostais: são freqüentes as sessões de exorcismo (ou descarrego) dentro das igrejas neopentecostais, onde as “entidades demoníacas” são impelidas a incorporar para, em seguida, serem

²¹ PATRIOTA, Karla Regina M. P. Mídia e religião: 82 horas de missas, cultos, pregações e exorcismo. Extraído de seu trabalho apresentado à Sessão de Temas Livres da Intercom. Acessado em 07/03/08. Disponível em: <http://repositorio.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/16956/1/R0238-2.pdf>.

desmoralizadas e expulsas como forma de libertação espiritual do fiel, o qual é visto como vítima de malefícios (doença, desavença familiar, problemas financeiros, vícios etc.) causados pelo contato direto ou indireto com elementos do candomblé e da umbanda. Observa-se, então, dois fenômenos no seio das igrejas neopentecostais: a) “um retorno ao ritual mágico como uma dimensão crucial da prática da fé e dos mecanismos de salvação ou obtenção da graça” (SILVA, Vagner: 2007, sem pag. definida) e; b) um entrelaçamento entre os dois sistemas (neopentecostal e afro-brasileiro), fazendo com que as crenças de ambos sistemas “se sobreponham e forneçam previamente seus significados, um a serviço da eficácia simbólica do outro” (SILVA, Vagner: 2007, sem pag. definida). A disseminação do conteúdo das religiões afro-brasileiras pelas igrejas neopentecostais (na forma de livros, programas de TV e rádio, sessões de exorcismo etc.), mesmo de uma maneira vexatória, é responsável pela eficácia dos rituais de cura e libertação, pois o vocabulário e os símbolos religiosos afro-brasileiros foram apreendidos por seus fiéis e, assim, possuem um significado que lhes garante a “eficácia simbólica” preconizada por Levi-Strauss (1975).

Esse embate entre neopentecostais e as religiões afro-brasileiras pode induzir muitos a classificá-la como uma religião fundamentalista. Essa suposição todavia é equivocada, pois como sabiamente aponta Antônio Mendonça, os neopentecostais:

não usam o texto bíblico primordialmente como repertório da verdade, mas como motivação para a prédica e a prática. A Bíblia, para eles, parece ser mais um repertório de contos exemplares. Não se nota entre eles, nessa prática, o dogmatismo típico do fundamentalismo e nem mesmo a tentativa de imposição de verdades literais. Fazem, sem dúvidas, leituras literais da Bíblia, mas com sentido ilustrativo (MENDONÇA, Antônio: 2004, p.75).

II.4 ESPIRITISMO NO BRASIL

Allan Kardec era o pseudônimo do pedagogo francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, nascido em Lyon (França) em 1804, que formulou e divulgou a doutrina espírita com a publicação do *Livro dos Espíritos* em 18 de abril de 1857. No Brasil, o espiritismo chegou enquanto Allan Kardec ainda escrevia os demais livros que constituiriam o corpo da doutrina espírita. Acredita-se que, em meados do século XIX, imigrantes e leitores de jornais europeus passaram a reproduzir em solo brasileiro o que era moda e diversão nos salões europeus: a comunicação com mortos por meio de movimentos e batidas estrondosas em mesas. Somente mais tarde, o divertimento deu

lugar à constituição de grupos voltado ao estudo e divulgação das obras de Allan Kardec.

Enquanto na Europa prevalecia a ênfase na dimensão experimental e científica da doutrina, no Brasil tornou-se dominante a feição religiosa, mística e terapêutica.²² Atraindo a classe média, esse espiritismo resignificado foi amplamente divulgado no país. Em setembro de 1865, em Salvador, Bahia, foi criado o “Grupo Familiar do Espiritismo”, o primeiro Centro Espírita Brasileiro. Em 1873, fundou-se a “Sociedade de Estudos Espíritas”. Esse grupo dedicou-se a traduzir para o português as obras de Kardec, tais como: *O Livro dos Espíritos* (1857), *O Livro dos Médiuns* (1861), *O Evangelho Segundo o Espiritismo* (1864), *O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo* (1865) e *A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo* (1868). Além dessas traduções, esses dois grupos foram responsáveis pela edição do primeiro periódico espírita brasileiro, *Echos do Além Túmulo*, lançado na Bahia em 1865 e pela edição e publicação, em 1860, do primeiro livro espírita brasileiro (*Les temps sont arrives* de Casimir Lieutaud), embora esse tenha sido redigido em francês.

Em 1884 foi fundada a Federação Espírita Brasileira (FEB) que hoje constitui uma das principais entidades representativas do espiritismo no Brasil. A FEB tem como objetivo difundir a doutrina espírita, baseada nas obras de Allan Kardec, além de promover seu estudo e sua prática por meio da caridade. A difusão da doutrina é feita principalmente pela publicação de obras espíritas, periódicos (revista Reformador) e veiculação de programas de rádio e TV (Brasil Espírita e Terceira Revelação). A prática é materializada na oferta de serviços assistenciais que visam beneficiar àqueles que buscam conforto espiritual e material. O estudo é promovido atualmente através do programa de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - ESDE. Embora atue de forma intensa no processo de divulgação da doutrina, a FEB não é um órgão de centralização

²² Essa idéia é suportada por argumentos de Cândido Procópio Camargo em seu livro “Kardecismo e Umbanda” (1961) no qual afirma que a ênfase no aspecto religioso constituiu o traço distintivo do espiritismo brasileiro. Em seu livro “Católicos, Protestantes, Espíritas” (1973) Camargo reafirma que embora o espiritismo não tenha sofrido modificações essenciais ao ser transplantado para o Brasil, sua adaptação à realidade social brasileira realçou o aspecto religioso em contraposição ao filosófico e científico. Mais tarde, seguindo a mesma linha de pensamento, outros autores afirmariam que o espiritismo no Brasil floresceu seguindo caminhos próprios mediante a redução da doutrina de Allan Kardec a uma religião com procedimentos rituais tipicamente cristãos. Roger Bastides (1985) e Ubiratan Machado (1983), ambos citados por Sandra J. Stoll em seu livro “Espiritismo à Brasileira” (2003), mostram que a reinterpretação mágica da obra de Kardec consiste em uma prática específica de certas classes sociais, notadamente as classes populares que se apegavam à dimensão terapêutica (o tratamento da saúde dos vivos pelas entidades desencarnadas), dada a familiaridade da população brasileira com práticas mediúnicas de origem africana.

hierárquica dos “centros espíritas”²³. Os “centros espíritas” podem ou não se filiar a FEB, ou seja, estão livres para organizarem-se e desenvolver suas atividades sem qualquer tipo de subordinação hierárquica.

Além desse forte investimento no campo literário, outras atividades contribuíram para a consolidação da presença do espiritismo no território nacional. O desenvolvimento da atividade doutrinária associada às práticas de cunho assistencial (distribuição de roupas e alimentos) e terapêutico (“passes” e cirurgias espirituais) fez com que o espiritismo se disseminasse rapidamente por intermédio dos “centros espíritas”.

O espiritismo é uma das religiões que mais tem crescido no Brasil. Em 2000, o Brasil concentrava 2,3 milhões de espíritas, sendo o país com maior número de espíritas do mundo. Não se trata de um volume significativo, visto que cerca de 74% (ou 126 milhões de pessoas) da população brasileira se declara católica. O contingente de espíritas em frente ao número de católico é inexpressivo, contudo, esses dados numéricos não refletem o grau de absorção de idéias da doutrina espírita pelo imaginário brasileiro. A tabela 5, a seguir, baseada em uma pesquisa de opinião pública realizada pelo instituto Gallup em Julho de 1988, mostra em que crêem os brasileiros. Essa pesquisa revelou que 98,5% dos entrevistados acreditam em Deus e que apenas 0,5% não acreditam em absolutamente nada do que havia sido citado. Porém, o fato realmente interessante é que 45,9% dos católicos que freqüentam a missa e outros serviços religiosos semanalmente acreditam em reencarnação, o qual é um credo reconhecidamente pertencente à tradição doutrinária espírita. Além disso, quase 40% daqueles que declaram não serem adeptos de nenhuma religião acreditam na reencarnação. Essa média de crença na reencarnação também prevalece para a população entrevistada como um todo, pois 45,4% dos entrevistados alegam crer em reencarnação. Vale mencionar que a crença em vida após a morte é ainda mais elevada, atingindo a marca de 61% daqueles entrevistados.

²³ “Centro espírita” é o termo utilizado por brasileiros para designar o local regular de reuniões onde se desenvolve atividades ligadas a diversas crenças e numerosos cultos, os quais envolvem ritos de origem africana, do espiritismo e do catolicismo. Devido ao sincretismo, não são apenas os espíritas (kardecistas) que utilizam o referido termo, ou seja, outras práticas religiosas no Brasil utilizam o termo “centro espírita” em referência a seu local de encontro e culto, a saber: a umbanda e o candomblé. A distinção se faz necessária porque as atividades realizadas diferem muito de acordo com o vínculo religioso do “centro espírita”. Nos locais em que se segue a doutrina de Allan Kardec, as reuniões podem ter um caráter público ou privado. As reuniões de caráter público são geralmente doutrinárias ou de evangelização (estudo e discussão de obras relativas à doutrina espírita). As reuniões privadas (ou reservadas) podem ser mediúnicas (desenvolvimento ou desobsessão espiritual), de tratamento espiritual (passes e cirurgias) ou de materialização (psicografia e outros fenômenos relacionados a essa prática religiosa).

Tabela 5 – Pesquisa de Opinião Pública Instituto GALLUP: Crenças (Brasil, 1988)

Você acredita em:	Total	Católicos*	Sem religião
Deus	98,5	99,9	89,7
Céu	74,0	80,5	55,9
Vida pós morte	61,0	64,0	50,6
Destino	58,6	60,0	45,4
Inferno	49,6	55,6	44,1
Reencarnação	45,4	45,9	39,9
Horóscopo	19,4	19,6	15,7
Amuletos	17,8	16,3	12,1
Cartomantes	12,5	11,9	8,5
Em nada	0,5	0,1	5,5

Fonte: CARNEIRO, Leandro e SOARES, Luiz Eduardo. Religiosidade, estrutura social e comportamento político.

(*) Inclui somente aqueles que freqüentam a igreja semanalmente.

Adicionalmente, em uma matéria da revista Veja de 2 de Abril de 1997, uma pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi mostrou que 69% dos entrevistados acreditavam em vida após a morte, sendo que 22% desse total acreditava que a jornada até as esferas superiores passava por outras encarnações e diferentes planos de existência. Em uma outra matéria da revista Veja de 19 de Dezembro de 2001 (edição 1.731), o Instituto Vox Populi realizou uma enquête com base em 1.017 entrevistas efetuadas por telefone entre a população adulta de 184 municípios em todas as regiões do país. Além da diversidade regional, a pesquisa refletiu a variedade de rendimentos, escolaridade e filiação religiosa dos brasileiros e, os resultados mostraram que 69% dos entrevistados acreditavam em punição ou recompensa após a morte, sendo que o grau de escolaridade e a classe social apresentaram pouca influência sobre essa crença. A crença em vida eterna no paraíso tem aceitação de 96% dos evangélicos, 84% dos católicos, 72% dos praticantes de religiões mediúnicas e de 68% daqueles que declaram não ter religião. Essa crença, surpreendentemente, tem maior aceitação entre os indivíduos de classe média e escolaridade elevada. Ao serem indagados sobre suas expectativas após a morte, 34% dos entrevistados afirmaram que iriam direto para o céu ou paraíso, 15% declararam que iriam reencarnar e cerca de 11% julgavam que iriam para o purgatório. Embora 55% dos entrevistados afirmem acreditar no inferno ou em punição eterna,

nenhum dos entrevistados afirmou que iria para o inferno após a morte. Além de mostrar que o universo católico brasileiro carece de consistência doutrinária, essas pesquisas demonstram que o sincretismo é um fenômeno que põe em cheque os quadros estatísticos de contornos claros e bem definidos e cumpre-nos reconhecer que “o fundamental não é saber quantas pessoas se identificam publicamente como umbandistas, espíritas etc., mas ser capaz de perceber o significado desse conjunto de crenças e sua importância para construções sociais da realidade em nossa cultura” (VELHO *apud* STOLL, Sandra: 2003, p. 52). Até certo ponto, podemos afirmar que muitos aspectos da doutrina espírita foram incorporados pela população brasileira e são partes constitutivas do *ethos* nacional em decorrência dos trabalhos de Chico Xavier, o qual será discutido em tópico à parte.

As tabelas 6 e 7 a seguir, mostram o perfil dos seguidores dos vários grupos religiosos no Brasil, por raça e número médio de anos de estudo de acordo com o censo de 2000.

Tabela 6 - Cor declarada dos seguidores por grupo religioso (Brasil, 2000)

Religião	Brancos	Pretos	Pardos	Outros*	Total
Católica	54,5	5,8	38,2	1,5	100%
Evangélicas históricas	61,2	4,9	32,3	1,6	100%
Evangélicas pentecostais	49,3	7,0	42,3	1,4	100%
Espíritas	75,6	4,6	18,5	1,3	100%
Candomblé	37,4	22,8	37,6	2,2	100%
Umbanda	54,5	16,7	27,3	1,5	100%
Sem Religião	44,5	9,3	44,0	2,2	100%
Total Brasil	53,7	6,2	38,5	1,6	100%

Fonte: PRANDI, Reginaldo – Segredos Guardados: Orixás na alma brasileira.

(*) Inclui asiáticos, indígenas e cor não declarada.

Observa-se na tabela 6 que o espiritismo é a religião que mais apresenta adeptos que se declararam da cor branca: 75,6% (1,7 milhões em números absolutos). Os evangélicos de missão (protestantes históricos) são o grupo que apresentam o segundo maior contingente de brancos, em termos percentuais, com 61,2%. O percentual de indivíduos de cor branca do catolicismo e da umbanda são equivalentes, ou seja, 54,5% dos seguidores dessas religiões se declaram brancos. Nota-se nessa mesma tabela que as

religiões afro-brasileiras, ao contrário do que usualmente se imagina, não são mais uma religião étnica, ou seja, exclusiva de indivíduos de origem africana. O contingente de brancos e pardos é superior ao número de adeptos declarados pretos, em ambas as religiões.

Tabela 7 - Média de anos de estudo por grupo religioso (Brasil, 2000)

Religião	1991	2000
Católica	4,6	5,8
Evangélicas históricas	5,8	6,9
Evangélicas pentecostais	4,0	5,3
Espíritas	8,3	9,6
Afro-brasileiras	6,3	7,4
Sem Religião	5,1	5,7
Total Brasil	4,7	5,9

Fonte: PRANDI, Reginaldo – Segredos Guardados: Orixás na alma brasileira.

De acordo com a tabela 7, os espíritas tiveram médias de 8,3 e 9,6 anos de estudo nos censos de 1991 e 2000, respectivamente. Essa constatação, aliada a análise dos dados da tabela 6, permite afirmar que o espiritismo no Brasil é seguido principalmente pela classe média branca de escolaridade elevada. Os adeptos das religiões afro-brasileiras também apresentam escolaridade elevada, se comparados com a média para o Brasil como um todo, atingindo a média de 6,3 e 7,4 anos de estudo nos censos de 1991 e 2000, respectivamente. Segundo Prandi (2005), isso denota a penetração da classe média branca escolarizada nas religiões afro-brasileiras. Os pentecostais apresentam as menores médias de anos de estudo nos dois censos consecutivos, ficando abaixo da média encontrada para o conjunto da população brasileira.

II.4.1 Chico Xavier: espiritismo à brasileira

No dia 2 de abril de 1910, nasceu na cidade de Pedro Leopoldo (MG), Francisco de Paula Cândido, o qual em meados dos anos 60 alteraria oficialmente seu nome para Francisco Cândido Xavier e, que seria conhecido simplesmente como Chico Xavier. Entre histórias comoventes de maus tratos na infância, escândalos, acusações de

pastiche, abnegação, problemas de saúde, prática da caridade e genuína humildade, o médium de Pedro Leopoldo passou a ser conhecido como o mais importante médium psicógrafo do mundo e, sua biografia mescla-se com a história do espiritismo brasileiro. Chico Xavier ganhou destaque, entre outras coisas, pela sua capacidade de psicografar mensagens transmitidas pelos espíritos desencarnados.

Apoiado pela FEB, em 1932, Chico Xavier publicou sua primeira obra psicografada: “Parnaso de Além-Túmulo”, o qual era uma coletânea de 56 poemas atribuídos a 14 poetas brasileiros e portugueses já falecidos. A edição definitiva desse polêmico livro seria, mais tarde, composta de 259 poemas cuja autoria é atribuída aos espíritos de 56 poetas renomados. O livro é polêmico porque reconhecer a produção literária de Chico Xavier como mediúnica e sobrenatural significa legitimar a tese espírita de imortalidade da alma, em contrapartida, refutar tal afirmação e chamá-lo de embusteiro, significa atribuir ao indivíduo de curso primário extraordinária cultura e talento literário dignos de uma recomendação à Academia Brasileira de Letras. A esse respeito, o jornalista, historiador e escritor brasileiro Mário Donato (1915-1992) escreve:

(...) opto pela explicação sobrenatural, que não satisfaz minha consciência, é verdade, mas apazigua a minha humaníssima vaidade de literato. Pode lá um homem avultar tantos palmos, por suas próprias forças, sobre a cabeça dos demais? Pode lá plagiar, velozmente como faz o Chico, Humberto, Antero e outros do mesmo naipe, a quem não se ‘pasticha’ senão depois de larga experiência literária e trabalhosa noite de insônia? Não, absolutamente. É milagre. Coisas assim não podem ser senão milagre, puro milagre. Há qualquer intervenção sobre-humana no fato; não porque o diz Chico Xavier, mas porque assim o exige a nossa arrogância...(TIPONI *apud* STOLL, Sandra: 2003, p.78)

A polêmica esmoreceu com o desinteresse da imprensa, principalmente após o encerramento do caso “Humberto de Campos”, ou seja, depois da ação que os familiares do escritor Humberto de Campos moveram contra Chico Xavier e a FEB, pleiteando a obtenção de direitos autorais das obras póstumas se sua autoria fosse realmente atribuída ao poeta, ter sido considerada imprópria. Chico Xavier psicografou por mais de 60 anos e quando encerrou sua carreira editorial, em 1993, haviam sido publicados 378 títulos e que cujas vendas ultrapassam os 20 milhões de exemplares segundo a FEB. Embora legalmente proprietário dessas obras, Francisco Cândido Xavier abriu mão dos direitos autorais de todas elas.

Segundo estudiosos, as obras de Chico Xavier podem ser divididas em três fases: a primeira, segundo eles, é de convocação (ou chamamento), a segunda é de esclarecimento e, a terceira seria de consolação. As primeiras obras psicografadas por Chico Xavier tem como temática a experiência e o significado da morte, a qual é utilizada como ponto de partida para a reflexão doutrinária. A morte, em suma, nas palavras dos renomados poetas que se expressaram por intermédio do médium, não representa uma ruptura. A morte nesses poemas e crônicas é apresentada apenas como uma “passagem”, do mundo físico para o espiritual, que não implica na perda de consciência, ou seja, na situação pós-morte há a preservação da memória e de sentimentos terrenos. Assim, servindo como chamariz das idéias espíritas, a temática da imortalidade da alma, em termos de preservação da memória temporal e afetiva, foi divulgada nas primeiras obras de Chico Xavier. É notória a utilização de linguagem rebuscada nesses primeiros trabalhos, o que permite supor que essas obras tiveram receptividade relativamente limitada junto ao público, quando se leva em consideração os níveis de escolaridade da população brasileira naquela época.

A fase de esclarecimento, cuja duração aproximada foi de 35 anos (de 1939 a 1974), é marcada pela publicação de outro gênero literário: o romance. Nesta fase, a autoria dos trabalhos de Chico Xavier é atribuída aos espíritos Emmanuel, o guia espiritual do médium, e André Luiz. “Há 200 anos”, publicado em 1939, foi o romance precursor desta segunda fase. Os romances têm um caráter autobiográfico dos referidos espíritos e descrevem, de maneira contextual e histórica²⁴, a experiência pessoal e subjetiva desses autores com relação à vida e a morte. O intuito desses romances históricos é fazer um relato do tipo exemplar: os “erros” cometidos por pessoas comuns em “vidas terrenas passadas” servem de exemplo às avessas. É notório o caráter didático dessas obras cuja pretensão “é promover uma nova disciplina religiosa, centrada na idéia de que o indivíduo é responsável por seu destino” (STOLL, Sandra: 2003, p. 92), e assim o sendo propõe padrões de conduta e modelos condizentes com a doutrina espírita mediante a intensificação de certos temas doutrinários tais como: o sacrifício, a renúncia, a resignação, a tolerância, a humildade etc. São abordados nos livros publicados nesse período termos e temas essenciais para a doutrina espírita tal como a idéia de livre-arbítrio, de carma (especificamente através da autobiografia de

²⁴ Aparentemente, o recurso à história teria propósito meramente de contextualização da narrativa. Entretanto, Sandra Stoll (2003) considera que o papel da história, nos livros de Chico Xavier, é na verdade outro: a mesma é manipulada com vistas a produção de evidências que contribuam para ajuizar a veracidade de fatos.

Emmanuel), de reencarnação, de evolução espiritual e, inclusive, a descrição da vida no “plano espiritual” ou pós-morte (“Nosso lar”, publicado em 1943, de autoria do espírito André Luiz foi o primeiro livro sobre o tema).

Além de abordarem a doutrina espírita por uma perspectiva moral, dois livros desse período (“Evolução em dois mundos” e “Mecanismos da mediunidade” publicados em 1959 e 1960, respectivamente) de autoria do espírito André Luiz (suposto médico em sua última encarnação) e escritos em parceria com Waldo Vieira (médium recém-formado em medicina e odontologia) abordam as questões doutrinárias pelo prisma “científico”, numa tentativa de obtenção de legitimação social da doutrina espírita mediante a aproximação dessa com o discurso científico. Essas duas obras, entretanto, não apresentam uma atualização da doutrina de Allan Kardec com os conhecimentos científicos da época, apenas descrevem fenômenos já conhecidos com uma nova linguagem, supostamente científica. Supõe-se que em decorrência das críticas e da pouca aceitação pelo público em geral, esse gênero literário deixou de ser produzido, mas a parceria com Waldo Vieira viria a render ainda mais 17 livros entre poesias, crônicas e textos doutrinários, mais simples no estilo e linguagem, com vistas à orientação da vida diária.

Nos meados dos anos 70 a terceira fase literária de Chico Xavier vem à tona. A literatura de consolação, como é comumente conhecida, é composta por coletâneas contendo mensagens particulares, psicografadas por Chico Xavier, de recém-falecidos aos seus familiares mais próximos. Essas narrativas rememoram os acontecimentos e sentimentos que antecederam a morte dos espíritos autores no intuito de dissipar os sentimentos de culpa ou revolta a que, possivelmente, estariam sujeitos os entes queridos do autor da mensagem. A linguagem coloquial e o forte apelo sentimental visam promover o consolo e a resignação daqueles que “aqui ficaram”. Embora constituam uma inovação na produção do médium, as obras dessa terceira e última fase somente reiteram a tese da imortalidade da alma e a necessidade de reeducação moral por intermédio da prática da caridade.

O intuito desses poucos parágrafos dedicados ao médium Chico Xavier é mostrar que a análise de sua influência deve, pois, ser feita num amplo espectro, desde sua pessoa carismática e exemplar até o conteúdo de suas obras. Foi a partir de seu trabalho que a doutrina espírita se popularizou e o vocabulário e idéias típicas dessa doutrina acabaram sendo absorvidos pelos brasileiros, todavia, isso com certeza não ocorreu da maneira como Allan Kardec idealizou. Isso, contudo, não significa que o

“espiritismo à brasileira” seja um subproduto, algo adulterado ou “menor” que o original, pois “as diferenças no modo de se praticar uma mesma religião decorrem de uma tensão que é inerente ao processo de universalização das religiões” (GEERTZ *apud* STOLL, Sandra: 2003, p. 60). O espiritismo é, sem dúvida, uma religião importada cujo processo de difusão no Brasil envolveu o confronto com uma cultura religiosa já consolidada e hegemônica. Postula-se que a difusão do espiritismo foi facilitada pelo fato das práticas mediúnicas de tradição africana estarem socialmente disseminadas no Brasil, resultando em uma predisposição à mística/mágica por parte da população brasileira. Não se pode descartar tal hipótese por completo, porém, é inegável que o espiritismo definiu sua identidade assumindo traços tipicamente católicos. A noção cristã de santidade, por exemplo, encontra respaldo na carreira religiosa e comportamentos de Chico Xavier, cuja figura revela o impacto que o imaginário e práticas católicas exerceram sobre o espiritismo. Essa “parceria” da doutrina espírita com valores católicos, talvez, explique a grande aceitação das idéias espíritas em um país majoritariamente católico mais do que a hipótese de predisposição natural à mística/mágica.

II.5 AS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS

A história das religiões afro-brasileiras é marcada, sobretudo, pelo fato de seu desenvolvimento ter se processado de maneira diversificada nas diferentes regiões do território brasileiro. Muitos fatores contribuíram para fomentar essa diversidade e a consequência foi a formação de diversas sínteses religiosas cujas diferenças, em alguns casos, são tão grandes que permitem falar em diferentes religiões.

No norte do Brasil, por exemplo, surgiu uma religião afro-brasileira profundamente influenciada por elementos religiosos de tradição indígena chamada de Pajelança (Pará e Amazonas), Encantamento (Piauí) ou Catimbó. As principais características da Pajelança são a inexistência de uma comunidade religiosa (clientelismo: a realização do culto se dá na residência do líder espiritual para atender demandas pessoais de seus adeptos e/ou clientes), a utilização de substância alucinógena (raízes da planta Jurema) para promover os transes e permitir a comunicação com os espíritos que habitam o mundo dos desencantados, a ausência de danças e atabaques nos cultos e o fato da liderança religiosa poder ser assumida por mulheres. Ainda no norte do país, existem algumas áreas que conservaram apenas a dança de invocação dos

espíritos, os quais são identificados com figuras indígenas, africanas e católicas a ponto das expressões religiosas desses grupos serem classificadas equivocadamente como meras expressões folclóricas.

No nordeste brasileiro, a rica e complexa teologia das tradições Iorubá e Dahomeana foi relativamente bem preservada e as práticas religiosas da Casa de Minas (Maranhão) e da Casa Branca (Bahia) são tidas como exemplos mais fidedignos das tradições africanas transplantadas no Brasil. Na Bahia essa religião é denominada Candomblé e em Pernambuco, Alagoas e Sergipe recebe o nome de Xangô. As diferenças estão mais relacionadas com a organização do culto e menos com a teologia.

Sob o nome de Batuque no estado do Rio Grande do Sul, na região sul do país, a tradição religiosa afro-brasileira se desenvolveu. A teologia e liturgia são em grande parte idênticas à do nordeste brasileiro, mas existem algumas diferenças marcantes, por exemplo, no nordeste um indivíduo só pode incorporar um Orixá, enquanto no sul há a possibilidade de incorporação de diversos Orixás por um mesmo indivíduo. No que tange a hierarquia, observa-se no sul que a influência do chefe do culto sobre a vida dos membros de seu terreiro não ultrapassa o espaço do culto, enquanto que no nordeste um babalorixá (pai-de-santo) ou uma ialorixá (mãe-de-santo) possui autoridade fora do âmbito religioso. Por motivos obviamente financeiros, observa-se também alteração na decoração dos altares (substituição de estátuas de santos por quadros dependurados em paredes) e na frequência da realização de sacrifícios de animais.

As maiores cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, por sua vez, servem de palco para o desenvolvimento da Umbanda. Embora tenha se originado na cidade do Rio de Janeiro, parece que a Umbanda não encontrou dificuldades para se estabelecer em outras grandes cidades brasileiras devido, talvez, à sua maior capacidade de adaptação em comparação ao Candomblé, o qual demanda maior espaço físico para instalação de um terreiro e que estabelece vínculos permanentes entre o local de iniciação e o Orixá de determinado indivíduo, ou seja, as principais obrigações religiosas desse indivíduo devem ocorrer no terreiro em que tal pessoa foi iniciada.

Além da diversidade das práticas e nomes relatados nos parágrafos anteriores, também faz-se necessário dizer que as religiões afro-brasileiras não são praticadas exclusivamente por negros e mestiços. A tabela 6, demonstra que essa etnia é maioria somente no Candomblé cujos adeptos negros e pardos totalizam 60,4% do total de adeptos, enquanto que na Umbanda eles totalizam apenas 44% do total de adeptos. Observa-se nessa tabela uma “universalização” das religiões afro-brasileiras, ou seja,

são praticadas tanto por negros como por brancos, o critério racial única e exclusivamente não permite traçar um perfil dos adeptos dessas religiões. Os dados censitários mostram, sobretudo, que o contingente de adeptos dessas religiões tem diminuído ao longo dos anos. As religiões afro-brasileiras contavam com 0,6% da população brasileira em 1980, essa parcela reduziu-se para 0,4% em 1991 e, finalmente, para 0,3% em 2000. Segundo Reginaldo Prandi (2005), essa queda no número de adeptos advém, em grande medida, da incapacidade de massificação dessas religiões, tal como fizeram as igrejas neopentecostais. A reunião não organizada e dispersa de grupos pequenos e quase domésticos, que são os terreiros; uma vida religiosa pautada no desempenho de papéis sacerdotais dentro de um grupo de características eminentemente familiares; a realização de ritos, sacrifícios e cerimônias secretas durante o período de iniciação tornam a divulgação e exibição pública inconcebíveis. Se o processo de secularização trouxe a ótica de mercado para o âmbito religioso (oferta e procura), torna-se claro as desvantagens que assolam essas religiões, ainda mais quando se leva em conta o ataque direto das igrejas neopentecostais às práticas religiosas afro-brasileiras. Isso leva Prandi (2005, p.237) a profetizar que “a religião que não muda, morre” e reconhecer que a importância cultural das religiões afro-brasileiras tem sido sempre maior que seu alcance demográfico.

II.5.1 Candomblé: o legado dos Orixás

Muitos estudiosos do candomblé concordam em um ponto: a matriz cultural do povo Iorubá (ou Nagô) é, sem dúvida, a principal fonte de idéias para formação do candomblé brasileiro. A cultura nagô e sua religião chegaram ao Brasil com o desembarque de escravos no porto de Salvador, durante o período de vigência do tráfico escravista. Não se sabe ao certo quantos escravos iorubás aqui desembarcaram, nem quando os primeiros chegaram, a única certeza que se tem é que a religião dos orixás que hoje conhecemos “existe em razão daquilo que pôde ser preservado, daquilo que sobreviveu” (PASSOS, Mara: 1999, p.30) da cultura desse povo. Embora haja testemunhos de que os escravos africanos trazidos ao Brasil continuaram a praticar aqui sua religião, não se pode de modo algum supor que as religiões afro-brasileiras atuais sejam simplesmente a continuação das religiões praticadas pelos escravos. As manifestações religiosas africanas eram sustentadas por grupos inconstantes e efêmeros, visto que seus membros não possuíam uma expectativa de vida longa e as taxas de

mortalidade superavam as taxas de natalidade. A sobrevivência desses grupos dependia sempre da chegada de novos escravos e da disseminação oral das práticas religiosas, dessa forma, o legado dos orixás resume-se ao que se manteve vivo na memória das pessoas e, somente, na memória daqueles poucos que conseguiram sobreviver a um período da história em que a distinção entre um animal doméstico e um ser humano de cor negra era praticamente nula. É por esse motivo que Mara Passos (1999, p. 30) afirma que “candomblé significaria, então, um modelo de religião que congrega supervivências étnicas da África e que encontraram, no Brasil, campo fértil para sua disseminação e *reinterpretação*.” [grifo meu].

O início das religiões afro-brasileiras atuais data do final do século XVIII, com a fundação da Casa de Minas no Maranhão. O registro mais antigo da utilização da palavra candomblé, todavia, é do ano de 1826, em referência a um local onde os escravos africanos buscavam refúgio após uma revolta. Fundada em 1830, a Casa Branca em Salvador, é conhecida como a mais antiga casa de candomblé do Brasil. A fundação e organização de terreiros só teve início com o aumento do número de negros livres e, atualmente, não existem estimativas do número de terreiros de candomblé influenciados pela tradição iorubá. Cada terreiro e sua comunidade é uma instituição isolada e independente, ou seja, não reconhece nenhuma instância superior que determine modos de realização do culto. Assim, existem variações nos cultos de um terreiro para o outro, embora, sejam mantidos os elementos básicos da teologia iorubá. Nos grupos mais tradicionais se insiste na manutenção das tradições africanas e a interpretação teológica dessas tradições é transmitida às novas gerações através dos rituais de iniciação. Como não existe nenhuma instância de controle ou orientação, o surgimento de novos grupos ou dissidências de grupos já existentes leva ao surgimento de novas interpretações. Algumas interpretações defendem a manutenção das formas tradicionais e outras defendem a introdução, adaptação ou remoção de determinados elementos (o sacrifício de animais, por exemplo, é tema recorrente nessas discussões) .

A organização social, bem como a hierarquia religiosa, dos iorubás tinha como base a família. O culto aos orixás era uma questão familiar, assim, cada orixá tinha um terreiro próprio e cada terreiro estava sob a responsabilidade de uma determinada família. Esse sistema de organização familiar, contudo, foi totalmente destruído pelo sistema de escravidão no Brasil. Os terreiros no Brasil constituem uma tentativa de ligar os cultuadores dos orixás em uma unidade familiar aos moldes antigos. O parentesco nos terreiros não baseia-se somente em critérios biológicos, mas em critérios religiosos,

espirituais e rituais. Os membros de um terreiro e os filhos de um determinado orixá se consideram irmãos e, seguindo a mesma lógica, o líder do terreiro é chamado de pai ou mãe. Essa noção de parentesco espiritual influencia enormemente o relacionamento entre as pessoas de um terreiro, pois sua importância simbólica afeta outras esferas da vida dos membros do terreiro. A palavra de um babalorixá ou de uma ialorixá é lei para sua comunidade. Um terreiro se sustenta com base na solidariedade entre pessoas e a distribuição de tarefas segue rigorosamente uma estrutura hierárquica determinada por diferentes níveis de iniciação e tempo de pertença ao grupo. Os iniciados são introduzidos paulatinamente nos segredos da religião e essa acumulação de conhecimento confere posições mais elevadas na hierarquia religiosa da comunidade a qual pertence o indivíduo, ou seja, as obrigações e serviços são efetuados apenas dentro do terreiro do qual se é membro.

Na cosmovisão religiosa do candomblé tudo que existe no universo está situado em dois níveis de existência. Os seres humanos e todas as coisas materiais pertencem ao *Aiê*, o qual é o nível de existência limitado e tangível. Paralelamente a esse plano material de existência, há o *Orum*, o qual é o nível sobrenatural, ilimitado e imaterial. No *Orum* habitam os Orixás e os Eguns (espíritos dos antepassados dos seres humanos) e a esses compete reger o nível material da existência. Segundos mitos do candomblé, esses dois níveis de existência nem sempre foram separados. Erros humanos levaram à essa separação. Isso, todavia, não implicou no rompimento de todos os elos de ligação. Os seres humanos mantêm o contato com os seres do *Orum* por meio de trocas a fim de “resistir à divisão entre os dois níveis de existência e tornar presente a realidade da ordem inicial” (BERKENBROCK, Volney: 1998, p.183), tida como a situação ideal, harmônica. O culto, a iniciação, as oferendas e os sacrifícios no candomblé têm por intuito permitir que os habitantes do *Orum*, notadamente os Orixás, possam vir ao *Aiê* por intermédio de seus representantes, ou seja, através da incorporação nos corpos dos seus filhos e filhas, no afã de conduzir o ser humano e o mundo à situação inicial de total harmonia e felicidade. É importante mencionar que, o contato com um meio social distinto e hostil, bem como a imposição do credo cristão, culminou com a extinção de centenas de divindades e orixás da “teologia” iorubá. Sobreviveram aqueles mais ligados a elementos essenciais da natureza e da vida humana e que encontraram alguma identificação com os seres e santos que povoavam o universo religioso católico. Essa associação entre santos católicos e orixás foi motivada pelo fato dos negros escravos terem de esconder dos brancos a sua religião. O culto secreto era por demais arriscado e

o problema foi resolvido pela utilização de estátuas de santos católicos que de alguma forma lembrassem aspectos do respectivo orixá que se pretendia ocultar. O *pegi* (ou altar de um determinado orixá) passou a se assemelhar a um altar católico, mas as danças, velas e oferendas postas diante daquelas estátuas não se destinavam na verdade àqueles santos. Essa dissimulação, que protegia os orixás e os seus devotos, é o ponto de partida do sincretismo entre o cristianismo e as religiões africanas no Brasil.

II.5.2 Umbanda: uma religião brasileira

Depois da abolição da escravatura, começou a se formar no Rio de Janeiro grupos de negros marcados pela cultura dos bantos (oriundos dos atuais países africanos: Angola, Moçambique e Congo). O conjunto de crenças banto englobava a fé em um ser superior, criador do mundo e a invocação dos espíritos de falecidos e antepassados. Em torno de 1930, esses grupos eram conhecidos como grupos de Macumba, a qual é uma palavra banto-angolana que designa a dança semi-religiosa dos sacerdotes e curandeiros bantos, denominados *cumbas*. Com o passar dos anos, a tradição iorubá começou a influenciar os grupos de Macumba e os espíritos bantos foram lentamente sendo substituídos pelos orixás sem que se alterasse, de forma radical, a maneira como os cultos eram conduzidos. A introdução de elementos do candomblé na Macumba incluiu inevitavelmente a identificação dos orixás com santos católicos, embora essa influência de elementos católicos sobre a Macumba não derive apenas desse fato. A esta base religiosa banto, somada aos elementos católicos e do candomblé, veio se somar posteriormente a doutrina espírita de Allan Kardec, visto que sua doutrina confirmava a fé nos espíritos e definia uma organização no mundo espiritual. Assim, segundo Volney Berkenbrock (1999, p.150), “a diferença entre orixás (espíritos da natureza) e as entidades banto (espíritos dos antepassados) recebeu do espiritismo uma *explicação lógica* com as idéias de diferentes estágios de desenvolvimento dos espíritos e das almas” [grifo meu]. Essa explicação lógica, dentro da ótica religiosa, permitiu a distinção entre espíritos superiores e inferiores e consolidou o papel do intermediador (médium) entre as pessoas e os espíritos, por exemplo. O espiritismo trouxe para esse novo movimento religioso, sobretudo, certa valorização e racionalização que atraiu a população branca e mais escolarizada. Isso facilitou sua aceitação pela sociedade ou, pelo menos, impediu que houvesse ataques diretos, visto que tanto católicos quanto espíritas podiam ver elementos de suas crenças ali refletidos.

A conjunção desses elementos (tradição banto, candomblé, espiritismo e cristianismo) forneceu as bases para um novo movimento religioso, conhecido mais tarde como quimbanda e umbanda. Essa mudança de nome deve-se ao fato do nome Macumba ter adquirido um significado pejorativo ao longo dos anos. Popularmente, o termo macumba é utilizado para designar todos os tipos de expressões religiosas afro-brasileiras que visam o sortilégio de outrem. Entre os anos de 1920 e 1940 esse movimento religioso adquiriu uma forma organizada e supra-regional. A cidade do Rio de Janeiro foi o ponto de partida da umbanda, porém, hoje ela já se espalhou pelas grandes cidades da região sul do país e possui cerca de 397 mil adeptos (IBGE, 2000), sendo a maior religião afro-brasileira sob esse ponto de vista. O rápido crescimento do número de adeptos deve-se principalmente a sua oferta terapêutica e caritativa (distribuição de roupas e alimentos, principalmente), pois é notório que as periferias das grandes cidades são o palco dessa religião. Além desses fatores, há que se somar sua capacidade adaptativa. Em termos teológicos, essa habilidade se reflete na capacidade da umbanda em acolher em si idéias de outras correntes religiosas e; em termos econômicos, por exemplo, deve-se citar a capacidade de adaptação da umbanda em espaços reduzidos que muitas vezes servem de local de culto bem como de residência dos médiuns.

Hierarquicamente, a estrutura em uma casa de umbanda (ou “centro espírita”) se assemelha a forma de organização adotada pelos terreiros de candomblé. Compete a liderança do centro e seus ajudantes diretos a iniciação de novos membros. O processo de iniciação visa o desenvolvimento da mediunidade, ou seja, a capacidade de incorporar uma entidade e a interpretá-la de forma correta, bem como o aprendizado das obrigações, termos religiosos e procedimentos para a realização do culto. Apesar de haver muitas maneiras de organizar o culto, usualmente, é seguida uma estrutura básica, da qual faz parte a preparação ou abertura, seguida da invocação e incorporação das entidades e espíritos e, logo após, inicia-se a realização de consultas individualizadas. Ao término das consultas efetua-se uma cerimônia de encerramento, agradecimento e despedida das entidades e espíritos. A total independência de cada grupo ou comunidade contribuiu para a existência de diferentes idéias e ensinamentos o que, por sua vez, conspirou contra a uniformidade dos cultos e da doutrina. Em seu livro “As religiões Africanas no Brasil” (1971), Roger Bastide afirma que as tentativas de unificar a umbanda através da formação de federações fracassaram sobretudo pela resistência dos chefes de culto e, embora existam algumas federações, essas não tem qualquer

influência no tocante à doutrina. Alguns estudiosos dessa religião acreditam que sua base doutrinária, por esse motivo, ainda encontra-se em processo de sedimentação, embora, reconheçam a existência de algum consenso doutrinário no que tange a:

a) Fé em um ser supremo: cuja figura se assemelha mais à idéia cristã (Javé) e menos ao deus banto (Zâmbi) ou iourubá (Olorum);

b) Crença na existência de espíritos: essa crença abrange os orixás das tradições iorubá, os santos católicos, espíritos de mortos africanos, indígenas (caboclos), antigos escravos (pretos-velhos), etc. Esses espíritos são considerados puros, ou seja, espíritos que alcançaram o último grau de evolução;

c) Crença na possibilidade de contato entre espíritos e pessoas: a influência dos espíritos sobre os seres humanos pode levar tanto à felicidade, como às doenças, e inclusive à morte. O contato acontece mediante situação de transe do médium, no qual o espírito incorpora para ouvir as histórias dos consulentes, responder perguntas, aconselhar, receitar e transmitir energias positivas (ministrar “passes”);

d) Crença na evolução do espírito e na reencarnação: assume-se que os espíritos possam evoluir passando para graus de maior perfeição e isso permite a classificação dos espíritos em diferentes grupos. A reencarnação, por sua vez, é apenas um recurso utilizado no processo de aperfeiçoamento dos espíritos.

A umbanda e as religiões afro-brasileiras, em geral, têm como principal característica essa capacidade de assimilar conteúdo religioso de outras doutrinas, reinterpretá-los e integrá-los no seu culto. Não se observa nesses grupos nenhum ardor missionário ou postura apologética contra as demais religiões. A sobreposição de diversas religiões e esta postura neutra dão a impressão de que os seguidores da umbanda não possuem um identidade religiosa, porém, há que se levar em consideração que uma identidade religiosa é forjada em um processo social, histórico e contextual. A preservação de elementos antigos e a acolhida de novos elementos não se processa de forma cartesiana. Um elemento não é simplesmente posto do lado do outro, esses elementos na verdade se fundem de tal forma que se converge para uma e única identidade religiosa. Para seus seguidores, não se trata de uma mistura ou confusão de doutrinas religiosas que podem ser separadas a qualquer momento, pois é da união de diversas tradições que se forma uma única tradição. É por isso que muitos autores afirmam que a umbanda é de fato uma religião brasileira.

CAPÍTULO III

SAÚDE/DOENÇA E SUAS INTERPRETAÇÕES

RELIGIOSAS

INTRODUÇÃO

Como fenômeno social, as religiões e a diversidade religiosa exercem influência sobre a cultura e os modos de interpretação da realidade. No campo religioso brasileiro não é raro observar o fenômeno de dupla, e até tripla, identidade religiosa, ou seja, um indivíduo se auto-reconhece como seguidor de duas ou mais doutrinas religiosas distintas sem que isso configure um conflito ideológico ou moral. A aceitação de diversos sistemas de crença articula-se à fatores macro-sociais, tais como: a migração, o crescimento urbano, a massificação e a midiaticização da cultura, e às decorrências socioeconômicas deste processo, como por exemplo a dificuldade de acesso à saúde. No entanto estes fatores não são exclusivos, pois fatores subjetivos como a perda de referência e sentido, crises familiares e financeiras, enfermidades, insatisfação com a religião precedente, também expressam a busca por um modelo de religião cada vez mais flexível, pragmático e funcional. Atualmente, é neste contexto que as práticas terapêuticas religiosas ocidentais ganham destaque e servem de atrativos para as religiões angariarem novos fiéis e manterem os antigos.

Uma das principais diferenças entre as concepções de doença sob a ótica médica e religiosa repousa no reconhecimento da raiz sociocultural das doenças por parte das religiões. Segundo a medicina, a doença tem uma estrutura fisiológica independente de qualquer contexto e válida em qualquer lugar e, isto basta para apreender seu significado. Mas será que existe mesmo doença independente do discurso social que se faz dela? Miriam Rabelo (1993, p. 316) afirma que muitos estudos se voltaram para a "análise das diferentes estratégias pelas quais as religiões interpretam a experiência da doença e modificam a maneira pela qual o doente e a comunidade percebem o problema" e que a maioria desses estudos mostraram que as terapias religiosas visam, sobretudo, impor ordem sobre a experiência caótica do sofredor e daqueles diretamente responsáveis por ele. E de fato, a história comparada das religiões corrobora tais asserções. A análise fenomenológica sobre a função terapêutica das religiões apresentada por Aldo Terrin, no livro *O sagrado off-limits* (1998), mostrou que

qualquer prática terapêutica antiga tinha seu ponto de apoio e força no mundo religioso. Essa proximidade entre o religioso e o médico devia-se em grande parte aos sentidos que eram atribuídos aos termos saúde e salvação. Segundo Terrin, basta rever a etimologia dessas duas palavras "para compreender que não havia diferenças substanciais e que a saúde estava sempre inserida num plano e numa perspectiva mais ampla que incluía a salvação" (TERRIN, Aldo; 1998: p. 199). Dentro dessa perspectiva, a salvação começa com a ordenação da existência terrena e o bem-estar físico é condição *sine qua non* da salvação. Nos primeiros tópicos, desse que é o terceiro e último capítulo desta dissertação, a discussão desse assunto será aprofundada a fim de evidenciar as reais semelhanças e diferenças entre medicina e religião.

As religiões oferecem um conjunto de certezas que constituem pontos de referência diante da imprevisibilidade da vida cotidiana, afirma José Magnani (2002). Embora nem sempre evitem o sofrimento, pelo menos buscam torná-lo inteligível, conferir-lhe um sentido. Essa tentativa de propiciar a ordem em meio ao caos torna-se mais evidente quando analisamos as funções terapêuticas assumidas pelas religiões. O fato das religiões possuírem tais funções decorre das interpretações que são feitas a respeito das doenças, em outras palavras, ritos e comportamentos religiosos com propósitos terapêuticos são guiados pela concepção religiosa de doença. A eficácia dessas práticas terapêuticas, creio eu, reside menos nas propriedades dos objetos e gesticulações rituais do que na referência a um "sistema mais abrangente que, antes de mais nada, define o que é doença (...)"(MAGNANI, José; 2002: sem paginação definida).

É baseado nessas idéias que no segundo bloco de discussões desse capítulo serão abordadas as interpretações religiosas das doenças. Nos tópicos relacionados à esse tema, as representações sociais da doença sob a ótica das religiões tratadas no capítulo anterior serão finalmente explicitadas. O estudo das idéias do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo e das religiões afro-brasileiras (candomblé e umbanda) sobre as doenças terá início com uma análise pormenorizada desse assunto na Bíblia cristã. A fim de facilitar a apreensão das diferentes formas de interpretar as doenças pela ótica bíblica as análises foram divididas entre o Antigo e Novo Testamento, sendo que no tópico sobre as concepções de doença no Novo Testamento serão retomadas as concepções da análise precedente, ou seja, do Antigo Testamento. Esse procedimento permitirá avaliar quanto das idéias de um período histórico (do Antigo Testamento) sobreviveram e se mantiveram ao longo de outro (o do Novo Testamento). É notório

que atualmente a facção mais conservadora da Igreja Católica não faça uso das noções bíblicas de doença em seu discurso, talvez, porque tema maiores retaliações da imprensa e do meio acadêmico. Historicamente, por ser uma religião majoritária, a religião católica foi a maior prejudicada pelo avanço dos conhecimentos científicos. As descobertas geológicas, a teoria da evolução de Darwin dentro outros trabalhos científicos abalaram sobremaneira as crenças católicas e levaram inevitavelmente à perda de fiéis. A visão positivista, defendida pela ciência, acabou sendo assumida pela Igreja Católica e isso acabou relegando as práticas terapêuticas dessa religião a um segundo plano. Não obstante, outros movimentos católicos apóiam-se exatamente nessas funções que a Igreja Católica conservadora transferiu para a medicina. É esse o caso do catolicismo popular e dos movimentos carismáticos, onde os fins curativos do catolicismo são mais evidentes e, por conseguinte, onde se observa comportamentos e rituais diretamente (porém, não exclusivamente) relacionados com a concepção de doença. Assim, os trabalhos de Alba Zaluar (1983) complementam a análise das interpretações católicas da doença ao lançar luzes sobre o modo de pensar no âmbito do catolicismo popular, mostrando que as idéias calcadas em um sistema de troca (entre seres humanos e as divindades) da cosmovisão bíblica ainda prevalecem.

Quanto às interpretações protestantes, a tese de doutorado de Jonatas S. Meneses (2002) forneceu as bases para uma nova categorização dos evangélicos brasileiros a fim de sintetizar os pontos de vista desse grupo religioso sobre as doenças. As classificações clássicas dos evangélicos, baseadas principalmente na obra de Cândido Procópio Ferreira Camargo (1973), são revisadas à luz da influência de novos paradigmas surgidos no âmbito dessa corrente religiosa. Não devemos esquecer do fato de que ainda estamos tratando de uma religião cristã; portanto, as análises sobre a concepção de doença na Bíblia são também aplicáveis à essa religião. Muito das crendices retratadas na Bíblia são ainda visíveis nos rituais e práticas dos evangélicos; algumas, logicamente, são apresentadas sob novas formas em decorrência da influência de outros sistemas de crenças, mas conservam a essência das idéias dos períodos históricos bíblicos.

Em seguida, a lógica espírita ganha espaço e, através da leitura das obras fundamentais da doutrina de Allan Kardec e dos mais diversos estudos a respeito do espiritismo, são definidas as categorias de interpretação das doenças pelos espíritas. Ainda que sobre a influência da moral cristã, a doutrina de Allan Kardec inova ao introduzir novos meios de interpretação das causas das doenças, com base na crença da

influência de um plano celestial na vida humana. Além de propor uma nova visão cosmológica, baseada na existência de seres espirituais, o conceito de carma, termo emprestado de algumas religiões orientais, é reinterpretado e utilizado para dar sentido aos distúrbios mentais e fisiológicos, por exemplo.

Encerrando esse tópico a respeito das interpretações religiosas das doenças, será apresentada a visão das religiões afro-brasileiras. Retratarei, primeiramente, a cosmovisão do candomblé, pois as interpretações sobre as doenças dessa religião são dependentes da compreensão da interação entre o *Aiê* (mundo material) e o *Orum* (mundo espiritual), bem como da inter-relação de seus habitantes: os seres humanos e os orixás, respectivamente. A idéia de equilíbrio, bastante acentuada nas religiões orientais, ressurge nessa corrente religiosa para explicar os estados de morbidez. Ganha importância os esforços de manutenção do equilíbrio entre forças naturais e sobrenaturais para conservar ou restaurar a saúde de um indivíduo. O trabalho de Luciana M. Dias (1995), que se baseou em entrevistas feitas com pais e mães-de-santo de terreiros de candomblé, foi fonte inestimável de informações a respeito das interpretações das doenças desse grupo religioso. O trabalho de graduação de Dias revelou que embora a noção de equilíbrio norteie as representações sobre as doenças no candomblé, as interpretações não se limitam a estabelecer relações única e exclusivamente com um plano transcendente, pois se reconhece a influência de aspectos socioeconômicos, comportamentais e emocionais na causa das enfermidades. Finalmente, em segundo lugar, será discutida as interpretações umbandistas das doenças. Visto que a umbanda é uma religião que mescla elementos do candomblé com as doutrinas católica e espírita, muito das concepções de doença desses três grupos religiosos é reproduzido pelos umbandistas. Seguindo a mesma lógica do candomblé, a noção de equilíbrio é reinterpretada e ganha o sentido de ordem. O livro intitulado *Da Doença à desordem: a magia na umbanda* (1985), de Paula Montero, forneceu as informações essenciais para a compreensão do modo de pensar umbandista sobre os estados mórbidos e do impacto desse evento na vida de um indivíduo, que acometido pela doença se vê e é visto pelas outras pessoas como síntese de uma desordem orgânica, espiritual e social.

Antropologicamente, Desmond Morris (2004) afirma que os seres humanos tem uma necessidade inerente de "acreditar em alguma coisa" devido as formas de organização social dos nossos antepassados. Segundo ele, em nossas origens, cada grupo de seres humanos possuía um indivíduo dominante que, além de solucionar as

contendas entre os membros do grupo, deveria ser constantemente apaziguado em troca da proteção coletiva. Assim, ainda segundo Morris, os seres humanos conservaram essa necessidade de uma figura todo-poderosa que mantivesse o grupo sob controle e a vaga acabou sendo preenchida pela invenção de um deus ou qualquer outra forma transcendente dotada de imenso poder. A permanência das religiões, mesmo diante de todos os avanços científicos, deve-se a essa necessidade primordial de submissão e garantia de proteção e "sempre que [a religião] se torna inaceitável, é rejeitada, de maneira calma ou violenta, mas surge imediatamente sob uma nova forma (...), mas contendo todos os antigos elementos básicos" (MORRIS, Desmond: 2004, p. 134). Essa talvez seja uma das características mais importantes das religiões: sua capacidade de assumirem novas formas, sem de fato, alterarem sua essência. As interpretações religiosas das doenças parecem corroborar a digressão de Morris, o qual durante suas análises dos comportamentos agressivos humanos abriu um parêntese para tratar das religiões.

As formas de interpretação das doenças são diversas, porém, é possível identificar duas formas básicas sobre as quais se sobrepõem todas as demais. A primeira diz respeito à noção de que o indivíduo é o causador direto da enfermidade que o aflige e, a segunda assume que o indivíduo adoece sem o concurso de sua própria vontade em virtude de ações de terceiros. O modo de apreensão da doença, aparentemente dominante, encorajado em nossa sociedade consiste em afirmar que o ser humano não está na origem da sua patologia, ou seja, prefere-se assumir que a doença procede de um agente externo, nocivo e maléfico. Esse incentivo à isenção da responsabilidade não impede que o indivíduo enfermo proceda a uma reinterpretação simbólica da prática e do discurso erudito. Seus questionamentos não se limitam ao *como* de sua doença, mas principalmente ao *porquê*, ou seja, com base nas informações culturais à disposição no que tange à origem das enfermidades, é empreendida uma busca do responsável ou culpado pelo estado enfermo. Trata-se de uma questão do sentido, principalmente de um sentido metafísico.

Na busca pelo sentido ou causalidade das doenças o trabalho de Andras Zempléni (1994) revelou que existe uma polivalência etiológica, ou seja, não é possível atribuir uma única condição antecedente ao surgimento de uma enfermidade em um determinado sujeito. Segundo Zempléni, o diagnóstico das doenças permite quatro tipos de questionamentos ou operações: a) o reconhecimento nosológico e sintomático (qual doença?); b) a percepção de sua causa instrumental (como?); c) a identificação do

agente responsável (quem ou qual?); d) a reconstituição de sua origem (por que?). Embora o saber médico moderno, atualmente, conspire contra a noção totalmente exógena das doenças porque, em grande medida tende a responsabilizar o indivíduo por seu estado enfermo, de uma forma geral, após o reconhecimento e definição da doença que assola um sujeito, podem ser atribuída diferentes "causas" para seu estado. A primeira causa é chamada de instrumental, pois visa de forma imediata identificar o mecanismo ou o meio de criação da doença. A segunda causa é denominada eficiente, pois tem por objetivo identificar o agente que detém a força eficaz na produção da doença. A terceira causa, a causa conjectural ou última, constitui um empreendimento de busca do sentido da doença, ou seja, é a busca por um acontecimento conjectural ou representação simbólica cuja reconstituição torna inteligível a experiência mórbida: por que aconteceu nesse momento e sob essa forma e justo nessa pessoa?

É com base nesse referencial que para encerrar o capítulo há um tópico em que se discute e se sintetiza as informações a respeito das interpretações religiosas das doenças sob o ponto de vista de católicos, protestantes, espíritas, umbandistas e praticantes do candomblé. É uma tentativa de se mostrar que, quando se trata de representações sociais das doenças, ao longo da história, há mais permanências do que mudanças.

III.1 DOENÇA E RELIGIÃO

É natural do ser humano buscar explicações para os mais diversos eventos da vida. Buscamos explicações e justificativas para os eventos mais corriqueiros ou para os mais complexos. Quando criança, os seres humanos não hesitam em fazer perguntas: sejam elas constrangedoras ou demasiadamente simples. Muitos pais enfrentam situações embaraçosas seja por questões de pudor ou por mera ignorância ante as milhares de indagações que fervilham na mente de sua prole. Esse ímpeto e sadia curiosidade parecem diminuir ao longo dos anos e os seres humanos adultos aceitam, em geral, as “coisas como elas são”. A doença, entretanto, é um dos eventos que não escapa às exigências de respostas típicas da infância. Acometido por uma sensação orgânica desagradável, o indivíduo busca explicar aos outros aquilo que sente, se necessita de ajuda e se precisa tomar alguma atitude. Pode parecer que a elaboração de questões e a compreensão da doença se restrinjam apenas à esfera individual, mas de fato a interpretação que o indivíduo faz a respeito de seu estado de saúde está ligada ao

social e à cultura. Philippe Adam & Claudine Herzlich (2001) acreditam que a cultura fornece aos indivíduos os limites dentro dos quais se operam essas interpretações relativas aos fenômenos corporais, principalmente, quando se trata da doença e seus sintomas. Isso significa que comunidades distintas poderão apresentar diferentes abordagens discursivas, percepção e expressão dos sintomas de uma mesma doença ou; em outras palavras, há uma relatividade cultural na definição do normal e do patológico.

Nesse contexto, a atividade médica desempenha um papel interpretativo. Baseado em noções biológicas, o médico decodifica os sintomas de seu paciente. O doente, por sua vez, cria modelos explicativos próprios para seu estado de saúde influenciado por suas raízes culturais. Os médicos estão conscientes dessa variedade de percepção e expressão dos sintomas segundo as culturas, porém a maioria não confere grande importância à esse fato por julgar que os indivíduos percebem e traduzem diferentemente uma realidade que é sempre a mesma em termos biológicos. Nas sociedades onde prevalece a medicina científica moderna, a relação com o corpo é modelada pela proximidade de um grupo social com o discurso científico predominante. Quanto maior o contato com os médicos, maior será a absorção de seus conceitos e explicações para os problemas de saúde. A compreensão e difusão desse saber médico, entretanto, não bastam para dar respostas a todas as questões do doente. A doença vista como transtorno que ameaça e altera o modo de vida, geralmente coloca questões em busca de um sentido: Por que está acontecendo? Por que comigo? Por que justo agora? O doente não encontraria respostas a essas questões somente no diagnóstico médico. As doenças, em todas as sociedades, são interpretadas de maneira específica e servem de suporte à expressão de crenças e valores. A concepção de doença manifesta-se através de relacionamentos com a ordem social e, *pari passu*, com a religiosa, pois segundo Terrin, “é totalmente lógico que a doença como mal, ou melhor, como a concretização física e determinativa de um mal, entre no contexto das religiões e defronte-se com o problema da vida e do seu significado” (TERRIN, Aldo: 1998, p. 195).

III.1.1 Definindo religião

Se no primeiro capítulo desta dissertação tentamos responder “mas afinal, o que é doença?”, acreditamos que chegou a hora de se perguntar também “o que é religião?” e “qual sua relação com as enfermidades?”. Quanto a primeira questão, embora não seja propósito central deste trabalho, uma melhor compreensão da definição e da função

desempenhada pela religião nas sociedades contemporâneas nos obriga a recorrer aos autores clássicos: Freud, Marx, Durkheim e Weber. Isso por si só renderia facilmente uma nova dissertação, portanto, as próximas linhas abordarão as idéias desses autores em linhas mais gerais, sem que isso dirima a importância dessas idéias na conceituação e compreensão do termo religião, bem como de sua função.

Freud tratou a religião como uma neurose obsessiva universal, atribuindo-lhe um caráter inteiramente psicológico, descartando os aspectos culturais e sociais. Segundo Freud (FROMM *apud* TANAKA, Márcia: 1994) os nossos desejos estão fadados ao fracasso. Nascemos, crescemos, envelhecemos e, finalmente, morremos. Esse ciclo desperta a imaginação humana que, em desespero inconsciente, cria mecanismos de consolo e fuga para a maior das angústias humanas: a consciência da finitude inexorável de tudo aquilo que vive. Freud concluiu então que as religiões têm como função propiciar meios ilusórios para tornar esse ciclo de vida mais “suave”, fazendo com que a morte perca seu caráter ameaçador. Em síntese, a religião não passaria de uma fantasia, uma ilusão que permitiria a extensão do ciclo biológico da vida. Ainda dentro dessa perspectiva negativa sobre as religiões e suas funções vieram se somar as idéias de Karl Marx. Ao abordar o tema da religião, Marx (2006) trata-a como o “suspiro da criatura oprimida” e “ópio do povo”, cuja necessidade seria superada com o advento do socialismo. Para Marx, a religião reflete o que falta na sociedade; é uma idealização das aspirações do povo que não podem ser satisfeitas de imediato. Assim, ao contrário de Freud, Marx afirma que a religião não é apenas uma superstição ou uma ilusão. Segundo ele, a religião possui sim uma função social: distrair as pessoas da realidade opressiva típica do sistema capitalista. Mais do que servir de distração, Marx alerta que a religião é uma ideologia com capacidade de legitimar a opressão, considerando-a parte de uma ordem natural, bem como os instrumentos de dominação de classes. Ao prometer àqueles que sofrem a felicidade plena em um futuro distante e em outro plano existencial, a religião impede as pessoas de enxergar e perceber as mediações e contradições que formam a realidade e; assim, a religião ajuda na manutenção do *status quo*.

Durkheim (2003), diferentemente dos outros dois autores, considera a religião como parte importante nos processos sociais e que age como instrumento sistematizador daquilo que é ensinado aos indivíduos nas suas relações sociais. Em outras palavras, a religião segundo Durkheim é eminentemente social e está fundamentada na necessidade de identificar a experiência humana em duas categorias: o sagrado e o profano. Ainda

segundo Durkheim, “se a religião gerou tudo o que existe de essencial na sociedade, é porque a idéia da sociedade é a alma da religião” (DURKHEIM *apud* MENESES, Jonatas: 2002, p.34). Isso permitiu a Durkheim sabiamente concluir que não é possível caracterizar essa ou aquela religião como falsa, pois todas de alguma forma atendem às necessidades daqueles que a praticam independente de sua configuração, ou seja, se são mais ou menos institucionalizadas, com maior ou menor incidência de comportamentos mágicos etc.

Enquanto Durkheim (2003) percebe a religião como a própria sociedade, ou melhor, como um conjunto de valores e crenças construídos nas relações sociais e culturais entre os seres humanos, o pensamento weberiano a interpreta como parte dessa mesma sociedade, subtraída dos comportamentos mágicos (“desencantamento”) ou em processo de subtração desses comportamentos. Weber se atém à noção de “ação social” para interpretar a sociedade. Isso significa que enquanto os marxistas enxergam a sociedade apenas pelo prisma do conflito de classes e a religião como meio das classes dominantes manterem as classes pobres subjugadas, Weber enxerga os indivíduos como portadores de motivações que, racionalmente, atribuem sentido ao seu comportamento social. Desta forma, para Weber “a ação religiosa ou magicamente motivada, em sua existência primordial, está orientada para este mundo” (WEBER, 2004, p.279), ou seja, as ações religiosas são motivadas e têm uma finalidade prática na sua relação com a sociedade.

O pensamento desses quatro autores mostra quão polêmico é definir religião e determinar sua função. Pessoalmente, me atenho às idéias de Durkheim e Weber, embora algumas categorias das obras desses autores possam ser consideradas contraditórias. Desta forma, a fim de responder à segunda indagação, no que tange ao relacionamento das religiões com os estados mórbidos, assumo que a religião é capaz de produzir uma integração emocionalmente satisfatória entre o indivíduo e a sociedade e, adicionalmente, reconheço que “a religião é parte indissociável da sociedade, constituída por certo número de coisas sagradas coordenadas e subordinadas, formando um sistema com certa unidade” (DURKHEIM *apud* MENESES, Jonatas: 2002, p.31) que “atua com propósito claro de oferecer aos atores sociais a possibilidade de dar sentido ao que é experimentado como destituído de sentido” (WEBER *apud* MENESES, Jonatas: 2002, p.31). Se assim não o fosse, falar em função terapêutica das religiões careceria totalmente de fundamento.

III.1.2 A função terapêutica das religiões

Léo Pessini (2000) afirma que mesmo quem rejeita as religiões deve levá-las a sério porque elas são uma realidade social. E como uma realidade social, Pessini crê que elas tratam do sentido e do não-sentido da vida, da justiça e da opressão, da paz e da guerra e, da saúde e da doença, sendo essa última entendida como uma das causas das angústias humanas. Essa afirmação de Pessini revela que o campo de atuação das religiões vai além das paredes simples ou suntuosas de templos e igrejas. E de fato, ao longo da história da humanidade, é possível enumerar diferentes funções atribuídas às religiões. Se por um lado, é notório que esteja ocorrendo um enfraquecimento da religião entendida enquanto norma, doutrina, dogma e, sobretudo, instituição, por outro lado, mesmo diante desse processo de secularização, nota-se um fortalecimento da busca do sentido último da existência humana por meio da experiência religiosa. Esse processo realçou algumas das funções das religiões e, obviamente, em contrapartida, fez com que algumas funções fossem abandonadas ou relegadas a um segundo plano. A função terapêutica das religiões foi uma das áreas de atuação religiosa que, confrontada pelos avanços científicos modernos, sofreu grande impacto. As mudanças tecnológicas e científicas dirimiram as expectativas de cura religiosa das doenças, porque pouco a pouco se deixou de reconhecer uma ligação íntima entre religião e bem-estar e aquilo que outrora era atribuído ao mundo religioso é hoje atribuído a outros âmbitos.

III.1.2.1 Saúde e Salvação: uma divisão secular

Pesquisas históricas revelam, entretanto, que no passado as religiões não dissociavam a missão de salvação da tarefa terapêutica. Reflexões filológicas e semânticas demonstraram, também, que os termos saúde e salvação são co-originais, ou seja, originaram-se de um mesmo conceito e compartilharam durante muito tempo o mesmo significado global. Isso indica que no passado cabia às religiões salvar seus adeptos em sua totalidade física, pois a salvação não era dissociável de saúde. A salvação não estava isolada dos contextos concretos de existência e, portanto, era antecipada de forma significativa ainda nessa existência no exato momento em que se tornava sinônimo de saúde e cura. Assim como a saúde e salvação são correlatas, também, em contrapartida, a doença se confunde com o pecado, a possessão de espíritos maus e de demônios. A doença é a experiência pessoal do caos e da desordem, é a

manifestação dos espíritos malignos, dos demônios e, até mesmo, de Deus. A desordem cósmica parece ser o “paradigma original sobre o qual se conjugam as correspondências próprias de qualquer outra desordem que intervém de modo variado para perturbar o organismo humano e provocar as doenças” (TERRIN, Aldo: 1998, p.157).

Nas religiões antigas, monstros e deuses mitológicos estavam na origem do mal metafísico e das doenças. Tiamat (no mundo Mesopotâmico) e Leviatã (no mundo judaico antigo), por exemplo, aparecem de modo genérico na origem dos males e do caos, portanto, são a fonte de todas as coisas de cunho negativo. Não havia, entretanto, nesses primórdios, uma acusação precisa, ou seja, não se buscava ir mais à fundo na etiologia do mal a ponto de atribuir a responsabilidade por essa ou aquela doença a um determinado ser mitológico. Porém, aos poucos, essa necessidade de encontrar uma causa mais precisa das doenças é objetivada mediante a criação de uma etiologia de inspiração ético-religiosa que lentamente substituiu os grandes monstros e deuses mitológicos por seres maus menores – os demônios – que podiam ser combatidos de uma forma mais pragmática. Assim, devido ao desespero provocado pelas doenças, os indivíduos passaram a invocar, por meio de orações, a piedade de seus deuses. Somente os deuses podiam curar, libertar das doenças e salvar as pessoas cujas feridas infligidas no corpo faziam o espírito agonizar. Salvação e saúde aparecem aqui como faces de uma mesma experiência.

Para melhor compreender a relação entre doença e visão religiosa no mundo antigo, Terrin (1998) acredita que é fundamental analisar certos aspectos da cultura do antigo Egito, onde a busca pela juventude eterna e a não prestação de contas à morte era uma obsessão. A doença, para os egípcios antigos, era o resultado de uma invasão do corpo humano por espíritos ou pelas próprias divindades cultuadas naquela época. Acreditava-se, inclusive, que as divindades podiam ser acometidas pela doença se fossem atacadas por espíritos malignos. Com base nessa concepção das doenças e na sua preocupação extrema com a saúde, os egípcios desenvolveram na área cultural e religiosa diagnósticos muito avançados das doenças, aliando uma visão empírica indutiva com uma visão espiritual marcada pelas orações e encantamentos. É mérito dos antigos egípcios a visão localista das doenças, ou seja, de que a doença deveria estar ligada e ser estudada em relação ao lugar e ao órgão doente. Se por um lado havia esse conhecimento técnico-prático, por outro lado, era respeitada também a crença de que cada órgão era presidido por uma força espiritual e, desta forma, a fronteira entre medicina, magia e religião era bem flexível.

O mundo do Extremo Oriente, por sua vez, considerava a doença estritamente ligada a um equilíbrio total de energias e forças. Se a desordem é a causa de todos os males, a harmonia espiritual e energética é o princípio do bem-estar. A doença é, portanto, uma desarmonia do espírito e surge de um desequilíbrio entre as energias espirituais individuais e as energias cósmico-universais e, assim “o espírito – esse microcosmo, espelho de todo o universo – torna-se o verdadeiro protagonista da saúde e da salvação” (TERRIN, Aldo: 1998, p. 170). No hinduísmo, por exemplo, o cosmo é feito de transações, fluxos e interações entre diversos níveis: o *atman* (microcosmo) e o *brahman* (macrocosmo). A doença é, sob essa concepção, o resultado de um desequilíbrio entre a natureza e o ser humano, entre fatores sociais e pessoais, espirituais e materiais. A religião leva à meditação, que por sua vez leva à consciência espiritual que liberta o espírito dos conflitos e, por conseguinte, das enfermidades. Saúde e salvação são continuação uma da outra e não podem ser separadas.

Ainda seguindo essa linha de equilíbrio de energias, a doutrina de Yin e Yang tornou a filosofia religiosa chinesa bastante conhecida. Os fenômenos universais dependem da alternância desses dois princípios e de seu equilíbrio, visto que são forças de polaridades opostas e ao mesmo tempo complementares de um mesmo princípio: o *tao*. A saúde humana depende, segundo esse ponto de vista, da interação do organismo com o ambiente que o cerca e do fluxo de energia *ki*, que pode ser definida como a expressão energética e espiritual do corpo com relação à natureza. Essa visão sistêmica faz do corpo humano um palco de conflitos e tendências que estão nas origens das doenças. Baseado nisso, a medicina tibetana deu extremo valor aos “fenômenos espirituais e ao equilíbrio psicofísico do paciente, em combinação com o tipo de alimentação, o regime alimentar e a constituição pessoal” (TERRIN, Aldo: 1998, p. 176). Esse tipo de visão que alia aspectos espirituais e somáticos permitiu incluir no diagnóstico das doenças a ignorância, o ódio e o desejo, pois se acredita que a falta de controle da própria mente gera bloqueios no plano espiritual que provocam desequilíbrios no plano físico. Dessa maneira, a cura e a saúde dependem de capacidades intrínsecas e espirituais da pessoa que diante de circunstâncias negativas é capaz de superar seus condicionamentos para criar o ambiente adequado para o reequilíbrio das energias e dos elementos fundamentais do corpo. Esses exemplos mostram que as religiões orientais, mais antigas que as religiões e a medicina ocidental, não separam os conceitos de saúde e salvação, a qual é “vista em estreita correlação

com a capacidade de desvincular-se dos condicionamentos psicofísicos” (TERRIN, Aldo: 1998, p. 179).

Não há, segundo as representações das religiões orientais, uma separação entre corpo e mente, entre mente e energias espirituais capazes de fazer refletir no corpo as desarmonias de um plano transcendente. Embora não seja possível calcular o real alcance e estabelecer o tipo de influência, a mente sem dúvida desempenha papel relevante nos estados enfermos e nos processos de cura. A eficácia do placebo demonstra que o sofrimento e a cura pertencem, muitas vezes, ao domínio do processo mental, no qual as idéias e informações podem funcionar como causas. Assim, pode-se supor que talvez a força terapêutica das religiões resida não nas religiões em si, mas no fato de que a experiência religiosa influa positivamente na psique. A experiência religiosa ajuda a eliminar as contradições da vida e, de alguma forma, injeta força no sujeito a ponto de lhe permitir superar dificuldades existenciais; porém, considerar toda e qualquer doença como um sintoma de um desequilíbrio psíquico espiritual é um caminho pouco recomendado para se chegar a uma concepção de doença que esteja em linha com os conhecimentos acumulados ao longo dos séculos pela humanidade.

No mundo greco-clássico e ocidental em geral, a medicina manteve seu caráter holístico, ecológico e quase religioso até o limiar do Renascimento, quando toda filosofia religiosa cedeu lugar ao positivismo da pesquisa científica que, como defensora de um saber objetivo e indutivo, rebela-se contra os saberes vinculados à esfera religiosa. Isso fez com que a religião cristã se diferenciasse bastante das religiões orientais, pois fatores culturais acabaram por lhe forçar uma visão mecanicista e determinista da existência humana que culminaram com a separação dos significados de saúde e salvação. Para ainda encontrar um lugar no mundo secularizado, por exemplo, a Igreja Católica praticamente abdicou de toda e qualquer função terapêutica. Isso não impediu, entretanto, que outros segmentos religiosos cristãos se apoiassem exatamente nessa função para atrair e engrossar seu contingente de fiéis. Uma vez que os textos bíblicos revelam que Jesus Cristo propunha a saúde física como sinal e antecipação da salvação final, esses novos grupos cristãos encontraram as justificativas necessárias para sua empreitada no mercado religioso.

Desta forma, a história comparada das religiões nos permite concluir que, de uma forma geral, as religiões além de dar conta da força negativa atribuída às doenças, fazendo-as derivar de causas psíquicas ou espirituais, arrogavam para si uma função terapêutica que buscava antecipar a salvação final mediante a recuperação e manutenção

da saúde física e mental durante a existência material. Adicionalmente, uma vez que essa história revela que as práticas terapêuticas tinham quase sempre seu ponto de apoio e de força no mundo religioso, pode-se afirmar que “a medicina não passa de uma especialização da religião e/ou até constitui a verdadeira praxe religiosa original” (TERRIN, Aldo: 1998, p. 197).

III.1.2.2 Religião e Medicina: a saúde como ideal social

No último capítulo de seu livro *Antropologia da Doença*, Laplantine busca ir além das interpretações e processos etiológico-terapêuticos (como fiquei doente e como vou me curar?). O autor desloca a discussão para as razões da doença, ou seja, a discussão situa-se no *porquê* da doença e as respostas à essa questão demonstram a estreita relação que há entre medicina e religião, saúde e salvação. Sobre a relação da medicina com a religião, Laplantine escreve:

A função médica, desligada da função religiosa, assume uma autonomia relativa e, depois, total, com relação a essa última, tornando-se uma prática específica e especializada. A eventual dimensão religiosa (da medicina), seja sob forma residual, seja sob uma nova forma, não é absolutamente percebida pela sociedade, tanto da parte dos que são curados quanto da parte dos que curam, os quais afirmam que são praticantes de uma ciência neutra e objetiva, nada mais (LAPLANTINE, François: 1991, p. 215).

O autor justifica essa afirmação através de uma análise histórica da medicina no Ocidente cuja maior dificuldade epistemológica foi separar seu conhecimento do corpo e de seus males da mitologia e das questões sacras e filosóficas a respeito do ser humano e do mal. Em outras palavras, o processo de diferenciação do pensamento médico científico reside em um ato de diferenciação consumada entre o que advém do mal biológico e o que advém de outros males (tidos como não científicos) oriundos de crenças metafísicas, de especulações filosóficas e interrogações psicológicas. Porém, quando um indivíduo se depara com a doença, inevitavelmente, há a presença de dois níveis interpretativos estritamente ligados: uma interpretação referente ao *como* (processo etiológico-terapêutico) e outra quanto à questão do *sentido* e do *porquê*. Assim sendo, seria ilusório pensar que existem práticas puramente médicas ou puramente mágico-religiosas.

No ano de 1976 a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de

distúrbios e doenças” (MOURA *apud* DIAS, Luciana: 1995, p. 11). Essa definição de saúde proposta pela OMS provocou muita polêmica e insatisfação em diversas áreas de conhecimento acadêmico, pois, além de ser considerada utópica, ela caracteriza um retorno à visão terapêutica religiosa, na qual as fronteiras entre religião e medicina se encontram e se confundem. Isso é logicamente inaceitável em um mundo em que o trabalho médico tornou-se cada vez mais técnico e dependente das diferentes medições e monitoramentos realizados por máquinas de alta tecnologia e, no qual a visão religiosa da doença foi banida por carecer de correspondências verificáveis e; portanto, sem valor estimável. Essa visão científica das doenças esquece-se, porém, de que o conceito de doença está relacionado à aspectos culturais, “pois a percepção e a conceitualização da realidade apresentam-se sempre mediadas por modalidades sociais de apropriação dela. Não existe doença independente do relato que é feito da doença e do significado que socialmente lhe é atribuído” (TERRIN, Aldo: 1998, p. 208).

A especialização médica trouxe, sem dúvida, resultados significativos por justamente não ter se atido a um conceito holístico das doenças, mas esses resultados são parciais, circunscritos, limitados e unilaterais. Diante da doença, a especialização, leva o médico a considerar o corpo como um organismo biológico em total isolamento orgânico, não se questionam causas psicológicas, motivos conflitivos e dificuldades de adaptação a uma determinada situação que poderiam ajudar a diagnosticar o estado enfermo, ou seja, descartam-se as vivências subjetivas. Em suma, enquanto a intervenção médica oficial pretende fornecer uma explicação experimental dos mecanismos químico-biológicos da morbidez e dos meios eficazes para controlá-los, as religiões associam uma resposta integral a uma série de insatisfações (não apenas somáticas, mas psicológicas, sociais, espirituais e até existenciais). Laplantine (1991) acredita que a permanência das práticas medicinais populares, calcadas basicamente em crenças religiosas, deve-se ao fato de que o indivíduo doente encontra dificuldades em conformar-se com a questão do porquê de sua doença. Enquanto, por um lado, não se pode afirmar que a “saúde real do corpo e da mente dependa, em última análise, da vida religiosa” (KELSEY *apud* ALVAREZ, Francisco: 2000, p. 444); por outro lado, seria incorreto também aceitar indubitavelmente o modelo médico inspirado por um dualismo cartesiano que limita a saúde à sua dimensão biológica, negligenciando sua dimensão biográfica. Do ponto de vista teológico, o que torna a saúde/doença interessante não é sua componente biológica, e sim, sua dimensão biográfica. A doença e a saúde tornam-se relevantes porque, no momento em que são assumidas pela consciência humana,

transformam-se em objetos de decisões, integrações e cisões, revelando um sistema de valores e princípios culturais. Há que se ressaltar que ao moralizar a doença corre-se o risco de prejudicar o doente, pois isso poderia vir a servir de escusa para negar-lhe a solidariedade devida; não obstante, os danos seriam ainda maiores caso a doença fosse vista exclusivamente como algo natural, inevitável, independente da pessoa e da sociedade.

As interpretações e avaliações a respeito das doenças abrangem um mosaico de fatores culturais, socioeconômicos e religiosos que tornam a saúde um ideal social “dotado de grande valência simbólica, elemento agregador que reúne acima das diferenças (...) aquilo que identifica a condição humana: o desejo de viver em plenitude; de superar aquilo que é fragmentário e precário” (ALVAREZ, Francisco: 2000, p. 445). De fato, as preocupações concernentes à saúde são tão importantes atualmente que acabaram por se transformar em objetivo, fim e valor da existência humana. Neste contexto, o papel da medicina deixa de ser o de apenas curar e passa a ser o de elevar ao extremo essa preocupação do indivíduo consigo mesmo. A medicina tornou-se um segmento dominante nas sociedades ocidentais, influenciando sobremaneira sua cultura a ponto de que as representações globais do indivíduo e da sociedade outrora religiosas, políticas, sociais e econômicas tendem a se tornar biomédicas. A medicina passou a ditar o que é verdadeiro e bom, tornando-se a diretriz da conduta dos indivíduos e “estendendo seu monopólio bem além dos limites do domínio biológico” (LAPLANTINE, François: 1991, p.237). A medicina ordena, prescreve, certifica, promete e, sobretudo, ameaça (provocando a angústia em todos aqueles que não obedecem aos comportamentos padrões que garantem a saúde e a longevidade). Em suma, a medicina é capaz de ditar a moral.

Esse caráter de normatividade da medicina, o qual lhe permite medir a ignorância, recompensar a obediência, punir a transgressão, lutar contra as práticas não oficiais e, principalmente, intervir cada vez mais na vida cotidiana de cada um de nós, pode ser qualificado de religioso, no sentido literal do termo. A saúde nas sociedades atuais ocupa rigorosamente o mesmo lugar que antes era ocupado pela idéia religiosa da salvação. Já a fé médica (crença no progresso infinito que levará o ser humano à saúde absoluta, através da eliminação gradual de todas as doenças), por sua vez, preenche parte do vazio deixado pelo enfraquecimento das grandes religiões. E analogamente às promessas utópicas de salvação das grandes religiões, o discurso médico parece falar de um estado de completo bem estar físico, mental e social. Em decorrência disso, a

medicina passou a ser uma atividade diferente das outras, alcançando prestígio e admiração social que desperta ao mesmo tempo fascínio e temor, tal como nos escreve Rudolf Otto em sua análise fenomenológica do sagrado. Esse temor e fervor reafirmam a ligação da doença com o sagrado, tornando a medicina uma prática correlata das religiões.

III.2 AS INTERPRETAÇÕES RELIGIOSAS DAS DOENÇAS

Antes de abordarmos as interpretações religiosas das doenças é importante ressaltar que:

O que importa para o pensamento mágico-religioso não é a compreensão do processo físico que se desenvolve num estado mórbido, nem sua causação puramente biológica. A doença se torna elemento significante somente quando associada à idéia de uma negatividade genérica, à noção de uma desordem que extrapola o corpo individual ao abranger as relações sociais e a própria organização do mundo sobrenatural (MONTERO, Paula: 1985, p. 129).

Não alheias ao fato de que em qualquer doença está em questão o indivíduo enquanto tal e que a doença envolve fatores psicológicos, sociológicos e espirituais, vinculados ao sentido subjetivo de viver em determinado ambiente e num contexto social particular e com determinados problemas pessoais, as religiões alvo desse estudo, de uma forma geral, dão forte ênfase às suas funções terapêuticas. O estudo das representações sociais da doença dessas religiões vem, sobretudo, corroborar o provérbio "quanto mais as coisas mudam, mais elas continuam as mesmas".

III.2.1 Catolicismo: as doenças sob a ótica bíblica

O termo grego *bíblia* significa literalmente “livros”. Assim, antes de tudo, a Bíblia cristã é uma coleção de livros que começou a ser escrita provavelmente entre 950 e 850 a.C. A bíblia completa contém 73 escritos, obras de numerosos autores, com estilos de escrita distintos em decorrência das diferentes personalidades e lugares e ambientes em que viveram. O nome desses autores é desconhecido e alguns escritos resultam de uma colaboração ou compilação de textos antigos. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, chamadas Antigo e Novo Testamento. A coleção de quarenta e seis livros do Antigo Testamento, formada ao longo da história da comunidade judaica, pode ser dividida em quatro grupos gerais:

- a) a Lei (*Torá*), a qual é formada por cinco livros, a saber: Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse conjunto de livros é comumente denominado de Pentateuco (que significa os *cinco volumes*);
- b) Livros Proféticos, o qual é composto pelos escritos dos profetas Isaías, Jeremias (incluindo Lamentações e Baruc), Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Habaduc, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias;
- c) Livros Sapienciais, que corresponde aos seguintes livros: Salmos, Provérbios, Jô, Eclesiastes (Coélet), Cântico dos Cânticos, Eclesiástico (Sirac) e livro da Sabedoria;
- d) Livros Históricos: Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite e Ester e Macabeus.

Alguns dos livros citados acima não são admitidos pelos protestantes como parte integrante da Bíblia, simplesmente porque vieram a se somar à Bíblia hebraica primitiva sem serem considerados inspirados pelo Espírito Santo. Diferentemente das edições católicas da Bíblia, as edições protestantes não incluem os seguintes livros: Tobias e Judite, alguns suplementos dos livros de Daniel e Ester, os livros da Sabedoria e do Eclesiástico, Baruc e a Carta de Jeremias, que se lê no último capítulo de Baruc.

O Novo Testamento, por sua vez, é formado por vinte e sete livros, os quais podem ser distribuídos em três grupos:

- a) Livros Históricos, o qual é composto por cinco livros: sendo quatro Evangelhos segundo os apóstolos São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João somados aos Atos dos Apóstolos;
- b) Cartas dos Apóstolos, as quais totalizam vinte e um manuscritos cuja autoria é assim distribuída: quatorze cartas de São Paulo, uma de São Tiago, duas de São Pedro, três de São João e uma de São Judas;
- c) Livro Profético: o apocalipse de São João.

Uma vez cientes da estrutura da Bíblia, convém tratar do seu conteúdo. A Bíblia apresenta um conteúdo, em decorrência do grande número dos autores de seus livros, bastante diversificado. Os seus textos narram fatos históricos; fornecem listas genealógicas; discorrem sobre legislação, profecias e sermões; apresentam ensaios

filosóficos, cantos, poemas, orações e cartas dentre uma variedade de outros documentos que dão testemunho da evolução da religião cristã ao longo da história do povo hebreu. O texto rebuscado, para maioria dos seus leitores, é marcado por parábolas, anedotas e fábulas no intuito de promover a compreensão de conceitos, valores e ensinamentos de caráter religioso. Dentre a diversidade de assuntos abordados pela Bíblia, a saúde do corpo humano é um tema recorrente em diversas passagens, assim como os assuntos correlatos: doença e cura, também o são.

Tentar sintetizar ou compreender a noção de doença retratada nos textos bíblicos é uma tarefa que requer uma série de cuidados. Primeiro, porque o entendimento da palavra “doença” e/ou a qualificação do indivíduo como “doente” estão condicionados à visão contemporânea da nossa realidade. Essa visão, como qualquer outra, é historicamente condicionada e, em certa medida, é inclusive resultado da influência do sistema de valores da tradição bíblica. Isso quer dizer que a compreensão atual a respeito desses temas é relativa. A aceitação dessa relatividade, a qual é patente em comparações históricas, nos obriga a aceitar que não existe verdade absoluta e que uma análise dessa natureza requer o apoio em sistemas de referência fincados em experiências de vida similares que minimizem ou impeçam qualificações baseadas única e exclusivamente na visão e conceitos compartilhados por nossa era.

Em segundo lugar, deve-se levar em consideração que existem inúmeras interpretações sobre o conceito de saúde/doença. A despeito do fato das ciências médicas terem logrado um diagnóstico cada vez mais preciso sobre as manifestações mórbidas, no meio acadêmico atual, ainda prevalece uma pluralidade de interpretações e idéias sobre o tema das doenças. Essas interpretações são calcadas, de acordo com o ponto de vista de seus interlocutores, nos aspectos biológicos e químicos das doenças, nos aspectos psicossomáticos, nos aspectos sociais dentre outros. Embora orientados por modelos básicos de interpretação, a falta de unidade e os escopos muito distintos exercem uma influência considerável na interpretação e na relação da sociedade atual para com as doenças.

E, em terceiro, devemos lembrar que as doenças, assim como quaisquer outras manifestações humanas, também possuem uma história. As doenças surgem, se proliferam, são mantidas sob controle e, em alguns casos, desaparecem. Assim, pode se dizer que as doenças possuem até idade: há as “novas doenças” e as “velhas doenças”. Com certeza, o período retratado nos textos bíblicos não conheceu algumas das doenças

dos tempos modernos e, da mesma forma, muitas doenças daquele período não mais existem hoje.

Em quarto, e último, deve-se tomar cuidado com a terminologia bíblica e seus diagnósticos no que tange as doenças, visto que a distância histórica de seus autores encerra diferenças lingüísticas, mentais e sociais que impedem um acesso direto às afirmações, registros e interpretações daquela época. Esse fato é agravado, muitas vezes, pela falta de clareza e vagueza dos termos empregados. Tomemos, por exemplo, o termo hebraico *halã* ou *holî*, que aparecem com freqüência no Antigo Testamento. Segundo Klaus Seybold e Ulrich Müller (1981), esses termos não podem ser traduzidos simplesmente como “ficar doente” ou “estar doente” ou ainda como “doença” de forma mais geral, visto que seu significado é mais extenso e engloba todos os tipos de fraquezas do corpo. Esses termos são utilizados, por exemplo, para definir o estado de Sansão quando Dalila lhe corta os longos cabelos, fazendo com que ele perdesse sua força sobre-humana e se tornasse “tão fraco como qualquer homem” (Juízes, 16: 7, 11 e 17).

Assim, antes de se prosseguir com a análise dos textos bíblicos, assumir-se-á que o termo doença sugere que:

- a) é uma experiência física e psicológica individual da pessoa enferma;
- b) algum tipo de prática terapêutica é levada a cabo no intuito de curar ou restabelecer a condição anterior à doença. Em outras palavras, o enfermo assume o papel de paciente;
- c) o fim da vida, ou seja, a morte torna-se visível e a doença aparece como uma crise da vida;
- d) questões sobre o sentido dessa crise, situação ou evento incitam os indivíduos afetados a diagnosticar, interpretar, teorizar e a fazer considerações pertinentes ao estado enfermo.

Esses critérios propiciam a diferenciação necessária entre o entendimento das doenças e de outros fenômenos antropológicos, tais como: sofrimento, suicídio e morte, por exemplo. A análise dos textos bíblicos, dada a sua complexidade, será dividida em dois grandes grupos: as interpretações segundo o Antigo Testamento e, posteriormente, as interpretações sob o ponto de vista do Novo Testamento.

III.2.1.1 As doenças no Antigo Testamento

Uma das formas mais utilizadas pela Bíblia para falar a respeito das doenças e das pessoas doentes é a narrativa. As primeiras narrativas abordando o tema das doenças aparecem nos relatos de infertilidade feminina descritas no livro Gênesis. De acordo com esses relatos a promessa de filhos e herdeiros é tida como uma grande benção, principalmente, para as castas nobres: faraós e reis. De modo contrário, a falta de filhos é tida como um castigo, punição divina. Nas narrativas patriarcais (Gn 12-36), a infertilidade aparece como uma doença cuja origem é resultado da intervenção direta de Deus para punir atos pecaminosos. Por exemplo, o rei de Gerara, cujo nome era Abimelec, é punido por Deus por arrebatara Sara, esposa de Abraão, como sua cōnjuge (Gn 20). A punição para o caso de Abimelec foi a infertilidade de suas mulheres e servas. Em Gênesis 20: 18 lê-se: “Porque o senhor tornará estéreis todas as mulheres da casa de Abimelec, por causa de Sara, mulher de Abraão.” O problema da infertilidade e da intervenção divina no que tange a esse assunto aparece em outras passagens: Gênesis 21: 1-7 relata a intervenção de Deus para que Sara, mesmo em idade avançada, desse à luz Isaac; Gênesis 29: 31-35 narra como Deus tornou Lia fecunda a fim de que essa concebesse quatro filhos de Jacó, que aparentemente a desprezava por ter amor maior por sua segunda esposa Raquel, a irmã mais nova de Lia. Raquel, com inveja de sua irmã, demanda que Jacó também lhe dê filhos e este lhe responde: “Acaso posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade?” (Gn 30:2).

Essa noção de intervenção direta de Deus sobre o estado de saúde humana aparece também em narrativas que não guardam relação com a fertilidade. Em outros livros do Pentateuco as pragas, epidemias e a lepra ocupam posição central nas narrativas relacionadas às doenças. Desloca-se a atenção dos problemas familiares para as doenças de natureza coletiva ou que possuem significado de ordem coletiva. As pragas e pestilências são consideradas uma punição coletiva de Javé²⁵ contra todos que

²⁵ O tetragrama YHVH refere-se ao nome do Deus de Israel em forma escrita transliterada e latinizada. Originariamente, em aramaico e hebraico, era escrito e lido horizontalmente, da direita para esquerda, ou seja, HVHY. Formado por quatro consoantes hebraicas, o tetragrama original em sua forma latinizada tem sido usado por muitos séculos. Os nomes YahVeH (vertido em português para Javé), ou YeHoVaH (vertido em português para Jeová), são transliterações possíveis nas línguas portuguesas e espanholas, mas alguns eruditos preferem o uso mais primitivo do nome das quatro consoantes YHVH, já outros eruditos favorecem o nome Javé (Yahvéh ou JaHWeH). Estima-se que o tetragrama apareça mais de 6.800 vezes — sozinho ou em conjunção com algum adjetivo — no texto hebraico do Antigo Testamento. Embora muito utilizado nas antigas escrituras judaicas, o significado fonético desse tetragrama se perdeu. Existe muita controvérsia quanta as causas desse abandono da pronúncia, alguns acreditam que esse fato tenha sido motivado pela superstição (dentre os Dez Mandamentos há um que diz: “Não tomarás o nome

desrespeitem sua lei. De acordo com Números 12, a irmã de Moisés, Maria é castigada com a lepra por criticar a liderança conferida à Moisés por Deus. Em Números 14 Javé castiga com a pestilência e morte aqueles que duvidam de seu poder; já em Números 25 pragas são enviadas para castigar aqueles que idolatram outros deuses. Samuel 5:1-12 relata uma epidemia de tumores (?) que assola os Filisteus que inadvertidamente tomaram para si a arca da aliança de Deus com Israel. A ira do Deus cristão estende-se muitas vezes aos filhos, netos e bisnetos daqueles considerados pecadores. Em Samuel 12: 15 está escrito que “o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias tinha dado a Davi e, ele adoeceu gravemente”. O menino, fruto do adultério de Betsabé com o rei Davi, morre após setes dias para expiar os pecados do rei, tal como previra o profeta Natã. Essa passagem bíblica mostra que a absolvição dos pecados por Javé não isenta o pecador de uma punição, quer essa recaía sobre o próprio indivíduo ou sobre seus consangüíneos ou até sobre seus compatriotas e servos.

Como um assunto interpessoal entre Deus e os seres humanos, os estados mórbidos demandam um determinado comportamento, seja penitencial ou suplicante, a fim de que a magia e os elementos medicinais, integrados pela oração e sancionados pelos profetas, adquiram legitimação. A cura, entretanto, assim como a doença, resultará da palavra final de Javé, ao qual compete tanto a punição quanto a absolvição. Em Levítico 26: 16, Javé ameaça: “Se não me escutardes e não puserdes em prática todos estes mandamentos, se desprezardes as minhas leis (...) porei sobre vós o terror, a tísica e a febre...”, mas para aqueles que o escutam “(...) ele abençoará vosso pão e vossa água e afastará de vosso meio as enfermidades” (Ex 23: 25).

A figura do médico praticamente inexistia no período abrangido pelo Antigo Testamento e, assim, Javé mantêm o monopólio das doenças e das curas, sendo intermediado pelos profetas. Essa ausência de médicos, tal como concebemos os praticantes dessa profissão atualmente, e os escárnios dirigidos à esses membros da sociedade daquela época, entretanto, não serviam de escusa para abandonar os cuidados com o corpo. Como o ser humano era considerado uma criação à imagem e semelhança de Deus, a vida era considerada sagrada e, portanto, o ser humano era obrigado a preservá-la. Os cuidados com o corpo, nessa época, restringiam-se à higiene, às práticas

de Deus em vão...”) e outros acreditam simplesmente que isso ocorreu porque a pronúncia se tornou incerta ao longo dos anos após tantas traduções. Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/YHWH> acessado em 25/07/08.

dietéticas e aos ritos de caráter profilático. Os capítulos 11 a 15 do Levítico tratam exatamente desses assuntos e a doença que recebe maior atenção aí é a lepra.

As narrativas pertencentes ao livro Crônicas são caracterizadas pelo forte interesse nas manifestações e causas das doenças. Embora as doenças e a cura ainda sejam assuntos exclusivos de Javé, o tom das narrativas nos faz crer que as pessoas estão naquele momento buscando meios objetivos, em dadas situações, para descrever e explicar o fenômeno da doença. No segundo livro das Crônicas 16: 11 o Rei “Asa teve uma grave doença nos pés. Mesmo na doença, ele não recorreu a Javé, mas aos médicos”. A Bíblia nos faz crer que sua morte dois anos depois é justificada por tal ato, pois embora encontremos no Eclesiástico 38: 1-15 um pedido para que se honre os serviços médicos, pois Javé em sua infinita bondade lhes concedeu as habilidades de curar e aliviar a dor em seu nome, o autor conclui ironicamente: “Quem peca contra seu Criador, que caia nas mãos do médico.” (Eclo 38: 15). Em II Crônicas 21:12-19, o rei Jorão falece em meio a dores terríveis provocadas por uma doença nos intestinos tal como profetizará Elias. A doença, provocada por Javé, é uma punição por ele ter promovido a idolatria em Judá e por ter assassinado seus seis irmãos, além de alguns chefes de Israel. Já em II Crônicas 26: 16-21, o orgulhoso rei Ozias é punido com a lepra por ousar acender ilicitamente um incenso no templo de Javé. Essa tarefa de acordo com os escritos somente poderia ser realizada pelos sacerdotes descendentes de Aarão. Essas narrativas revelam que as ações humanas que despertam a ira de Javé são sempre advertidas mediante o envio de uma doença.

Ainda no que tange a relação entre comportamento humano e as dádivas e punições de Javé, há que se fazer menção ao livro de Jó e ao livro de Tobias. O livro de Jó é interessante por se contrapor a teologia da retribuição vigente naquela época, ou seja, a idéia de que Deus retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Assim, pondo em cheque essa noção de escambo, a narrativa a respeito de Jó tenta ensinar qual deve ser o comportamento de um fiel que se defronta com situações de miséria e infortúnio. De acordo com a história, com o propósito de testar a devoção de seu fiel, Deus permite que Satã cause uma série de infortúnios ao virtuoso Jó, incluindo “feridas graves, desde a planta do pé até a cabeça” (Jó 2:7). Tentar diagnosticar a doença de Jó é uma tarefa complicada: primeiro, porque se trata de um caso fictício e segundo, porque seu autor não fornece maiores detalhes. Entretanto, com base em comparações com outros textos bíblicos, Seybold & Müller (1981) acreditam que possivelmente o autor do texto estava fazendo referência à lepra. Ainda de acordo com a história, Satã acredita que a

saúde e a vida são as coisas mais importantes aos olhos de Jó e que sua devoção tem por objetivo apenas assegurar tão preciosos bens. “Pele por pele!” (Jó 2:4) diz Satã, ironicamente insinuando que Jó somente mantém sua devoção a Deus por interesse, ou seja, a fim de conservar sua integridade física. “O homem dá tudo o que tem para manter a vida. Estende, porém, a mão e o atinge na carne e nos ossos. Garanto que ele te amaldiçoará na cara!” (Jó 2:5), propõe Satã à Deus em tom desafiador, mas Jó passa no teste e, mantendo uma resoluta devoção, afirma “se aceitamos de Deus os bens, não devemos também aceitar os males?” (Jó 2:10). O comportamento de Jó, limitado à aceitação e rendição, propõe um modelo de vida e fé para o qual existe reservado um final feliz, pois Javé lhe concede, ao fim da história, uma total recuperação e compensação.

Os debates de Jó com seus amigos são peculiares, visto que a doença acaba por assumir papel central na história. De um lado, temos os amigos de Jó que representam o sistema tradicional de pensamento que segue a lógica da doença-punição, ou seja, a noção de que a doença é o resultado de uma punição divina. De outro lado, temos Jó que é incapaz de aceitar esse modelo de raciocínio por se opor fortemente a uma das premissas básicas desse modelo. Jó, sem dúvida, aceita uma das premissas do pensamento tradicional: a idéia de que Deus está na origem do sofrimento, da doença. Mas quanto à segunda premissa desse tipo de pensamento, Jó nega-se a admitir que a doença seja uma punição para a culpa e que, portanto, Deus pune justamente. Aí surge uma questão: Como um indivíduo daquela época deveria se comportar quando fosse acometido por uma doença? Sob a ótica tradicional, o comportamento ideal seria uma confissão pública da culpa e aceitação do sofrimento como uma punição merecida, tal como veremos mais adiante quando abordarmos os salmos, visto que ritualmente a confissão da culpa criaria a possibilidade do indivíduo experimentar uma restituição (cura) por parte de Deus. Esse tipo de comportamento ressalta a natureza comercial, baseada em um sistema de trocas, que norteava as ações religiosas dos indivíduos. Jó, todavia, nega-se a proceder de tal maneira, pois ele acredita que não possui culpas a confessar. É guiado por essa certeza de absoluta retidão que Jó busca uma confrontação direta com Deus. Embora ele adote algumas práticas tradicionais, ele logra seguir caminhos nunca antes trilhados. Ele não busca o contato com Deus mediante lamentação e penitência, mas se respalda em pressupostos legais e jurídicos. Ao se sentir despojado de seus direitos, o direito à vida, Jó busca procedimentos sacrais e legais que lhe concedam um julgamento divino. Embora beirando a insanidade, as falas

de Jó clamam por um julgamento divino de Deus, um Deus que lhe roubou o direito a vida injustiçadamente e sem motivo aparente. Esse fato pode ser ilustrado pelas seguintes passagens bíblicas:

Desde agora tenho uma testemunha no céu, e o meu defensor, está lá em cima. Ele interpretará minhas queixas diante de Deus, enquanto diante de Deus os meus olhos derramam lágrimas. Que ele julgue entre o homem e Deus, como se costuma fazer entre as pessoas, porque o número limitado dos meus anos passará e, eu farei a viagem sem retorno (Jó 16: 19-22).

Oxalá houvesse alguém para me escutar! Está é a minha última palavra. Que o Todo-poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação. Eu a levarei sobre os meus ombros e a usarei como se fosse coroa. Eu lhe prestaria contas de todos os meus passos e me apresentaria a ele como um príncipe (Jó 31: 35-37).

O desejo de Jó e sua contestação direta deram resultado, pois Javé lhe aparece e lhe restaura a saúde e lhe ressarcir por todas as perdas. E assim, a história de Jó, fomentou novas idéias no que tange as causas da doença. Embora não haja meios de determinar o impacto dessas idéias na época em que foram concebidas, o modelo doença-provação surge como um caminho novo, uma alternativa que se opõe ao modelo doença-punição fortemente enraizado em uma era dominada pelo temor a Deus.

A narrativa do livro de Tobias, por sua vez, gira em torno de três personagens fictícias denominadas: Tobit, Tobias (filho de Tobit) e sua esposa, Sara. De acordo com os padrões atuais, o livro de Tobias pode ser considerado uma espécie de romance ou novela com o propósito de transmitir um ensinamento. O autor apresenta o caso de pessoas que acatam os desígnios de Deus aconteça o que acontecer. O tema central, assim como do livro de Jó, é o sofrimento dos justos. A doença, o sofrimento e as privações são vistas como provações, algo que fortalece a fé. Tobit e Sara, em seu sofrimento, clamam pela misericórdia divina. Deus, representando pelo anjo Rafael, lhes envia ajuda. O anjo Rafael ensina a Tobias como proceder a cura da cegueira de seu pai e a desobsessão de sua futura esposa, chamada Sara, em um ritual mágico que envolvia a utilização do fel, do fígado e do coração de um peixe. A história é interessante porque concebe pela primeira vez uma quebra no monopólio da cura detido por Javé, além de destacar a presença de entidades demoníacas que afetam negativamente os seres humanos. Concebe-se nessa história a possibilidade de que Javé possa delegar o ato de curar aos seres humanos sob a supervisão e orientação de membros de seu esquadrão celestial. Assim, de certa forma, está história viria a

legitimar as práticas exorcistas, bem como as práticas medicinais populares no combate às doenças.

Quanto ao ponto de vista dos próprios doentes, o livro dos Salmos constitui a melhor fonte para a análise da expressão da experiência individual da pessoa enferma. Os salmos são um exemplo da influência da fé na vida das pessoas. Por meio dessas orações as pessoas relataram situações pessoais ou coletivas, reivindicaram direitos, denunciaram a injustiça, questionaram, lamentaram e agradeceram a Deus. No tocante as doenças, os salmos podem ser divididos em dois grandes grupos: os salmos de lamentação e os salmos de agradecimento. Os salmos de lamentação apresentam as súplicas da pessoa doente que, em momentos de profunda tristeza e sofrimento, se volta para seu Criador na esperança de ser curada. Então, depois de uma recuperação, louva-se ao enternecido Deus de forma ritualística.

É interessante observar que os salmos de lamentação, geralmente, refletem ao mesmo tempo uma confissão de culpa e um pedido de misericórdia. O salmo 38 serve para exemplificar tal afirmação. Nos versículos 4 e 5, do referido salmo, lê-se: “Por causa de tua ira, nada em meu corpo está intacto; nada está inteiro em meus ossos; por causa do meu pecado. Minhas culpas ultrapassam minha cabeça, e pesam sobre mim, como fardo pesado...”. Essas palavras sintetizam a aceitação da culpa, a admissão dos pecados, além de implicitamente reconhecer na doença uma punição enviada por Deus em decorrência dessas faltas. Mais adiante no mesmo salmo, o autor implora por misericórdia: “Javé, não me abandones! Meu Deus, não fiques longe de mim! Vem socorrer-me depressa, meu Senhor, minha salvação!” (Sl 38: 22 e 23). O autor do salmo 39, após admitir sua culpa por ter caluniado e difamado, implora: “Afasta de mim tua praga, pois eu sucumbo ao ataque da tua mão! (...) Afasta de mim o teu olhar, e deixa-me respirar! Antes que eu me vá, e já não exista mais!”.

Os salmos de lamentação revelam também outro fato muito importante: o ambiente que cerca o doente é geralmente hostil. A sociedade daquela época, cujo conhecimento sobre as doenças e remédios era bastante superficial, considerava as pessoas doentes como estigmatizadas ou marcadas pela culpa. Os doentes se tornavam impuros, indignos e, sobretudo, dependentes de um ambiente marcado pela presença de inimigos pessoais, especuladores e fanáticos religiosos que apenas intensificavam seu sofrimento. Isso levava a maioria dos doentes ao isolamento e, nos casos extremos, os próprios doentes compreendiam seu estado como uma “morte preliminar”. O autor do salmo 88 considera-se, tão drástica é sua situação, como um abandonado, um ser

esquecido por Deus de tal forma que a única coisa que lhe resta é uma existência nas sombras de um mundo subterrâneo similar ao do túmulo. O salmo 41 também revela esse lado perverso das relações sociais daquele período. Inimigos declarados, visitantes e amigos dissimulados especulam sobre a sorte do doente e as palavras (de conforto), para autor do salmo 41, soam-lhe cínicas, jocosas e falsas. Aparentemente, para esse autor, as acusações e intrigas parecem causar mais dor do que a doença em si. Essa dinâmica das relações sociais justifica o porquê, nos casos em que havia recuperação, dos rituais e cerimônias públicas. Essas atividades penitenciais visavam reintegrar o indivíduo outrora doente à sociedade. Culturalmente, a pessoa curada via a necessidade de utilização de todos os recursos ao seu alcance para reafirmar sua integridade, que dentro da lógica culpa-punição tinha sido posta à prova, a fim de assumir novamente suas funções sociais e fazer valer os direitos que antes lhe foram negados. Os salmos de agradecimento tratam exatamente dessa reintegração e constituem, assim, um dos recursos freqüentemente utilizado para reivindicar uma readmissão ao seio da sociedade e a participação nos atos religiosos, visto que isso era uma prerrogativa somente dos puros. Esse tema aparece nos salmos 5, 32, 41 e 103, por exemplo, onde seus triunfantes autores rejubilam-se com o desfecho de seu sofrimento e a supremacia sobre seus inimigos. Outros salmos tratam desse mesmo tema sem deixar claro, entretanto, se estão relacionados à situações de enfermidade, como é o caso do salmo 3 e 7, por exemplo.

De acordo com Seybold & Müller (1981), para encerrar essa reflexão, as análises dos textos bíblicos do Antigo Testamento permitem identificar um importante aspecto teológico no que concerne às doenças: a responsabilidade exclusiva de Javé. Diferentemente de outras representações culturais da Antiguidade, as idéias a respeito da origem das doenças no Antigo Testamento não são centradas em aspectos mágicos, demoníacos ou naturais, embora algumas passagens de certos livros do Antigo Testamento apresentem indícios dessas interpretações. Na perspectiva do Antigo Testamento, Javé monopoliza tanto as causas das doenças quanto a sua solução, a cura. Em Êxodo 15: 26 ele afirma categoricamente: “Pois eu sou Javé, aquele que te cura”. Ainda por intermédio de Moisés, em outro livro da Bíblia, Javé proclama: “E agora, vejam bem: Eu sou eu e fora de mim não existe outro Deus. Eu faço morrer e faço viver, sou eu que firo e torno a curar, e ninguém se livra da minha mão” (Dt 32: 39). Isso revela a crença de que Javé tem total controle sobre a vida humana e as doenças resultam de sua intervenção direta. Ele toca, fere, assola, castiga e esmaga dentre uma série de outros verbos que servem de meio para a expressão de sua ira e vingança. Ele

envia pragas, pestilências e cobras picam os seres humanos ao seu comando (Nm 21: 6) como forma de punição coletiva. Assim a vida, frágil como é, oscila eternamente entre a perspectiva de manutenção e término (morte). A doença é, então, um sinal de crise nessa balança celestial e resulta de uma alteração do humor divino ante a conduta humana. A vida humana está, literalmente, nas mãos de Javé e as doenças são formas de manifestação de sua presença junto ao seu povo e temer-lhe pode vir a garantir a saúde.

III.2.1.2 As doenças no Novo Testamento

Uma análise rápida dos textos bíblicos do Novo Testamento pode dar a impressão de que há muito material a respeito das representações das doenças naquele período, visto que Jesus Cristo confronta-se com a doença em diversas passagens. Entretanto, todas as histórias a respeito dos feitos de Jesus foram influenciadas em grande medida pela crença e pontos de vista da comunidade judaica e, desta forma, esses autores deixaram seus próprios pensamentos e problemas permearem suas narrações. Esse fato impede que se separe um possível núcleo histórico que reflita os pensamentos próprios de Jesus, enquanto ser histórico e terreno. Assim, os leitores atuais da Bíblia, na verdade, tem acesso aos pensamentos e fé daqueles primeiros cristãos. Todavia, Seybold & Müller (1981) acreditam que algumas passagens bíblicas possam ser consideradas fontes relativamente seguras do ponto de vista de Jesus de Nazaré sobre as doenças e a cura, pois há momentos em que os narradores deixam de falar sobre Jesus e simplesmente reproduzem as falas do nazareno. Além dessa constatação, deve-se lembrar que as histórias que abordam as doenças servem apenas com um pré-requisito de um cenário onde o grande ato – a cura milagrosa – irá ocorrer, ou seja, os narradores não estão interessados na doença como tal e, portanto, não fornecem detalhes que permitam diagnosticar à luz dos conhecimentos atuais quais são realmente as doenças mencionadas.

De acordo com Klaus Seybold & Ulrich Müller (1981), a cultura judaica privilegiava quatro tipos de interpretações das doenças, sendo elas:

a) Causas naturais

No livro Eclesiástico (ou livro de Jesus Bem Sirac) é apresentada uma visão natural das doenças, embora seu autor enfatize que as reflexões de sua obra devem-se a

extrema fé em Javé, o Criador de tudo e todos. Seu autor destaca que os médicos são capazes de empregar substâncias extraídas da natureza para promover a cura sem a utilização de recursos mágicos (Eclo 38:1-15), isto porque se considerava que as doenças tenham causa natural. As preocupações de ordem financeira são a causa de insônia (Eclo 31:2), a ingestão excessiva de alimentos “é sempre acompanhada por mal-estar, insônia, náusea e cólica” (Eclo 31: 20) e todos os excessos são prenúncios de aflições (Eclo 37: 27-30). Embora parte dessa concepção tenha sobrevivido através das práticas medicinais populares, ela não foi capaz de assumir papel relevante nas representações da doença no Judaísmo e não se encontra no Novo Testamento textos que reproduzam ou façam referência a esse tipo de visão.

b) Causas demoníacas

O Judaísmo incorporou, também, das religiões mais antigas a interpretação demoníaca das doenças, ou seja, a noção de que os estados mórbidos são resultado da ação de um determinado demônio. Presume-se que essa crença em demônios e em seus poderes nefastos sobre a saúde evoluiu ao longo dos anos. No Antigo Testamento esse tipo de interpretação não é privilegiado e somente algumas passagens mencionam a influência negativa de demônios sobre os seres humanos; por exemplo, no livro de Tobias o demônio Asmodeu mata todos os cônjuges de Sara antes que as relações conjugais se consumassem (Tb 2: 8). Já no Novo Testamento, o fenômeno de possessão demoníaca tornou-se um evento comum nas narrativas dos milagres de Jesus. O medo de demônios e o medo de ser infectado por um demônio de uma pessoa possuída eram elevados naquela época. Acreditava-se que a pessoa doente era governada por demônios que residiam em seu corpo e que, mediante coerção desses demônios, a pessoa assumia um comportamento autodestrutivo. Pelos relatos, presume-se que os fenômenos de possessão geralmente ocorriam em público e a cura era efetuada através do exorcismo desses demônios.

As principais características da possessão eram: a supressão da própria subjetividade e a perda de controle das próprias ações. Em Marcos 1: 21-28, um homem possuído por um “espírito mau” ao se defrontar com Jesus berra: “Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir?”. A perda da subjetividade é demonstrada pelo uso do plural “nós”, que indica que existem diversos demônios que falam por intermédio da boca do indivíduo possuído. Mas adiante, em Marcos 5: 1-20, torna-se

claro que são muitos os demônios que habitam o corpo de um indivíduo, pois quando Jesus indaga a um homem possuído “Qual é o seu nome?” esse indivíduo responde: “Meu nome é Legião, porque somos muitos” (v. 9). A crença de que os demônios controlam as ações do indivíduo possuído aparecem em Marcos 9: 14-29, onde se relata que por diversas vezes a vida de um menino fora posta em risco em decorrência das convulsões provocadas pela fúria destrutiva de um “espírito mudo”. Embora esse relatos atribuam aos demônios a causa das doenças, vale ressaltar que à luz dos conhecimentos modernos as passagens de Marcos 5: 1-20 e Marcos 9: 14-29, as quais fornecem detalhes que possibilitam um diagnóstico, seriam retratadas como casos de loucura e epilepsia, respectivamente. Quanto a relato encontrado em Marcos 9: 14-29, deve-se ainda ressaltar que existem relatos paralelos em Mateus 17: 14-20 e em Lucas 9: 37-43 que omitem o termo “mudo” na definição do espírito que assola o pobre menino e, além disso, no relato de Mateus a doença é abertamente nomeada: o menino é epilético. Em síntese, isso mostra que a epilepsia, naquela época, era interpretada como uma possessão, como resultado da ação demoníaca.

Jesus foi um exorcista ativo na batalha contra esses “espíritos impuros”. É interessante observar que a idéia de possessão demoníaca e exorcismo corroboram a doutrina propagada por Jesus e, talvez, duas passagens bíblicas sejam fiéis ao seu ponto de vista. As doenças não são causadas por quaisquer demônios, elas são causadas por demônios a serviço de Satanás, o príncipe dos demônios. Em Lucas 10:18, Jesus afirma: “Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago”. Essa afirmação mostra que Jesus está convencido de que o mal, incorporado na figura de Satanás, foi expulso do céu por Deus e que agora Satanás habita entre os mortais na Terra. As doenças, desgraças e infortúnios da vida são causados por Satanás e seu exército de demônios. Todo o sofrimento, porém, terá fim quando o reino de Deus se estender do céu à Terra. Jesus se considera um instrumento de Deus com o propósito de divulgar e preparar os seres humanos para o reinado de Deus. Diante de acusações de que aquele que comanda demônios está a serviço de Satanás, em Mateus 12: 28 (com paralelo em Lucas 11:20) Jesus retruca: “se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o Reino de Deus chegou para vocês”. Seguindo a lógica desse pensamento, cada exorcismo realizado, a expulsão do demônio e a libertação da pessoa, implicam em uma redução do poder de Satanás sobre a Terra e cada vitória de Jesus é simbolicamente sinal do advento do reino de Deus na Terra. A idéia da existência de demônios e de enfermidades causadas por esses seres não são inovações do pensamento cristão,

entretanto, o mesmo não se aplica às ações de Jesus. Suas ações combinaram a possibilidade de salvação miraculosa individual com a perspectiva de uma salvação futura universal mediante a instauração do reino de Deus.

c) Pré-morte

Na antiga Israel, as fraquezas, debilidades e doenças pertenciam ao domínio da morte, ou seja, acreditava-se que, ao limitar as possibilidades da vida, as doenças representavam um estado de íntima conexão com a morte. As leis rabínicas atestavam que os pobres, os leprosos, os cegos e os inférteis encontravam-se no mesmo estado dos mortos. Essa concepção devia-se ao fato dos sujeitos leprosos, cegos ou inférteis serem marginalizados, excluídos de todo convívio social e, sua sobrevivência dependia da caridade de estranhos, pois a mendicância era em geral a única atividade realizada por esses infelizes.

Essa idéia, que era muito comum no Antigo Testamento, continua fazendo parte das crenças do período dos relatos do Novo Testamento. Uma passagem bíblica ilustra essa íntima relação entre doença e o domínio da morte. Trata-se da história, relatada em Marcos 3: 1-6, da cura da mão “seca” (?) de um indivíduo durante o período sabático. O ponto de partida da história é o encontro de Jesus com um homem que apresenta um problema na mão (infelizmente, os relatos bíblicos não são específicos e não fornecem detalhes que permitam um diagnóstico da doença a que fazem menção). Os oponentes de Jesus esperam para verificar se Jesus irá curar o indivíduo durante o *Sabbath* (o sábado é o dia de recolhimento semanal para os judeus, assim como o domingo é para os cristãos), o que seria uma violação das leis judaicas. Jesus aceitando o desafio indaga aos seus opositores: “o que é que a lei permite no sábado: fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou matar?” (Mc 3:4). A primeira questão não deixa margens à argumentação e a segunda revela a noção de pré-morte atribuída aos estados mórbidos. A cura significa salvação e, portanto, restauração da vida. Os estados enfermos inviabilizam a vida e, assim, a cura resume-se a um ato de salvação que deve ser realizado mesmo durante o Sabbath. A omissão de ajuda deixaria a pessoa mais perto da verdadeira morte, uma vez que se considera que a pessoa enferma já adentrou os domínios da morte. Jesus revela que as interpretações do Antigo Testamento ainda são válidas e que a doença é tida como uma proximidade com a morte, ou seja, estar doente significa estar sob o controle da morte de alguma maneira.

A doença que mais levava judeus à esta condição de pré-morte na Antiga Israel era a lepra. Isso ocorria porque, de acordo com leis rabínicas, o leproso era visto como uma pessoa impura ritualmente e capaz de contaminar qualquer coisa em que tocasse ou da qual meramente se aproximasse. Essa classificação do mundo entre puro e impuro, fazia com que os leprosos fossem afastados do convívio social e o rigor imposto por essa separação torna compreensível o fato de que a existência do leproso fosse bastante similar a de uma pessoa morta. Portanto, de acordo com este entendimento, a cura de um leproso equivalia praticamente à ressurreição de um morto e, tamanho feito só poderia ser realizado por Deus. O relato em Marcos 1: 40-45 mostra a transferência desse poder divino para Jesus. Nesta passagem o leproso implora: “Se queres, tu tens o poder de me purificar” (v. 40) e Jesus tocando-o prontamente responde: “Eu quero, fique purificado” (v. 41). Essa história atribui a Jesus um feito que antes era reservado apenas a Deus a fim de enfatizar o caráter divino de seus poderes. O termo “purificar” utilizado na narrativa revela a aceitação da divisão do mundo entre pessoas puras e impuras e assim, mesmo após a cura, a reintegração à sociedade dependia ainda da declaração de pureza do indivíduo por um sacerdote. Por isso, nesse mesmo relato Jesus ordena: “Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles” (v. 44). Outro evento de cura dos leprosos, relatado em Lucas 17: 11-19, revela o mesmo tipo de visão. Nesta passagem, dez leprosos clamam à distância por misericórdia e Jesus os despacha imediatamente para a presença de um sacerdote, sem sequer tocá-los. A cura, concretizada mediante um desafio à fé daqueles indivíduos, ocorre enquanto eles caminhavam para se apresentar ao sacerdote.

d) Punição

Os textos do Antigo Testamento revelam a íntima relação entre pecados e doenças. Sob essa lógica de pensamento, a doença é a punição pelos pecados. Para cada tipo de transgressão das leis divinas, associava-se uma doença específica. Deus supostamente avalia as faltas e, baseado na culpa de um indivíduo, lança as devidas punições que poderiam atingir diretamente o dito pecador ou os seus entes queridos. Seguindo esse tipo de interpretação, a cura significava, além do alívio dos males físicos, a absolvição de todos os pecados. Essa prerrogativa cabia apenas a Javé, pois “ele perdoa suas culpas todas e cura todos os seus males” (Sl 103: 3). Assim, confissões de

culpa, orações e sacrifícios são vistos como extremamente necessários para o apaziguamento da ira divina e, conseqüente, recuperação da saúde.

O doente, não bastando o sofrimento provocado pela doença, era também confrontado com a condenação religiosa que via na sua aflição um merecido castigo. As pessoas acreditavam que podiam determinar a partir do estado enfermo de um indivíduo qual era o seu pecado, sua culpa. O judaísmo dava claros sinais de intolerância e crueldade para com as pessoas enfermas.

Mas é quanto ao Novo Testamento? Jesus compartilhava desse ponto de vista: seriam as doenças para Jesus meramente uma punição para os pecados? Em Lucas 13: 1-5, Jesus mostra-se contra esse modelo de culpa e punição para explicar os sofrimentos e as doenças. Embora esses versículos não tratem das doenças, mas sim de outros tipos de sofrimento considerados punições, a fala de Jesus permite concluir que ele se opunha ao modelo recompensatório e comercial da fé adotado por muitos ainda em seu tempo. Nesta passagem do livro de Lucas, pessoas perguntam a Jesus se os Galileus mortos por Pilatos eram pecadores e se, portanto, mereciam tal destino. Jesus então responde: “Pensam vocês que esses Galileus, por terem sofrido tal sorte, eram mais pecadores do que todos os outros Galileus? De modo algum, lhes digo eu. E se vocês não se converterem, vão morrer todos do mesmo modo” (Lc 13: 2 e 3). Esse discurso de Jesus rejeita o dogma de que os infortúnios são uma punição para pecados individuais específicos. Esse ponto de vista serve aos seus propósitos doutrinários, é claro. Uma pessoa que não fosse afetada por infortúnios ou doenças poderia, com segura convicção, se considerar como isenta do pecado e, portanto, sem necessidade de se converter a fé de Jesus. Contra esse tipo de interpretação, Jesus ameaça e afirma que todas as pessoas são pecadoras e que a conversão é necessária em decorrência do eminente julgamento de toda a humanidade por Deus.

Outra passagem no livro de João também revela essa refutação, por parte de Jesus, do modelo etiológico baseado em culpa e punição. No capítulo 9 do livro de João, os discípulos de Jesus ao se depararem com um cego de nascença indagam: “Mestre, quem foi que pecou, para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? (Jo 9:2). E Jesus responde: “Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus” (Jo 9:3). Essa narrativa procura também destacar o poder divino de Jesus, pois mais adiante o indivíduo curado afirma aos seus inquisidores: “Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada” (Jo 9: 32-33). Esse

ponto de vista de Jesus remove o problema opressivo e injusto do modelo adotado pelos judeus, que viam nas doenças a culpa e não o indivíduo sofredor.

Assim como a lepra, a cegueira era considerada incurável e a maioria dos cegos da antiga Israel vivia em estados de extrema pobreza. A imagem do cego mendigo retratada pela Bíblia mostra o duro destino desses indivíduos e justifica a comparação da cegueira com o estado das pessoas mortas. Com base no modelo pecado-punição, a cegueira era geralmente interpretada como uma punição de Deus às más ações passadas. O ser humano era geralmente punido no órgão com o qual havia pecado, desta forma, a cegueira era a punição para olhos libidinosos. Mas havia também outras interpretações para as causas da cegueira. Por exemplo, em Mateus 12: 22 ela aparece como resultado da possessão demoníaca e em Atos dos Apóstolos 13: 11, o falso mago e profeta, Elimas é amaldiçoado e Deus o torna cego logo após Paulo proferir sua maldição. As histórias de cura da cegueira em Marcos 8: 22-26 e João 9:1-34 revelam também que a cegueira podia ser interpretada como uma condição de fraqueza do corpo ou falta de força vital que poderia ser compensada mediante o toque (transferência de energia, força vital) ou emprego de substâncias curativas (nesses casos específicos, a saliva de Jesus e argila).

III.2.1.3 Saúde e fé cristã: o advento da RCC

Os textos bíblicos não estão interessados na doença pura e simplesmente. Estão mais interessados nas experiências existenciais associadas com a doença. Esses textos retratam a angústia provocada nas pessoas pelas doenças, o sofrimento físico e as conseqüências decorrentes do isolamento social. Em resumo, tratam mais “do estar doente” do que da doença. Essa diferenciação é importante porque a angústia provocada pela doença é um critério essencial na afirmação: “Estou doente!”. Isso porque a essência da doença é a angústia, a qual leva o indivíduo a solicitar ajuda. O pedido de ajuda permite que a atenção seja dirigida não mais à doença em si, mas ao indivíduo doente. A pessoa como um todo entra em perspectiva e; a doença passa a ser vista como um fenômeno com várias dimensões, representando ao mesmo tempo um evento físico e espiritual, que em sua complexidade traz à tona a questão do sentido.

A doença vista como uma ameaça à vida pode ser vivenciada como a proximidade do fim de uma história de vida, como uma desgraça predestinada, como obra do acaso etc. Seja qual for a forma de experimentá-la, a questão do sentido

ocasionalmente aparece. Nos textos bíblicos são feitas várias tentativas de se responder a essa questão do sentido, um sentido que torne o sofrimento suportável. Se por um lado, quando a doença é associada à ação de demônios e deuses, pode-se afirmar que na verdade trata-se de uma tentativa vã dos indivíduos em explicar e compreender aquilo que carece de sentido. Por outro lado, há que se reconhecer que essa interpretação oferece aos indivíduos a possibilidade de combater a doença, mesmo que seja através de rituais mágicos de eficácia dúbia. Já se a doença é considerada uma punição para os pecados, assinala-se um particular entendimento da natureza da saúde. Saúde não é apenas integridade física, pois envolve a moral individual e o estado das relações entre o fiel e seu Deus. A doença, então, indica um distúrbio que extrapola as condições físicas do indivíduo. Porém, apesar dessas interpretações apresentarem esses aspectos positivos, suas conseqüências também podem ser danosas. Por exemplo, se as doenças são uma punição para os pecados, pode-se facilmente condenar a pessoa doente e relegar-lhe a solidariedade necessária em decorrência de seu sofrimento.

Talvez, cientes das conseqüências negativas dessas interpretações, os autores da Bíblia buscaram expandir as interpretações religiosas do sentido das doenças. Tomemos por exemplo o livro de Jó, no qual a doença (e o sofrimento, de uma forma mais geral) é retratada como uma provação da fé, um teste da devoção. Não obstante, outra crítica pode ser feita à esse tipo de interpretação. Trata-se do risco do indivíduo aceitar e render-se à sua doença, adaptando-se a viver em estado enfermo em nome de uma suposta vontade divina, seja por provação ou por punição. É como se a doença passasse a ter direitos sobre o indivíduo por estar associada à um ser divino. Assim não é de se surpreender que no Novo Testamento, por sua vez, Jesus não tente convencer os doentes de que sua doença tem um sentido particular, as narrativas mostram que ele simplesmente os cura. Aparentemente, ele procedia de tal maneira para anunciar a chegada do reino de Deus e assim atestar que a cura não significava apenas a recuperação da saúde. A cura, para Jesus, significa o fim do poder de Satanás e da morte e, indiretamente, o fim do poder da doença sobre os indivíduos. Assim, nas narrativas sobre os milagres de Jesus, não se encontram alusões à aceitação e tolerância aos estados mórbidos tampouco quanto à aceitação das interpretações tradicionais; ao contrário, o exorcismo aparece como a batalha contra poderes anti-divinos e as terapias como meios de expressão de um novo poder que tornava a vida saudável possível. Assim, para os cristãos, o Evangelho visa mostrar que uma interpretação do sentido das doenças só faz sentido se ajudar os doentes a lidarem individualmente e socialmente

com sua doença e; desta maneira, o sentido da doença passa a ser simplesmente a superação desse estado.

Ademais, para os cristãos, o encargo de sua religião foi definido logo em seus primórdios quando “Jesus convocou os Doze, e lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e lhes concedeu curar as doenças. E os enviou-os a proclamar o Reino de Deus e fazer curas” (Lc 9: 1-2). Não obstante, devido aos avanços das ciências, principalmente da medicina, a Igreja Católica limitou-se a ter compaixão e solidariedade para com os doentes, deixando claro que não se aventuraria nas áreas agora sob domínio da medicina moderna. Talvez insatisfeitos com esse papel da Igreja Católica renovada, surgiram movimentos e grupos no interior da Igreja Católica fortemente ligados de alguma maneira à renovação no Espírito Santo. Esses grupos, notadamente a Renovação Carismática e os protestantes, retomam o mandamento evangélico de curar os doentes. Acreditam, tal como está escrito em Marcos 16: 17-18, que aqueles que forem batizados e crerem em Cristo poderão “expulsar demônios em seu nome, falarão novas línguas” e que “quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados”. Tudo isso se deve à aceitação dos dons concedidos pelo Espírito Santo, os quais são pormenorizados em Coríntios I 12: 7-11. A liturgia, desses grupos, nem sempre isenta de excessos e confusão doutrinal, é calcada na virtude curativa da fé e, embora, aleguem que seu alvo seja a “cura interior”, a possibilidade de cura física não é excluída.

III.2.1.4 Catolicismo popular: na saúde e na doença, rogai ao santo!

São muitas as nuances da fé cristã e, no Brasil, uma dessas nuances contrasta sobremaneira com as demais: trata-se do catolicismo popular. A Bíblia e sua mensagem, a igreja institucional e o que o padre diz ocupam posição secundária na visão desse grupo de católicos. Isso ocorre porque, de acordo com Alba Zaluar (1983), existem quatro categorias básicas na organização do sistema cosmológico do catolicismo popular, a saber: a promessa, o milagre, o mal de Deus e o castigo divino. Essas quatro categorias constituem “a base de um sistema fechado para a explicação de acontecimentos percebidos pelos agentes como extraordinários ou incontroláveis” (ZALUAR, Alba: 1983, p. 80). O uso e a manipulação dessas categorias permitem o controle desses acontecimentos. Através de suas normas e valores, essas categorias legitimam as relações sociais e expressam a manifestação da vontade divina e a aprovação ou desaprovação dos santos quanto à conduta dos humanos.

É notório que o campo sob domínio de Deus e dos santos no catolicismo popular não se restringe às doenças. A ajuda dos santos é solicitada em todos os acontecimentos em que há elementos de incerteza ou que escapem ao controle humano. A ajuda do santo é obtida mediante o estabelecimento de uma relação de reciprocidade, isto é, uma relação entre seres humanos e santos que engloba uma série de prestações e contraprestações socialmente estipuladas. A idéia de reciprocidade é sintetizada no termo promessa. Uma promessa denota ao mesmo tempo o pedido feito ao santo, a dívida a saldar e a efetivação do pagamento. As promessas enfatizam o sacrifício pessoal do promesseiro e muitas vezes envolvem longas peregrinações a um determinado santuário, além da execução de penitências propriamente ditas: andar de joelhos na cidade do santo, carregar pedras, fazer jejum, raspar a cabeça etc. No ciclo de vida de um indivíduo, a proteção é invocada principalmente nas fases “liminares”, por exemplo: no parto, no batismo, no casamento, na doença e na morte, isto é, em ocasiões em que a pessoa atravessa um período de transição de um estado socialmente definido para outro, durante o qual deixa de operar o controle social. Os elementos de indeterminação dessas fases transitórias são dirimidos ao se delegar seu controle aos santos em uma tentativa de ordenar a experiência vivida durante essas fases. Busca-se, em outras palavras, a ordenação da esfera social (real) mediante a interferência da esfera transcendente (espiritual). A manifestação do poder do santo é nesses casos denominada de milagre. O milagre é considerado, para os devotos, como o resultado benéfico da intervenção do santo nos momentos de necessidade e em situações cujo desfecho não é óbvio ou certo em termos de expectativas, antes ou depois da execução de uma promessa. Em alguns casos, acredita-se que a devoção ao santo por si só garante graças ao devoto sem que promessas sejam rogadas.

Embora cientes da amplitude do campo de atuação de Deus e dos santos, nos estudos de Alba Zaluar (1983) sobre o catolicismo popular verificou-se que há entre seus praticantes uma marcante preocupação com as doenças, às quais se atribuem causas sobrenaturais, e os meios de evitá-las ou superá-las. As interpretações das origens dos estados mórbidos situam-se, em geral, em dois pólos distintos: o do mal e o do castigo. A característica principal das doenças classificadas no pólo do mal é que essas são interpretadas como resultado da ação maléfica de uma pessoa contra outra. Quando os métodos da medicina oficial falham ou quando a doença prossegue por muito tempo ou quando há acessos de doença inesperados, a origem da doença é atribuída ao mau-olhado, malfeito, feitiço, quebranto, coisa-feita dentre outros termos

que designam a interferência proposital ou não de indivíduos de má índole no curso natural da doença. Uma análise superficial desse tipo de interpretação da etiologia das doenças pode levar o observador a menosprezá-la, visto que essa interpretação compartilha muito das crenças medievais de bruxaria e feitiçaria, as quais são comumente vistas como formas “primitivas de pensamento” (na plenitude do significado pejorativo que o termo primitivo encerra no meio acadêmico). Entretanto, esse sistema de crença possui uma lógica própria que, em linhas gerais, oferece “uma explicação *a posteriori* para a ocorrência de fenômenos inesperados e imprevisíveis que revelam pontos de conflito na estrutura social” (ZALUAR, Alba: 1983, p. 83). Em outras palavras, esse tipo de interpretação na verdade projeta para uma esfera sobrenatural os significados e tensões das relações da ordem social construída pelos seres humanos. Conflitos de interesse, manipulação e conflito de normas sociais, não cumprimentos de regras moralmente obrigatórias e/ou relações inamistosas e tensas entre indivíduos envolvendo interesses pessoais podem desencadear acusações em que a parte atingida projete a culpa de seu mal ao atrito com a outra parte da relação. Essa forma de interpretação das doenças, quando as acusações são declaradas publicamente, pode resultar no rompimento de relações ou na negação de obrigações sociais consideradas insatisfatórias. Não causa espanto o fato de essas acusações serem geralmente dirigidas a pessoas estigmatizadas e marginalizadas pela sociedade, pois essas pessoas geralmente não contam com o apóio de uma rede de parentes e amigos com os quais trocar favores e obrigações.

No pólo oposto está o castigo, ou seja, a idéia de que a doença é resultado de um castigo enviado pelo ser supremo – Deus – e seus intermediários – os santos. O sofrimento é explicado pela vontade das entidades sagradas e a ineficácia das tentativas mágicas é tida como resultado dessa vontade sobrenatural, a qual não se contesta e tampouco está sujeita à barganha. O castigo, nesse sistema ideológico, é visto sob dois prismas distintos: primeiro, subentende-se que o sofrimento é inerente à condição humana e que, dessa forma, todos estão sujeitos a padecer dos mais diversos males durante a existência terrena e; segundo, está implícita a idéia de que os indivíduos são responsáveis por suas ações e que o sofrimento é uma provação devida pelos que praticam más ações. Dentre todas as más ações possíveis, o catolicismo popular enfatiza principalmente as sanções de auto-sustentação do sistema, ou seja, aquelas vinculadas ao rompimento do equilíbrio entre o santo e os indivíduos. “O infortúnio presente de alguém é sempre remetido a uma falta contra os santos no passado: falta de respeito,

esquecimento ou quebra de promessa ou, pior ainda, omissão ou escárnio pelas coisas do santo” (ZALUAR, 1983, p.85). Tamanha é a importância das obrigações para com os santos que, mesmo quando há falecimento de um indivíduo, os deveres decorrentes de uma promessa, especialmente naqueles envolvendo pedidos de proteção em casos de doença, continuam a valer. Cabe aos parentes mais próximos saldar a dívida para que a alma do falecido logre o merecido descanso. A esse respeito, Zaluar escreve que “a análise dessas promessas constitui um meio para se inferir o grau de proximidade e a estreiteza dos laços que unem as pessoas que as cumprem, ao mesmo tempo em que elas são, para os agentes, um meio de ativar os laços de solidariedade entre eles” (ZALUAR, Alba: 1983, p. 85).

A preocupação com o pecado, a qual é uma idéia que permeia todo o universo cristão, parece não ser relevante no âmbito do catolicismo popular. Os atos de honra ao santo e a obrigatoriedade do cumprimento das promessas sobrepujam a idéia de pecado e, podem inclusive, servir como meios bem mais efetivos de controle social. Por exemplo, as histórias de castigos decorrentes do desrespeito pelo santo incitam fazendeiros e comerciantes a assumirem encargos com as festas enquanto pessoas de maior posse localmente. Em linhas gerais, o sistema do catolicismo popular envolve dois tipos de relação: uma explícita e outra implícita. A relação explícita é aquela entre o santo e o indivíduo devoto e a relação implícita remete as relações das pessoas entre si. As obrigações para com os santos são, nessa perspectiva, obrigações para com os semelhantes. Primeiro, porque para pagar suas promessas e cumprir suas obrigações para com os santos as pessoas se organizam e realizam atividades em conjunto. A realização dessas atividades depende de um esforço coletivo que reforçam os laços simbólicos de união dos seres humanos, união essa que é mediada pelo santo da comunidade. Em segundo, porque num plano simbólico a relação entre o devoto e o santo reproduz relações sociais idealizadas de proteção e segurança, tal como pai (protetor e provedor) e filho (carente e dependente). A realização das festas em homenagem aos santos incorpora essa noção: cabe, em geral, aos indivíduos de maior posse o provimento de recursos para a concretização da festa. Esse ato acaba se tornando uma forma de legitimação da ordem social revelando as redes de solidariedade e a divisão na estrutura social da comunidade devota, além de constituir “uma oportunidade para a competição pelo prestígio e para expressar simbolicamente a unidade e os conflitos inerentes a essas relações sociais estabelecidas” (ZALUAR, Alba: 1983, p.95).

III.2.2 Protestantismo: uma dicotomia desnecessária

As religiões são resultado de uma interpenetração e interdependência entre partes distintas, que se influenciam reciprocamente, proporcionando seja um produto novo ou um produto com características diferentes do fenômeno original. Nessa perspectiva é possível pensar a religião cristã como resultado de uma longa jornada na qual foram surgindo novas formas sem que isso representasse uma ruptura com as etapas anteriores. As diversas formas do cristianismo, em conformidade com a época e espaço em que estiveram situados, apresentaram maior ou menor incidência desse ou daquele fenômeno, mantendo, contudo, uma base como referencial da identidade cristã. Uma das principais mutações da fé cristã foi denominada de Protestantismo. O Protestantismo foi um movimento profundamente marcado por sua relação com a sociedade, visto que o ascetismo e a predestinação à salvação impelem seus fiéis a necessidade de provar à sociedade, por meio do trabalho e do sucesso financeiro, que de fato eram escolhidos para a salvação eterna. O entendimento da religião cristã sob essa ótica de circularidade e trocas recíprocas permite compreender que, mesmo que falemos de “protestantismos”, dada suas muitas facetas, “as fronteiras normalmente interpostas entre eles não assumiram e nem estabeleceram rupturas. (...) A caminhada do protestantismo foi e continua sendo o resultado do sincretismo com diversos protestantismos e com outras religiosidades” (MENESES, Jonatas; 2002: p.131). Esse fato é evidenciado, por exemplo, no discurso de um fiel:

Eu não sei porque algumas igrejas dizem que nós não temos o Espírito Santo de Deus e que ele não age em nossas vidas. Se não temos o Pai e temos também o Filho é porque também temos Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nós e tem feito maravilhas em nosso meio. Portanto, eu não sou nem maior nem menor do que qualquer outro crente (transcrição do discurso de um fiel da Igreja Presbiteriana do Brasil extraído de MENESES, 2002, p. 134)

As divisões clássicas do protestantismo, a saber: protestantismo histórico ou clássico; pentecostalismo e neopentecostalismo, são assim contestadas por Meneses, cujo trabalho constatou que paradigmas (por exemplo, os dons carismáticos) tidos como práticas exclusivas dos pentecostais e neopentecostais estenderam suas ações inclusive sobre os protestantes históricos, propiciando intenso processo de pentecostalização. Segundo essa interpretação, os protestantes históricos tornaram-se praticantes de paradigmas pentecostais mesmo que mantenham, oficialmente, a identificação com

denominações originárias da Reforma Protestante. A nova classificação proposta por Meneses resume-se, também, a 3 grupos: pentecostais institucionalizados tradicionais; protestantes históricos renovados (igrejas protestantes históricas que passaram pelo processo de pentecostalização e assumiram uma nova identidade) e, finalmente, os protestantes históricos (igrejas que embora tenham absorvido paradigmas pentecostais não renunciaram suas denominações históricas).

Assim, para os fins desse trabalho, adotarei a classificação proposta por Jonatas Meneses e tratarei os evangélicos que aparecem nas rubricas do censo do IBGE como pentecostais. Isso implica dizer que os evangélicos estão alicerçados, basicamente, em dois pilares centrais: a crença na contemporaneidade dos dons espirituais e a manifestação desses dons em determinadas denominações ou momentos do movimento protestante. Não obstante, o fato de que essa ou aquela denominação evidencie em graus diferentes de intensidade esse ou aquele dom espiritual não é ignorado. Isso permite entender o fato da glossolalia ter maior evidência na primeira onda pentecostal, o dom da cura divina se destacar entre os pentecostais da segunda onda e as batalhas espirituais e a teologia da prosperidade serem mais evidentes na terceira onda (neopentecostal), por exemplo. Isso, entretanto, não refuta o fato de que até mesmo grupos históricos do protestantismo absorveram e praticam em maior ou menor medida paradigmas do movimento pentecostal.

III.2.2.1 Doença e cura divina

A cura divina para os pentecostais é elevada à categoria de obra divina e não é considerada pelos integrantes desses grupos religiosos como uma simples mercadoria, ao contrário, do que as cerimônias televisionadas fazem parecer. A cura divina é interpretada pelos pentecostais como a recompensa pela fé verdadeira e expressão do poder de Deus delegado àqueles que o buscam. Independente da importância simbólica que é atribuída a esse fenômeno e da incapacidade de se transmitir isso em shows e templos com milhares de pessoas se acotovelando, essa crença é utilizada como forte atrativo para a conquista de novos fiéis. A esse respeito, Meneses escreveu:

Os rituais de cura divina são o marketing principal que contribui decisivamente, em todos os momentos, para o processo de conversão, transformação e afiliação do fiel a uma denominação pentecostal ou pentecostalizada. O primeiro contato do candidato a fiel com o grupo é o resultado do proselitismo que anuncia o poder de Deus que cura todas as

enfermidades, e é a busca desse poder que ele vai a essas agências de salvação (MENESES, Jonatas: 2002, p. 7).

Isso ocorre porque para os pentecostais a cura é necessária para a preservação do corpo que, mesmo enfermo, ainda é a morada do espírito. Na perspectiva pentecostal, doença, corpo e cura estão necessariamente interligados.

A doença, de acordo com Laplantine (1991), não pode inscrever-se apenas no universo da biomedicina, pois ela é parte de um complexo social maior e não está isenta das representações que a sociedade estabelece a respeito do tema. Se limitarmos o conceito de doença a esfera bioquímica, a correção ou superação da função desviada seria possível única e exclusivamente por meio de intervenções no aparato fisiológico, e esse tem sido o comportamento da medicina moderna que trata das doenças sem levar em consideração os intercruzamentos da doença e do doente com fatores sociais, psicológicos, religiosos etc. A análise de alguns trabalhos acadêmicos talvez torne possível uma melhor compreensão das representações sociais e religiosas que os pentecostais atribuem ao sofrimento gerado pelas doenças.

Um estudo sobre os protestantes no Estado de São Paulo demonstrou que “os pentecostais aceitam dois tipos básicos de diagnósticos para as doenças que os afligem: doenças originárias do pecado e doenças originárias da ação demoníaca” (SOUZA *apud* MENESES, Jonatas: 2002, p. 141). O trabalho de Souza, realizado em 1966, embora retrate um contexto muito diferente do atual, visto que hoje seria possível indicar outras possibilidades de diagnóstico em decorrência da dinâmica social e religiosa, ressalta o fato ainda válido e comprovado por Meneses (2002) de que a doença é compreendida como nociva, perniciosa, resultado do pecado e da ação de entidades espirituais maléficas. Três novos tipos de diagnósticos vêm se somar aos dois anteriormente propostos por Souza com base nos trabalhos de Meneses.

Meneses constata nos depoimentos de indivíduos pentecostais que a doença pode ser interpretada como o resultado da ação de Deus sobre o ser humano com o objetivo de provar a sua fé, ou seja, mesmo protegido e em comunhão com Deus o fiel é acometido por doenças para que sua fé seja testada com o intuito de fortalecê-lo física e espiritualmente. Adicionalmente, verificou-se que muitos discursos assinalam as doenças como não resultantes apenas de ordem espiritual, mas também de ordem fisiológica e sócio-econômica. Alguns ressaltam, inclusive, apenas o lado fisiológico revelando a eficiência na difusão de conceitos e diagnósticos oriundos da medicina oficial propiciada pela expansão do sistema de saúde brasileiro, deixando-se quaisquer

críticas de lado. O crescimento do atendimento médico, decorrente do processo de urbanização, propiciou à população pobre “o acesso a um novo tipo de conhecimento, com um novo tipo de linguagem que, como sistema de valores, transforma-se em norma superior aos indivíduos” (CÉSAR & SHAULL *apud* MENESES, Jonatas: 2002, p. 143). Em decorrência disso, os comportamentos sociais são re-orientados e a busca das duas terapias, religiosa e médica, é o reflexo do constante contato dos indivíduos com essas novas formas de linguagem e, assim, busca-se a Deus através de orações individuais e coletivas sem, contudo, abrir mão do aparato médico à disposição. Outro diagnóstico muito comum atribuído pelos pentecostais relaciona-se com as condições de vida e de trabalho a que estão submetidos, conforme nos revela o depoimento desse fiel da igreja Evangélica Assembléia de Deus:

Nem tudo de doença que temos é do demônio ou do pecado ou do corpo. Muitas doenças acontecem porque as pessoas comem mal e vivem mal. Também, com o salário que a gente ganha (transcrição do discurso de um fiel da Igreja Evangélica Assembléia de Deus extraído de MENESES, 2002, p. 144).

Ao assumirem que a doença é causada por baixos salários, pelas moradias e alimentação precárias, pela corrupção política e pela falta de atendimento médico adequado, os discursos revelam uma adequação dos indivíduos à realidade sócio-política brasileira, bem como a disseminação das idéias da medicina social abordada no primeiro capítulo desse trabalho.

As representações pentecostais a respeito da doença apontam na direção de causas diversas: fisiológicas, pecaminosas, demoníacas, condições de vida e provação divina. Os esforços para se fazer a distinção entre a doença de origem material e a doença de origem espiritual não impedem, todavia, a adoção simultânea do tratamento médico e da oração. Isso revela uma visão totalizante do ser humano onde as fronteiras entre o material e o espiritual tornam-se por demais imprecisas. Os trabalhos de Minayo, embora não relacionado à nenhuma religião, já demonstrará essa concepção holística das representações de saúde e doença entre as classes populares, a qual geralmente é responsável pela lotação das instalações pentecostais. Mesmo mergulhado nos paradigmas pentecostais (práticas religiosas mágicas), os discursos dos fiéis destacam o corpo como dádiva de Deus que precisa ser preservado por todas as vias disponíveis. Isso se deve, principalmente, ao fato de se reconhecer o corpo sem a hierarquização da dualidade corpo/espírito. Embora isso não configure uma:

superação total da dicotomia cartesiana de corpo/alma, constitui um avanço que permite ao fiel uma melhor compreensão dos seus estados de doenças, impelindo-o à utilização dos dois modelos de terapia: a terapia médica oficial e a terapia religiosa como formas que interagem reciprocamente e que proporcionam a ajuda para a manutenção do corpo (MENESES, Jonatas: 2002, p. 157)

III.2.3 Espiritismo e sua lógica

A base da doutrina espírita, propagada por Allan Kardec, é a crença na existência de espíritos, seres inteligentes que povoam o universo além da existência material. Essa crença é suportada por três pilares, a saber:

- a) a convicção na reencarnação (o ser humano é visto como um espírito imortal encarnado que herda as conseqüências boas ou más de suas encarnações anteriores);
- b) a existência do perispírito (corpo fluídico que envolve o espírito e cuja responsabilidade, dentre outras funções, é a transmissão da vontade do espírito para o corpo e das sensações do corpo para o espírito) e;
- c) a possibilidade de comunicação, através de médiuns, com os espíritos.

Assim, embora, os espíritas apresentem diferentes orientações e ênfases (doutrinárias, assistenciais, terapêuticas, intelectualizadas, evangélicas etc.), os princípios básicos das duas primeiras obras de Allan Kardec: *O Livro dos Espíritos* (1857) e *O Livro dos Médiuns* (1859) são geralmente aceito por todos.

A doutrina de Kardec rejeita uma série de princípios cristãos, dentre os quais podemos citar: o conceito trinitário de Deus, a divindade de Jesus Cristo e, por conseguinte, a natureza divina dos milagres, a existência de anjos e demônios e a existência do inferno e do paraíso. Além desses, não há como não mencionar o ponto mais controverso e contraditório de ambas as religiões. Refiro-me a idéia espírita da reencarnação que se opõe, de forma drástica, à idéia cristã de ressurreição. Para os espíritas, a crença na reencarnação encontra respaldo em outros dois princípios de sua doutrina: primeiro, na lei de causa e efeito, a qual contabiliza a acumulação de carma de acordo com as ações do indivíduo e; segundo, na importância do livre arbítrio na evolução espiritual de cada ser humano durante suas mais diversas encarnações. É

importante ressaltar que, embora, a doutrina espírita rejeite todos esses fatores-chaves da fé cristã, a moralidade cristã não foi abandonada. Isto fica evidente, sobretudo, na obra *O Evangelho segundo o Espiritismo* (1864), na qual o discurso relativamente científico das duas primeiras obras é substituído por um discurso moral-religioso.

A prática espírita no Brasil é marcada por sessões ou reuniões que podem ser divididas nas seguintes categorias: estudo doutrinário, desenvolvimento de mediunidade, trabalhos de caridade e desobsessão. A prática terapêutica espírita é calcada na “fluidoterapia”, pois se acredita que as doenças e os espíritos obsessores exercem uma influência negativa no perispírito e que os *passes* são capazes, ao mesmo tempo, de descarregar as energias negativas e infundir energias positivas no perispírito. Os médiuns dão *passes* em quase todos os tipos de sessões mencionadas anteriormente e, comumente, os freqüentadores de um centro espírita enfrentam longas horas em filas para receber um *passo* de um determinado médium daquele centro. Os freqüentadores podem ou não ser adeptos da doutrina kardecista e, em geral, a participação nessas sessões e reuniões é esporádica ou ocorre em intervalos de tempo irregulares. A execução de um *passo* compreende a movimentação dos braços do médium em torno do corpo do “cliente” a fim de se transferir energia ao indivíduo e a fonte de energia pode ser o médium, o mundo espiritual ou ambos. O termo “cliente” é empregado aqui somente para realçar o fato de que o indivíduo que procura esses serviços não é necessariamente um adepto; não obstante, há que se lembrar que a maioria dos centros espíritas não cobra por seus serviços.

É ainda importante mencionar que a desobsessão é uma prática que pode ser interpretada mais como um processo de conscientização, aconselhamento e educação dos espíritos do que uma prática terapêutica para os obsediados. A desobsessão não deve, dessa forma, ser confundida com o exorcismo, o qual visa apenas a expulsão de uma entidade maligna, uma vez que os espíritas não acreditam em demônios. A possessão representa um caso extremo da capacidade dos espíritos de afetar o pensamento e a saúde dos encarnados e a mesma resulta de uma série de fatores. Dentre esses fatores merece destaque a crença na influência do pensamento do próprio indivíduo afetado: a cobiça, a inveja, a mágoa dentre outros sentimentos humanos são considerados pelos espíritas como atrativos para espíritos obsessores. A sessão de desobsessão e os *passes* não podem ser encarados como meios definitivos de solução dos problemas dos obsediados. Por isso, a fim de eliminar a causa e prevenir novas

obsessões é altamente recomendado que o indivíduo estude a doutrina espírita e aja de acordo com os princípios morais dessa doutrina.

III.2.3.1 Hospital celestial: a doença como terapia

O Livro dos Espíritos apresenta pouco mais de mil respostas a perguntas dirigidas por seu autor aos espíritos. Kardec organizou essas respostas em quatro livros: “As Causas Primárias”, no qual ele discute os elementos gerais do universo, a existência de Deus, a criação e o princípio vital; “Mundo dos Espíritos”, onde esclarece a tipologia dos espíritos e a sua interação com os seres vivos, a reencarnação e o papel dos espíritos em fenômenos psicológicos; “As Leis Morais”, que apresenta onze leis morais que regem o universo e; por fim, “Esperanças e Consolações”, no qual discute-se as penas e gozos terrenos e celestiais. Para Kardec, seu livro apresenta uma doutrina sistemática e científica do mundo espiritual que se fez possível mediante a redescoberta da mediunidade. Além de atestar a existência de outro plano existencial, os espíritos prescreveram modelos de comportamento para a vida terrena baseados em princípios morais tipicamente cristãos. Isso é compreensível, levando-se em conta que os avanços científicos do século XIX erodiam a visão religiosa do mundo, desmistificando a cosmologia e a cronologia histórica cristã apresentada na Bíblia. Kardec, assim como muitos intelectuais de sua época, preocupava-se com a crise moral que adviria dessa erosão da fé cristã; portanto, seu trabalho caracteriza-se por um esforço em criar uma ponte entre ciência e religião, entre o “é” e o “deve”. Embora Kardec tenha interpretado sua doutrina como uma ciência empírica, capaz de interpretar e condensar a comunicação espiritual em princípios morais, no Brasil sua doutrina acabou sendo identificada e assimilada de imediato como uma religião. Em certa medida, isso ocorreu porque o Espiritismo se propagou mais rapidamente entre as classes populares.

É bem provável que foram os seguidores populares de Kardec que contribuíram para enfatizar a capacidade terapêutica da mediunidade, tendo em vista seus interesses e crenças. Embora Kardec tenha se distanciado da visão cristã dos milagres e da idéia de seres sobrenaturais (anjos e demônios), ele aparentemente não se opunha a utilização da mediunidade com propósitos curativos. A pergunta 556 do Livro dos Espíritos fornece maiores esclarecimentos a esse respeito:

556. Certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? O poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque os bons espíritos auxiliam. Mas é necessário desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. (KARDEC, p. 204, 2006)

Essa passagem do Livro dos Espíritos mostra que a possibilidade de cura espiritual é aceita, ademais recomenda cautela e ceticismo quanto aos relatos sobre esses atos. De uma forma geral, acredito que Kardec julgava que a mediunidade deveria ser utilizada mais para educar e prover orientação moral do que para curar. Isso, entretanto, não impediu o advento de uma série de interpretações etiológicas das doenças, respaldadas na crença de um mundo celestial e na lei de causa e efeito, bem como de terapias espirituais com o propósito de restaurar a saúde física e mental mediante os mais diversos tipos de intervenção celestial. Em seu livro *Apometria para Iniciantes* (2002), Patrícia Barz & Geraldo M. Borbagatto destacam as seguintes causas dos estados mórbidos segundo a ótica espírita:

a) Indução Espiritual

É o processo em que desencarnados (espíritos) transmitem energia negativa aos encarnados (seres humanos) em decorrência de suas angústias e dores, a ponto de causar uma desarmonia que se traduziria em mal estar físico e psíquico. A indução espiritual, segundo Barz & Borbagatto, poderia ser desencadeada pela conduta do indivíduo afetado. Acredita-se que os hábitos perniciosos, os vícios, o medo despropositado e a descrença seriam atrativos para esses espíritos malfeitores. Adicionalmente, os mesmos autores também afirmam que em certas circunstâncias alguns indivíduos podem ter vislumbres de experiências marcantes ocorridas em outra encarnação. Essas reminiscências, guardadas no âmago do espírito, poderiam causar sensações de angústia, desespero ou remorso sem causas aparentes; psicologicamente falando, essas seriam manifestações do que comumente conhecemos como neurose.

b) Obsessão espiritual

É a ação maléfica e persistente de um espírito sobre um indivíduo que, diferentemente da indução espiritual, muitas vezes independe da conduta do indivíduo alvo. A obsessão pode causar perturbação completa do organismo e das faculdades mentais do indivíduo afetado. Quanto às causas das obsessões, Allan Kardec escreveu:

245. As causas da obsessão variam, de acordo com o caráter do Espírito. É, às vezes, uma *vingança* que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes, também, não há mais do que o *desejo de fazer mal*: o Espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram; encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. (...) Outros são guiados por um *sentimento de covardia*, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistirem (KARDEC, texto extraído da versão eletrônica do Livro dos Médiuns, sem paginação) [os grifos são meus].

No entanto, as causas não se limitam a essas apontadas no texto acima. No tópico 252 do mesmo livro são indicadas outras causas para a obsessão. É possível deduzir, mediante leitura do relato das irmãs atormentadas por um espírito zombeteiro, no tópico 252, que a obsessão pode resultar de transgressões graves dos encarnados e desencarnados e o sofrimento provocado por esse processo serve como expiação das faltas. Ainda, nesse mesmo tópico, Kardec afirma que as imperfeições morais dão azo à ação dos espíritos obsessores. Calcados, talvez, nessa interpretação, Patrícia Barz e Geraldo Borbagatto (2002) afirmam que a obsessão espiritual seria a causa primordial de todas as doenças mentais. É interessante observar que esses autores interpretam e tratam, inclusive, as formas de dominação tirânicas entre seres humanos como pseudo-obsessões. Esse tipo de relação interpessoal, alimentado pelo ódio mútuo, teria segundo a concepção dos referidos autores os mesmos efeitos nocivos da obsessão espiritual e, além disso, o maior culpado, nesse tipo de comportamento errôneo, seria justamente aquele que se deixa dominar. Os autores também relacionam os processos de obsessão com os conceitos biológicos de simbiose (relação mutuamente vantajosa entre espíritos e seres humanos) e parasitismo (associação entre espíritos e seres humanos que resulta em prejuízos aos últimos).

c) Estigmas cármicos não obsessivos: físicos e psíquicos

O carma é um termo religioso utilizado pelo Budismo, Hinduísmo e Jainismo para designar as conseqüências das ações humanas, ou seja, de forma análoga aos postulados físicos de Isaac Newton (1687), essas religiões assumem que para toda ação existe uma reação de força equivalente em sentido contrário. Assim, segundo essa formulação, um indivíduo que comete uma má ação irá com certeza receber um mal equivalente àquele que praticou. No Ocidente, essa noção de carma foi adotada e reformulada pelo espiritismo. Vale ressaltar que o termo carma não foi utilizado por Allan Kardec em nenhum de seus livros. Isso, longe de ser apenas um fato frívolo, revela a oposição de Kardec quanto às idéias deterministas inerente à concepção oriental do termo carma. Essa discordância conceitual levou Kardec a uma reformulação da idéia original, a qual foi denominada de Lei de Causa e Efeito ou Lei das Causalidades. Assim, enquanto o conceito de carma sugere que as ações passadas resultarão em dívidas a serem resgatadas, a lei das causalidades apresenta a idéia de que os acontecimentos da vida, inclusive o sofrimento, possuem um motivo justo e uma finalidade proveitosa.

As doenças, assim como qualquer contingência humana, podem então ser interpretadas como resultado dessa lei. Acredita-se que as ações antiéticas produzem "complexa desarmonia psíquica que (...) se enraízam no perispírito, só se exteriorizando mais tarde sob a forma de deficiência ou enfermidades complexas no transcorrer das reencarnações sucessivas" (BARZ, Patrícia & BORBAGATTO, Geraldo: 2002, p. 25). As deficiências físicas congênitas (ausência de membros, surdez, cegueira etc.) e manifestações mentais patológicas (Síndrome de Down, esquizofrenia, autismo etc.) são vistos, sob essa ótica, como uma oportunidade para reaprender e evoluir espiritualmente, pois se assume que os estados patológicos de nascença resultam de faltas cometidas em existências passadas. Pode-se dizer, na verdade, que as doenças na existência terrena são muitas vezes interpretadas pela ótica espírita como "recursos terapêuticos, requeridos pelo espírito moralmente enfermo, visando o reajuste de sua consciência culpada" (BARZ, Patrícia & BORBAGATTO, Geraldo: 2002 , p. 26).

d) Síndrome da Mediunidade Reprimida

A mediunidade é a faculdade psíquica que permite a interação com o plano de existência espiritual. O médium é, portanto, um instrumento de ligação ou sintonização entre dois planos existenciais distintos e, que é capaz de captar, canalizar e transmitir energias do mundo espiritual. Acredita-se que essa capacidade, entretanto, quando não é disciplinada pode causar grandes perturbações psíquicas (ansiedade, angústia, mania de perseguição etc.) que podem, em casos extremos, levar a psicose. Mas o que justifica o fato daqueles que exercem a mediunidade em sua plenitude não sofrerem os efeitos negativos desse dom? Antes de responder a essa indagação, convém salientar se de fato a mediunidade oferece riscos à saúde humana. De acordo com Allan Kardec:

221. 2ª O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga?

O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga; a mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos, ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido, que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. (KARDEC, texto extraído da versão eletrônica do Livro dos Médiuns, sem paginação definida)

221. 5ª Poderia a mediunidade produzir a loucura?

Não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura, quando esta já não exista em gérmen; porém, existindo este, o bom-senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. (KARDEC, texto extraído da versão eletrônica do Livro dos Médiuns, sem paginação definida)

Fica claro pelo conteúdo dos trechos acima que a mediunidade só oferece riscos à saúde quando usada de forma exagerada ou inescrupulosa. Portanto, poderíamos dizer que o fato dos médiuns saberem “desligar” a conexão com o mundo espiritual é essencial para a manutenção da sua saúde. Essa constatação responde à indagação proposta no parágrafo anterior e justifica a origem da crença de que o não-aprimoramento das habilidades mediúnicas possa acarretar sérios prejuízos ao equilíbrio psíquico-físico de um indivíduo. Acredita-se que o contato constante com forças e energias celestiais gera um desgaste insuportável para o corpo humano, esse desgaste inevitavelmente traduzir-se-á em doenças e, portanto, o estudo e a prática dos dons mediúnicos são necessários para manutenção de um equilíbrio.

III.2.4 O candomblé e sua cosmovisão

O candomblé não é só uma religião, é uma “comunidade-terreiro”. O terreiro é um território mítico, ancestral que oferece aos seus membros a possibilidade de integrarem uma família independente dos vínculos consangüíneos. Um terreiro confere novos papéis sociais aos seus membros quando esses são inseridos em sua estrutura, sem com isso romper os vínculos com a sociedade como um todo. “O terreiro é o espaço cultural onde foram restituídos e transferidos os conteúdos culturais da África genitora” (SANTOS *apud* DIAS, Luciana: 1995, p.40) em uma tentativa de reproduzir, em um espaço físico limitado, a relação harmoniosa entre *Aiê* e *Orum*, através da presença simbólica dos elementos do *Orum* e através do culto. O *Orum* é um mundo paralelo ao mundo real, o *Aiê*, que coexiste com todos os conteúdos deste. Assim “cada indivíduo, cada árvore, cada animal possui um duplo espiritual e abstrato no *Orum*, ou ao contrário, tudo que existe no *Orum* tem sua ou suas representações materiais no *Aiê*” (SANTOS *apud* DIAS, Luciana: 1995, p.41).

No candomblé, as divindades cultuadas são chamadas de orixás²⁶. Segundo seus mitos, cada indivíduo que nasce está ligado à uma dessas divindades e a ligação está situada, mais especificamente, dentro da cabeça do indivíduo. A cabeça, conhecida como *ori* na tradição Nagô, é a síntese da individualidade de uma pessoa e cada aspecto da personalidade humana deve-se às características das divindades existentes no “plano espiritual” (*orum*). É por isso que essa divindade é chamada de *eledá* ou dono da cabeça (*olori*) e, assim, todos os ritos de passagem no candomblé envolvem primeiro uma oferenda ao dono da cabeça. “A cabeça estabelece a junção do individual e do coletivo, sendo vista como uma ponte de intersecção onde se concentram as forças sagradas e a possibilidade de realização pessoal” (DIAS, Luciana: 1995, p. 42). Se o mundo concreto e o mundo do além se organizam em torno da individualidade (a cabeça), o corpo humano pode ser interpretado como um microcosmo cujo equilíbrio depende da forma como o indivíduo vive sua própria vida. Por isso no candomblé, é muito importante que o indivíduo saiba “quem ele realmente é”, quem é seu correspondente espiritual (o dono

²⁶ O orixá representa uma matéria de origem abstrata, cada pessoa está vinculada a um tipo ou qualidade de matéria, constituindo grupos vinculados ao mesmo orixá enquanto símbolos desta qualidade. Cada orixá está associado a um dos quatro elementos da natureza (água, terra, fogo e ar), a uma força da natureza, a um símbolo social ou a um modelo de comportamento. Simbolicamente, são representados, nos terreiros por suas cores e alimentos favoritos, seus emblemas, ervas e vestimentas. Nos terreiros paulistas são geralmente cultuados cerca de treze orixás, a saber: Exu, Ogum, Oxossi, Ossaim, Omulu ou Obaluaiê, Iroko, Oxumaré, Nanã, Xangô, Iansã, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Uma descrição detalhada dos mitos relativos a essas divindades pode ser lida no trabalho de Luciana M. Dias, 1995, p. 45-49.

da sua cabeça) e quais as afinidades é preciso respeitar para que se mantenha o equilíbrio das relações com essa divindade. Assim, é necessário recorrer ao oráculo (jogo de búzios) para se reconhecer, saber quem se é realmente e como se deve conduzir a vida de modo coerente com essa parte da individualidade. Seguindo a lógica desse pensamento pode-se afirmar que:

o mal provém então de uma ignorância, os homens ignoram o que são e transgridem as interdições próprias a cada tipo de cabeça. As proibições têm um sentido profilático, servindo para proteger o indivíduo de seus próprios descuidos (DIAS, Luciana: 1995, p. 43).

Isso, porém, não significa que o indivíduo deva se submeter à arbitrariedade de leis impostas desde seu nascimento, significa que cada um deve-se conformar com sua natureza e, para isso, é essencial conhecer a si próprio. Assim, o jogo de búzios nas cerimônias do candomblé permite a identificação da constituição espiritual do indivíduo, ou seja, permite determinar o orixá principal (*olori*) e os demais orixás ligados à pessoa, bem como ajuda a desvendar os males e as oferendas e os sacrifícios necessários para a defesa (ou contra-ataque) do mal. O serviço prestado pelos terreiros de candomblé à população em geral consiste, basicamente, no jogo de búzios e na execução de “trabalhos” com o intuito de resolver uma série de problemas, tais como: doenças, desilusão amorosa, alcoolismo etc. ou para promover a prosperidade ou para garantir proteção. Em um mundo secularizado, no qual o “desencantamento” e “desmágicação” da religião não chegam a ser plenos, as pessoas contam com o oráculo do candomblé como mais um instrumento para aliviar suas ansiedades, livrar-lhes dos seus males, saciar seu desejo de explicação dos eventos que carecem de sentido e de conhecer o futuro. O oráculo sempre mostrará uma forma de agir ou contra-atacar. As soluções para resolver o que o jogo de búzios revelou dependem, em geral, de oferendas, sacrifícios e “limpezas”, os quais são conhecidos como *ebós*. Segundo definição de Reginaldo Prandi o:

ebó é o sacrifício ritual através do qual os males que estão no cliente são desviados para alimentos, objetos, e mesmo animais abatidos, os quais são despachados, isto é, levados para lugares determinados pelo jogo, que podem ser uma encruzilhada, uma mata, uma lagoa...(PRANDI *apud* DIAS, 1995, p.60).

Essa característica determina o caráter mágico do candomblé, ou seja, a tentativa de intervenção no mundo através de símbolos e significados da religião. A eficácia do

ebó é avaliada, fora do contexto do culto, por aqueles que desse artifício se utilizaram. Além disso, o *ebó* constitui para o indivíduo um ato de afronta contra a sua própria realidade, é um contra-ataque à passividade e à frustração a que estava submetido, visto que a pessoa acredita de fato que pode contar com forças que intervêm à seu favor. Cabe ainda ressaltar que Luciana Dias (1995, p. 61), ainda se referindo a obra de Reginaldo Prandi, afirma que essa “materialidade do sagrado e da magia são referências muito imediatas, o que faz com que não haja necessidade de referências transcendentais de âmbito mais geral, sendo a magia eficaz em si mesma”.

III.2.4.1 A balança dos Orixás

No trabalho empírico realizado por Luciana Dias (1995) constatou-se que a principal representação sobre a saúde/doença no candomblé é a noção de equilíbrio. Essa noção de equilíbrio, para os entrevistados, envolve três diferentes instâncias: o físico, o emocional (ou psíquico ou mental) e o espiritual. Ambas, a instância física e a mental estão intimamente ligadas à espiritual, tendo em vista que existe uma profunda ligação do orixá com o indivíduo. Dada a cosmovisão do candomblé, em que a esfera material (*aiê*) está permeada pela esfera espiritual (*orum*), em uma relação de constante troca e comunicação, não seria realmente concebível uma interpretação distinta da que fora revelada pelas entrevistas. Vale ressaltar que a repercussão do desequilíbrio entre as três diferentes instâncias citadas não se limita apenas às doenças orgânicas, físicas. Acredita-se que a fronteira entre o mental e o espiritual seja bem mais estreita, portanto, frequentemente as doenças mentais são vinculadas aos problemas do plano espiritual (feitiçaria, quebra de tabus, encostos dentre outros) e aos aspectos emocionais (carência afetiva, ansiedade, ambição etc.).

A necessidade do indivíduo saber quem é seu *olori* torna-se condição *sine qua non* para a manutenção desse equilíbrio. A transgressão de tabus, geralmente alimentares, decorrentes da constituição espiritual é apontada como a principal causa do desequilíbrio que gera doenças. Luciana Dias (1995, p. 74), citando Barros e Teixeira, aponta que no processo iniciático a noção de equilíbrio é geralmente associada à de saúde. Na pesquisa dos referidos autores foi constatado que a iniciação no candomblé, na maioria dos casos por eles analisados, foi motivada por questões de saúde. A doença constitui um apelo para a inserção e iniciação parcial ou total no candomblé, visto que os estados mórbidos são geralmente interpretados como uma manifestação do orixá

sobre “seu filho”, em outras palavras, as doenças são vistas como uma transgressão não-intencional (no caso daqueles que não são iniciados) da natureza do *olori* do indivíduo.

Nas falas dos entrevistados de Luciana Dias (1995) são apontadas, também, as condições para se ter saúde, equilíbrio. O equilíbrio, como condição da saúde, depende da possibilidade do indivíduo ter acesso aos cuidados básicos e prioritários (alimentação, higiene, moradia), educação, trabalho e lazer. Todas essas condições, invariavelmente, remetem à questões de cunho sócio-econômico. Essas falas refletem as preocupações da população de baixa renda que, geralmente, representam a maioria dos freqüentadores dos terreiros de candomblé. Esse fato, entretanto, traz consigo uma contradição: se por um lado revela a consciência de marginalização, por outro revela a acomodação. Os pais e mães-de-santo na maioria das vezes assumem uma postura de solidariedade e buscam formas de resolver os problemas através dos recursos religiosos de que dispõem. Assim, mesmo cientes dos agravantes sociais, não há uma busca de transformação do contexto social que promove o desequilíbrio. Talvez isso se deva à forma como o indivíduo vivencia e enfrenta os problemas de saúde, ou seja, talvez resulte da sua crença na eficácia da magia sobre os problemas de ordem material. Acredita-se que os despachos (*ebós*), já discutido anteriormente, satisfaçam as necessidades do indivíduo, em decorrência de uma absoluta certeza da intervenção espiritual, de tal forma que quaisquer outras ações são descartadas por serem consideradas desnecessárias.

A saúde para o candomblé é um bem inestimável, pois a possessão não se dá em um corpo fragilizado. O corpo humano saudável tem papel fundamental na religião, visto que os orixás dependem do corpo de “seus filhos” para se comunicarem com o *Aiê*. Por isso é muito importante que o indivíduo siga uma série de cuidados profiláticos que evitem a fragilização do corpo. Esses cuidados (ou restrições) irão depender obviamente do orixá vinculado ao indivíduo. Uma interpretação como essa encara a doença enquanto manifestação de uma fragilidade do indivíduo, ou seja, é uma manifestação individual de que algo não está bem, algo que gera um desequilíbrio. Isso levou Luciana Dias (1995, p. 79) a concluir que, na ótica do candomblé, “cada pessoa tem pólos mais frágeis em função de um arquétipo”. Quando a pessoa está fragilizada, sua sensibilidade aumenta e, portanto, torna-se mais suscetível aos fatores externos (biológicos, sociais e espirituais) que podem causar doenças. Sob essa ótica, a doença é uma manifestação pessoal (ordem interna) decorrente de fatores externos. É importante

lembrar que estar fragilizado no candomblé significa um estado de perda de *axé*, de força vital, cuja restauração dependerá da mediação dos médiuns.

As entrevistas que Luciana Dias (1995) realizou com os sacerdotes de candomblé revelam também outras formas de conceber a doença, sem abandonar por completo a idéia de desequilíbrio. A primeira delas, talvez, possa até ser interpretada mais como uma crítica dos pais e mães-de-santo do que realmente um novo olhar sobre o mesmo objeto. Pais e mães-de-santo no candomblé assumem que a falta de discernimento, quando uma pessoa não vê ou se recusa a ver o que está causando seus problemas, é também uma das causas das enfermidades. Alguns comportamentos humanos são, então, encarados como doença. A pessoa, segundo este ponto de vista, não *está* doente...ela *é* doente. A depressão, a ansiedade, a angústia são apontadas como formas de auto-agressão que, causando debilidade orgânica, podem levar aos estados mórbidos. Em síntese, aparece aqui a noção de que o indivíduo causa seus próprios sortilégios. Ressalto ainda que essa noção difere daquela que envolve quebra de tabus, seja intencional ou não, no qual o desequilíbrio resulta da quebra das proibições típicas de um determinado orixás (*olori*). A segunda forma de interpretar as origens das doenças enfatiza a ação de terceiros sob a forma de feitiçaria e transmissão de energias negativas (mau-olhado, por exemplo).

Um fato interessante a ser observado é que, embora existam no candomblé diversas relações entre partes do corpo/enfermidades e os orixás, essas classificações preestabelecidas não aparecem na fala dos entrevistados. Como fora mencionado anteriormente, as doenças podem ser vistas como uma manifestação do orixá principal (*olori*) ou dos demais orixás vinculados ao indivíduo (“carrego-de-santo”). Essa crença motivou a elaboração de um sistema classificatório dos sintomas e das enfermidades típicas de cada orixá. Assim, dentre os exemplos citados por Dias (1995), podemos destacar que as doenças de pele são atribuídas a Obaluaiê²⁷, enquanto o vitiligo à Oxumaré. Iemenjá e Oxum, deusas ligadas às águas, à feminilidade e a maternidade,

²⁷ Sobre Omulu ou Obaluaiê, também chamado Xapanã (Nigéria) e Sapatá (Daomé), Dias (1995) escreveu: “ele é o deus da varíola, da febre, das doenças da pele. Obaluaiê, filho de Nanã, é um dos deuses da terra. Ele está ligado às epidemias, à provocação de doenças e à promoção da cura. É visto como ‘médico dos pobres’. É muito temido, visto como um deus terrível, que exige respeito. Veste-se de palha da costa, com um capuz deste material cobrindo todo o rosto e parte do corpo. Dizem que é para esconder as pústulas da varíola. Dança fazendo movimentos simbólicos de quem mata e come, varre o mundo com seu *xaxará*, espécie de cetro que chega a representar o próprio rei dos espíritos. Está ligado aos mistérios da morte e do nascimento. Sua comida típica é o *doburu*, a pipoca, que acompanha todos os momentos do culto, desempenhando papel relevante em todos os rituais que visam promover uma regeneração periódica do mundo. É com *doburu* que Obaluaiê limpa o mundo de seus males” (DIAS, 1995, p. 46).

exprimem-se através de doenças venéreas femininas, disfunções menstruais e infertilidade. A impotência e a infertilidade masculina são atribuídas a Xangô e Exu. Iansã, deusa dos ventos, tem como “marca” a asma, falta de ar e enfisemas. Oxossi, considerado o “dono de todas as cabeças”, Ossaim e Iansã aparecem com responsáveis por distúrbios emocionais e a loucura. Muitos são os mitos e as associações, mas infelizmente a utilização de todos é incabível neste trabalho.

III.2.5 Umbanda: doença é desordem

Em meados de 1920, no Rio de Janeiro, surgia o primeiro centro de umbanda, resultado de uma dissidência com um kardecismo que rejeitava e menosprezava a presença de guias negros e caboclos, os quais eram tidos como espíritos inferiores pelos kardecistas mais ortodoxos. Essa umbanda que nascia e se consolidaria nos anos seguintes é profundamente marcada pelo caráter assistencial. A presença das entidades (orixás e espíritos dos antepassados) no transe tem por finalidade a cura, a proteção e o aconselhamento dos fiéis. Caboclos, pretos velhos, pomba-giras, ciganos, marinheiros dentre outros personagens estigmatizados e marginalizados pela sociedade possuem na umbanda a mesma missão: trabalhar em favor dos sofredores. Mesmo tendo herdado do kardecismo a idéia do trabalho em benefício do próximo, a visão umbandista sobre doença compartilha muito das interpretações religiosas africanas. Concone, citado por Rita Diniz (1999, p. 53), ressalta que a idéia de força vital como valor essencial é encontrada em diversas formas de expressões religiosas africanas e, de acordo com essa perspectiva, as religiões africanas visam essencialmente captar essa força ou energia para assegurar a vida pondo em atuação forças naturais. “A doença, o sofrimento, a fadiga são sinais da diminuição dessa força [*axe*]” (DINIZ, Rita: 1999, p. 54) ou, em outras palavras, resultam de um desequilíbrio de forças e, assim, cabe à ação mágica da religião intervir cada vez que essa ameaça de desordem ou desordem apareça a fim de colocar ordem no caos que se apresenta ao indivíduo em forma de doença e outros males. Apesar disso, essa intervenção não é interpretada sob a ótica dos milagres, tão comuns no catolicismo popular. O milagre aparece usualmente como uma mudança brusca e admirável, uma presença sobrenatural na natureza. Já na umbanda, a cura, dado o caráter mágico das religiões mediúnicas, é resultado de um intervenção dentro da ordem natural das coisas a fim de corrigir desequilíbrios e favorecer os indivíduos que a esse meio recorrem.

Assim como ocorre no pentecostalismo, percebe-se que na umbanda as fronteiras entre “doença espiritual” e “doença material” também não são tão nítidas quanto nos faz crer os discursos religiosos. A primeira dificuldade encontrada refere-se à definição desses conceitos. As “doenças materiais” são aquelas pertinentes à esfera de atuação da medicina oficial e as “doenças espirituais”, por sua vez, são aquelas que não são “doenças materiais”. Esse círculo vicioso e pouco esclarecedor deve-se ao fato das “doenças materiais” trazerem “embutidas, em sua própria definição, a possibilidade de uma interpretação mágico-religiosa” (MONTERO, Paula: 1985, p.118). Essa afirmação ganha sentido quando se analisa a trajetória daqueles que buscam um terreiro de umbanda por motivos de saúde. A maioria dos indivíduos busca a cura mágica após ter experimentado, geralmente, recursos oferecidos pela medicina oficial. Seja por que a medicina oficial fracassa ao tentar resolver os problemas do paciente ou por não ser capaz de dar um diagnóstico preciso, a cura mágica aparece como substituta ou algo que se contrapõe à medicina oficial. Diante do fracasso da terapia médica²⁸, o discurso mágico-religioso “explica” a doença, atribuindo-lhe causas sobrenaturais, permitindo ao indivíduo obter sentido de um fenômeno visto em um primeiro momento somente em sua negatividade: a perda da saúde. Quando a doença é espiritual, o médico se torna incapaz de diagnosticá-la e isso se deve ao fato da “doença espiritual” subtrair a materialidade primordial para a existência de uma doença. A “doença espiritual” “supera a ordem do puramente fisiológico e se torna indicador de forças sobrenaturais cuja natureza, origem e intenções cabem ao médium, e não ao médico, investigar” (MONTERO, Paula: 1985, p. 123).

Quando a terapia médica oficial reconhece a existência de uma doença, mas não é capaz de promover melhoras no estado de saúde de um indivíduo, ou quando o médico é incapaz de diagnosticar as causas mórbidas, indiretamente, a idéia de que existem causas patogênicas anteriores aos efeitos orgânicos e comportamentais (doenças psiquiátricas) é corroborada. Em outras palavras, essa ineficiência é vista como um indicador de uma outra ordem de acontecimentos. Acontecimentos esses vinculados à esfera mágica e transcendente, que evidenciam para os doentes a espiritualidade de seu

²⁸ O fracasso da terapia médica significa, sobretudo, a impossibilidade de se “ver” e localizar a doença. Nas representações sobre as enfermidades (orgânicas e comportamentais), sejam elas eruditas ou populares, poder localizar e “ver” a doença constitui condição *sine qua non* de sua existência. Se não pode ser vista, não existe. A adoção do modelo ontológico, já abordado no tópico I.2.1.1, dá segurança ao indivíduo enfermo, pois a possibilidade da doença ser vista, percebida, tocada e alcançada em sua própria materialidade confere aos médicos o poder de extirpá-la e assim por fim a agonia do doente, além de desvincular o doente da doença.

mal em contraposição ao meramente fisiológico e orgânico. A noção de doença é resignificada simbolicamente pelo universo mágico-religioso e passa a expressar a desordem para além do corpo. Montero afirma que:

A doença, enquanto expressão da negatividade absoluta, se torna paradigma do conflito (social, moral, psicológico), do caos. Enquanto metáfora, ela passa a significar a desordem por excelência, que se manifesta no corpo físico, mas também no corpo social e no corpo astral (MONTERO, Paula: 1985, p.124)

É próprio da doença a interferência no cotidiano do indivíduo, impondo uma nova norma de vida. Essa ruptura com o que o indivíduo costumava fazer e não pode mais, facilita a associação entre doença/desordem, permitindo ao indivíduo reinterpretar sua doença como uma experiência do sobrenatural, como interferência espiritual em seu corpo e em sua vida. E assim a “doença espiritual”, transforma os sintomas do corpo, em sinais de uma desordem abrangente que até então carecia de sentido para o paciente e, por conseguinte, fora do alcance e compreensão do médico. A doença é então uma maneira dos fenômenos transcendentais se manifestarem, de virem à tona. Dito em outras palavras, a “doença espiritual” não é doença, mas pode vir a tornar-se quando suas causas não forem identificadas e tratadas pelo médium a tempo. Nos casos em que a cura espiritual é impotente, seja por um diagnóstico espiritual tardio ou por predestinação cármica, quando o sofrimento é visto como um mal necessário para reparar faltas cometidas em vidas passadas, o doente geralmente é encaminhado novamente ao sistema terapêutico oficial, invertendo-se as ordens de importância e legitimidade. No final do processo cabe à medicina acompanhar para à morte aqueles destinados a sofrer as agruras de uma vida enferma, ou seja, cabe à medicina os casos sem solução na esfera espiritual. Isso significa que a explicação sobrenatural se sobrepõe às causas orgânicas das doenças e é através dessa idéia de desordem/desequilíbrio que se processa a interpretação dos acontecimentos mórbidos sobre o indivíduo.

Observa-se no discurso “teológico” umbandista três categorias que permitem distinguir as origens ou causas das enfermidades, são elas: a) doenças causadas pelo próprio indivíduo; b) doenças provocadas por terceiros e; c) doenças cármicas.

A respeito do primeiro tipo, Paula Montero escreve:

o indivíduo pode ser considerado o causador da doença que o aflige quando transgredir as regras do jogo ritual desconhecendo-as ou negligenciando seus deveres religiosos, ou quando se recusa a desenvolver sua mediunidade e/ou a utiliza de maneira desvirtuada (fazendo “trabalhos” contra terceiros) (MONTERO, Paula:1985, p.130).

Isso significa que em qualquer dessas circunstâncias, o indivíduo moral e espiritualmente debilitado está desprotegido. Um corpo frágil e desprotegido está sujeito aos malefícios oriundos de forças malignas de um plano transcendente. Essas forças malignas são comumente associadas aos espíritos, ditos inferiores, que ficam vagando sem destino à procura de um corpo para que possam se infiltrar. Esses espíritos são popularmente denominados “encostos”. Seja pela recusa de fortalecimento espiritual, (entendido como o desenvolvimento da mediunidade e a obediência ao deveres religiosos), ou pelo uso mal intencionado da capacidade mediúnica (que pode ser entendido como a prática de magia negra) ou ainda pelos comportamentos vergonhosos, indisciplinados e faltosos, em geral, conseqüências bastante desagradáveis estão reservadas àqueles que assim se portaram. A umbanda reconhece, entretanto, que alguns indivíduos podem ficar vulnerável à ação dessas forças maléficas, sem consciência ou vontade pessoal de transgressão. Nesses casos, o doente, é visto geralmente como vítima, sofredor e totalmente isento de responsabilidade do mal que lhe acomete. Isso pode ocorrer, por exemplo, em situações socioeconômicas desfavoráveis, tais como: desemprego, más condições de trabalho e moradia, carências alimentares entre outros, pois acredita-se que essas situações, invariavelmente, levam à depressão, ao desânimo, à descrença e à revolta (geralmente expressada por meio de comportamentos faltosos: vícios e agressividade) que enfraquecem espiritualmente um sujeito. Seguindo esse raciocínio somos guiados à segunda categoria de interpretação etiológica da umbanda.

Os umbandistas acreditam que existam dois tipos de casos que podem levar a influência negativa do plano espiritual na vida do indivíduo sem o concurso de sua vontade, são eles: os casos de feitiços e os casos de obsessão. Nos casos de feitiços, um indivíduo pode se tornar vítima da doença em decorrência de trabalhos de magia negra (quimbanda) executados por pessoas que se utilizam dos espíritos de baixa espiritualidade (ou simplesmente espíritos inferiores) para alcançar seus interesses pessoais. A obsessão (encosto) decorre do desejo dos espíritos atrasados em perseguir, vingar antigas mágoas e atormentar os seres humanos. Os “encostos” podem provocar uma série de doenças orgânicas e comportamentais e sua ação nefasta independe da postura moral e religiosa do indivíduo alvo.

Já a terceira categoria de interpretação das causas das doenças na umbanda reflete a incorporação de conceitos da doutrina de Allan Kardec às práticas umbandistas. As doenças cármicas resultam da necessidade de um determinado indivíduo reparar faltas cometidas em vidas anteriores. Para os espíritos desencarnados, o carma consiste na aceleração ou retardamento de seu grau de perfeição e, para os encarnados, representa o destino bom ou mau de um determinado indivíduo. Os sofrimentos de uma vida podem assim serem interpretados como um castigo (ou provação) não passível de absolvição, pois independe das ações do indivíduo em sua vida presente. Os motivos que justificam essa “punição” são desconhecidos uma vez que fazem referência à uma existência passada e fora do controle do indivíduo. A noção de carma permite explicar “os casos de seres humanos cegos ou aleijados ou com piores doenças e que assim nascem sem que possam ter a menor possibilidade de se curarem” (FÉLIX *apud* MONTERO, Paula: 1985, p. 135). A reparação mediante sofrimento físico parece ser a moeda na qual se paga todos os débitos de vidas passadas e não há médico ou médium que possa advogar a favor do sujeito vitimado.

III.3 O CONSENSO RELIGIOSO

O modo de apreensão dominante da doença tão amplamente encorajado em nossa sociedade consiste em afirmar que o ser humano não está na origem da sua patologia, ou seja, a mesma procede de um agente externo, nocivo e maléfico. Porém, o indivíduo enfermo e aqueles que o cercam procedem inelutavelmente a uma reinterpretação simbólica da prática e do discurso erudito. Seus questionamentos não se limitam ao *como* de sua doença, mas principalmente ao *porquê*, ou seja, com base nas informações culturais à disposição a respeito das origens das enfermidades, empreende-se uma busca de identificação do responsável (ou culpado) e de obtenção de uma justificativa pelo estado enfermo. Trata-se de uma questão do sentido, principalmente de um sentido metafísico.

Em decorrência desse questionamento, considerado positivismo lógico redundante para o discurso científico, podemos destacar dois modelos básicos interpretativos da doença: o modelo doença-maldição e o modelo doença-punição. No primeiro modelo a doença é apreciada como efeito de uma vingança gratuita, obra do destino, uma fatalidade contra a qual nada se pode fazer. O doente é considerado uma vítima que padece pelo que não provocou. Assim, qualquer que seja a formulação

empregada (natureza hostil, divindade impetuosa, demônios e espíritos) e a reação social (resignação, prostração e purificação), a doença é considerada neste modelo como algo totalmente estranho a quem padece dela. No segundo modelo, a doença é vista como consequência necessária do que o próprio indivíduo ou grupo provocou, ou seja, é uma sanção direta dada a transgressão de uma lei ou tabu. O indivíduo é punido com a doença devido a uma negligência ou excesso, mau comportamento com relação às prescrições religiosas ou médicas. Diferentemente do primeiro modelo, qualquer que seja a representação adotada (infração contra Deus, contra os mortos, contra as divindades, contra seu “próximo”), o que está sempre envolvido são as noções de responsabilidade, de justiça, de reparação e de culpa. Essa moralização da doença deve-se principalmente à cultura cristã, que impregnou todas as esferas da sociedade ocidental, incluindo os comportamentos médicos, tidos laicos e totalmente emancipados da esfera religiosa. O fato de considerar as representações da doença em uma perspectiva ao mesmo tempo moral e religiosa contribui para delinear a percepção médica contemporânea de que a doença possa ser interpretada como doença-maldição (problema genético fruto do acaso) e doença-punição (transgressão da normalidade preventiva).

Embora os modelos etiológicos de caráter exógeno continuem a dominar a mentalidade cultural, a sociedade tende cada vez menos a considerá-los obras do destino ou fatalidade, uma vez que se pode prevenir e evitar a grande maioria dos fatores externos prejudiciais à saúde. É claro que para tanto um indivíduo deve seguir todo o arcabouço profilático ditado pela medicina oficial. A exogeneidade etiológica desta forma não isenta mais, integralmente, o indivíduo da responsabilidade pela doença, o qual a contraiu quer por ignorância, negligência ou desobediência. Essa concepção consolida a relação da doença com o social e, sobretudo, cria uma tensão entre a doença (e o doente) e a comunidade na qual ambos se inserem.

III.3.1 A causalidade

Em síntese, os parágrafos pretéritos deste tópico mostraram que as representações sociais da doença privilegiadas pela contemporaneidade, em decorrência da influência do pensamento médico, tendem em grande medida a responsabilizar o indivíduo pelo seu estado enfermo. Quando iniciei esta pesquisa dividia a mesma opinião e acreditava que encontraria nas representações sociais das religiões estudadas a

corroboração desse pensamento. Estava seguro de que acharia nessas religiões evidências discursivas que ressaltassem o fato de que o indivíduo é o causador direto da enfermidade que o aflige, em contraposição, as interpretações que ressaltassem que o indivíduo adoece sem o concurso de sua própria vontade em virtude de ações terrenas ou espirituais de terceiros. Mas estou me adiantando nas conclusões. Antes de entrarmos nesse mérito faz-se extremamente necessário uma síntese das interpretações religiosas das doenças apresentadas até aqui e essa síntese, claro, deve ser precedida das considerações teórico-metodológicas que a viabilizaram.

Primeiro, devemos retomar uma questão que se apresenta nos primeiros parágrafos deste trabalho: mas o que é doença? Seria simplesmente uma alteração biofísica objetivamente demonstrável de um determinado organismo? Seria um mecanismo de adaptação ao meio ambiente natural e cultural a que um indivíduo é submetido? Seria uma experiência individual de transformação interna desagradável e involuntária? Ou seria uma realidade psíquica fruto do desejo ou de uma estratégia intersubjetiva? Seria ainda uma realidade sociojurídica de um mau comportamento cujo ato de legitimidade, o diagnóstico, transfere a responsabilidade para qualquer "causa" colocada fora da intenção do agente social? Seria antes a realidade cultural traduzida em um sistema simbólico de conduta que envolve a ordem biológica, social e transcendente? A elaboração destas perguntas mostra que inúmeros seriam os aspectos que poderiam ser utilizados na tentativa de uma definição da doença. Essas perguntas, de certa maneira, ajudam a elucidar o fato de que as doenças não podem ser compreendidas se a análise for focada em apenas um de seus aspectos e, isso deve-se ao fato de toda doença apresentar uma tríplice realidade, a saber: uma subjetiva, uma biofísica e uma sociocultural. A doença é uma experiência subjetiva de qualquer coisa anormal. O sofrimento, a dor e a indisposição que marcam essa experiência individual são considerados como sinais de uma ou mais alterações biofísicas que podem, na maioria dos casos, ser objetivamente comprovadas no organismo. Esse estado biofísico é legitimado mediante o diagnóstico médico e, assim, o estado e o papel social de "doente" deixa de ser apenas uma realidade psicológica ou biomédica e passa a ser uma realidade sociocultural. Essa relação entre a esfera psicológica, biomédica e social possui implicações complexas de reciprocidade, co-ocorrências e transitividade que tornam pouco evidente as fronteiras dessas esferas na conceituação do termo doença e, sobretudo, na definição de quem é realmente "doente". Por exemplo, depois de simular ou mostrar provas biomédicas ou culturais de uma "doença" um indivíduo pode adquirir

os direitos associados ao papel social do portador daquela doença. Ou ainda, um indivíduo pode sofrer os constrangimentos sociais segregativos aplicados aos "doentes" mesmo na ausência de alterações biofísicas objetivas. Todas essas interações são processadas a partir das representações socioculturais da doença.

Seguindo o raciocínio imposto pela formulação da questão: afinal o que é doença?, há que se discutir o conceito de "causa". Sob a ótica da Sociologia do Desvio²⁹, a distinção entre a doença e as outras formas de comportamento desviante "são as técnicas especiais que a sociedade estabelece para justificar a pessoa doente e o fato que a responsabilidade social desse comportamento pode sempre ser transferida para alguma causa além da vontade da pessoa doente" (YOUNG *apud* ZEMPLÉNI, Andras: 1994, p.139). Essa distinção permite compreender porque a causalidade é um tema relevante quando se trata das doenças, ou seja, sociologicamente a causalidade da doença é importante porque a doença, enquanto comportamento desviante, permite ao indivíduo "escapar", mesmo que momentaneamente, de suas responsabilidades sociais (familiares, profissionais etc.) sem que haja qualquer tipo de sanção. Todavia, essa definição, pretensamente universal, sucinta algumas objeções.

A primeira objeção se apóia no fato de que através da observação dos sintomas e manifestações biofísicas é possível determinar a enfermidade e, portanto, homologá-la, ou seja, a referência a uma causa involuntária não seria a única forma de validá-la e justificá-la.

A segunda objeção diz respeito ao fato de que a sociedade não elabora "técnicas especiais" distintas para a justificação e legitimação de comportamentos de pessoas consideradas enfermas daquelas consideradas saudáveis e, adicionalmente, nem todos os comportamentos desviantes atribuídos a um agente ou processo que escapa ao controle e a vontade efetiva de um indivíduo são denominados de "doenças". Por exemplo, a má influência espiritual pode servir tanto como justificativa para certas doenças como para o fracasso financeiro, ou seja, não há uma técnica distinta para

²⁹ A sociologia do desvio teve sua origem a partir de paradigmas positivistas e seu desenvolvimento data do final dos anos 50. Estudiosos americanos desenvolveram análises de conduta dos agentes sociais sob diferentes perspectivas, tais como: a funcionalista, a interacionista, a psicológica e a biológica (as duas últimas foram descartadas com a evolução da disciplina) dentre outras. O desvio é entendido como um comportamento ou uma qualidade (característica) da pessoa social que, superando os limites de tolerância em relação à norma, consentidos em um determinado contexto social espaço-temporal, é objeto de um processo de sanção e/ou de estigmatização, que exprime a necessidade funcional do sistema social de controlar a mudança cultural segundo a lógica do poder dominante. Em outras palavras, o desvio não é só um comportamento em que o indivíduo infringe uma norma por acaso, mas trata-se de uma infração motivada e contextualizada. Trata de um conjunto de comportamentos que não são conformes às normas e valores partilhados na sociedade, e, por isso podem ser sancionados.

justificar dois fatos de naturezas completamente diversas. A possessão de um indivíduo pelo seu orixá no candomblé e na umbanda ou por um espírito de luz nas sessões espíritas ou, ainda, a glossolalia dos cristãos são exemplos de comportamentos incomuns e, de certa forma, "desviantes", atribuídos a influência de agentes externos alheios à vontade do indivíduo. Não obstante, os três exemplos citados, não são rotulados pela sociedade como "doença". Em síntese, certas doenças são "legitimadas e justificadas da mesma forma que outros infortúnios que afetam os corpos, os bens e a vida social dos indivíduos" (ZEMPLÉNI, Andras: 1994, p. 140). Adicionalmente, a polivalência etiológica (vírus, divindade, feitiçaria, pecado, pobreza etc.), ao contrário dos postulados biomédicos tradicionais fundamentados em laços de causa e efeito biunívocos, impede que uma sociedade reserve "técnicas especiais" de justificação das doenças.

A terceira objeção está relacionada à noção de justificação. Inúmeras são as representações da doença, nas religiões aqui abordadas, que caracterizam certas doenças como sanção direta de certas condutas proibidas ou inadequadas com o propósito (implícito) de coibir ou dirimir práticas que contrariem os pressupostos de sua doutrina ou ameacem a manutenção de seu sistema. Se o pecado, o desrespeito ou o descumprimento de promessas ao santo, a promiscuidade, os vícios são atos punidos com a doença sob a ótica religiosa, então, a interpretação da doença como uma conduta social desviante involuntária e isenta de sanção não possui fundamento. A doença é, na verdade, a sanção de uma conduta social anterior – indesejável e desviante – que pode ser reparada mediante rituais religiosos diversos. Assim, a noção de justificação perde sua validade explicativa universal quando se destaca a responsabilidade do indivíduo na origem ou persistência da doença e a doença, em si, constitui a sanção que supostamente deveria inexistir segundo a definição universal apresentada por sociólogos e sociólogas do desvio.

Uma vez feitas essas considerações, é preciso retomar a discussão sobre a "causa" das doenças. A polivalência etiológica impede que seja atribuído a uma doença qualquer uma única condição antecedente que seria necessária para gerá-la. Assim, Andras Zempléni (1994) acredita que o diagnóstico de uma doença admite quatro operações e questionamentos correspondentes:

- a) O reconhecimento nosológico e sintomático (Qual doença?);
- b) A percepção de sua causa instrumental (Como?);

- c) A identificação do agente responsável (Quem ou qual?);
- d) A reconstituição de sua origem (Por que?).

De uma forma geral, após o reconhecimento e definição da doença que assola o indivíduo, são atribuída diferentes "causas" para seu estado. A primeira causa é chamada de instrumental, pois visa de forma imediata identificar o mecanismo ou o meio de criação da doença. A segunda causa é denominada eficiente, pois tem por objetivo identificar o agente que detém a força eficaz na produção da doença. A terceira causa, a causa conjectural ou última, constitui um empreendimento de busca do sentido da doença, ou seja, é a busca por um acontecimento conjectural ou representação simbólica cuja reconstituição torna inteligível a experiência mórbida: por que aconteceu nesse momento e sob essa forma nesse indivíduo?

Tabela 8 – Causalidade das doenças por religião

Religião	Causas (Como?)	Agente (Quem?)	Origem (Por que?)
Catolicismo (Bíblia)	Orgânica Espiritual	Deus Demônios Indivíduo	Punição Provação Conduta
Catolicismo Popular	Orgânica Espiritual	Deus Santos Indivíduo Terceiros	Magia Punição Provação Conduta
Protestantismo	Orgânica Espiritual	Deus Demônios Indivíduo Terceiros Espíritos	Magia Punição Provação Conduta Socioeconômica
Espiritismo	Orgânica Psicológica Espiritual	Espíritos Indivíduo Terceiros	Provação Emocional Mediunidade Conduta
Candomblé	Orgânica Psicológica Espiritual	Divindades Espíritos Indivíduo Terceiros	Magia Emocional Mediunidade Conduta Socioeconômica
Umbanda	Orgânica Psicológica Espiritual	Espíritos Indivíduo Terceiros	Magia Provação Emocional Mediunidade Conduta Socioeconômica

Seguindo o modelo de apreensão das causas das doenças proposto por Zempléni, foi elaborada a tabela 8 na tentativa de sintetizar as idéias discursivas sobre as doenças no catolicismo, protestantismo, espiritismo, candomblé e na umbanda tomando por base

as obras consultadas e utilizadas na elaboração do segundo tópico do terceiro capítulo, desta dissertação, que trata exclusivamente das interpretações das doenças por parte de religiões brasileiras.

III.3.1.1 Causas Instrumentais

Quanto às causas instrumentais foram identificadas três formas privilegiadas pelo discurso religioso de todas as religiões analisadas: a orgânica, a psicológica e a espiritual. A natureza bioquímica ou biofísica das doenças não é negada por nenhuma religião; porém, vale ressaltar que o corpo é apenas o palco onde se desenrola os conflitos entre a ordem material e espiritual e, a doença, embora orgânica em sua essência, não se limita ao corpo que sofre. Essa compreensão do organismo humano deve-se à medicina, cujo saber foi disseminado e apreendido por grandes segmentos sociais. As religiões não ficaram alheias à isso. Por isso, em alguns casos observa-se a utilização de argumentos biomédicos para validação de pressupostos morais religiosos, ou então, a arguição de idéias e práticas médicas pelos mais diversos grupos religiosos.

O aspecto psicológico é destacado somente pelas religiões mediúnicas e isso talvez seja reflexo da incorporação de conceitos avançados da psicologia moderna que trouxe à tona a existência de doenças psicossomáticas, mas, sobretudo, é provável que isso deva-se à pouca distinção que é feita entre corpo-mente-espírito por essas tradições religiosas. As religiões que destacam a natureza psicossomática das doenças (a mente agindo sobre o corpo) não descartam, entretanto, que a depressão, os "maus pensamentos" ou quaisquer outras formas de ações resultantes de uma debilidade moral sejam capazes de atrair a má influencia de espíritos que poderiam agravar o caso particular de um indivíduo.

O último elemento, mas não menos importante, das causas instrumentais é o reconhecimento de uma esfera sobrenatural que por si só pode representar o mecanismo pelo qual a doença se processa e, adicionalmente, ainda pode ser vinculado à qualquer uma das duas causas instrumentais anteriores. Assim, o discurso de indivíduos religiosos pode, em alguns casos, refletir tanto a noção biológica da doença quanto a noção espiritual. Não é em nenhum momento negado ou, às vezes, sequer mencionado, por exemplo, que o câncer seja resultado do aparecimento de tumores no organismo quando as células começam a crescer de uma forma descontrolada, em função de um processo de mutação das células provocado pela predisposição genética do indivíduo,

exposição à radiação ou ataque viral. Mas, o desenvolvimento do câncer no corpo de um indivíduo pode ser concomitantemente atribuído à influência de fatores sobrenaturais (Deus, demônios, espíritos, magia etc.). Isso realça o fato de que a relação entre "doença material" e "doença espiritual", segundo definições religiosas dos problemas do corpo, é bastante flexível e nada impede que as duas noções caminhem junto na busca de um sentido maior para a doença.

Em síntese, a definição de uma causa instrumental não impede que seja eleita outras que complementem a idéia que o indivíduo faz da própria doença. Em alguns momentos, tendo em mente que o contexto social, cultural e histórico exercem grande influência sobre as representações sociais da doença, uma dessas causas pode ser privilegiada em relação as demais, mas essa marginalização não é generalizada, ou seja, poderá ocorrer variações de ênfase em um mecanismo entre diversos casos de uma mesma comunidade ou grupo religioso.

III.3.1.2 Causas Eficientes

Os agentes apontados pelo discurso religioso são bastante diversos: sete diferente tipos de agentes foram citados nas obras consultadas. Esse sete agentes, por sua vez, podem ser divididos em dois grupos: os sobrenaturais e os naturais. No grupo sobrenatural encontramos Deus, santos, demônios, divindades e espíritos diversos como causadores das enfermidades. No segundo grupo, o natural, encontramos como agentes eficazes dos estados mórbidos as condições socioeconômicas (terceiros), os membros da sociedade relacionados com o indivíduo enfermo (terceiros) e o próprio indivíduo enfermo.

Conforme já exposto nos parágrafos acima, embora admita-se a natureza orgânica das doenças, o discurso religioso é capaz de incutir a responsabilidade pelo aparecimento e permanência da doença em um indivíduo aos seres sobrenaturais ou transcendentais. Dada a herança católica do povo brasileiro, não causa surpresa que Deus, santidades do catolicismo popular e outras divindades das religiões afro-brasileiras sejam apontados como agentes das doenças. Essa mesma herança católica legitima a interferência de forças demoníacas no estado de saúde dos seres humanos e as práticas exorcistas são comuns nos meios religiosos (notadamente dos protestantes) que se atêm à essa crença. Já por conta da influência das idéias de Allan Kardec, os espíritos são apontados também como agentes causadores de enfermidades, principalmente no

caso de doenças psicológicas. É interessante observar, porém, que a crença em espíritos e na sua influência sobre os encarnados não se limitou à religião espírita, pois observa-se que cristãos e praticantes das religiões afro-brasileira também reconhecem sua existência.

O maior grau de conscientização política e o maior contato com o saber médico talvez tenham contribuído para que alguns indivíduos das religiões aqui abordadas se dessem conta de que as condições socioeconômicas desempenham papel relevante nas condições de vida e, sobretudo, na saúde. Saneamento básico, alimentação, condições de moradia e trabalho precários são apontados, assim, como responsáveis por doenças diversas. A interferência sobrenatural é descartada nesses casos, mas ainda se roga à Deus e aos santos como meio de se obter ajuda e alterar a dura realidade da vida.

A magia, a feitiçaria, o "mau-olhado", a "coisa feita", o "encosto" e outras denominações povoam o imaginário religioso e, portanto, indivíduos de má índole são apontados como causadores de muitos infortúnios àqueles que despertam seu desafeto, sua inveja ou qualquer outro tipo de interesse. A crença na capacidade de outros seres humanos afetarem, à distância, a integridade física de um determinado indivíduo repousa não na crença em super-poderes, mas sim na crença na habilidade que certos indivíduos possuem de colocarem à seu serviço seres espirituais e "energias cósmicas" despertadas por emoções negativas (raiva, inveja, ciúme, vingança etc.) desses indivíduos. Cristãos, evangélicos e praticantes de religiões mediúnicas acreditam na eficácia dessas habilidades e elaboraram práticas terapêuticas de contra-ataque e defesa contra os agentes sociais supostamente possuidores desses dons. Assim, só para ilustrar, no catolicismo popular a benzedura muitas vezes tem por propósito anular ou dirimir os efeitos negativos do "mau-olhado", o *ébo* (despacho), no candomblé, é uma importante prática ritual para os indivíduos que se julgam vítimas de ações de terceiros mal intencionados e as sessões de descarrego tornaram-se práticas comuns nos cultos evangélicos.

O último agente destacado nos relatos e textos das religiões aqui analisadas é o próprio indivíduo. A noção de que o indivíduo é o responsável por sua enfermidade permeia todas as religiões aqui estudadas, assim como a noção de que terceiros podem causar mal à saúde desse mesmo indivíduo sem que haja contato físico ou qualquer ato de violência. Esta constatação contraria a suposição de que a responsabilidade dos estados mórbidos pode ser sempre transferida para alguma causa além da vontade da pessoa doente e, assim sendo, isentando essa mesma pessoa de quaisquer tipos de

sanções sociais. Adicionalmente, sob o ponto de vista sociológico, isso nos faz encarar a doença como um processo judicial inverso. Um livro clássico de histórias infantis – *Alice nos Países das Maravilhas* (1865) de Lewis Carroll – ilustra bem o que é um processo judicial inverso. Em uma passagem do livro, na qual Alice está sendo julgada pela sua própria inimiga (a rainha de Copas), o júri contesta os protestos de Alice proclamando: "a sentença primeiro, o julgamento depois!". Seguindo a mesma lógica do magistrado louco, quando o indivíduo é o culpado por seu estado enfermo, a doença corresponde a sentença e o julgamento, ou seja, a apreciação social de sua conduta, somente ocorre após o pronunciamento da sentença. Essa noção de culpa e responsabilidade pelo estado enfermo é devedora de uma tradição judaica cristã que durante séculos moralizou as doenças permitindo que as faltas de um indivíduo pudessem ser supostamente deduzidas a partir das mazelas do corpo. Os riscos desse tipo de concepção das causas das doenças já era apontado nos textos bíblicos do Novo Testamento: a estigmatização, a exclusão e a negação de solidariedade à pessoa enferma. Alheias à esses alertas, as representações sociais das doenças revelam que há mais permanências do que mudanças ao longo de nossa história. Quanto ainda deveremos percorrer para nos livrarmos de velhos conceitos e preconceitos é algo incerto e, talvez, um dos papéis mais importantes da Academia seja pelo menos expô-los e ansiar pelo melhor.

Há alguns autores, entretanto, que acreditam que quando se passa do discurso teológico à sua aplicação prática o indivíduo é sempre considerado vítima. Em outras palavras, as doenças advindas da irresponsabilidade do próprio indivíduo se fundem ao grupo daquelas provenientes das ações de terceiros, reais ou simbólicos, que não são passíveis de controle. O carma, por exemplo, remete a uma responsabilidade tão distante e fora do controle da vontade pessoal que acaba por colocar o indivíduo mais no papel de vítima do que de transgressor de certas regras morais. A ignorância, enquanto carência de conhecimentos que leva à transgressão de certos tabus religiosos e que supostamente traria as doenças como meio de alerta da falta cometida, muitas vezes desperta a piedade e compaixão daqueles que cercam o indivíduo acometido pela doença. Isso ocorre porque esse tipo de violação contrapõe-se à idéia de pecado que supõe uma falta a ser expiada por um sujeito livre e responsável que, se quisesse, de outra maneira poderia ter agido. Mas mesmo no caso dos pecados, em decorrência das fraquezas humanas, o indivíduo é menos culpado e mais vítima de forças cósmicas que escapam à sua consciência limitada. O ser humano é vítima da inexorável batalha entre

o "bem" e o "mal" e a doença é apenas um momento no qual o "mal" prevaleceu, momentaneamente, sobre o "bem". O corpo é o palco desse combate transcendente e, portanto, estará sujeitos aos "efeitos colaterais" dessa disputa.

Essas objeções ao discurso teológico nos faz crer que as religiões, na verdade, podem ser comparadas a uma "lâmina de dois gumes"; em outras palavras, concomitante ao ato de acusação e julgamento (o dedo indicador acusador) vem atrelado a condescendência e absolvição (a mão estendida em sinal de ajuda). Deixando de lado estas metáforas, mediante uma análise da história comparada das religiões não há porque esperar por uma postura religiosa distinta, haja vista a estreita relação entre saúde e salvação discutida em tópicos passados. Quanto dessas elucubrações é compreendido e assimilado pelos agentes sociais é discutível e carece de estudos empíricos que corroborem sua aplicabilidade, mas ignorar a existência dessas críticas poderia levar a conclusões errôneas, dispares da realidade.

III.3.1.3 Causas Conjecturais

A obtenção de respostas para as três primeiras indagações do diagnóstico de uma doença, em muitos casos, é seguida por uma última questão – por que? – que complementa e dá sentido ao quadro geral. Sociologicamente, julgo que essa questão seja a mais importante, pois é capaz de revelar valores e princípios culturais de uma dada sociedade. Adicionalmente, as resoluções apresentadas em decorrência desse questionamento ajudam a elucidar tanto o comportamento do indivíduo enfermo quanto a reação social (resignação, apatia, solidariedade, revolta etc.) daqueles diretamente ligados à esse indivíduo. Em nosso cotidiano, essas nuances não são tão nítidas, mas quando nos movemos para o espaço religioso é possível, em teoria, lançar luzes sobre essas particularidades.

Sete foram as causas conjecturais destacadas pelo discurso religioso, a saber: punição, provação (incluindo o carma), má conduta (comportamentos reprováveis socialmente), magia, mediunidade, fatores emocionais e socioeconômicos. Vale ressaltar que as causas conjecturais decorrem das duas primeiras causas analisadas, ou seja, há uma relação direta entre meio, agente e finalidade da doença.

Começamos discutindo a noção de doença-punição, a qual é muito valorizada pelas religiões cristãs. As escrituras sagradas dessas religiões, bem como o discurso de seus seguidores indicam um alto grau de absorção dessas idéias. Teologicamente, essa

representação encontra seus fundamentos na suposta relação de troca entre seres humanos e Deus, ou seja, Deus premia ou castiga os seres humanos de acordo com as ações desses últimos. Dentro desse sistema lógico, as boas ações e o respeito aos princípios doutrinários são recompensados por Deus com a saúde, a manutenção e prosperidade das posses e a vitória sobre os inimigos dentre outras dádivas. Já o comportamento pecaminoso e as más ações de forma mais geral são repreendidas imediatamente com males físicos de todas as sortes. Os textos bíblicos forneceram as idéias básicas desse tipo de representação social, embora saibamos que os textos bíblicos reproduzam muito das crenças de religiões mais antigas³⁰, bem como dos costumes e valores das primeiras comunidades judaicas. Quando se trata do catolicismo popular, observa-se que essa idéia foi reformulada, mas em essência compartilha da mesma noção: a capacidade de seres transcendentais interferirem na ordem material e afetarem diretamente o corpo e a saúde humana. Os santos, entidades divinas hierarquicamente inferiores a Deus, possuem a habilidade de recompensar ou castigar devotos e/ou descrentes tal como o Deus Javé dos relatos bíblicos.

A doença-provação, por sua vez, decorre exatamente da mesma visão exposta no parágrafo anterior, ou seja, da crença na capacidade que seres transcendentais teriam de influenciar diretamente o plano físico, material. O propósito dessa interferência, entretanto, é bastante distinto. A doença antes vista como uma punição pelas faltas passa a ser encarada como uma prova da fé do indivíduo acometido pelos males físicos. A doença configura-se como eleição e oportunidade para evolução e fortalecimento espiritual (o carma, para os espíritas, por exemplo). Os relatos bíblicos levam a crer que se trata do sofrimento dos justos (o caso de Jó, por exemplo) e os discursos contemporâneos ainda são devedores dessa concepção. Entender os processos mórbidos como carma ou como uma prova de caráter divino oferece aos indivíduos enfermos uma justificativa que leva indubitavelmente à resignação e acomodação em virtude da impossibilidade de reversão dos quadros clínicos de doenças congênitas ou crônicas.

A terceira causa conjectural destacada pelos discursos é a má conduta do indivíduo. Antes de tudo, é importante salientar que em decorrência do fato de o

³⁰ Essa afirmação é baseada na suposta relação entre a Bíblia e o poema épico da antiga Babilônia denominado *Enuma Elish*. Esse poema, escrito em sete tábuas de argila que foram descobertas no século XIX nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, atualmente localizada na cidade iraquiana Ninive, narra o mito da criação. Estima-se que essas tábuas de argila são do século XII a.C. e que podem refletir idéias ainda mais antigas provenientes da civilização sumeriana. A incontestável semelhança com a narração bíblica do Gênesis fez surgir inúmeras discussões sobre qual das histórias é uma adaptação à religião em causa.

indivíduo ser designado como agente dos processos mórbidos em todas as religiões tratadas, o seu comportamento é utilizado, da mesma forma e nas mesmas proporções, para explicar a origem do mal que o acomete.

A má conduta dentro do quadro religioso cristão pode ser entendida como pecado, ou seja, a violação de uma lei ou de princípios religiosos, éticos ou normas morais. O pecado para os cristãos pode ser cometido por meio de palavras, ações ou por negligência e omissão (deixar de fazer o bem). Em suma, o pecado é um ato e não um estado do ser. Vale ressaltar que para as religiões de cunho mediúnico (espiritismo e religiões afro-brasileiras) a má conduta distancia-se da noção de pecado cristão. Para essas religiões a má conduta pode ser resultado da ignorância dos preceitos religiosos, ou seja, é em muitos casos uma violação não-intencional e desapercibida de princípios religiosos. O pecado diferentemente é uma ação premeditada e intencional, ou seja, o indivíduo tem ciência de que seu ato é reprovável e, se o quisesse, poderia não cometê-lo. Embora a terminologia cristã não seja empregada tal como é concebida no seu meio de origem, as religiões mediúnicas não descartam que algumas má ações podem ser levadas à cabo intencionalmente pelo indivíduo com o intuito de lesar ou obter benefícios ilícitos.

Sociologicamente, a má conduta configura-se como um ato desviante, ou seja, uma ação individual que contraria os valores e princípios de uma determinada comunidade, em um dado período histórico, e que; portanto, está sujeita à sanções por partes dos demais agentes sociais. A união dos dois conceitos de má conduta, o religioso e social, permitiu a permanência de representações sociais da doença calcadas na idéia de que o comportamento individual deixa o corpo mais ou menos exposto às ações nefastas do plano espiritual, transcendente ou cósmico que podem ser desencadeadas por Deus(es), demônios ou espíritos. Assim, a doença aparece sempre como resultado da ação espiritual em um corpo "enfraquecido" pelo vício, pelo pecado ou pela violação de qualquer regra religiosa ou moral. Vale lembrar que atitudes de descrença ou escárnio dos símbolos religiosos também são taxadas como má conduta passíveis de sanções de caráter fisiológico.

A crença em magia e/ou feitiçaria aparece também como explicação da origem das doenças. Os evangélicos (neopentecostais) e os praticantes dos cultos afro-brasileiros acreditam que existam indivíduos capazes de fazer uso de energias, forças ou seres sobrenaturais para promover distúrbios de todas as sortes na vida de uma pessoa. A prática de magia negra para os evangélicos está, em geral, vinculada aos praticantes

dos cultos afro-brasileiros e, portanto, as acusações são dirigidas tanto aos seus praticantes quanto às divindades cultuadas por esses grupos religiosos. Comumente, segundo a interpretação religiosa, as mazelas do corpo são atribuídas à ação de um "encosto", o qual é supostamente um demônio ou espírito inferior invocado por alguém que pratica magia negra. Motivado por sentimentos negativos (raiva, rancor, inveja etc.) ou interesses pessoais diversos, o feiticeiro supostamente comanda esses seres que se acercam dos seus alvos e influem negativamente no seu comportamento, na sua mente e/ou no seu corpo. Embora o espiritismo rejeite a noção de goécia desses grupos religiosos (na questão 552 do Livro dos Espíritos as pessoas que crêem nesses pretensos poderes mágicos são taxadas de supersticiosas e ignorantes das leis da natureza), admite-se a influência dos espíritos por meio da transmissão de energias aos encarnados. Seguindo a mesma lógica espírita, no catolicismo popular é mais comum se ouvir a respeito do "mau-olhado" ou "olho gordo" ou "quebranto", o qual é supostamente uma energia negativa transmitida de uma pessoa para outra. Acredita-se que alguns indivíduos, motivados pela cobiça ou inveja ou "apego excessivo", sejam capazes de ocasionar a degradação de situações de prosperidade de outros por meio do "mau-olhado". Sensações de mal estar, doenças cuja duração prolonga-se para além das expectativas, revés financeiro dentre outros acontecimentos são geralmente atribuídos a este fenômeno, por exemplo.

A mediunidade também aparece como explicação última das doenças. A mediunidade ou faculdade psíquica que permite a interação com o plano de existência espiritual, para os espíritas e praticantes dos cultos afro-brasileiros, pode explicar a origem das doenças de duas formas distintas. A primeira, está relacionada ao desenvolvimento desta capacidade. Sendo considerada um dom inato, cabe ao indivíduo desenvolvê-la para evitar os malefícios decorrentes de uma exposição e contato prolongado com forças e energias cósmicas, espirituais. A segunda, está relacionada ao mau uso dessa capacidade. Faz parte do sistema de crenças dessas religiões que aqueles que fazem uso indevido dessa capacidade podem sofrer efeitos colaterais negativos. O uso indevido da capacidade mediúnica é entendido como o contato com espíritos ou entidades de ordem inferior com o propósito de obter benefícios ilícitos para si próprio ou para alguém mediante o prejuízo de outrem. A doença, em ambos os casos, é apenas um sintoma de uma influência espiritual negativa derivada da ignorância ou da violação moral de preceitos doutrinários.

Uma vez que há, sob o ponto de vista das religiões mediúnicas, uma estreita relação entre corpo, mente e espírito, as emoções ou aspectos da personalidade de um indivíduo são utilizados para explicar a causa dos males físicos e infortúnios da vida. As representações dessas religiões reconhecem o caráter endógeno ou psicossomático de algumas doenças. A neurose, a depressão e outros tipos de expressão dos sentimentos humanos (raiva, ansiedade, mágoas dentre outros) considerados negativos são utilizados para explicar processos mórbidos de natureza fisiológica ou psicológica. Os praticantes das religiões mediúnicas crêem que esses problemas psicológicos e emocionais, em última instância, deixam o corpo suscetível à uma maior influência negativa espiritual que, por ventura, materializar-se-ia em algum tipo de enfermidade.

O discurso de protestantes e praticantes das religiões afro-brasileiras a respeito das doenças revela algumas idéias provenientes da medicina social, ou seja, são algumas vezes marcados pela noção da influência de fatores socioeconômicos nos processos de debilidade física. As doenças são explicadas pelas condições materiais de existência, tais como: o tipo de trabalho, a moradia, o saneamento básico, a alimentação, o acesso a serviços públicos básicos dentre outras questões sociais. As condições precárias de moradia, a baixa renda familiar, a falta de alimentação e as condições insalubres de trabalho são apontadas como principais causas de diversas enfermidades. É importante mencionar que embora essas religiões sejam capazes de destacar a influência das condições sociais na saúde de seus membros, pouco ou nada é feito para mudar as condições socioeconômicas responsáveis pelas mazelas que acometem os indivíduos de baixa renda. É inegável que algumas instituições religiosas oferecem apóio aos mais necessitados sob diferentes formas (distribuição de cestas-básicas, realização de bazares, doações diversas etc.); porém, as ações políticas são, geralmente, descartadas e muitas vezes o que se oferece é uma resposta religiosa/espiritual para solucionar problemas concretos da existência humana: as diferenças de distribuição de renda e classe.

III.3.2 A essência das interpretações religiosas das doenças

Uma vez concluída essa síntese e feitas as devidas considerações, cabe ainda responder como as interpretações religiosas sobre as doenças interferem na elaboração das representações e como estas representações interferem na vida social. Embora a reunião e exposição sistemática das informações referente as diferentes interpretações

religiosas das doenças tenha seus méritos, creio que essa contribuição ainda não é suficiente para elucidar as questões que me propus a responder. Portanto, tentarei nas linhas que se seguem deixar evidente as características essenciais das interpretações religiosas das doenças aqui apresentadas.

A idéia de buscar a essência das representações religiosas das doenças remeteu-me, inevitavelmente, à uma área de estudo das religiões muito controversa. Trata-se da Fenomenologia da Religião. Quando o termo "fenomenologia da religião" foi empregado pela primeira vez, no final do século XIX, não se referia a um novo método, mas apenas retomava o método comparativo vigente na época, o da Religião Comparada, cuja finalidade era evidenciar analogias de crenças e de ritos entre as mais variadas religiões. Com o desenvolvimento dessa área de estudos, aos poucos, o termo passou a designar toda pesquisa histórica dos fatos religiosos que empregasse o método comparativo na classificação dos mesmos, mas que fosse mais a fundo, na tentativa de estudar o significado desses fenômenos como expressão do pensamento e do sentimento dos indivíduos religiosos. A fenomenologia passou assim a ser o estudo descritivo de um fenômeno ou de um conjunto de fenômenos. Esse sistema de estudo acabou sendo elaborado e divulgado, tal como o entendemos hoje, pelo filósofo alemão Edmund Husserl (1859-1938) e é caracterizado principalmente pela abordagem dos problemas filosóficos segundo um método que busca a volta "às coisas mesmas", numa tentativa de reencontrar a verdade dos dados originários de experiência. Os conceitos fundamentais dessa fenomenologia filosófica de Husserl são:

- a) Epoché (suspensão de juízo; neutralidade) quando o estudioso deve se aproximar do fenômeno com consciência pura, sem influências históricas, científicas, filosóficas, literárias, religiosas, de modo a captar a essência do fenômeno estudado.
- b) Visão eidética – relativo à essência das coisas e não à sua existência ou função. O olhar do fenomenólogo se dirige para a própria coisa.

Repousa no primeiro princípio dessa metodologia as maiores críticas, pois a neutralidade intencionada é utópica. A crítica feminista, sobretudo, nos alerta da impossibilidade de que o processo de formação de conhecimento seja algo neutro, independente da pessoa que o produz ou sem implicações sociais e políticas. Não obstante, creio ainda ser possível aplicar parte do que é proposto por essa metodologia na compreensão das representações sobre saúde/doença das religiões. Trata-se do

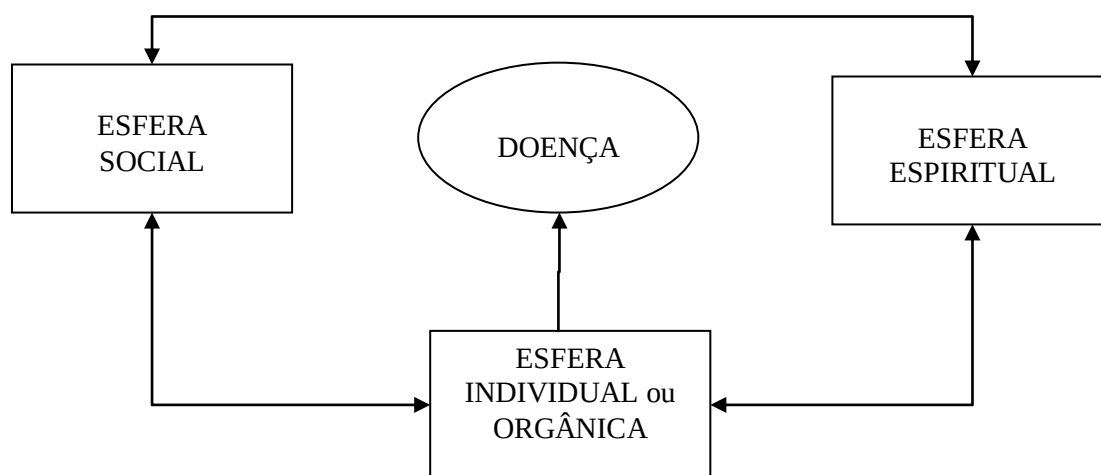
segundo princípio que busca mostrar que a fenomenologia aplicada à religião não estuda os fatos religiosos em si mesmos (tarefa da história das religiões), mas sua intencionalidade (seu eidos) ou essência. O objetivo da fenomenologia da religião não é o de “classificar” os vários fenômenos religiosos, mas apreender o seu significado próprio. A fenomenologia parte necessariamente dos fenômenos religiosos (fatos, testemunhos, documentos), contudo, explora cientificamente seu sentido. A fenomenologia da religião repete assim o estudo comparado das religiões, porém num nível mais profundo, uma vez que tem a convicção de que é possível chegar à essência da religião e captar a própria verdade da religião e da experiência religiosa.

O fenômeno religioso tem o seu sentido específico, que é de uma reação espontânea, não racionalizada, perante aquilo que as pessoas religiosas consideram sagrado ou transcendente ou dotado de características espirituais, mas em si mesmo esse ato não revela traços de uma doutrina, e, por isso, pode fazer parte tanto de um sistema religioso como de outro. O fenômeno religioso poderia ser comparado assim a um tijolo, que é um elemento básico de uma construção, mas que em si mesmo não define a construção de que pode fazer parte. A fenomenologia estuda o significado deste tijolo, ou seja, a sua capacidade para a construção de uma parede. Analogicamente, a interpretação das doenças pelas religiões é apenas um dos tijolos de uma estrutura maior que em certa medida incentiva comportamentos de auto-flagelo e sacrifício de bens materiais. Essa constatação é de vital importância para que não seja erroneamente estabelecida uma relação direta entre a compreensão das doenças e estes comportamentos. Muitos outros fatores fomentam tais comportamentos e, infelizmente, o estudo de todos não cabe aqui e, mesmo que coubessem, creio que tampouco seria possível determinar em que medida esses fatores influenciam os comportamentos mencionados.

A experiência humana é fruto de uma vivência relacional (com a natureza, com outro indivíduo e com a sociedade) e de desejos pessoais. Segundo José S. Croatto (2001) o desejo de todo ser humano desperta duas consciências: a primeira refere-se as necessidades específicas para a vida (físicas, psíquicas e socioculturais) e a segunda refere-se as limitações (fragmentação, finitude e falta de sentido de muitas experiências vitais). É no contexto da experiência humana que se insere a experiência religiosa, visto que o ser humano tende à totalidade através do atendimento de suas necessidades e superação de suas limitações. Aparentemente, tanto as necessidades quanto os desejos dos indivíduos religiosos podem ser saciados na instância religiosa através de um apelo

a forças transcendentas ou espirituais. As doenças são reconhecidamente parte da existência humana; não obstante, para muitos indivíduos ela continua sendo uma experiência vital que carece de sentido. As religiões, segundo as diferentes interpretações aqui relatadas, buscam dar sentido a esse evento da vida calcadas em essência no reconhecimento de três diferentes esferas, a saber: a individual ou orgânica, a social e a espiritual. A esfera individual ou orgânica representa o corpo e a mente (aspectos psicológicos) de um indivíduo, bem como a conduta ou o comportamento desse indivíduo. A esfera social engloba as pessoas ou a comunidade e o sistema cultural com a qual o indivíduo mantém contato, ou seja, é em síntese a representação das inter-relações sociais. A esfera espiritual, por sua vez, envolve todas as crenças religiosas de um indivíduo, abrangendo os seres sobrenaturais: santos, demônios, espíritos, deuses, por exemplo e os valores morais pregados pela doutrina religiosa. Antes de fazer maiores elucubrações, esquematizarei meu pensamento:

Figura 1 - Esquema de interpretação religiosa das doenças



Note que as conexões possuem setas duplas para indicar que a influência entre as diferentes esferas é recíproca. Note também que todas as esferas estão interligadas. A doença aparece, então, como o resultado da interação desarmônica entre essas três esferas, embora esteja ligada diretamente apenas à esfera orgânica. Esse esquema permite vislumbrar que as doenças, ainda que sempre referidas ao plano espiritual, não estão diretamente vinculadas à interferência de fatores sobrenaturais, ou seja, as mesmas podem ser consequência de conflitos e dificuldades bem prosaicos. Para melhor compreender o esquema e a afirmação anterior, analisaremos alguns exemplos a

respeito da noção de doença, segundo as interpretações religiosas, abordados ao longo deste trabalho:

a) Encosto/Feitiçaria: as doenças causadas por encostos ou feitiçaria ainda que induzidas pela ação de terceiros (esfera social) são mediadas pela esfera espiritual. Sob essa ótica interpretativa, os reflexos das ações de terceiros na esfera orgânica são obra de um espírito (encosto) que por ignorância ou vingança apossa-se de um encarnado ou da manipulação de forças e entidades espirituais através de determinados ritos por pessoas que querem afetar negativamente à outrem. Em ambos os casos, o efeito pretendido é aparecimento de doenças físicas e/ou mentais e alterações comportamentais, principalmente em direção àquelas tidas como moralmente reprováveis pela sociedade e, que potencialmente levariam a estados de enfermidade. Vale ressaltar ainda que o encosto pode ser motivado tanto pela fraqueza moral ou comportamentos desviantes do indivíduo quanto pela ação de terceiros alheios à vontade do indivíduo afetado. Seja qual for o caso, as interpretações religiosas envolvem as três esferas na explicação do problema.

b) Condições socioeconômicas desfavoráveis: seja qual for a situação, (desemprego, carência alimentar, trabalho intenso e desgastante etc.) o discurso religioso é capaz de fazer tais assuntos sociais relacionarem-se com a esfera espiritual. Uma situação de desemprego, por exemplo, pode induzir um indivíduo a adotar comportamentos e pensamentos reprováveis que, em última instância, o debilitam espiritualmente. Essa fraqueza momentânea, decorrentes de situações prosaicas, deixariam o indivíduo sujeito à toda sorte de influência de forças espirituais capazes de gerar doenças no corpo e na mente. Mais uma vez, as três esferas da figura 1 são envolvidas na explicação da origem dos problemas de saúde.

c) Carma/Provação divina: nos dois casos, reconhece-se a interferência direta do plano transcendente na vida humana e, principalmente, na saúde humana. Seguindo o esquema proposto, reconhece-se a influência direta da esfera espiritual na esfera individual como "punição"/"provação" pelos atos cometidos e que resultaram em perdas ou prejuízo para a esfera social. A única diferença entre as duas formas de interpretação das doenças é que enquanto o carma diz respeito a um único indivíduo, a provação divina pode se abater sob uma comunidade e não apenas sobre uma pessoa. Assim, as

epidemias e/ou os desastres ecológicos que resultam em doenças (ou até mesmo em morte) para uma determinada comunidade podem, sob essa ótica, ser interpretadas como a ação direta de uma entidade divina, geralmente, Deus, no destino dos seres humanos. Os motivos e justificção para essa intervenção divina repousam na conduta individual ou coletiva contrária aos regulamentos da religião. Em suma, mesmo quando se considera que o agente causador da doença possui a capacidade de intervir na realidade ou existência humana, não se descarta a idéia de que sua ação seja motivada exclusivamente pela conduta de um indivíduo ou de uma comunidade, ou seja, as ações divinas não são infundadas. Assim, mais uma vez, o discurso religioso é capaz de depreender que a esfera espiritual trespassa fatos concretos da existência humana.

d) O comportamento desviante: repete-se aqui a idéia de que as ações individuais desviantes e sujeitas às sanções sociais, debilitam espiritualmente o indivíduo ou despertam a ira divina. Por um motivo ou pelo outro, o resultado esperado é um desequilíbrio orgânico ou psicológico provocado por algum agente do plano transcendente ou, ainda, pela manipulação de seres espirituais por partes de terceiros que queiram vingança pelos atos que de alguma forma os afetaram. repete se aqui as mesmas idéias apresentadas no item c) acima.

Levando-se em conta as idéias propostas por esse esquema e os exemplos acima, pode-se concluir que a atividade terapêutica religiosa visa a manutenção ou restauração do equilíbrio entre as esferas: social, orgânica e espiritual. Os indivíduos que compartilham de crenças religiosas vêm se obrigados, então, no processo de busca de restauração da saúde, a pleitear um acordo, direta ou indiretamente, com essas três esferas. Uma vez empreendida a análise das causas (como? quem? e por que?) da doença, compete ao indivíduo, com ou sem auxílio, buscar meios para corrigir o desequilíbrio que lhe causa a doença. As religiões, de uma forma geral, oferecem apóio nesses momentos, por serem capaz de intermediar as relações com a esfera espiritual, a qual não é necessariamente a fonte do distúrbio. A esfera espiritual é apenas um dos elos da corrente e, é utilizada para dar sentido à experiência mórbida, mesmo quando essa deriva de fatores triviais. O apóio religioso requer, muitas vezes, provas da intencionalidade de reversão da desordem, bem como demonstrações rituais públicas que evidenciem a identidade e pertença a um determinado grupo religioso. Mesmo quando tais comportamentos não são requeridos, julgo que os indivíduos são

compelidos à eles, não apenas pelo evidente júbilo, mas também a fim de demonstrar publicamente sua nova condição, dada a relevância social da saúde.

Creio que essas considerações auxiliem na compreensão dos meios de construção das interpretações religiosas a respeito das doenças. Pode-se concluir, em linhas gerais, que o discurso religioso tem a capacidade de remeter as doenças, derivadas tanto da esfera individual quanto da social, à esfera espiritual a fim de lhes conferir sentido. O grau de influência ou a ênfase nos aspectos particulares de uma dessas três esferas na explicação das doenças dependerá das diferentes experiências individuais e da cosmovisão compartilhada por determinado grupo religioso. É também possível inferir que as religiões não são alheias aos conhecimentos provenientes de outras áreas e, sobretudo, que elas tem a capacidade de incorporá-los e reinterpretá-los segundo sua própria lógica. A diversidade de interpretações das doenças aqui abordadas comprovam tal asserção. Com o decorrer dos anos essas religiões elaboraram, mediante a utilização das três esferas propostas em meu esquema, formas criativas para explicar as causas das doenças, mas a essência dessas interpretações continua sendo a mesma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discordância com relação ao conceito de saúde é praticamente universal e essa divergência parece existir desde a época de Hipócrates (460-377 a.C.), o qual é tido como o "pai da medicina". Muitas foram as tentativas de conceituação do termo até que, finalmente, em 1946 a OMS reconheceu oficialmente que a saúde seria um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Assim a saúde passou a significar um estado positivo para qual contribuem as condições biológicas, psíquicas e sociais vividas pelas pessoas. Embora isso possa ser considerado um avanço, não houve demora para esse conceito provocar nos meios acadêmicos as mais fervorosas discussões. Os críticos alegam que a definição da OMS coloca a saúde em um plano ideal, inatingível e utópico. Intrigantemente, a definição da OMS somente trouxe à tona uma concepção de saúde antiga e que, apesar de todas as pressões contrárias, sobreviveu até os dias contemporâneos no ambiente religioso. Portanto, a crítica à definição de saúde da OMS é na verdade uma crítica à definição religiosa da saúde que mescla-se e confunde-se com a idéia de salvação, tal como a entendemos atualmente.

A doença, enquanto oposto do ideal social que é a saúde, insere-se em um quadro social dinâmico, determinado pela interação de múltiplos fatores e marcado pela relação entre a esfera da individualidade e do contexto sociocultural. Quando iniciei a pesquisa nessa área de estudo de conceitos sociais, minhas preocupações recaíam sobre uma definição de doença que fosse universal. Estudos e leituras posteriores revelaram que é muito difícil lograr êxito em tal empreendimento, a universalização de conceitos, pois todo conceito é parcial, limitado e circunscrito. Ao contrário do que se prega, creio que o conhecimento não é universal, pois as perguntas que nos fazemos são devedoras de diversos fatores, tais como: o gênero, a classe, a raça e o contexto histórico-cultural. Não obstante tal constatação não esmoreceu meu ânimo, pois a exploração da diversidade das representações sociais da saúde/doença no âmbito religioso trouxe-me à essas linhas que mostram que as relações entre os diferentes saberes: médico (acadêmico), popular e religioso; é de vital importância para a compreensão dos comportamentos dos agentes sociais diante das doenças. A história da medicina mostra que as relações entre esses saberes não ocorrem em uma via de "mão única", ou seja, em um só sentido, de acordo com supostas hierarquias e dependências. Tendo por base uma abordagem histórica das mentalidades ou das culturas o presente trabalho revelou que as relações dos seres humanos com as doenças apresentam mais permanências culturais do

que mudanças. No Brasil, essas permanências são devedoras de uma visão cristã do mundo, cujo conteúdo doutrinário permeia os discursos e os textos de religiões bastante distintas entre si.

A visão holística das doenças é a característica básica de todas as interpretações religiosas sobre este tema, ou seja, diferentemente do discurso médico, a doença vai muito além do corpo e de sua constituição fisiológica. A doença, que é capaz de modificar a vida individual e coletiva, desperta a necessidade de uma interpretação complexa e contínua da sociedade. É por isso que o discurso religioso está calcado em uma causalidade tripla dos estados mórbidos, ou seja, envolve o *como?*, o *quem?* e o *por que?*. As respostas à essas indagações, diferentemente do que usualmente se pensa, não revelam apenas a crença em um sistema sobrenatural e transcendente que demanda equilíbrio para a manutenção da saúde; revelam também os princípios e valores culturais de uma sociedade. As representações de cunho religioso revelam que a saúde e a doença, ao longo da história, sempre foram pautadas pela inter-relação entre os seres humanos e tudo aquilo que o cerca (natural e sobrenatural) ou lhe diz respeito. Elementos da natureza, seres sobrenaturais e míticos, sentimentos de culpa e medo, superstições dentre outros estão indissociavelmente vinculados às expressões da doença e isso não deveria ser visto como demérito. São, ao contrário, preciosos indícios de elementos culturais que nos ajudam a compreender e elucidar as estruturas sobre as quais repousam as condutas sociais. As interpretações que são feitas a respeito das doenças são relevantes porque envolvem um sistema de opções que determinam como os integrantes de uma dada sociedade reagem ao se depararem com um indivíduo "doente". Esses critérios interpretativos definirão as práticas de exclusões, os controles sanitários, as formas de assistência, as reações ao medo da morte, as intervenções clínicas e os rituais religiosos, por exemplo.

A doença e a percepção que se faz dela tem capacidades transformadoras. A relação da medicina com as religiões, apontada por Foucault (1977) e Laplantine (1991), comprova isso. A medicina enquanto atividade normativa está autorizada a aconselhar e demandar posturas para uma vida equilibrada e saudável regendo não só as relações fisiológicas, mas as relações morais dos indivíduos e da sociedade. Tal feito é comparável àquele das grandes religiões com a diferença de que a medicina científica (ou oficial) talvez não tenha conseguido lidar com as contradições entre o que se apresenta como necessário para o indivíduo ter "boa saúde" (ou, simplesmente, saúde) e

sua forma predominante de atuação (a clínica) e compreensão (fisiológica) dos processos marcados pela debilidade física.

Ficou claro, durante a realização desta pesquisa, que nem todo desenvolvimento tecnológico e, tampouco os modelos ideais de saúde, são capazes de assegurar o bem-estar e a satisfação humana. Adoecer é um processo passível de diversas formas de interpretação e, infelizmente, a medicina oficial e o saber médico não dão conta de resolver todos os problemas de saúde que as pessoas trazem. E é em decorrência desse fracasso que as funções terapêuticas religiosas se mantêm, embora em alguns casos não seja tão evidente quanto em suas origens. As religiões moldam-se às necessidades sociais e, de certa forma, ainda preenchem vazios existenciais, dando sentido àquilo que carece de sentido. É nesse vale de lágrimas, onde as informações são muitas e dispersas, que a esfera biológica e social são agregadas à uma esfera espiritual que legitima as mazelas e os malogros de um fenômeno complexo e dinâmico que sintetizamos em uma palavra diminuta: vida. A complexidade da vida e a natureza não-empírica desta dissertação impedem maiores elucubrações, mas pelo menos espero ter contribuído para fomentar outras indagações nas mais diversas áreas das ciências sociais. Creio que mais importante do que as respostas que aqui foram obtidas, são as possíveis questões que esse conhecimento ajudará a gerar, inspirando novas pesquisas.

BIBLIOGRAFIA

ADAM, Philippe & HERZLICH, Claudine. **Sociologia da doença e da medicina**. EDUSC: São Paulo, 2001.

ALEIXO, Sérgio. **O que é Espiritismo**. Editora Nova Era: Rio de Janeiro, 2003.

ALVAREZ, Francisco. Saúde: uma abordagem teológica. In: **Revista O Mundo da Saúde**. Saúde, Religiões e Espiritualidade. Ano 24 v. 24 n. 6 – Novembro/Dezembro, p. 443-451. Editora do Centro Universitário São Camilo: São Paulo, 2000.

AMARAL, Rita. **Xirê! O modo de crer e de viver no candomblé**. Editora Pallas: Rio de Janeiro, 2002.

ANDERSON, Matthew R.; SMITH, Lanny; SIDEL, Victor W. What is social medicine? Monthly Review Magazine. Vol. 56. No. 8, Janeiro/2005. Acessado em 24/04/2007: <http://www.monthlyreview.org/0105anderson.htm>.

ANDRADE, Solange Ramos de. O catolicismo popular no Brasil: notas sobre um campo de estudos. In: **Revista Espaço Acadêmico**, n. 67, Dez/06, Ano VI, ISSN 1519.6186.

AZZI, Riolando. **A cristandade colonial: um projeto autoritário**. Paulinas: São Paulo, 1987.

_____. Evangelização e presença junto ao povo – aspectos da história do Brasil. In: **Religião e Catolicismo do Povo**. Editora Ave Maria: São Paulo, 1977, p. 39-72.

_____. **O catolicismo popular no Brasil: Aspectos históricos**. Vozes: Rio de Janeiro, 1978.

BASTIDE, Roger. **As religiões africanas no Brasil : contribuição a uma sociologia das interpretações de civilizações**. Pioneiras: São Paulo, 1971.

_____. **O candomblé da Bahia: rito nagô**. Editora Nacional: São Paulo, 1978.

_____. **As Américas negras: as civilizações africanas no novo mundo**. DIFEL: São Paulo, 1974.

BARZ, Patrícia & BORBAGATTO, Geraldo Magela. **Apometria para iniciantes**. 1ª Edição. Editora do Conhecimento: São Paulo, 2002.

BERGER, Peter L. **O dossel sagrado: Elementos para uma teoria sociológica da religião**. Paulinas: São Paulo, 1985.

BERKENBROCK, Volney J. **A experiência dos Orixás: um estudo sobre a experiência religiosa no Candomblé**. Vozes: Rio de Janeiro, 1998.

BOBSIN, Oneide. Etimologia das doenças e pluralismo religioso. **Estudos Teológicos**. v.43, n.2, 2003. p. 21-43.

BORGES, Luciano. Considerações sobre o tema da religião no pensamento de Hume, Durkheim e Weber. Revista Enfoques – revista eletrônica do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. v.4, n.1, Julho/2005. Acessado em 13/08/08:

http://www.enfoques.ifcs.ufrj.br/julho05/pdfs/julho2005_04.pdf

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Religião, campo religioso e relação entre religião erudita e religião do povo. In: **Religião e Catolicismo do Povo**. Editora Ave Maria: São Paulo, 1977, p. 07-38.

BRANDÃO, Margarida L. R. Saúde e fé cristã: um ensaio ético-teológico. In: **Revista O Mundo da Saúde**. Saúde, Religiões e Espiritualidade. Ano 24 v. 24 n. 6 – Novembro/Dezembro, p. 515-523. Editora do Centro Universitário São Camilo: São Paulo, 2000.

BRESCIANI, Carlo. Saúde: uma abordagem histórico-cultural. In: **Revista O Mundo da Saúde**. Saúde, Religiões e Espiritualidade. Ano 24 v. 24 n. 6 – Novembro/Dezembro, p. 437-442. Editora do Centro Universitário São Camilo: São Paulo, 2000.

BRITO, Ênio J. da Costa. Agonia de um modelo. In: SOUZA, Beatriz Muniz de & MARTINO, Luís M. Sá (orgs.). **Sociologia da Religião e mudança social: católicos, protestantes e novos movimentos religiosos no Brasil**. Editora Paulus: São Paulo, 2004.

CAMARGO, Candido P. F. **Kardecismo e Umbanda: Uma interpretação Sociológica**. Livraria Pioneira: São Paulo 1961.

CAMARGO, Cândido P. Ferreira (Org.). **Católicos, Protestantes, Espíritas**. Vozes: Rio de Janeiro, 1973.

CÂMARA NETO, Isnar de Albuquerque. Diálogos sobre religiosidade popular. In: Revista de Antropologia – Os Urbanistas. Acessado em 23/04/08. Disponível em: <http://www.aguaforte.com/antropologia/ISNARD.html>

CAMPOS, Leonildo Silveira. Protestantismo brasileiro e mudança social. In: SOUZA, Beatriz Muniz de & MARTINO, Luís M. Sá (orgs.). **Sociologia da Religião e mudança social: católicos, protestantes e novos movimentos religiosos no Brasil**. Editora Paulus: São Paulo, 2004.

CAMPOS, Roberta Bivar C. Sobre a "docilidade" do catolicismo: interpretações do sincretismo e anti-sincretismo na/da cultura brasileira. In: **Revista Brasileira de Informações Bibliográficas em Ciências Sociais (ANPOCS BIB)**. no. 65, 1o. semestre de 2008, ISSN 1516-8085, Editora: HUCITEC, p. 89-103.

CANGUILHEM, Georges. **O normal e o patológico**. 5ª edição. Forense Universitária: Rio de Janeiro, 2000.

CANHADAS, Cleide Martins. **Cura espiritual, uma visão integradora corpo/mente/espírito**. Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião. PUC: São Paulo, 1999.

CARNEIRO, Leandro e SOARES, Luiz Eduardo. Religiosidade, estrutura social e comportamento político. In: BINGEMER, Maria Clara L. (org.). **O impacto da modernidade sobre a religião**. Loyola: São Paulo, 1992.

CARRANZA, Brenda. Radiografia dos dados religiosos. Acessado em 27/02/08. <http://www.prime.org.Br/mundoemissao/religpentecostalismomodados.htm>

CASTRO, Maria Laura Viveiros de. **O que é Espiritismo**. Brasiliense: São Paulo, 1985.

CERVO, Amado L. & BERVIAN, Pedro A. **Metodologia Científica**. 5ª. edição. Editora Prentice Hall: São Paulo, 2002.

Coleção Biblioteca Época. **Personagens que marcaram época – Chico Xavier**. Editora Globo: São Paulo, 2006.

CONCONE, Maria Helena Vilas Boas. **Umbanda: uma religião brasileira**. CER/USP: São Paulo, 1987.

CROATTO, José Severino. **As linguagens da experiência religiosa**. Paulinas: São Paulo, 2001. p. 39-78.

DAMATTA, Roberto. **O que faz o brasil, Brasil?** Editora Rocco: Rio de Janeiro, 1991.

DENCKER, Ada de Freitas Maneti & VIÁ, Sarah Chucid. **Pesquisa Empírica em Ciências Humanas (com ênfase em comunicação)**. Futura: São Paulo, 2001.

DIAS, Luciana de Mattos. **Candomblé: O sagrado e a saúde – um estudo das representações sociais de saúde e doença de sacerdotes do candomblé**. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Psicologia. PUC: São Paulo, 1995.

DIBO, Dulcídio. **Espiritismo e Religiões Reencarnacionistas: Um compêndio sobre vidas passadas**. Editora Madras: São Paulo, 2001.

Dicionário de Neurociências. Definição do termo holístico. Acessado em 23/04/2007: <http://www.psiqweb.med.br/gloss/dich.htm>.

DINIZ, Rita de Cássia Ferreira. **Lembranças de Cura no Catolicismo Popular e na Umbanda**. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais. PUC: São Paulo, 1999.

DURKHEIM, EMILE. **As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália**. Trad. Port. Paulo Neves. Martins Fontes: São Paulo, 2003.

ELIADE, Mircea. **O sagrado e o profano. A essência das religiões**. 1ª ed., Martins Fontes: São Paulo, 1999.

EPEGA, Iyá Sandra M. Doenças do corpo e da alma. In: **Revista O Mundo da Saúde**. Saúde, Religiões e Espiritualidade. Ano 24 v. 24 n. 6 – Novembro/Dezembro, p. 488-494. Editora do Centro Universitário São Camilo: São Paulo, 2000.

EVANS-PRITCHARD, E. E. **Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande**. Tradução Port. Eduardo Batalha Viveiros de Castro. Editora Zahar: Rio de Janeiro, 1978.

FERRETI, Sérgio. Religião e Cultura popular: Estudo de festas e sincretismo religioso. In: Revista de Antropologia – Os Urbanistas. Palestra proferida a 07/06/2001, em Recife, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Acessado em 24/04/08. Disponível em:

<http://www.aguaforte.com/antropologia/osurbanitas/revista/Ferretti.html>

FILORAMO, Giovanni & PRANDI, Carlo. **As ciências das religiões**. Paulus: São Paulo, 1999.

FONSECA, Laura; MAGALHÃES, Maria José & ARAÚJO, Helena Costa. Interrogando as metodologias qualitativas na sua contribuição para o campo educativo e de estudos sobre as mulheres. In: **Coeducar para uma Sociedade Inclusiva, Actas do Seminário Internacional do Projecto Coeducação**. Lisboa: CIDM, 2001, p. 133-14. Acessado em 08/11/2008: <http://www.fpce.up.pt/ciie/publs/artigos/SG2.doc>

FOUCAULT, Michel. **O nascimento da clínica**. Trad. port. Roberto Machado. Forense-Universitária: Rio de Janeiro, 1977.

FRANKE, Edith. Feminist Orientation as an Integral Part of Religious Studies. In: **Revista de Estudos da Religião (REVER)**, no. 2, Abril, 2001, p. 46-60. Acessado em 06/09/08: http://www.pucsp.br/rever/rv2_2001/p_edith.pdf

GALLIANO, A. Guilherme. **O método Científico: Teoria e Prática**. Editora Habra: São Paulo, 1986.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Editora Atlas: São Paulo, 1988.

GODOY, A.S. Introdução à Pesquisa Qualitativa e suas Possibilidades. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 35, n.2, p. 57-63, 1995.

GRESCHAT, Hans-Jürgen. **O que é Ciências da Religião?** Paulinas: São Paulo, 2005.

GROETELAARS, Martien Maria. **Milagre e religiosidade popular: reflexões sobre pastoral missionária**. Vozes: Rio de Janeiro, 1981.

HESS, David J. **Spirits and Scientists: Ideology, Spiritism and Brazilian culture**. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1991.

JOÃO PAULO II, Papa. **Carta Apostólica Salvifici Doloris sobre o sentido cristão do sofrimento humano**. 2ª. ed. Vozes: Rio de Janeiro, 1984.

KARDEC, Allan. **O livro dos espíritos**. Trad. J. Herculano Pires. 65ª Edição. LAKE: São Paulo, 2006.

_____. **O Evangelho segundo o Espiritismo**. Trad. Guillon Ribeiro. 76ª Edição. FEB: Rio de Janeiro, 1944.

_____. **O livro dos médiuns**. Versão eletrônica acessada em 10/03/2008:
<http://www.espirito.org.br/portal/codificacao/lm/>

KLINTOWITZ, Jaime. Um povo que acredita. In: Revista Veja, edição 1.731, 19 de Dezembro de 2001.

Acessado em 27/03/08: http://veja.abril.com.br/191201/p_124.html

LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. Editora Atlas: São Paulo, 1985.

LANDIM, Leilah (org.). **Sinais dos Tempos: Diversidade religiosa no Brasil**. Instituto de Estudos da Religião (ISER): Rio de Janeiro, 1990.

LAPLANTINE, François. **Antropologia da Doença**. 1ª ed., Martins Fontes: São Paulo, 1991.

LEVI-STRAUSS, Claude. **Antropologia estrutural**. Editora Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 1975. p. 215-236.

MAGNANI, José G. C. Curas e milagres. In: QUEIROZ, José J. (Org.). **A religiosidade do povo**. Paulinas: São Paulo, 1984, p. 123-149.

_____. Doença Mental e Cura na Umbanda. Revista Teoria e Pesquisa. Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, n. 40/41, Jan/Jul 2002. Acessado em 05/12/08:
<http://www.n-a-u.org/magnanidioencaecuranaumbanda.html>

MARX, Karl. **Crítica da filosofia do direito de Hegel**. Trad. Port. Rubens Enderle e Leonardo de Deus. Boitempo: São Paulo, 2006.

MAZZOTTI, Alda Judite Alves. Representações sociais: aspectos teóricos e aplicações à Educação. Revista em Aberto. Ano 14, no. 61, Brasília: Jan/Mar. 1994. Acessado em 17/06/08:

<http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/912/818>

MENDONÇA, Antonio Gouvêa. Protestantismo brasileiro, uma breve interpretação histórica. In: SOUZA, Beatriz Muniz de & MARTINO, Luís M. Sá (orgs.). **Sociologia da Religião e mudança social: católicos, protestantes e novos movimentos religiosos no Brasil**. Paulus: São Paulo, 2004.

MENESES, Jonatas Silva. **Pentecostalismo e os rituais de cura divina: Personagens e Percursos**. Tese de Doutorado em Ciências Sociais. PUC: São Paulo, 2002.

MERRIAM-WEBSTER's Online Dictionary. Definition of Vitalism. Acessado em 10/04/2007: <http://www.m-w.com/dictionary/vitalism>.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Saúde-doença: uma concepção popular da etiologia. Cad. Saúde Pública, vol.4 no.4, Rio de Janeiro, Out./Dez. 1988. Acessado em 16/11/06: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v4n4/03.pdf>.

MONTENEGRO, Alfredo João. **Evolução do catolicismo no Brasil**. Vozes: Rio de Janeiro, 1972.

MONTEIRO, Luiz Felipe C. O âmbito do transcendente: O sagrado e o símbolo como elementos da vivência religiosa. Artigo publicado em 2004 pela faculdade de Psicologia Ruy Barbosa. Acessado em 21/12/2006: <http://www.frb.br/ciente/Imprensa/Psi/2004.2/BMLupi.pdf>.

MONTERO, Paula. **Da doença a desordem: a magia na umbanda**. Editora Graal: Rio de Janeiro, 1985.

MORRIS, Desmond. **O macaco nu**. Trad. Port. Hermano Neves. 15ª edição, Editora Record: Rio de Janeiro, 2004.

NEGRÃO, Lísias Nogueira. **Entre a cruz e a encruzilhada: formação do campo umbandista em São Paulo**. EDUSP: São Paulo, 1996.

NEVES, Sofia. Metodologias Feministas: A Reflexividade ao serviço da Investigação nas Ciências Sociais. **Revista Psicologia: Reflexão e Crítica**, 2005, 18 (3), pp. 408-412. Acessado em 08/11/2008: <http://www.scielo.br/pdf/prc/v18n3/a15v18n3.pdf>

OTTO, Rudolf. **O sagrado**. 1ª ed., Edições 70: São Paulo, 1992.

PASSOS, Mara de Sá Martins da Costa. **Exu pede passagem**. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 1999.

PATRIOTA, Karla Regina M. P. Mídia e religião: 82 horas de missas, cultos, pregações e exorcismo. Acessado em 07/03/08: <http://reposcom.portcom.intercom.org.br/bitstream/1904/16956/1/R0238-2.pdf>

PESSINI, Léo. Saúde, Religião e Espiritualidade. In: **Revista O Mundo da Saúde**. Saúde, Religiões e Espiritualidade. Ano 24 v. 24 n. 6 – Novembro/Dezembro, p. 435-436. Editora do Centro Universitário São Camilo: São Paulo, 2000.

PIERUCCI, Antonio Flávio & PRANDI, Reginaldo. **A realidade social das religiões no Brasil: religião, sociedade e política**. HUCITEC: São Paulo, 1996.

PIERUCCI, Antonio Flávio. “Bye bye, Brasil” – o declínio das religiões tradicionais no Censo 2000. In: Estudos Avançados, vol. 18, nº. 52, São Paulo, Dezembro/2004. Acessado em 05/03/2008: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v18n52/a03v18n52.pdf>

_____. Religião como solvente – uma aula. In: Novos Estudos – CEBRAP, no. 75, São Paulo, Julho/2006. ISSN 0101-3300. Acessado em 05/03/2008: <http://www.scielo.br/pdf/nec/n75/a08n75.pdf>

_____. É fácil ser católico. **Jornal Folha de São Paulo** de 06 de maio de 2007. Fotocópia / sem paginação.

PRANDI, Reginaldo. O Brasil com Axé: candomblé e umbanda no mercado religioso. In: Estudos Avançados, vol. 18, nº. 52, São Paulo, Dezembro/2004. Acessado em 05/03/2008: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v18n52/a15v1852.pdf>

_____. **Segredos Guardados: Orixás na alma brasileira**. Companhia das Letras: São Paulo, 2005.

_____. **Os candomblés de São Paulo**. EDUSP-HUCITEC: São Paulo, 1991.

QUIVY, Raymond & CAMPENHOUDT, LucVan. **Manual de Investigação em Ciências Sociais**. 1ª ed., Publicações Gradiva: Lisboa, 1992.

RABELO, Miriam Cristina. Religião e Cura: Algumas reflexões sobre a experiência religiosa das classes populares urbanas. Cad. Saúde Pública, vol.9, nº.3, p. 316-325, Rio de Janeiro, Jul./Set. 1993.
Acessado em 18/12/06: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v9n3/19.pdf>.

RAMOS, Denise Gimenez. **A psique do corpo: uma concepção simbólica da doença**. 2ª. ed., Summus Editorial: São Paulo, 1994.

REY, Bernard. Jesus curador e salvador, ontem e hoje. In: **Revista O Mundo da Saúde**. Saúde, Religiões e Espiritualidade. Ano 24, vol. 24, nº. 6, Novembro/Dezembro, p. 524-533. Editora do Centro Universitário São Camilo: São Paulo, 2000.

RIBEIRO, Darci. **O povo brasileiro: a formação e o sentido no Brasil**. Companhia das Letras: São Paulo, 1997.

RICHARDSON, Roberto Jarry. **Pesquisa Social: Métodos e técnicas**. Editora Atlas: São Paulo, 1999.

RYAN, Penélope J. **Catolicismo Praticante: a busca de um catolicismo para o terceiro milênio**. Loyola: São Paulo, 1999, p. 167.

SANCHIS, Pierre (org.). **Catolicismo: Unidade Religiosa e pluralismo cultural**. Loyola: São Paulo, 1992.

SCHROER, Silvia & STAUBLI, Thomas. **Simbolismo do corpo na Bíblia**. Paulinas: São Paulo, 2003.

SCLIAR, Moacyr J. **Da Bíblia à Psicanálise: Saúde, doença e medicina na cultura judaica**. Tese de Doutorado – Escola Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro, 1999.

SENFELDER, Leopold. Teophrastus Paracelso. Online Catholic Encyclopedia. Acessado em 09/04/2007: <http://www.newadvent.org/cathen/11468a.htm>.

SEVALHO, Gil. Uma abordagem histórica das representações sociais de saúde e doença. Cad. Saúde Pública, vol.9, n°3, Rio de Janeiro, Jul./Set. 1993. Acessado em 30/11/06: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v9n3/22.pdf>

SEYBOLD, Klaus & MÜELLER, Ulrich B. **Sickness & Healing**. Tradução de Douglas W. Stott. Biblical Encounters Series. Abingdon: Tennessee (USA), 1981.

SILVA, André Luiz. Devoções Populares no BRASIL: Contextualizando Algumas Obras das Ciências Sociais. In: Revista de Estudos da Religião (REVER), ISSN 1677-1222, n°3, 2003, p. 30-49.
Acessado em 20/04/08: http://www.pucsp.br/rever/rv3_2003/p_silva.pdf

SILVA, Drance Elias da. A representação social do dinheiro entre os neopentecostais. In: **Revista Symposium**, Ano 4, Número especial, Universidade Católica de Pernambuco: Dezembro 2000, p. 51-62.

SILVA, Paula; GOMES, Paula; GRAÇA, Amândio & QUEIROS, Paula. Acerca do debate metodológico na investigação feminista. In: Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. Portugal: Set/2005, vol.5, n°3, p. 358-370. ISSN 1645-0523. Acessado em 08/11/2008: http://www.fade.up.pt/rpcd/_arquivo/artigos_soltos/vol.5_nr.3/2.03.p_silva.pdf

SILVA, Vagner Gonçalves. Neopentecostalismo e religiões afro-brasileiras: significados do ataque aos símbolos da herança religiosa africana no Brasil contemporâneo. Revista Mana, vol. 13, n° 1, Rio de Janeiro, Abril/2007. Acessado em 12/03/08: <http://scielo.br/pdf/mana/v13n1/a08v13n1.pdf>

SMITH, Jonathan C. **Understanding stress and coping**. MacMillan Publishing Company: New York (USA), 1993, p. 95-111.

SPINK, Mary Jane Paris. O conceito de representação social na abordagem psicossocial. Cad. Saúde Pública, Julho/Setembro, 1993, vol.9, n°3, p.300-308. ISSN 0102-311X. Acessado em 17/06/08: <http://www.scielo.org/pdf/csp/v9n3/17.pdf>

SPINK, Mary Jane Paris & GIMENES, Maria da Gloria G. Práticas discursivas e produção de sentido: apontamentos metodológicos para a análise de discursos sobre a saúde e a doença. Saúde e Sociedade, 1994, vol.3, n°2, p.149-171. ISSN 0104-1290. Acessado em 19/06/08: <http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v3n2/08.pdf>

SORIANO, Raúl Rojas. **Manual de Pesquisa Social**. Trad. port. Ricardo Rosenbusch. Vozes: Rio de Janeiro, 2004.

STOLL, Sandra Jacqueline. **Espiritismo à Brasileira**. EDUSP: São Paulo, 2003.

TANAKA, Márcia Toyoko. **Terreiros de Umbanda e Candomblé – Um estudo das motivações e expectativas dos frequentadores**. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Psicologia. PUC: São Paulo, 1994.

TERRAGNI, Laura. A pesquisa de gênero. In: MELUCCI, Alberto. **Por uma sociologia reflexiva: pesquisa qualitativa e cultura**. Editora Vozes: Rio de Janeiro, 2005, p. 141-163.

TERRIN, Aldo Natale. **O sagrado off limits: A experiência religiosa e suas expressões**. Trad. Euclides Balancin. Loyola: São Paulo, 1998.

VALE, Edênio. Aspectos psico-grupais do comportamento religioso-popular. In: **Religião e Catolicismo do Povo**. Editora Ave Maria: São Paulo, 1977, p. 73-96.

WARNE, Randi. (En)gendering Religious Studies. In: JUSCHKA, Darlene M. **Feminism in the study of religion**. Continnum: New York, 2001, p. 147-156.

WEBER, MAX. **Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva**. Vol 1, 4ª Edição. Trad. Port. Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Editora UnB: São Paulo, 2004, p. 279 a 422.

ZALUAR, Alba. **Os homens de Deus: um estudo dos santos e das festas no catolicismo popular**. Zahar Editores: Rio de Janeiro, 1983.

ZEMPLÉNI, Andras. A “doença” e suas “causas”. In: **Cadernos de Campo**, São Paulo, n. 4, p. 137-163, 1994.